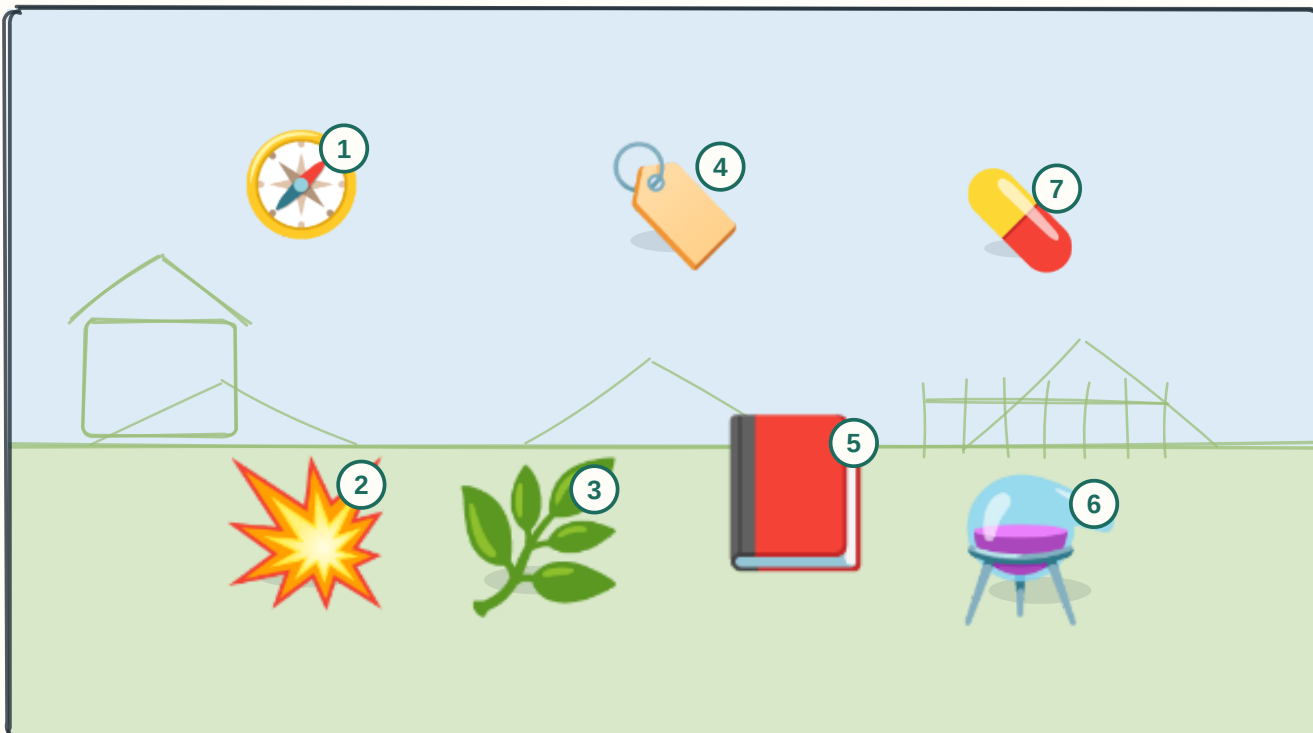


01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

LÉKÁRNICKÁ ZAHRADA — odsud pocházejí léky a odsud vedou dvě cesty: tam (kinetika) a zpátky (dynamika).



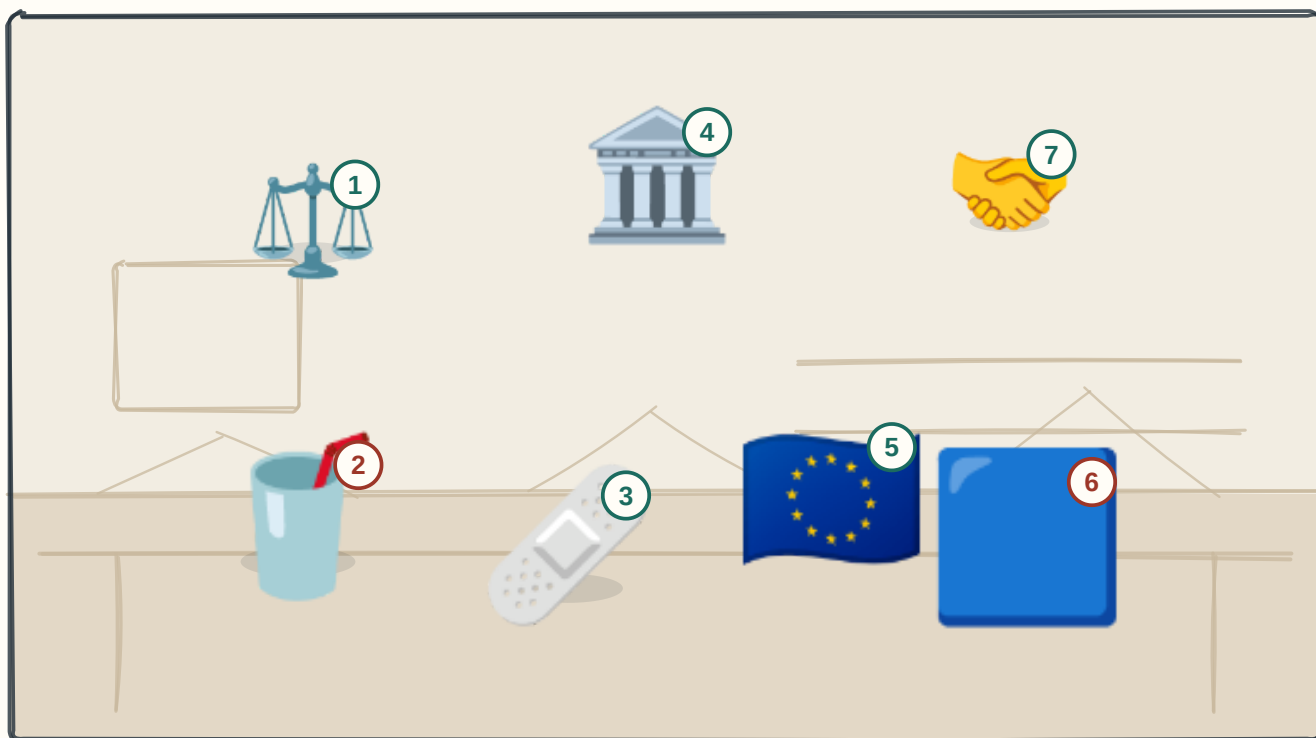
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|---------------------|---|
| 1 Kompas | FARMAKOKINETIKA — co dělá tělo s lékem: absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece (ADME). |
| 2 Výbuch | FARMAKODYNAMIKA — co dělá lék s tělem: mechanismus účinku a vztah dávky a odpovědi. |
| 3 Bylina | Zdroje rostlinné (morfin, atropin, digoxin), živočišné (heparin, inzulin), mikrobiální (peniciliny), chemická syntéza a biotechnologie (monoklonální protilátky). |
| 4 Tři visačky | Názvy: chemický (vzorec) · generický = mezinárodní nechráněný (ibuprofen) · firemní chráněný (Brufen®). |
| 5 Červená kniha | LÉKOPIS — závazný soubor požadavků na jakost léčiv; Český vychází z Evropského. |
| 6 Lékárnický kotlík | Magistraliter se připravuje v lékárně podle receptu; HVLP se vyrábí hromadně. |
| 7 Hotová tableta | Léčivá LÁTKA je nositel účinku, léčivý PŘÍPRAVEK je hotová forma, kterou pacient dostane. |

⚠ Farmakologie zastřešuje i farmakoterapii, toxikologii a farmakovigilanci — není to jen nauka o účincích léků.

02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

TRŽNICE SE TŘEMI PULTY — u každého platí jiná pravidla, a rozhoduje MECHANISMUS, ne složení.



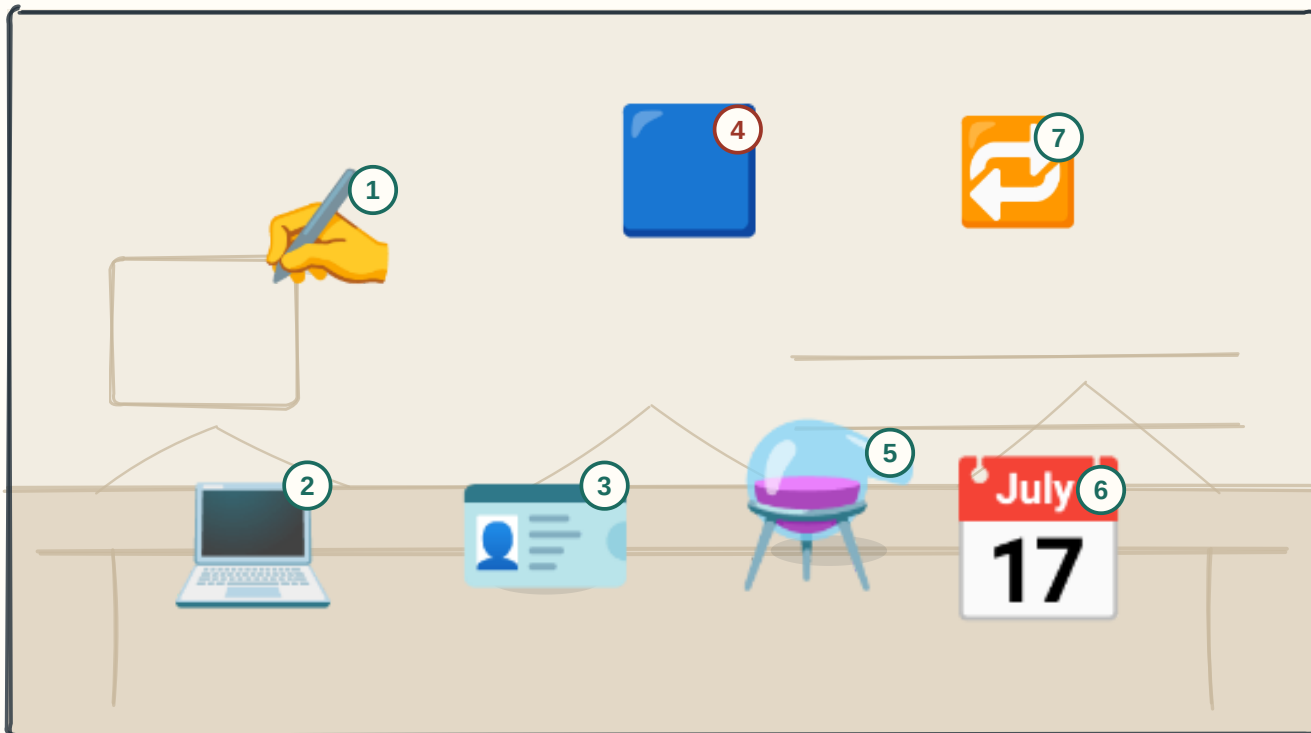
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Váhy na prvním pultu | LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky; musí prokázat účinnost, bezpečnost a jakost. |
| 2 Kelímek na druhém pultu | DOPLNĚK STRAVY je právně potravinu — účinnost dokládat nemusí, stačí ohlášení, a nesmí tvrdit, že léčí. Dozor má SZPI. |
| 3 Náplast na třetím pultu | ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK působí FYZIKÁLNĚ (výplň, implantát, obvaz) — posuzuje se shoda a riziková třída. |
| 4 Úřední budova | SÚKL registruje léčiva, stanovuje ceny a úhrady, dozoruje lékárny, povoluje klinická hodnocení a vede farmakovigilanci. |
| 5 Vlajka nad tržnicí | EMA vede centralizovanou registraci platnou pro celou EU. |
| 6 Modrý pruh na krabičce | Omamné a psychotropní látky se předepisují na recept s modrým pruhem a mají přísnější evidenci. |
| 7 Podání ruky | Klinické hodnocení musí kromě SÚKL schválit i etická komise. |

⚠ Pacient rozdíl mezi lékem a doplňkem nevidí — na doplňky se proto ptej cíleně: třezalka, ginkgo a česnek mají reálné interakce.

03 Předepisování léčivých přípravků

ORDINACE SE DVĚMA PODPISY — lékař ručí za to, co předepsal, lékárník za to, co vydal.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Dva podpisy pod receptem** Recept je právní dokument se sdílenou odpovědností — proto musí být čitelný a úplný.
- 2 Obrazovka s eReceptem** eRecept je standard: lékař ho vystaví do centrálního úložiště, pacient dostane identifikátor. Listinný recept zůstává pro výpadky.
- 3 Průkazka pacienta** Náležitosti: pacient (jméno, číslo pojištěnce) · léčivo (název, síla, forma, množství) · dávkování a způsob podání (D.S.) · lékař a pracoviště s podpisem a razítkem · datum.
- 4 Modrý pruh** Vyhrazen omamným a psychotropním látkám; přísnější evidence.
- 5 Třecí miska** Magistraliter předpis má stavbu Rp. (recipe) — složení — M.f. (misce fiat) — D.S. (da signa).
- 6 Kalendář na zdi** Platnost běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [⚠ ověřit dle skript]. Opakovací recept uvádí počet opakování.
- 7 Výměna krabiček** Generická substituce — lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou účinnou látkou, silou a formou, pokud to lékař nezakázal a pacient souhlasí.

⚠ Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita a kojení, funkce jater a ledvin a všechny ostatní léky včetně volně prodejných.

04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

ŽEBŘÍK O ČTYŘECH PŘÍČKÁCH — dole myš, nahoře celý svět. Každá příčka odpovídá na jinou otázku.



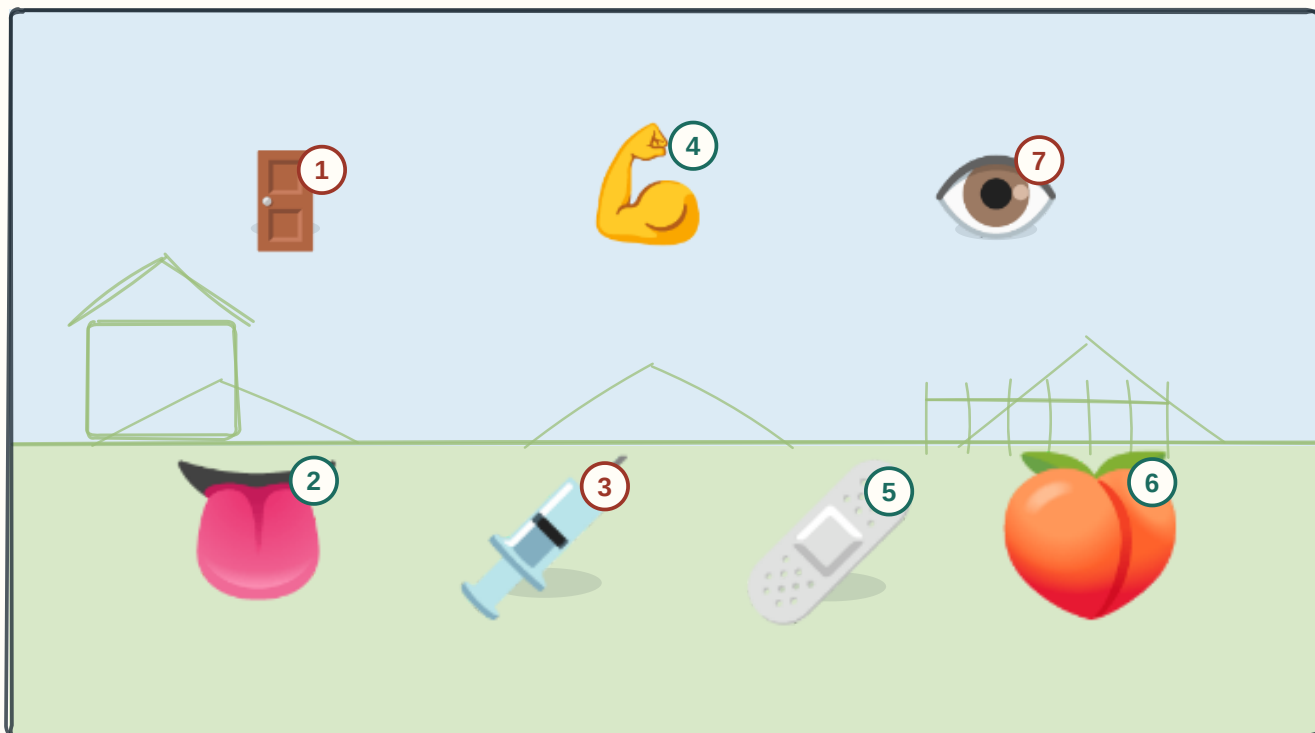
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Myš na spodní příčce | PREKLINIKA in vitro a na zvířeti: farmakokinetika, farmakodynamika, toxicita (ED50, TD50, LD50), mutagenita, teratogenita, karcinogenita. |
| 2 Zdravý dobrovolník | FÁZE I — desítky ZDRAVÝCH: bezpečnost a snášenlivost; zahajuje se mikrodávkami s pomalou eskalací. |
| 3 Stovka zkumavek | FÁZE II — stovky nemocných: hledá se účinná dávka. |
| 4 Zástup lidí | FÁZE III — tisíce nemocných: srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem; na jejím základě se registruje. |
| 5 Zeměkoule nahoře | FÁZE IV — po uvedení na trh, běžná populace. Teprve tady se odhalí VZÁCNÉ nežádoucí účinky, protože ve studii na tisících neměly šanci vyjít najevo. |
| 6 Kostka randomizace | Zásady studie: randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojitě), kontrolní skupina, předem daný cíl, souhlas etické komise. |
| 7 Kopírák | Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá BIOEKVIVALENCI, tedy shodný průběh hladin s originálem. |

! Preklinika sama nestačí: zvíře nemá stejný metabolismus ani receptory. Od objevu k registraci uplyne zpravidla 10–15 let.

05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

KŘÍŽOVATKA PŘED JÁTRY — hlavní otázka není „jak rychle“, ale „PROJDE TO JÁTRY?“.



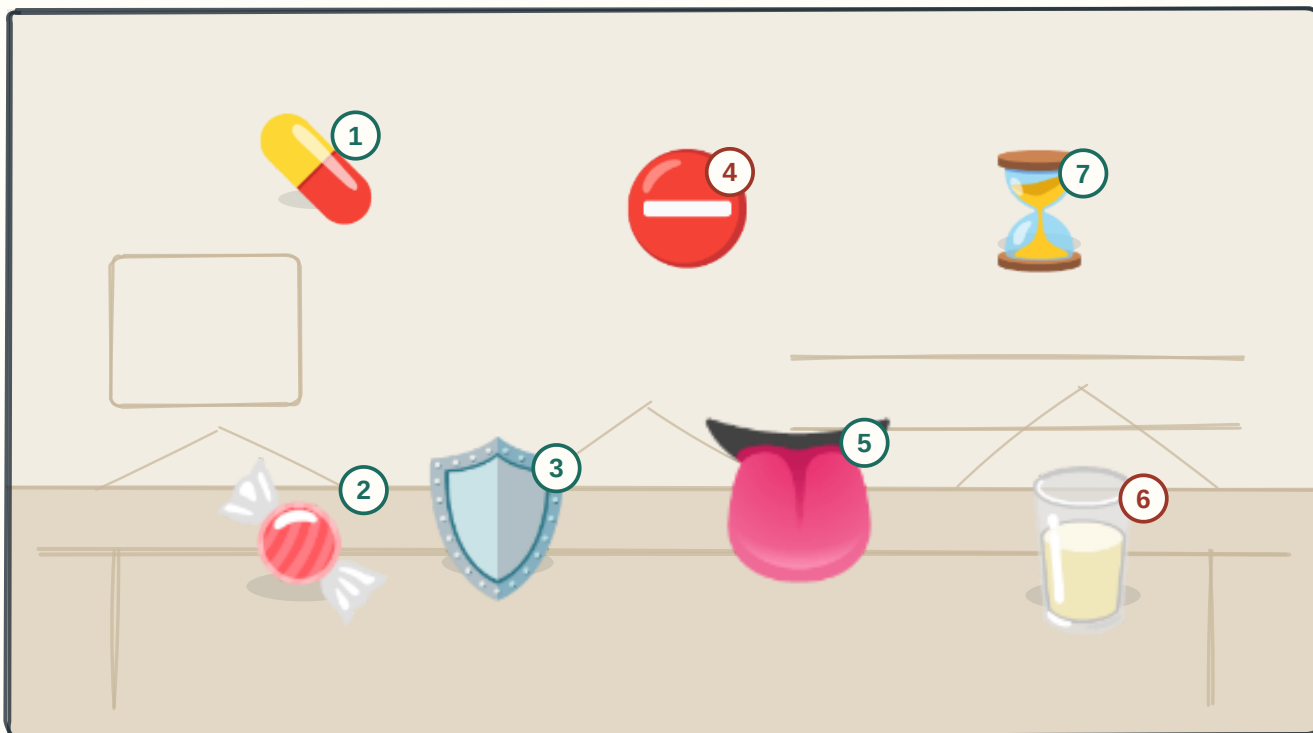
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Vrátnice u cesty**
PERORÁLNĚ: látka projde střevní stěnou a játry dřív, než se dostane do oběhu (first-pass). Proto se stejný lék podává ústy v mnohonásobně vyšší dávce než do žíly.
- 2 Odbočka pod jazykem**
SUBLINGVÁLNĚ a bukálně — vstřebání rovnou do systémového oběhu, obchází játra; proto nitroglycerin pod jazyk.
- 3 Stříkačka na cestě**
I.V.: okamžitý účinek a biologická dostupnost 100 % — ale podané se nedá vzít zpět.
- 4 Sval u cesty**
I.M. rychlé, S.C. pomalejší (inzulin, hepariny); dále intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně. Vyžadují sterilitu a personál.
- 5 Náplast na plotě**
TRANSDERMÁLNĚ — nejpomalejší nástup, ale stálá hladina po dny; po sejmutí účinek doznívá z kožního depa.
- 6 Zadní vrátka**
REKTÁLNĚ — funguje při zvracení a u dětí, játra obchází jen zčásti (dolní část konečníku), vstřebávání je kolísavé.
- 7 Oko nad krajinou**
„Místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — timolol z očních kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus.

! Biologická dostupnost F je podíl dávky, který se dostane nezměněný do oběhu; i.v. má z definice F = 100 %.

06 Lékové formy — perorální a orální

CUKRÁRNA S CEDULÍ NEDRTIT — co se polyká, jde dál do střeva; co se cucá, zůstává v ústech.



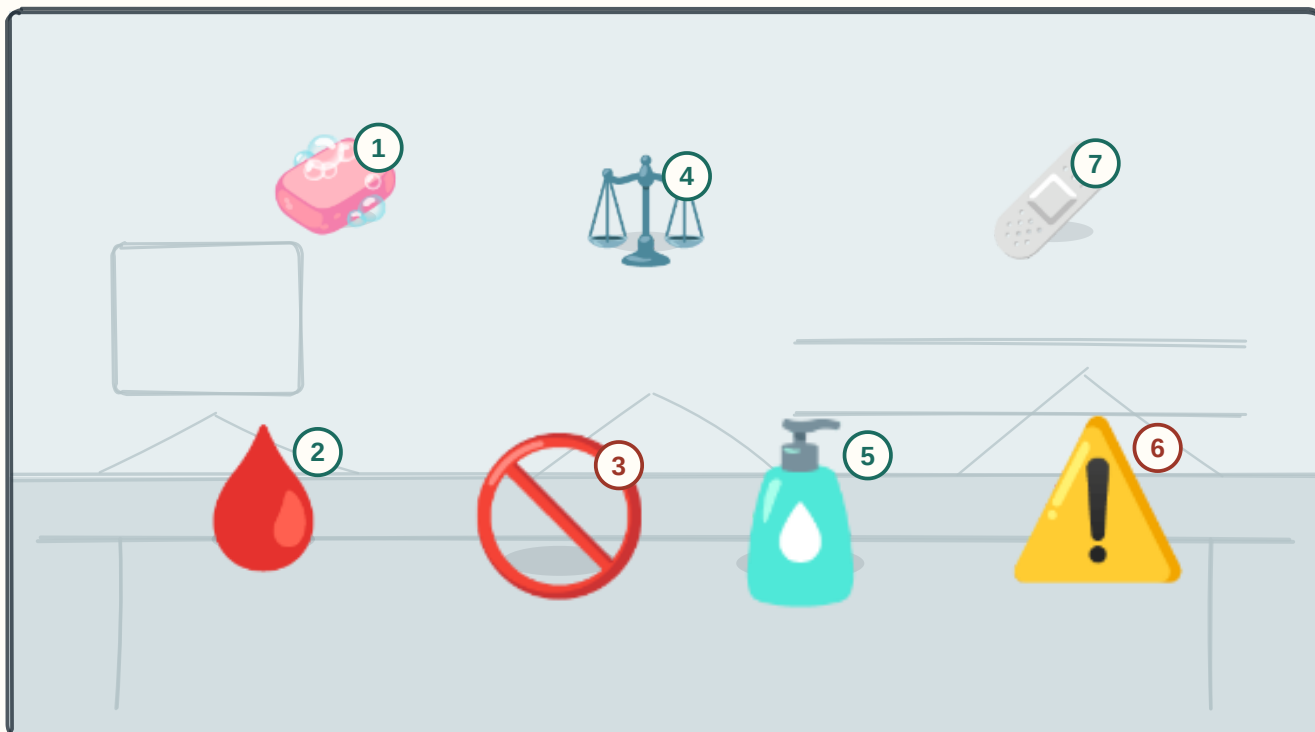
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Tableta na pultu | PERORÁLNÍ formy se polykají a působí až po vstřebání: tablety, potahované tablety, tobolky, granuláty, sirupy, suspenze, kapky. |
| 2 Pastilka ve sklenici | ORÁLNÍ formy zůstávají v ústech: pastilky, žvýkací tablety, ústní vody, gely (per os = skrz ústa, oralis = ústní). |
| 3 Štít na tabletě | ENTEROSOLVENTNÍ obal projde žaludkem a rozpadne se až ve střevě — chrání látku před kyselinou nebo žaludek před látkou. |
| 4 Cedula NEDRTIT | Retardované formy (SR, ZOK) uvolňují látku postupně — rozdrčením se uvolní celá denní dávka najednou nebo se látka zničí. Totéž platí pro enterosolventní obal. |
| 5 Jazyk pod pultem | Sublingválně a bukálně se látka vstřebá rovnou do krve a obejde first-pass — nitroglycerin, buprenorfin. |
| 6 Konvička s laktózou | Pomocné látky nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, barviva mohou vyvolat alergii, cukr v sirupech je při dlouhodobé léčbě rizikový. |
| 7 Rozpouštějící se kostka | Rozpad a rozpuštění předchází vstřebání — u málo rozpustných léčiv je rychlost rozpouštění krokem určujícím nástup účinku. |

⚠ Šumivé a orodispergovatelné tablety nástup urychlují, protože přeskakují fázi rozpadu tuhé lékové formy.

07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

STERILNÍ SÁL A VEDLE NĚJ MASTIČKÁŘSKÝ PULT — co obchází bariéry, musí být čisté.



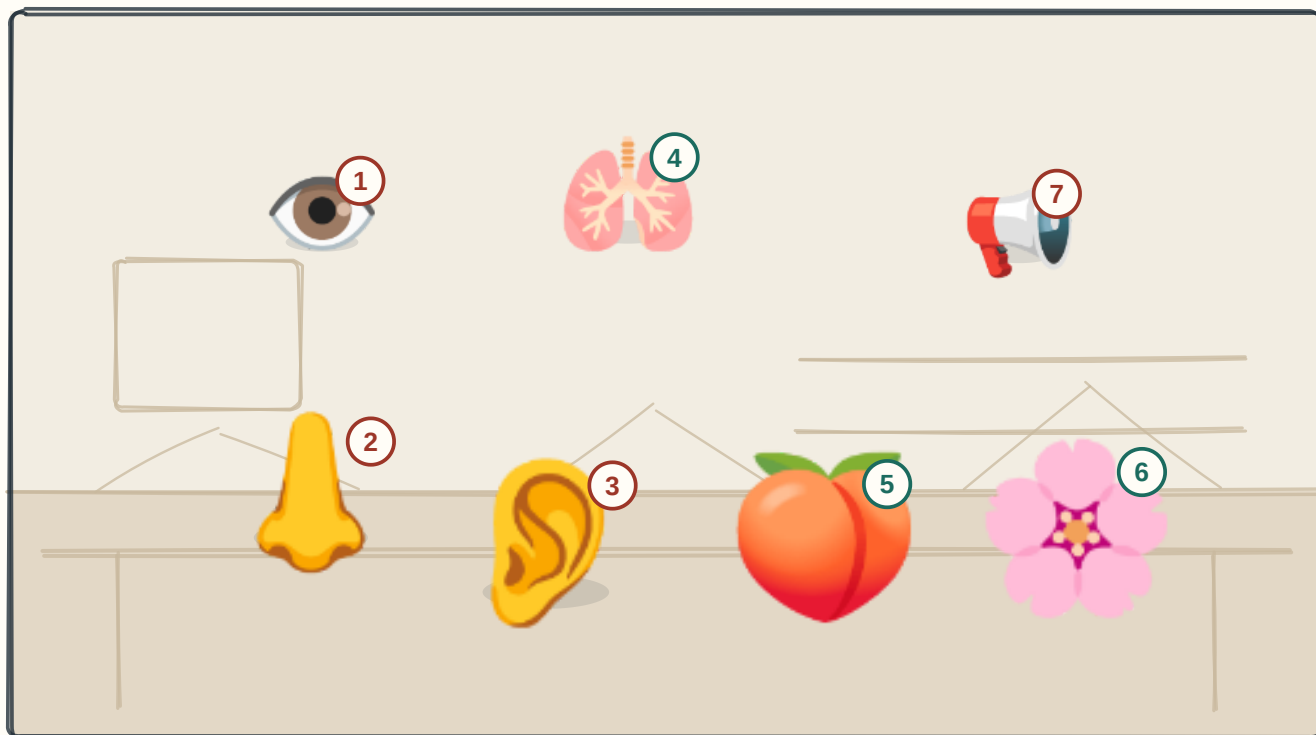
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Mýdlo a rouška**
Parenterální přípravek obchází kůži i sliznici, proto musí být STERILNÍ, APYROGENNÍ, IZOTONICKÝ, IZOHYDRICKÝ a bez mechanických nečistot.
- 2 Krevní řečiště**
Rychlost účinku sleduje prokrvení: i.v. okamžitě a se 100% dostupností · i.m. rychle · s.c. pomaleji · depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce.
- 3 Přeskrtnutá kalná lahvička**
SUSPENZE A EMULZE SE NIKDY NEPODÁVAJÍ I.V. — hrozí embolizace.
- 4 Váhy výhod a nevýhod**
Výhody: jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí. Nevýhody: bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a NEVRATNOST podání.
- 5 Řada kelímků**
Dermatologika: mast (tučný základ, největší průnik, na suchou kůži), krém (voda i tuk), gel (vodný, chladí), pasta, zásyp, roztok, náplast. Průnik zvyšuje okluze.
- 6 Ztenčená kůže**
Lokální kortikoidy dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie — na obličeji a do záhybů jen slabé přípravky a krátce, protože se tam vstřebávají nejvíc.
- 7 Náplast na paži**
Transdermální náplast obchází játra a udrží stálou hladinu po dny (fentanyl, nikotin, estrogeny).

⚠ Depotní a implantabilní formy působí týdny až měsíce — výhodou je adherence, nevýhodou to, že se při nežádoucí reakci nedají odstranit.

08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

ORDINACE SE VŠEMI OTVORY TĚLA — a nade všemi visí cedule: MÍSTNÍ NENÍ JEN MÍSTNÍ.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Oční kapky

Musí být sterilní a izotonické, po otevření omezená použitelnost. TIMOLOL z kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus; vstřebání sníží stisknutí vnitřního koutku po nakapání.

2 Nosní sprej

Dekongescencia (xylometazolin) jen 5–7 DNÍ, jinak vzniká rhinitis medicamentosa. Nosní cestou se podává i desmopresin a sumatriptan k celkovému účinku.

3 Ušní kapátko

Ušní kapky se nesmí podat při perforaci bubínku.

4 Inhalátor s nástavcem

Aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Rozhoduje TECHNIKA inhalace; nástavec zlepší depozici a sníží orofaryngeální kandidózu a chrapot po inhalačním kortikoidu.

5 Čípek

Rektalia obcházejí játra jen z dolní části konečníku, vstřebávání je kolísavé; hodí se u zvracení, u dětí a v bezvědomí (diazepam u křečí).

6 Vaginální globule

Slouží hlavně k místní léčbě (antimykotika, estrogeny), ale i odsud se látka částečně vstřebává.

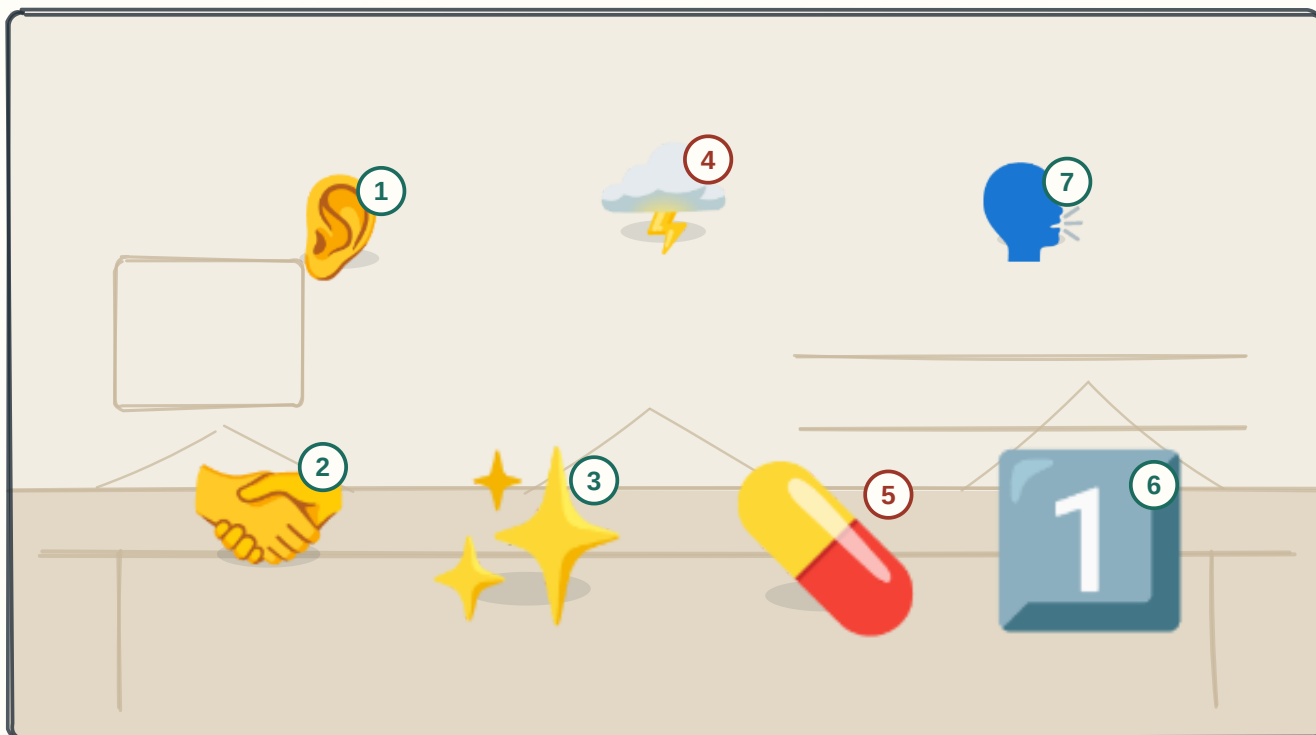
7 Cedule nade vším

Společné pravidlo: všechny tyto formy se vstřebávají a mohou působit celkově.

⚠ Nosní a bukalní sliznice jsou dobře prokrvené a first-pass obcházejí — vstřebání odsud může být rychlejší než ze střeva.

09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

ČEKÁRNA, KDE SLOVA MAJÍ DÁVKU — co lékař řekne, má nástup, účinek i nežádoucí účinky.



CO JE VE SCÉNĚ

① **Naslouchající ucho**

COMPLIANCE — míra, do jaké pacient dodržuje pokyny; pasivní pojetí.

② **Podání ruky**

ADHERENCE — pacient se na plánu podílel; KONKORDANCE je společné rozhodnutí lékaře a pacienta. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spoluodpovědnost.

③ **Jiskra nad hlavou**

PLACEBO — očekávané zlepšení; má neurobiologický podklad (endogenní opioidy, dopamin), není „vymyšlené“ a zesiluje účinek každého skutečného léku.

④ **Mrak s bleskem**

NOCEBO — očekávaná škoda; nepříznivé věty a příbalový leták vyvolají potíže. Odsud časté vysazení statinů a antidepresiv.

⑤ **Hromada krabiček**

Nejčastější příčina selhání léčby není špatný lék, ale NEBRANÝ lék: složitý režim, mnoho tablet, nežádoucí účinky a obavy z nich, cena, nepochopení, nedůvěra.

⑥ **Jedna tableta denně**

Zlepší to fixní kombinace (méně tablet), dávkování 1× denně, srozumitelné vysvětlení a kontrola.

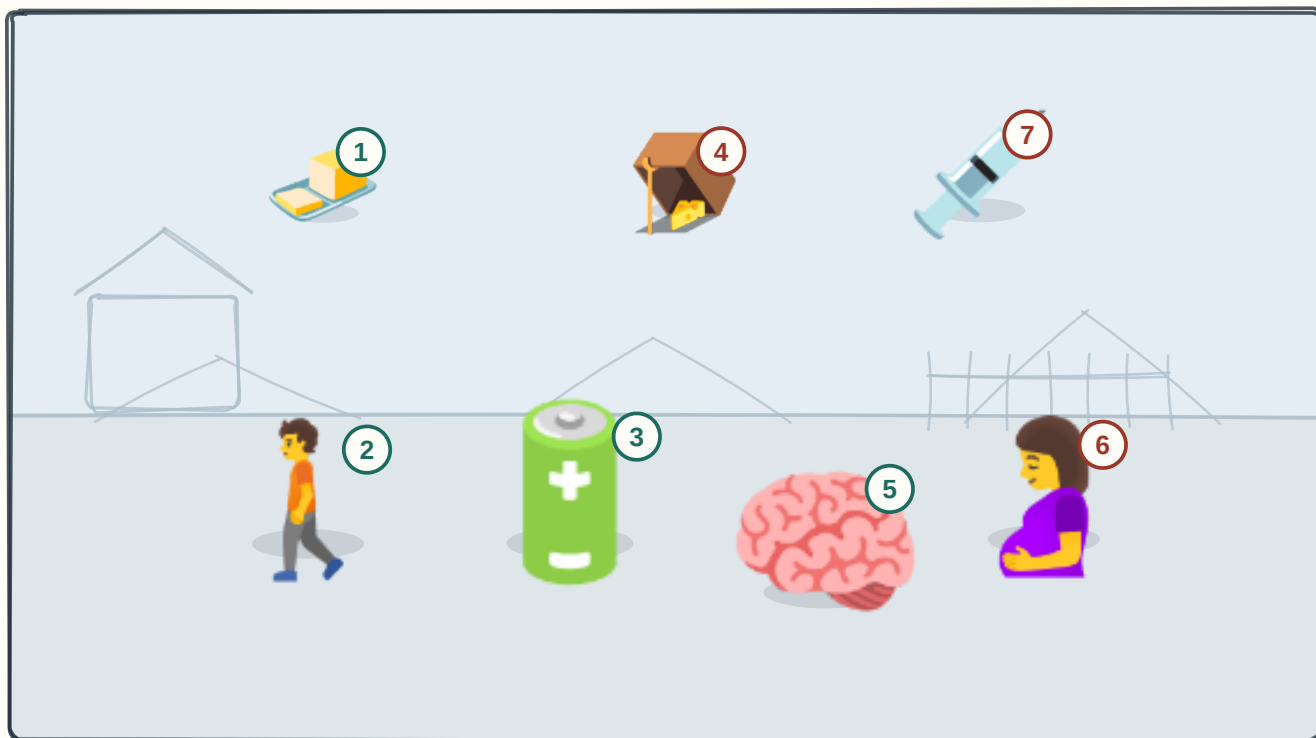
⑦ **Mluvící lékař**

Formulace lékaře je sama o sobě účinná látka s vlastní dávkou — proto se způsob sdělení plánuje stejně jako dávka.

⚠ Placebo se neomezuje na placebo tablety — každý účinný lék nese i placebovou složku, a ta se sčítá s jeho farmakologickým účinkem.

O10 Přechod látek biologickými membránami

TUKOVÁ ZEDĚ S JEDNOSMĚRNOU PASTÍ — projde jen ten, kdo je mastný a nenabitý.



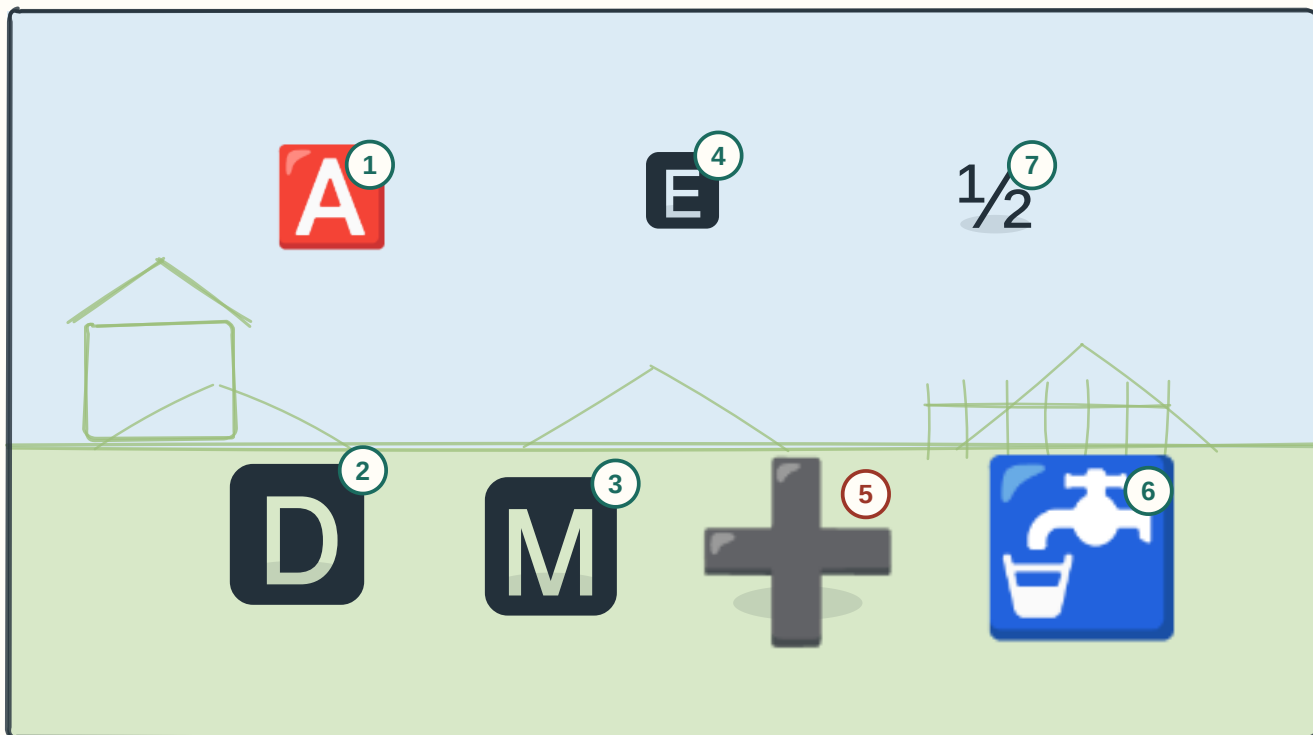
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Mástlová zeď**
Membrána je lipidová dvojvrstva — projde jen látka LIPOFILNÍ a NENABITÁ; ionizovaná forma neprojde.
- 2 Chodec po svahu**
PROSTÁ DIFUZE — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče; hlavní mechanismus u většiny léčiv.
- 3 Baterie u brány**
AKTIVNÍ TRANSPORT — proti spádu, spotřebuje ATP, je saturovatelný (P-glykoprotein léčiva aktivně vypuzuje z buňky). Facilitovaná difuze jde přenašečem, ale po spádu a bez energie.
- 4 Past za zdí**
IONTOVÁ PAST: látka projde v nenabitě formě, na druhé straně se při jiném pH nabije a zpět už neprojde — hromadí se. Proto alkalizace moči urychlí vyloučení salicylátů.
- 5 Hlídaná brána do mozku**
Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein. Zánět ji zpropustní: penicilin proniká do CNS jen při meningitidě.
- 6 Placenta**
Placentární bariéra je PROPUSTNĚJŠÍ, než se obvykle čeká — většina léčiv jí projde.
- 7 Anestetikum v zánětu**
V kyselém zánětlivém prostředí převáží nabitá forma lokálního anestetika, která neprojde k sodíkovému kanálu — proto tam nezabírá.

! Krev–varle a krev–sítnice jsou další bariéry; naopak zánět propustnost bariér obecně zvyšuje, což mění dávkování.

O11 Základní farmakokinetické parametry a procesy

ČTYŘI STANICE JEDNÉ TRATĚ — A, D, M, E. Kdo si splete eliminaci s exkrecí, vystoupí na špatné.



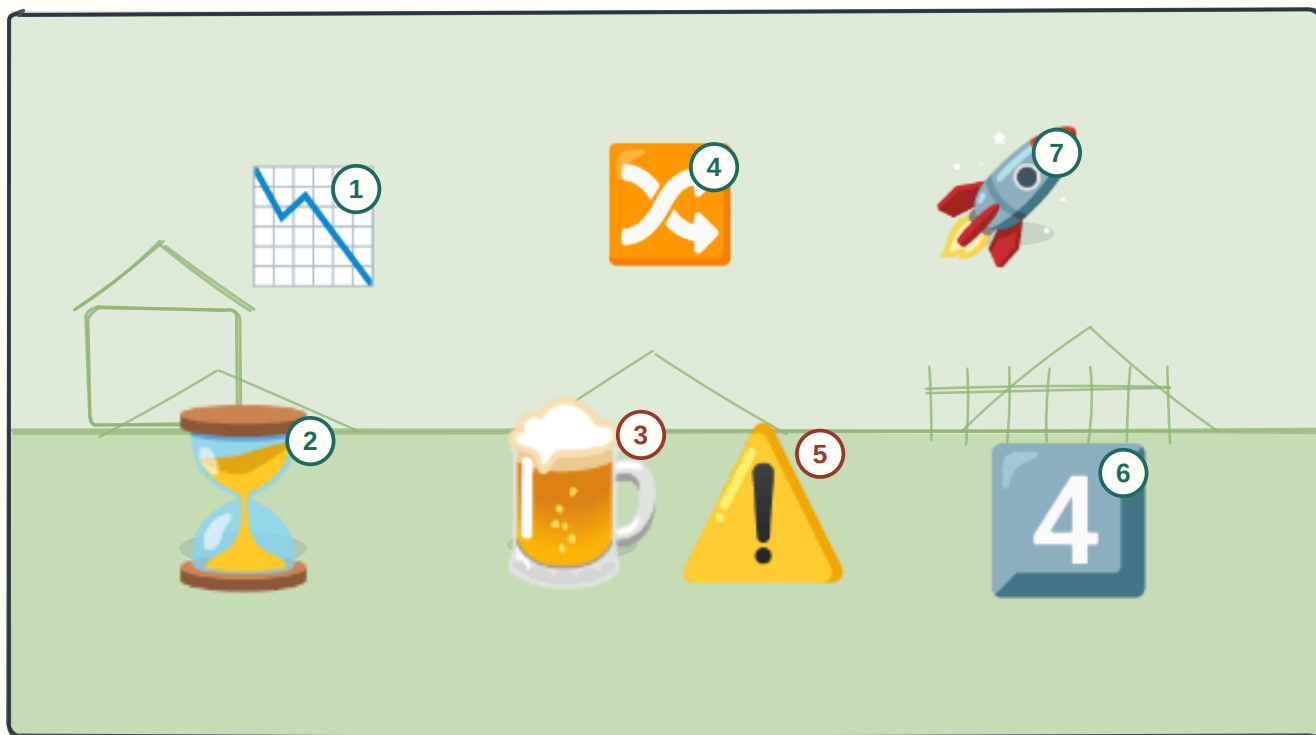
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|--------------------|---|
| 1 První stanice A | ABSORPCE — vstup do krve; její rozsah vyjadřuje biologická dostupnost F (i.v. = 100 %). |
| 2 Druhá stanice D | DISTRIBUCE — rozvod do tkání; popisuje ji distribuční objem Vd (poměr dávky k plazmatické koncentraci). |
| 3 Třetí stanice M | METABOLISMUS — přeměna, hlavně v játrech; I. fáze (oxidace, redukce, hydrolýza) a II. fáze (konjugace). |
| 4 Čtvrtá stanice E | EXKRECE — vyloučení, hlavně ledvinami; dále žlučí, plícemi, mlékem. |
| 5 Spojka M + E | ELIMINACE = metabolismus PLUS exkrece. Není totéž co vylučování — to je jen její část. |
| 6 Vodárna | CLEARANCE — objem krve zcela očištěný za jednotku času; sčítá se renální a jaterní. |
| 7 Půlená cedule | Biologický poločas — doba poklesu na polovinu. Ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení. |

⚠ Vysoké Vd znamená, že látka sedí ve tkáních, ne v krvi — proto ji hemodialýza neodstraní (digoxin, antidepresiva).

O12 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

DVĚ PILY NA DŘEVO — jedna ubírá vždycky POLOVINU hromady, druhá vždycky STEJNÝCH PĚT POLEN.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Klesající křivka

KINETIKA PRVNÍHO ŘÁDU — odbourává se konstantní **PODÍL** za čas (polovina za poločas). Platí pro naprostou většinu léčiv, protože enzymy mají kapacitní rezervu.

2 Přesýpací hodiny

KINETIKA NULTÉHO ŘÁDU — enzym je nasycený, odbourává konstantní **MNOŽSTVÍ** za čas bez ohledu na koncentraci. Pokles je lineární a poločas ztrácí smysl.

3 Korbel piva

Ethanol se odbourává řádově 0,1–0,15 ‰ za hodinu, vždy stejně — proto **NELZE** počítat „za dva poločasy bude polovina“ a rychlost nejde urychlit.

4 Výhybka

Michaelisova–Mentenové (saturační) kinetika je přechod mezi obojím: při nízké koncentraci první řád, po nasycení enzymu nultý.

5 Přetékající hrnec

U saturačního léčiva stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma — fenytoin (nystagmus, ataxie, zmatenost), salicyláty, theofylin. Proto se měří hladiny.

6 Čtyři zářezy

Ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.

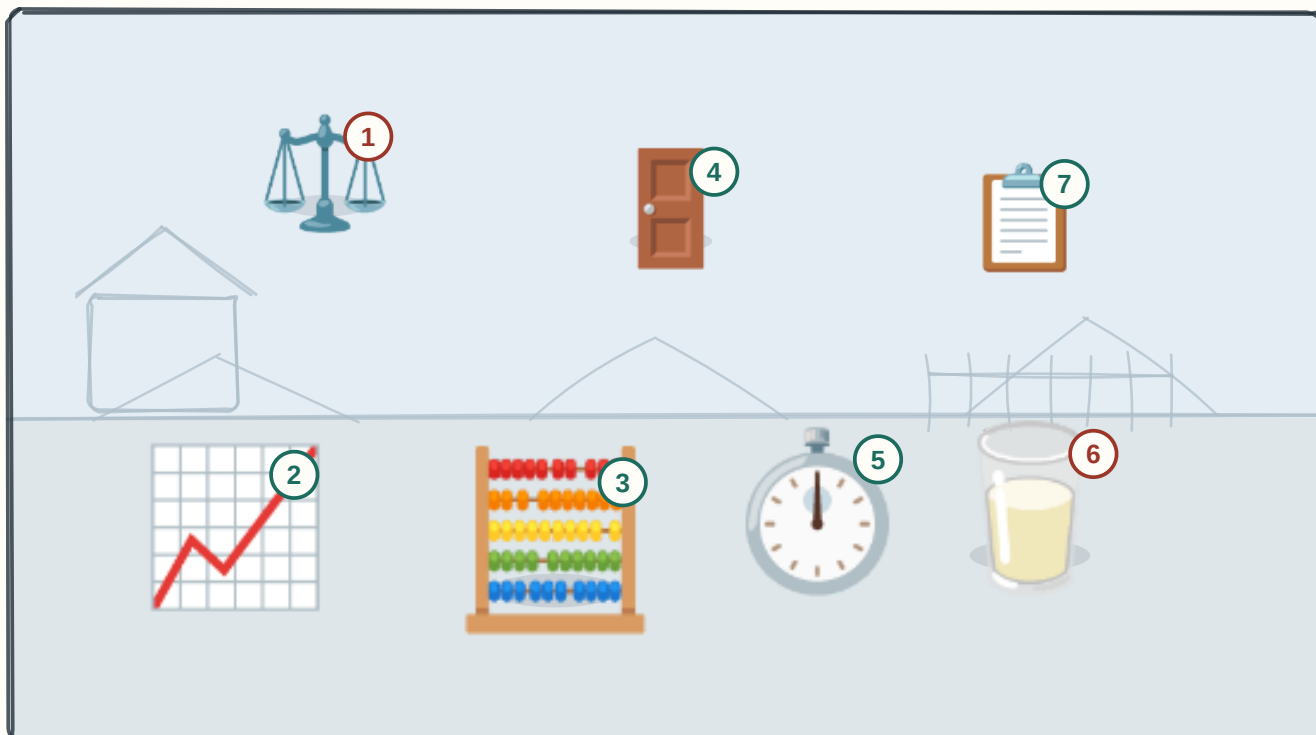
7 Nasycovací dávka

U dlouhého poločasu se čekání zkracuje nasycovací dávkou.

! Poločas má smysl jen u kinetiky prvního řádu — u nultého řádu se mění s koncentrací, a proto se neuvádí.

O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

PŘETAHOVANÁ NA VRCHOLU KOPCE — C_{max} je REMÍZA mezi vstřebáváním a eliminací.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Vyrovnané váhy**

C_{max} není konec vstřebávání — je to okamžik, kdy se rychlost vstupu vyrovná rychlosti eliminace. Vstřebávání pokračuje i po něm, jen ho eliminace převáží.
- 2 Křivka přes kopec**

BATEMANOVA FUNKCE popisuje průběh koncentrace po jednorázovém perorálním podání: vzestupná fáze (převažuje absorpce), vrchol, sestupná fáze (převažuje eliminace).
- 3 Počítadlo plochy**

AUC — plocha pod křivkou = celková expozice organismu; podle ní se srovnává originál s generikem (bioekvivalence).
- 4 Vrátnice s výběřčím**

Biologická dostupnost F = podíl dávky, který se dostane NEZMĚNĚNÝ do systémového oběhu; snižuje ji neúplné vstřebání a first-pass metabolismus.
- 5 Stopky**

t_{max} vypovídá o RYCHLOSTI vstřebávání, C_{max} a AUC o jeho ROZSAHU.
- 6 Sklenice mléka**

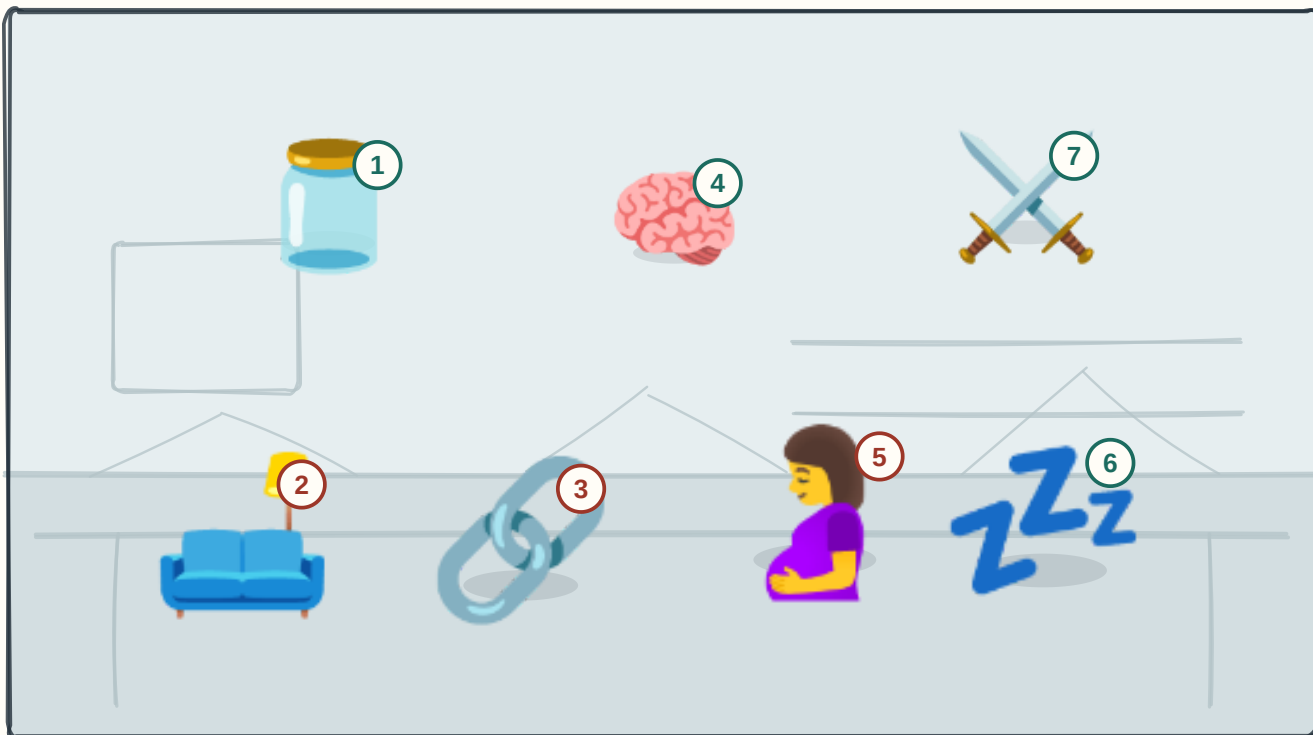
Vstřebání ovlivní léková forma, rozpustnost, pH, jídlo, motilita a prokrvení; antacida, železo a vápník váží tetracykliny a chinolony.
- 7 Dvě shodné křivky**

Generikum musí mít shodné AUC i C_{max} v předepsaném rozmezí — proto se u něj nezkoumá znovu účinnost.

! Vyšší C_{max} při stejném AUC znamená rychlejší, ale krátkodobější účinek — proto retardovaná forma snižuje C_{max}, aniž by změnila celkovou expozici.

O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

SKLAD S VELKOU NÁDOBOU — Vd je ZDÁNlivý objem, ne skutečný. Velké číslo znamená: lék není v krvi, sedí ve tkáních.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Obří nádoba

$V_d = \text{dávka} \div \text{plazmatická koncentrace}$. Je to počítaná veličina, ne anatomický prostor — může mnohonásobně převýšit objem těla.

2 Gauč ve skladu

Vysoké V_d = lék uložený ve tkáních (tuk, sval), v krvi ho je málo — proto ho HEMODIALÝZA NEODSTRANÍ (digoxin, antidepresiva).

3 Řetěz k albuminu

Účinná je jen VOLNÁ frakce. Albumin váže kyselé látky (warfarin, fenytoin), OROSOMUKOID (kyselý $\alpha 1$ -glykoprotein) zásadité. Při hypoalbuminemii stoupá volná frakce a s ní účinek i toxicita.

4 Brána do mozku

Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein; propustí jen lipofilní a nenabitě látky.

5 Placenta

Placentární bariéra je propustnější, než se čeká — proto se u gravidity vždy ptáme, co projde k plodu.

6 Usínající pacient

REDISTRIBUCE: thiopental uspí rychle (jde do mozku) a probudí rychle (přesune se do svalu a tuku) — konec účinku dělá PŘESUN, ne eliminace.

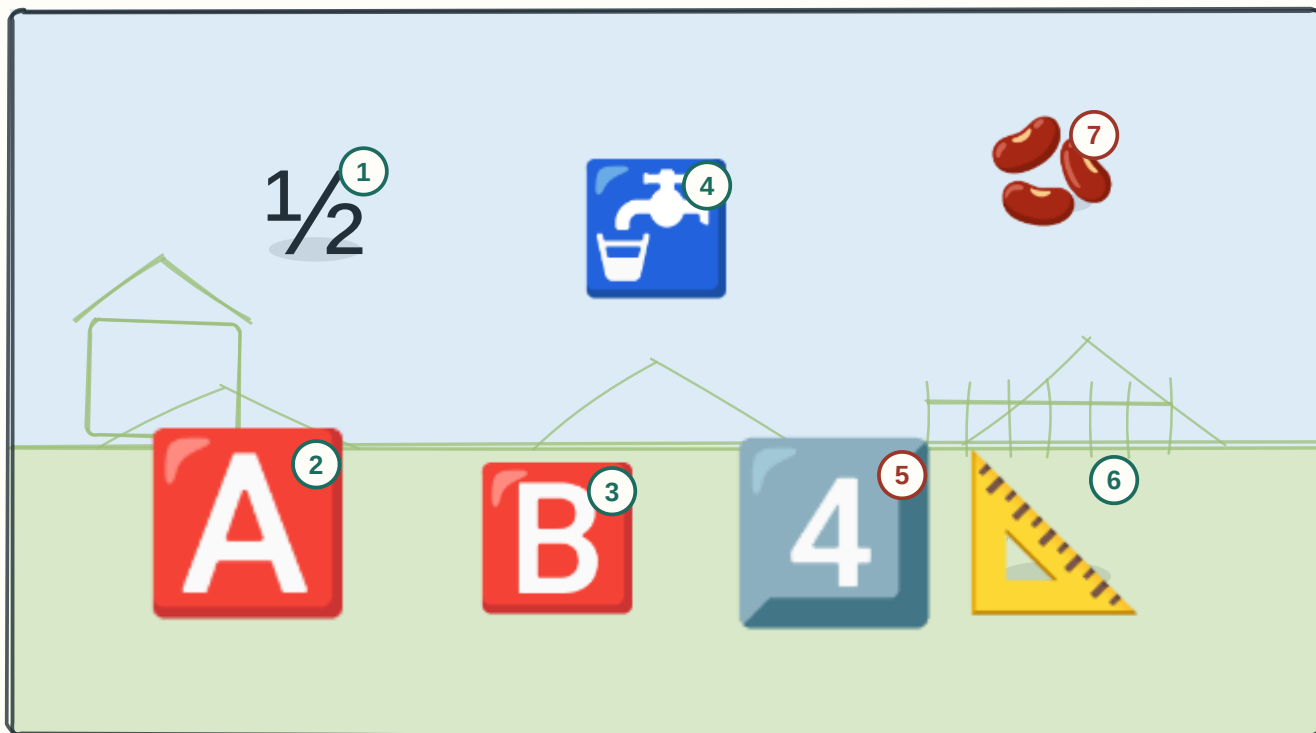
7 Vytěsnění z vazby

Sulfonamidy vytěsní warfarin z albuminu; samo o sobě bývá klinicky přechodné — nebezpečné je, když se přidá i útlum metabolismu.

! Hydrofilní látky mají nízké V_d (zůstávají v krvi a extracelulárně), lipofilní vysoké — proto se u obézního pacienta liší dávkování podle typu léčiva.

O15 Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

VODÁRNA SE DVĚMA SPÁDY — nejdřív strmý (rozvod), pak pozvolný (skutečná eliminace).



CO JE VE SCÉNĚ

1 Cedula s polovinou

Biologický poločas $t_{1/2}$ — doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu. U kinetiky prvního řádu je konstantní a nezávisí na dávce.

2 Strmý spád α

FÁZE α — po i.v. podání klesá koncentrace nejprve strmě, protože se látka rozvádí do tkání (distribuce).

3 Pozvolný spád β

FÁZE β — pozvolný pokles odpovídá skutečné eliminaci; poločas se počítá právě z ní.

4 Kohoutek clearance

CL = objem plazmy zcela očištěný za jednotku času; $CL = CL_{\text{ren}} + CL_{\text{hep}}$. Vztah: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d \div CL$.

5 Čtyři zářezy

Za 4–5 poločasů se dosáhne ustáleného stavu — a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.

6 Konstanta kel

Eliminační konstanta kel — podíl látky odstraněný za jednotku času; $t_{1/2} = 0,693 \div kel$.

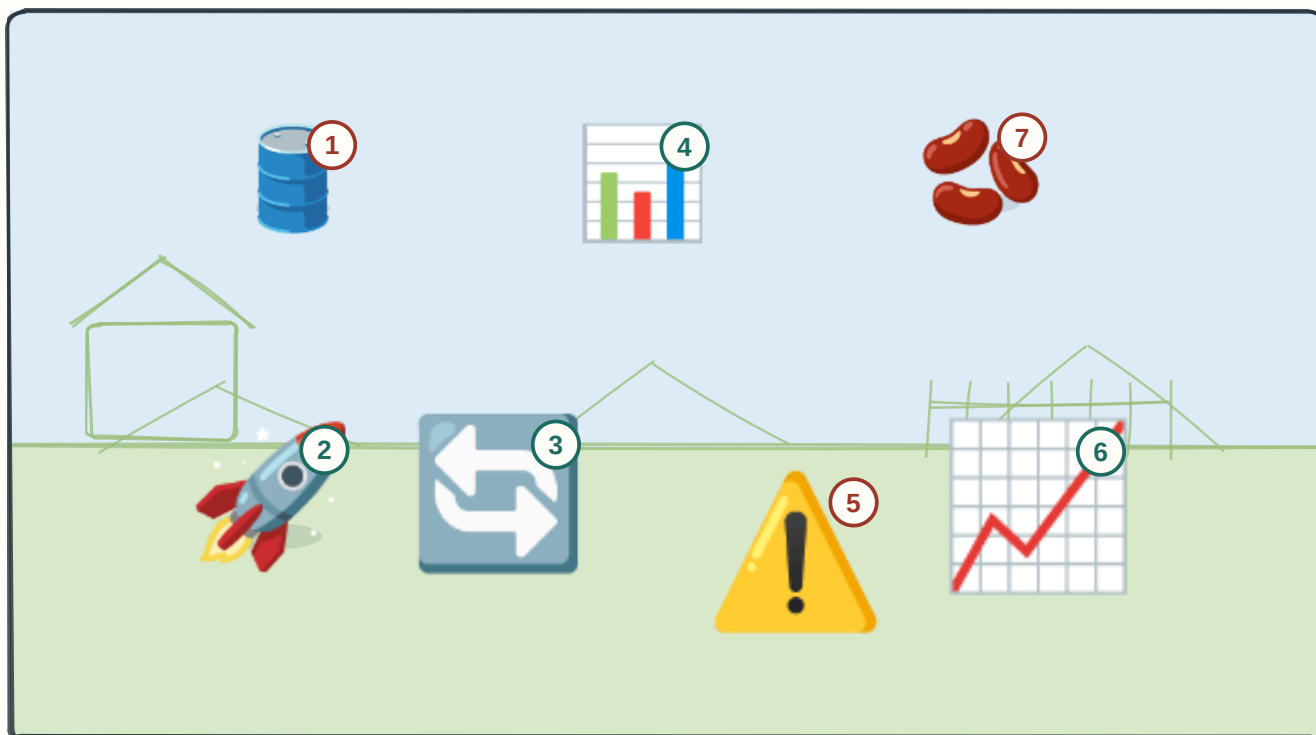
7 Ledvina a játra

Poločas roste, když klesne clearance (jaterní nebo renální selhání) NEBO když stoupne V_d — proto nestačí sledovat jen ledviny.

⚠ Krátký poločas neznamená krátký účinek: ireverzibilní inhibitory (aspirin na COX-1, omeprazol na protonovou pumpu) působí, dokud se neobnoví enzym.

O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

SUD, DO KTERÉHO PŘITÉKÁ RYCHLEJI, NEŽ ODTÉKÁ — tak vzniká kumulace.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Plnící se sud**

KUMULACE nastane, je-li dávkovací interval kratší než doba potřebná k eliminaci; hladina se ustálí po 4–5 poločasech.
- 2 Startovací raketa**

NASYCOVACÍ dávka = $V_d \times \text{cílová koncentrace}$. Podává se, když je poločas dlouhý a nelze čekat 4–5 poločasů na účinek.
- 3 Doplňovací konev**

UDRŽOVACÍ dávka = $CL \times \text{cílová koncentrace} \times \text{interval}$. Nahrazuje to, co se za interval vyloučí.
- 4 Plochá vlnovka**

Krátký interval a malé dávky = plochá, stabilní hladina. Dlouhý interval a velké dávky = větší kolísání mezi vrcholem a údolím.
- 5 Přetékající okraj**

Kolísání je nebezpečné u léčiv s úzkým terapeutickým oknem — proto se u nich volí kratší interval.
- 6 Kumulační index**

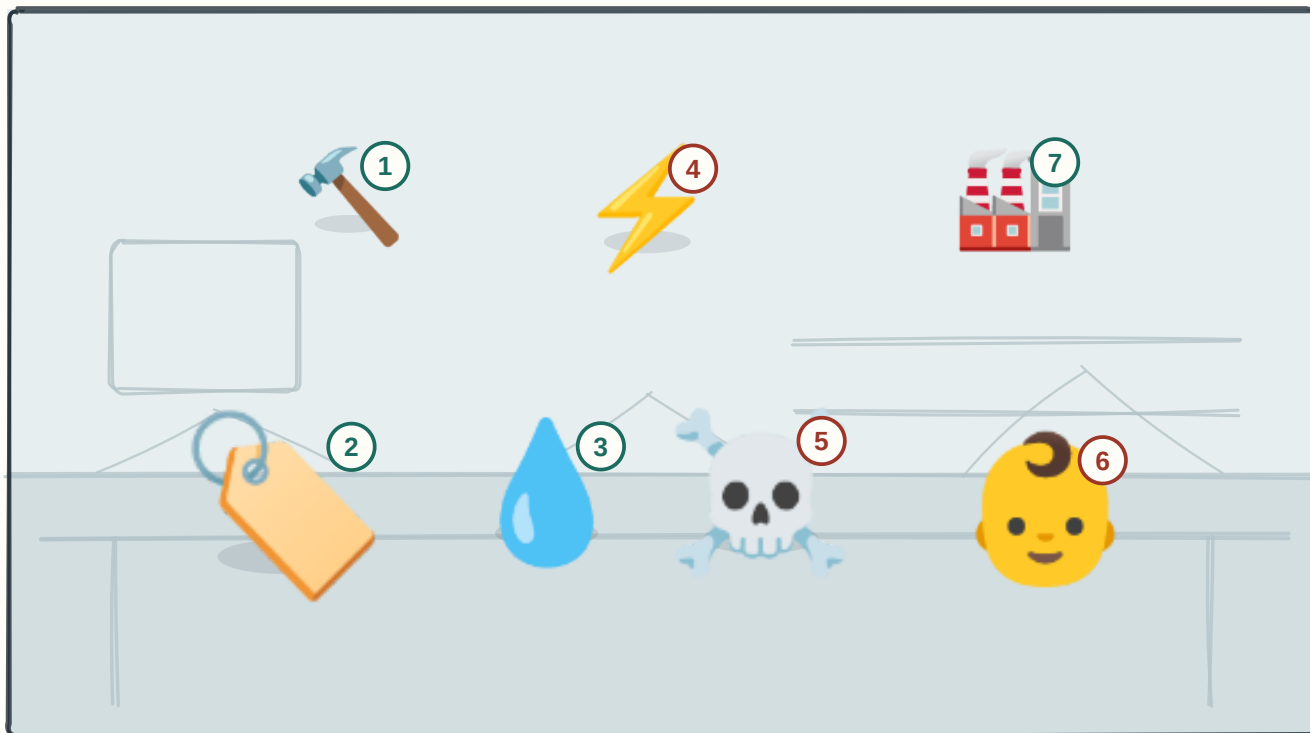
Poměr koncentrace v ustáleném stavu k té po první dávce; udává, kolikrát se hladina nahromadí.
- 7 Zúžený odtok**

Při renální insuficienci se krátí UDRŽOVACÍ dávka (závisí na clearance), ale nasycovací zůstává stejná (závisí na V_d).

! Nasycovací dávka se řídí distribučním objemem, udržovací clearance — proto se u renálního selhání mění jen jedna z nich.

017 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

DÍLNA VE DVOU KROCÍCH — nejdřív KLADIVO rozbije, pak ŠTÍTKOVAČ přilepí velkou vodorozpustnou visačku.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Kladivo I. fáze**

I. FÁZE — oxidace (hlavně cytochromy P450, nejvíc CYP3A4), redukce, hydrolýza. Vzniká reaktivnější metabolit s odhalenou funkční skupinou.
- 2 Štítkovač II. fáze**

II. FÁZE — konjugace: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, vazba na glutathion. Produkt je velký, polární a snadno vyloučitelný.
- 3 Kapka vody**

Smyslem je změnit lipofilní látku na hydrofilní — jinak by se v ledvinách stále zpětně vstřebávala.
- 4 Jiskra aktivace**

PROLÉČIVO se aktivuje až metabolismem: kodein → morfin (CYP2D6), enalapril → enalaprilát, cyklofosamid, klopido-grel.
- 5 Toxický metabolit**

Metabolismus může vytvořit i jed: paracetamol → NAPQI, methanol → kyselina mravenčí („letální syntéza“).
- 6 Novorozenec**

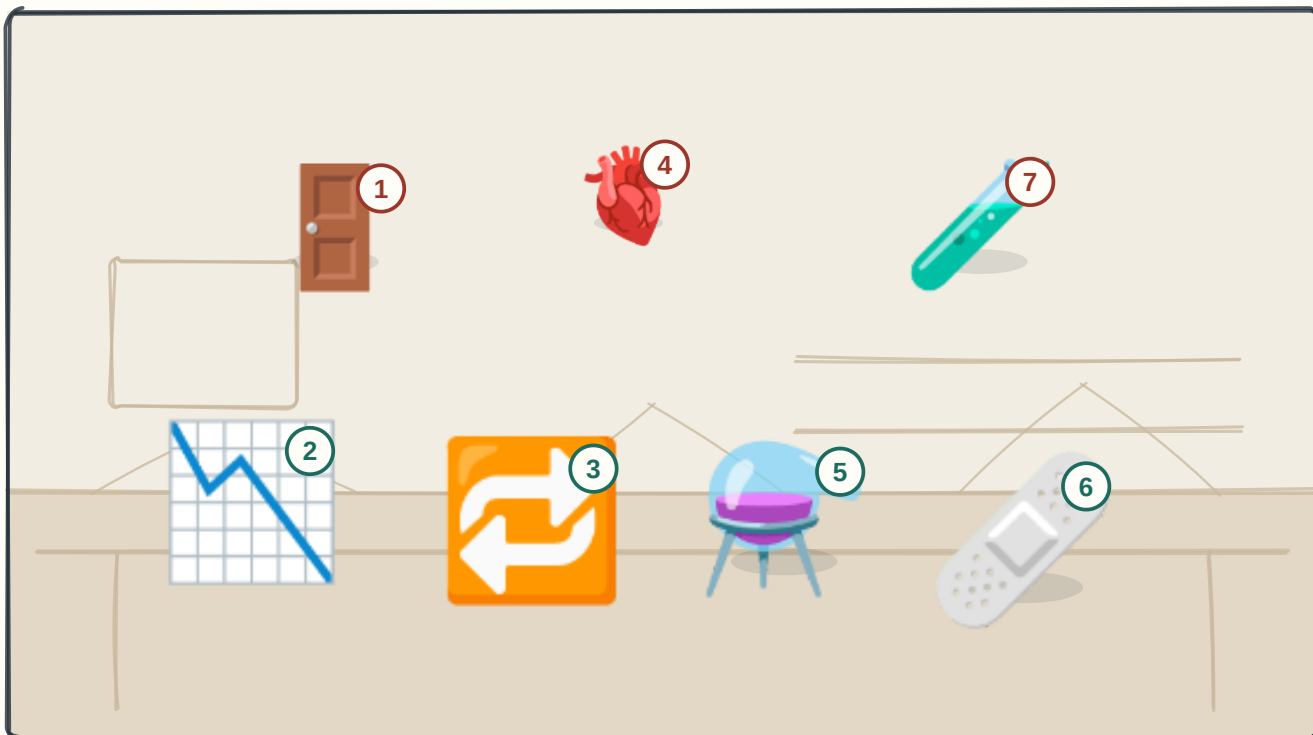
Nezralá glukuronidace u novorozence — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu.
- 7 Jiná pracoviště**

Kromě jater i střevní stěna, plíce, ledviny a plazma (esterázy). U starších klesá hlavně I. fáze, II. zůstává poměrně zachovaná.

⚠ Metabolit není vždy neúčinný — může být účinnější než původní látka, stejně toxický, nebo teprve toxický. Proto se sleduje osud metabolitu, ne jen léčiva.

O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

MĚSTSKÁ BRÁNA S CELNICÍ — všechno ze střeva projde nejdřív játry a zaplatí clo.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Celnice u brány

Vše vstřebané ze střeva projde portální žílou JÁTRY dřív, než se dostane do systémového oběhu — first-pass efekt.

2 Zmenšená zásilka

Silný first-pass mají nitroglycerin, propranolol, morfin, verapamil, lidokain — proto se nitroglycerin podává sublingválně a lidokain se ústy nepodává vůbec.

3 Kruhová cesta

ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH: látka se vyloučí žlučí, ve střevě se uvolní a znovu vstřebá — prodlužuje účinek (kontraceptiva; proto mohou antibiotika jejich účinnost snížit).

4 Pumpa u brány

U léčiv s VYSOKOU jaterní extrakcí limituje eliminaci PRŮTOK játry — při srdečním selhání a šoku hladiny stoupají.

5 Enzymová dílna

U NÍZKÉ extrakce rozhoduje enzymatická kapacita a vazba na bílkoviny, nikoli průtok.

6 Objízdná trasa

Játra obcházejí sublingvální, bukalní, transdermální a parenterální podání; rektální jen zčásti.

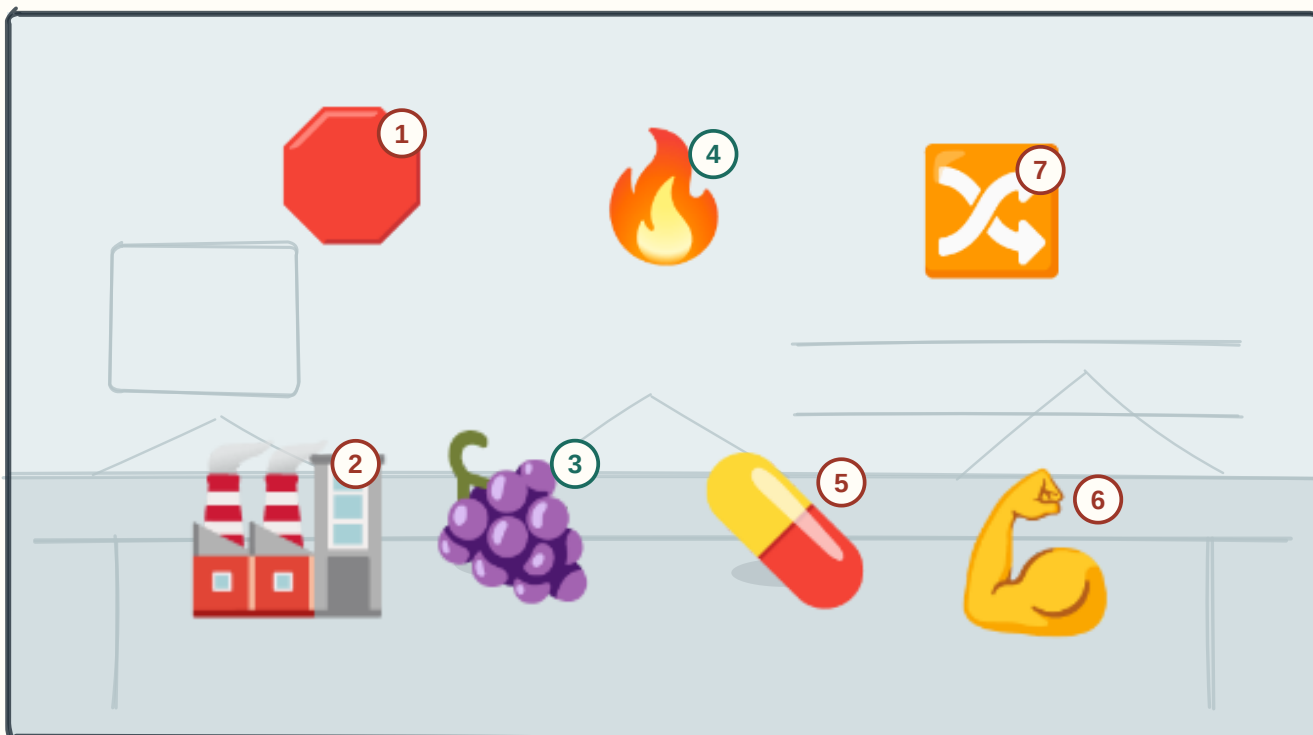
7 Nízký albumin

Při jaterním selhání klesá metabolismus i tvorba albuminu, roste volná frakce a zkratový oběh obchází játra — dávky se snižují.

⚠ Perorální dávka bývá mnohonásobně vyšší než nitrožilní právě kvůli first-pass efektu — záměna cest podání proto může znamenat předávkování.

O19 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

TOVÁRNA A ZÁVORA — závora spadne hned, ale novou halu se stavěl týden.



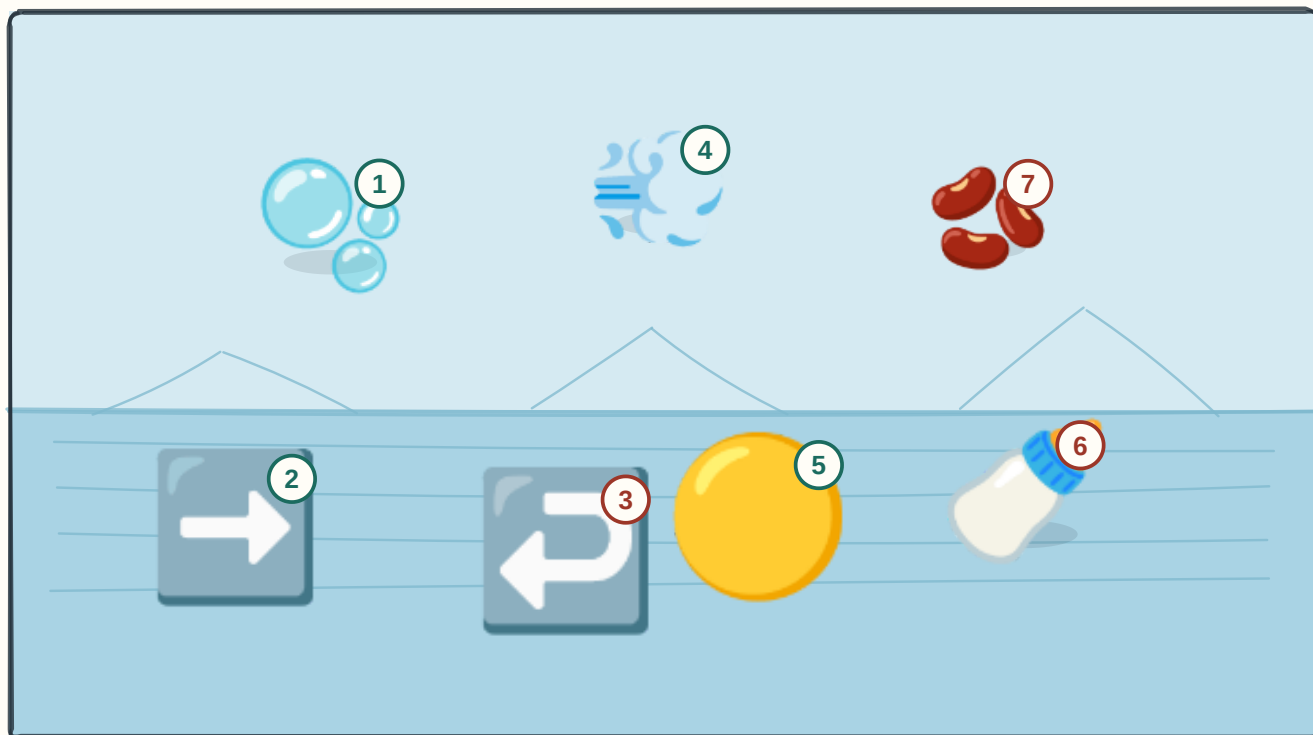
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Spadlá závora**
INHIBICE je RYCHLÁ (hodiny až dny): hladina druhého léčiva stoupá a hrozí TOXICITA.
- 2 Rostoucí továrna**
INDUKCE je POMALÁ (dny až týdny, protože se musí nasyntetizovat nový enzym) a stejně dlouho odeznívá: hladina klesá a LÉČBA SELŽE.
- 3 Grapefruit**
Inhibitory: grapefruitová šťáva, azolová antimykotika, makrolidy (erythromycin, klarithromycin — nikoli azithromycin), ciprofloxacin, verapamil, amiodaron, ritonavir.
- 4 Oheň pod kotlem**
Induktory: rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná; chronicky alkohol a kouření (CYP1A2).
- 5 Selhávající antikoncepce**
Rifampicin snižuje účinnost hormonální kontracepce, warfarinu a antiretrovirotik.
- 6 Bolavý sval**
Klarithromycin se statinem zvýší riziko rabdomyolýzy.
- 7 Obrácená šipka**
U PROLÉČIVA je to obráceně: inhibitor CYP2D6 (fluoxetin, paroxetin) SNÍŽÍ účinek kodeinu a klopidoogrelu, protože zabrání jejich aktivaci.

! Interakce nemizí okamžitě po vysazení induktoru — enzym se odbourává týdny, takže hladina druhého léčiva pak může naopak vyskočit.

O20 Vylučování léčiv renální a extrarenální

ČISTIČKA SE TŘEMI KROKY — filtruje, dopouští a část zase nasává zpátky.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Filtrační síto

GLOMERULÁRNÍ FILTRACE — projde jen VOLNÁ (nenavázaná) frakce; látka vázaná na albumin se nefiltruje.

2 Boční přítok

TUBULÁRNÍ SEKRECE je aktivní transport se společnými přenašeči — proto probenecid zpomaluje vylučování penicilinu (soupeří o týž přenašeč).

3 Zpětné nasávání

ZPĚTNÁ RESORPCE: lipofilní a nenabitě látky se z tubulu vstřebávají zpět. Alkalizace moči bikarbonátem urychlí vyloučení kyselých látek (salicyláty, barbituráty).

4 Výdech

Extrarenálně: plícemi (inhalační anestetika, ethanol — odtud dechová zkouška).

5 Žlučovod

Žlučí a stolicí, s možností enterohepatálního oběhu.

6 Mateřské mléko

Do mléka přechází nejspíš látka lipofilní, málo vázaná na bílkoviny a zásaditá — proto se u kojící ptáme na každý lék.

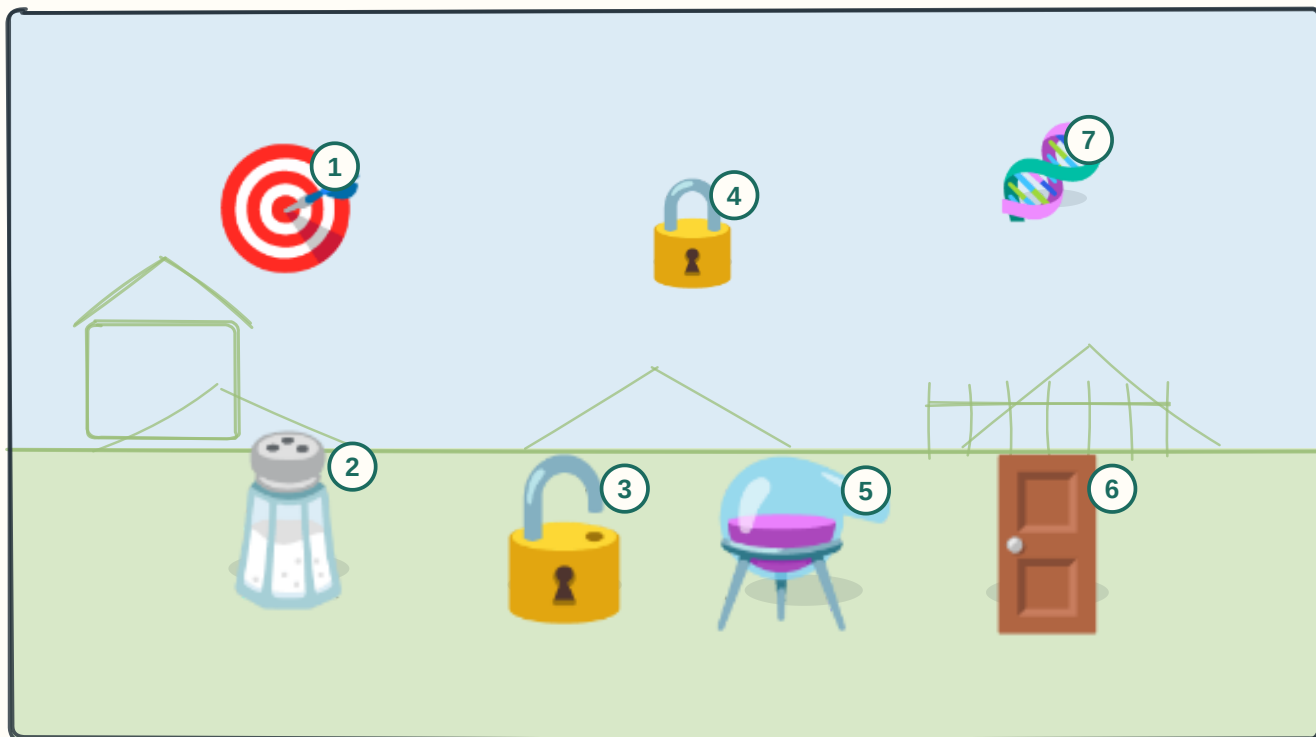
7 Zúžená ledvina

Dávky léčiv vylučovaných ledvinami se snižují podle clearance kreatininu — aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium, mnohá antibiotika.

! Vyloučit se dá jen látka vodorozpustná — proto biotransformace předchází exkreci; lipofilní látka by se v tubulu jen stále vstřebávala zpět.

021 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

STŘELNICE A VEDLE NÍ HROMADA SOLI — buď se trefíš do terče, nebo prostě zabereš místo.



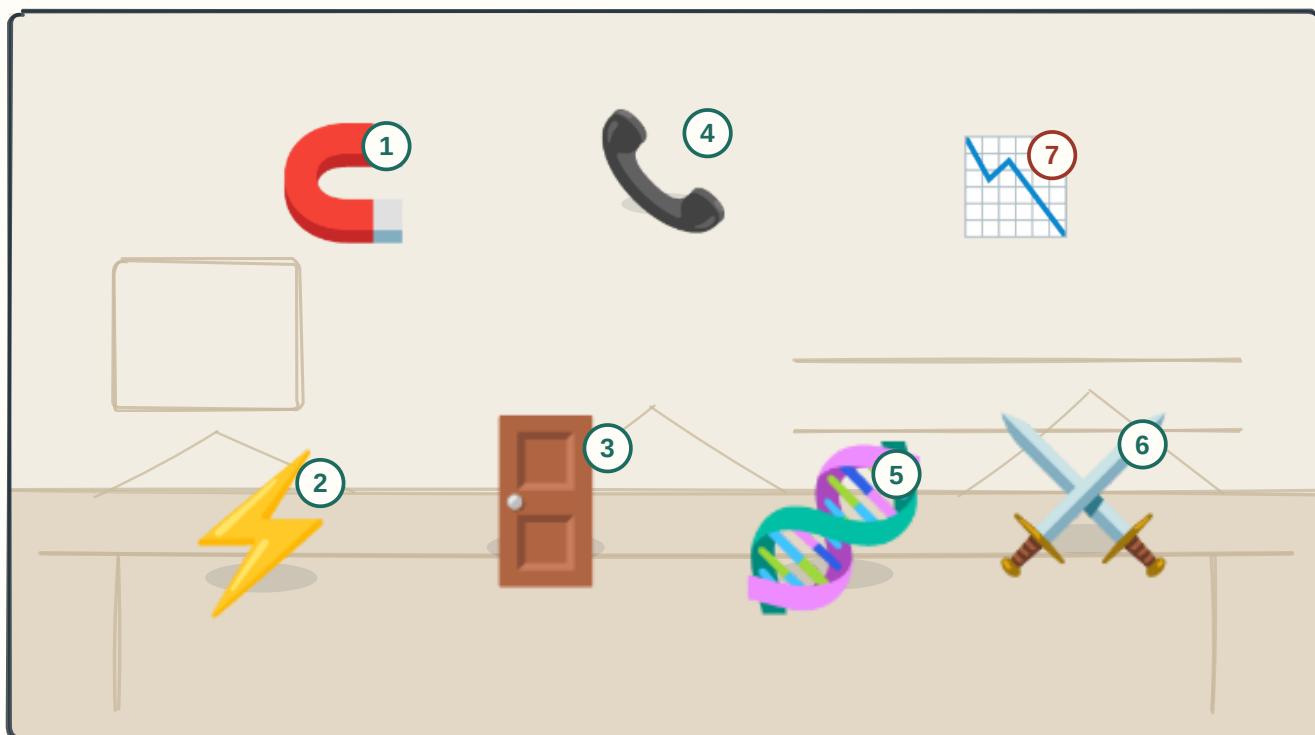
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|--|---|
| <p>① Terč</p> <p>② Hromada soli</p> <p>③ Klíč otvírá zámek</p> <p>④ Klíč v zámku bez otočení</p> <p>⑤ Enzym pod lupou</p> <p>⑥ Iontový kanál</p> <p>⑦ Šroubovice DNA</p> | <p>SPECIFICKÝ účinek — vazba na cílovou strukturu: receptor, enzym, iontový kanál, přenašeč nebo nukleovou kyselinu. Je strukturně závislý a nasycitelný.</p> <p>NESPECIFICKÝ účinek — fyzikálně-chemický, bez cílové struktury: antacida neutralizují kyselinu, osmotická projímadla táhnou vodu, aktivní uhlí adsorbují.</p> <p>AGONISTA se váže a receptor AKTIVUJE (má afinitu i vnitřní aktivitu).</p> <p>ANTAGONISTA se váže, ale neaktivuje (má jen afinitu) — brání navázání agonisty.</p> <p>Enzymy jako cíl: statiny na HMG-CoA-reduktázu, ACE inhibitory, inhibitory protonové pumpy.</p> <p>Kanály a přenašeče: lokální anestetika na sodíkové kanály, blokátory kalciových kanálů, SSRI na serotoninový transportér.</p> <p>Nukleové kyseliny jako cíl: cytostatika, chinolony (topoizomeráza), rifampicin (RNA-polymeráza).</p> |
|--|---|

⚠ Lék nevytváří novou funkci — jen zesiluje nebo zeslabuje děj, který v těle už probíhá. Proto nemá smysl čekat účinek tam, kde cílová struktura chybí.

022 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

ZÁMEČNICTVÍ SE TŘEMI RYCHLOSTMI — milisekundy, sekundy, hodiny.



CO JE VE SCÉNĚ

① Magnet

AFINITA — jak pevně se ligand váže; určuje potřebnou koncentraci.

② Blesk

VNITŘNÍ AKTIVITA — co se po navázání stane. Plný agonista 1, parciální mezi 0 a 1 (buprenorfin), antagonist 0, inverzní agonista pod 0 (H1-antihistaminika).

③ Rychlé dveře

IONOTROPNÍ receptory jsou samy iontovým kanálem — účinek za MILISEKUNDY: nikotinový acetylcholinový, GABA-A, NMDA.

④ Telefon s ústřednou

METABOTROPNÍ receptory jdou přes G-protein a druhého posla — účinek za SEKUNDY: muskarinové, adrenergní, opioidní.

⑤ Jádru buňky

NITROBUNĚČNÉ (jaderné) receptory mění přepis genů — účinek za HODINY až DNY: kortikosteroidy, hormony štítné žlázy, pohlavní hormony.

⑥ Přetlačovaná o zámek

KOMPETITIVNÍ antagonismus je překonatelný vyšší dávkou agonisty (posun křivky doprava); NEKOMPETITIVNÍ nepřekonatelný (snižuje maximum).

⑦ Ubývající zámky

DOWN-REGULACE při trvalé stimulaci vysvětluje toleranci; UP-REGULACE při dlouhé bloádě vysvětluje rebound po náhlém vysazení β -blokátoru.

⚠ Pomalý nástup kortikoidů není vlastnost lékové formy, ale mechanismu — musí proběhnout přepis genů a syntéza bílkovin.

O23 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

ÚZKÉ OKNO NAD PROPASTÍ — pod ním „nefunguje“, nad ním „škodí“.



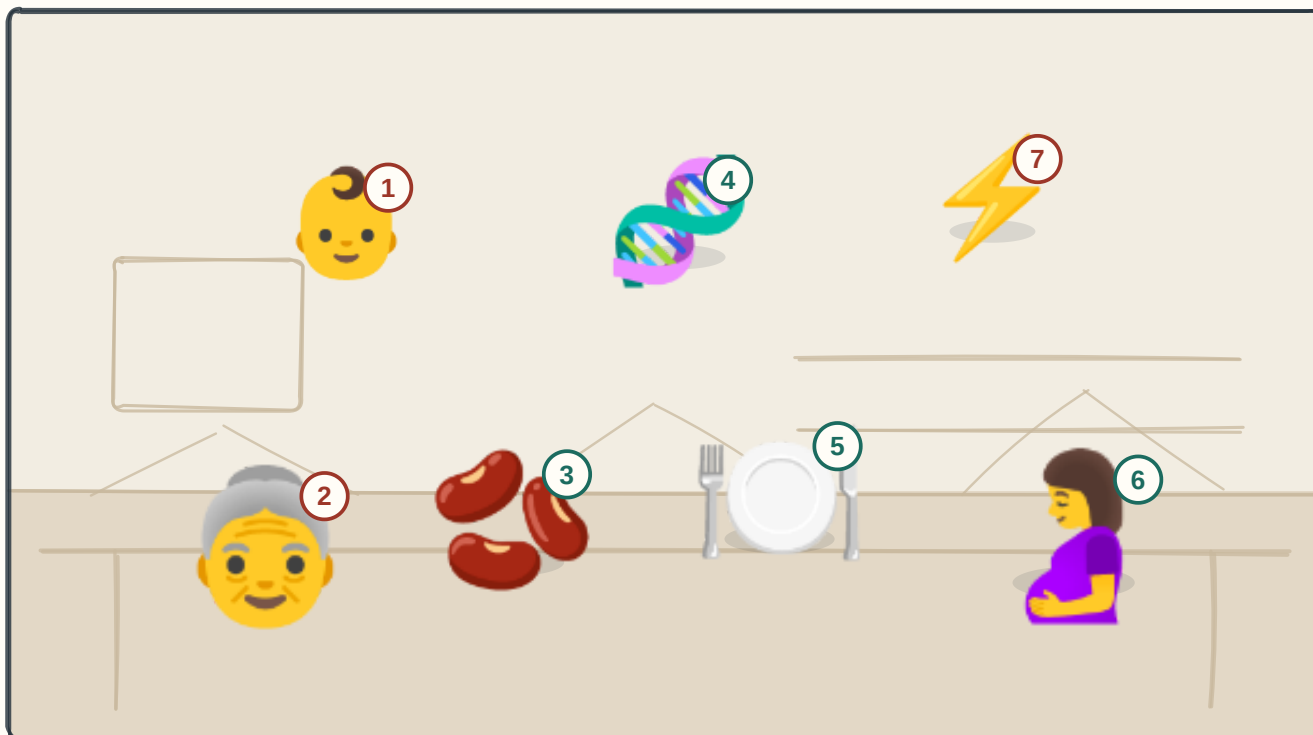
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Úzké okno
TERAPEUTICKÉ OKNO — rozmezí koncentrací mezi minimální účinnou a toxickou.
- 2 Pravítko
TERAPEUTICKÝ INDEX $TI = TD50 \div ED50$ (u zvířat $LD50 \div ED50$). $ED50$ = dávka účinná u poloviny, $TD50$ = toxická u poloviny, $LD50$ = smrtelná pro polovinu.
- 3 Fonendoskop a odběr
Úzký index mají digoxin, warfarin, theofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, cyklosporin — u nich se MĚŘÍ plazmatické hladiny.
- 4 Číslice NNT
NNT — kolik pacientů je třeba léčit, aby se u jednoho zabránilo příhodě; nízké NNT = účinná léčba. Obdobně NNH pro poškození.
- 5 Esovité křivky
Vztah dávky a účinku je sigmoidní (v logaritmickém měřítku).
- 6 Silák
ÚČINNOST (efficacy) = jak vysokého maxima lék dosáhne.
- 7 Malá tableta
POTENCE = jak malá dávka k tomu stačí. Potentnější lék NENÍ lepší lék — rozhoduje maximální účinek a bezpečnost.

⚠ Riziko se vždy váží proti prospěchu: u onkologické léčby se přijímá terapeutický index, který by u léku na rýmu byl nepřijatelný.

O24 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

STEJNÁ DÁVKA, SEDM RŮZNÝCH LIDÍ — a u každého jiný výsledek.

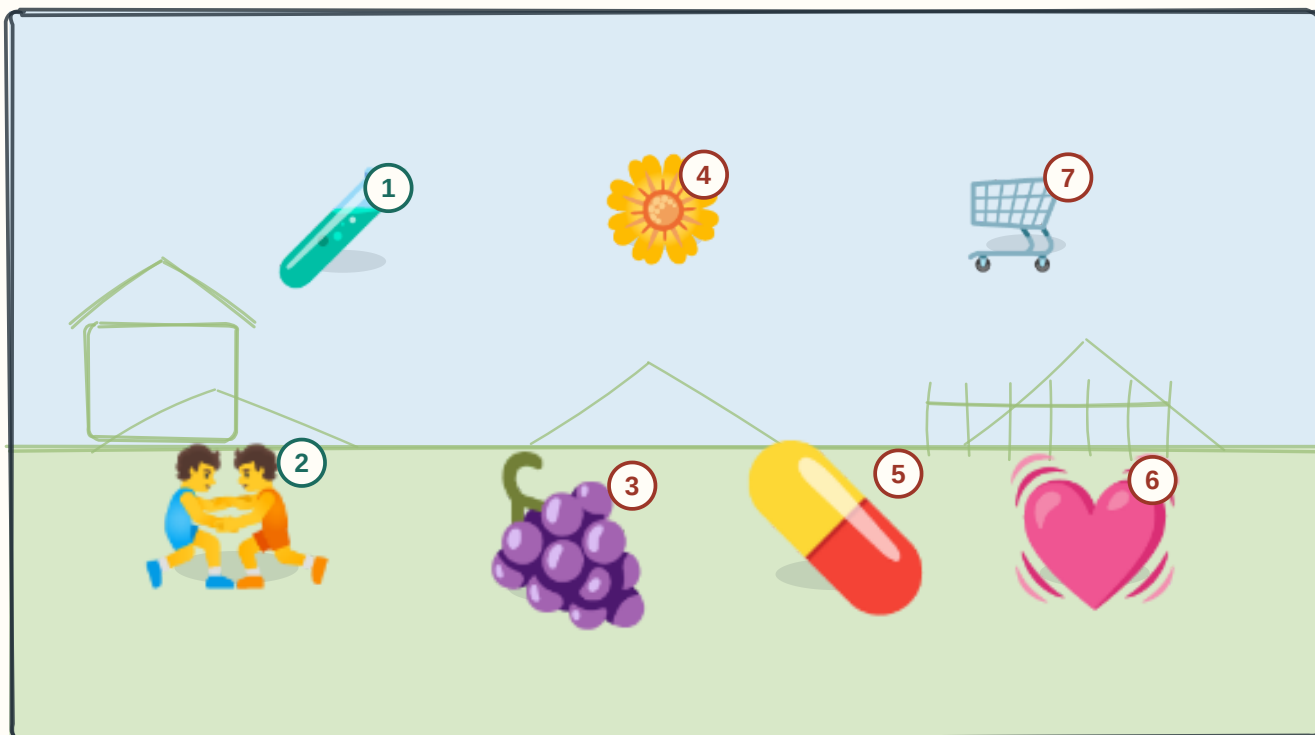


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Novorozenec**
Nezralá glukuronidace, vyšší podíl tělesné vody, nižší vazba na bílkoviny a nezralá glomerulární filtrace.
- 2 **Seniorka**
Nižší glomerulární filtrace, nižší albumin, méně svaloviny a více tuku (lipofilní léčiva se hromadí), vyšší citlivost CNS.
- 3 **Ledvina a játra**
Jaterní selhání snižuje metabolismus a tvorbu albuminu; renální insuficience zpomaluje vylučování. U obojího se dávky snižují.
- 4 **Šroubovice**
Polymorfismus CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2, TPMT rozhoduje, zda je člověk pomalý, nebo ultrarychlý metabolizátor.
- 5 **Talíř s jídlem**
Jídlo mění vstřebávání (mléko a antacida váží tetracykliny), grapefruit inhibuje CYP3A4, kouření indukuje CYP1A2 (theofylin, klozapin, olanzapin).
- 6 **Těhotná**
Roste objem distribuce a glomerulární filtrace, klesá albumin — a přibývá otázka, co projde placentou.
- 7 **Změněná citlivost**
Mění se i DYNAMIKA: u seniorů vyšší citlivost na benzodiazepiny a opioidy, při hypokalemii vyšší toxicita digoxinu.

! Kinetika i dynamika se mění současně — proto nestačí přepočítat dávku podle hmotnosti, ale je nutné počítat i s jinou odpovědí cílové struktury.

PŘETAHOVANÁ NA DVOU LANECH — na jednom se pere o hladinu, na druhém o účinek.



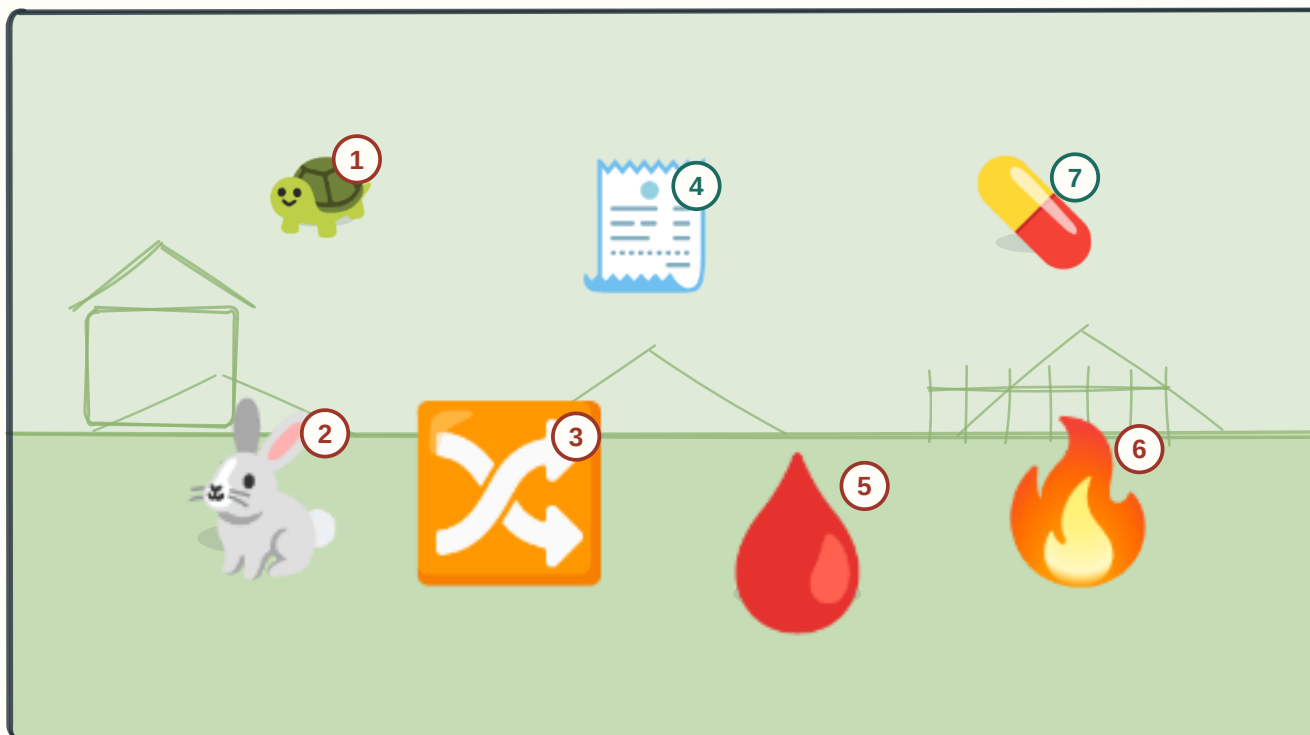
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Lano kinetické**
 FARMAKOKINETICKÉ interakce: vstřebávání (antacida a železo váží tetracykliny a chinolony), vazba na bílkoviny, metabolismus (inhibice a indukce CYP450), vylučování (probenecid a penicilin).
- 2 Lano dynamické**
 FARMAKODYNAMICKÉ interakce: synergie (alkohol + benzodiazepiny = útlum dechu; ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum = hyperkalemie) nebo antagonismus (β-blokátor ruší β2-agonistu u astmatu).
- 3 Grapefruit**
 Inhibuje střevní CYP3A4 → prudce zvýší hladinu statinů, blokátorů kalciových kanálů a imunosupresiv.
- 4 Třezalka**
 Silný induktor CYP3A4 a P-glykoproteinu → sníží účinnost kontracepce, warfarinu, cyklosporinu, digoxinu a antiretrovirotik.
- 5 Warfarin uprostřed**
 Nejrizikovější dvojice: warfarin s čímkoli · statin s makrolidem nebo azolem · NSA s antikoagulanciem.
- 6 Prodloužené QT**
 Látky prodlužující QT se sčítají: antiarytmika III. třídy, makrolidy, chinolony, antipsychotika, ondansetron.
- 7 Nákupní taška**
 Nejvíce interakcí nevzniká z léků na předpis, ale z toho, co pacient nehlásí: volně prodejné NSA, doplňky stravy a bylinky.

! Serotonergní léčiva se také sčítají — SSRI, IMAO, tramadol, triptany a linezolid mohou spolu vyvolat serotoninový syndrom.

O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

ZÁVOD ŽELVY A ZAJÍCE — stejná dávka, ale jeden ji odbourává pomalu a druhý bleskem.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Želva**

POMALÝ metabolizátor odbourává léčivo pomalu — hladina stoupá a hrozí TOXICITA (CYP2D6 a antidepresiva, CYP2C9 a warfarin).
- 2 Zajíc**

ULTRARYCHLÝ metabolizátor odbourá léčivo dřív, než stačí zabrat — LÉČBA SELHÁVÁ.
- 3 Obrácená cedule**

U PROLÉČIVA je to naopak: ultrarychlý CYP2D6 vytvoří z kodeinu nebezpečně mnoho morfinu, pomalý nemá z kodeinu ani z klopidoogrelu žádný účinek.
- 4 Laboratorní výsledek**

Testuje se HLA-B*5701 před abakavirem, HLA-B*5801 před allopurinolem, TPMT před azathioprinem a 6-merkaptopurinem, G6PD před primachinem a sulfonamidy.
- 5 Prasklý erytrocyt**

Deficit G6PD vede k HEMOLÝZE po primachinu, sulfonamidech a nitrofurantoinu.
- 6 Horečka na sále**

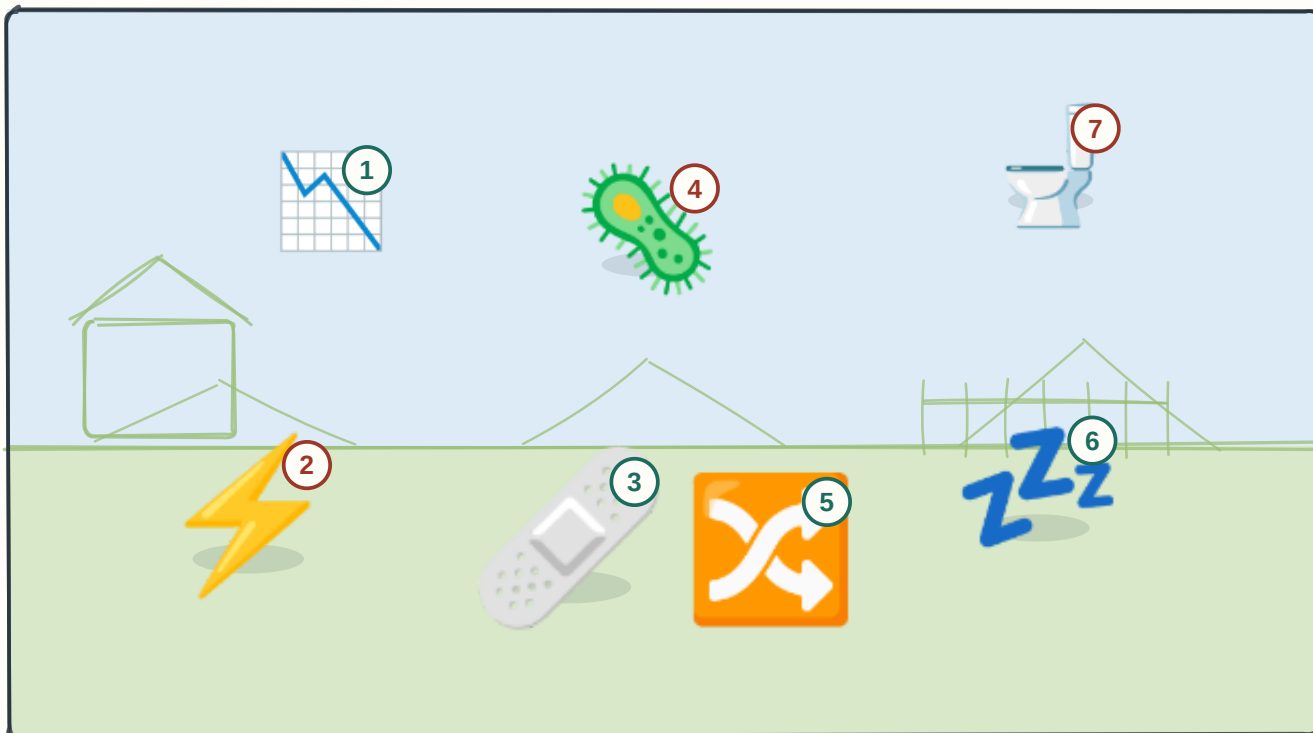
MALIGNÍ HYPERTERMIE po sukcinylcholinu a halogenovaných anestetikách — geneticky podmíněná idiosynkrazie; antidotem dantrolen.
- 7 Isoniazid**

NAT2 určuje rychlost acetylace izoniazidu — pomalí acetylátoři mají vyšší riziko neuropatie.

! Farmakogenetika vysvětluje idiosynkrazii — neobvyklou reakci, která nesouvisí s dávkou ani s mechanismem účinku a není imunitně podmíněná.

027 Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

TŘI RŮZNÉ DĚJE, KTERÉ SE PLETOU — pomalé slábnutí, bleskové vyčerpání a obrana bakterie.



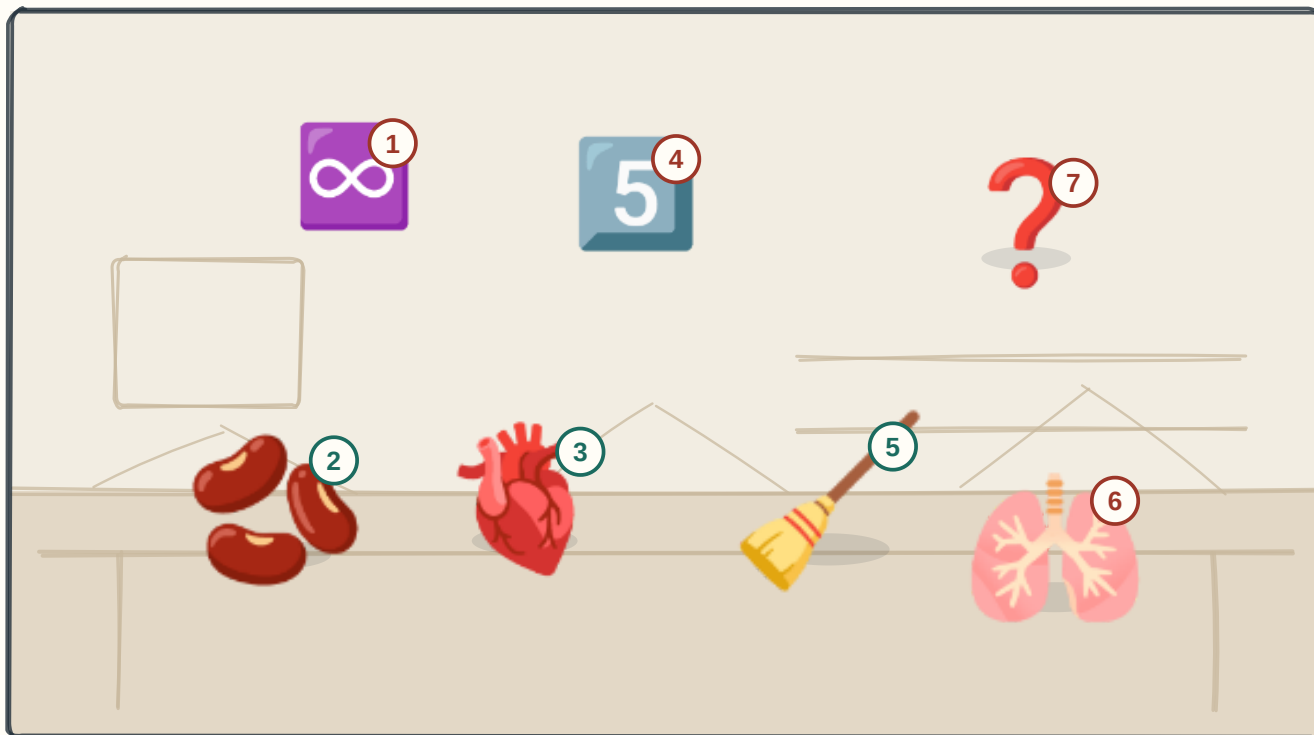
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Pomalu klesající křivka**
TOLERANCE — na týž účinek je třeba stále vyšší dávka; buduje se dny až týdny. Farmakodynamická (down-regulace receptorů) nebo farmakokinetická (indukce vlastního metabolismu — barbituráty).
- 2 Vybitá baterie**
TACHYFYLAXE — velmi rychlý pokles účinku při opakovaném podání v krátkém sledu, typicky vyčerpáním zásoby mediátoru (efedrin). ZVÝŠENÍ DÁVKY NEPOMŮŽE.
- 3 Náplast sundaná na noc**
Tachyfylaxe vzniká i u nitrátů — proto se ponechává noční interval bez nitrátu.
- 4 Bakterie za štítem**
REZISTENCE je vlastnost MIKROORGANISMU, ne pacienta — primární (přirozená) nebo získaná (mutace, přenos plazmidu). Neplet' si ji s tolerancí.
- 5 Zkřížené šipky**
ZKŘÍŽENÁ TOLERANCE existuje mezi látkami se stejným mechanismem — alkohol, benzodiazepiny a barbituráty; morfin a ostatní opioidy.
- 6 Spící pacient**
U opioidů roste tolerance rychle na euforii a útlum dechu.
- 7 Zácpa, která zůstává**
Na zácpu a miózu po opioidech tolerance prakticky nevzniká — proto se laxativum podává po celou dobu léčby.

⚠ Tolerance na různé účinky téže látky se vyvíjí různě rychle — proto pacient s tolerancí na útlum dechu může být stále ohrožen zácpou a miózou.

O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

LÉKÁRNIČKA, KTERÁ SE SAMA PLNÍ — každý nový lék léčí nežádoucí účinek předchozího.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Nekonečná smyčka

PRESKRIPTČNÍ KASKÁDA: metoklopramid vyvolá parkinsonské projevy → nasadí se antiparkinsonikum. Blokátor kalciových kanálů vyvolá otoky → nasadí se diuretikum.

2 Zúžená ledvina

Renální insuficience — snížit dávku léčiv vylučovaných ledvinami (aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium).

3 Slabé srdce

Srdeční selhání snižuje průtok játry i ledvinami; u léčiv s vysokou jaterní extrakcí hladina stoupá.

4 Pět krabiček

POLYPRAGMAZIE — zpravidla 5 a více léčiv současně; roste riziko interakcí, pádů, hospitalizací a klesá adherence.

5 Koště

DEPRESKRIPTCE — plánované vysazení léků, které už nepřinášejí užitek; u polymorbidních stejně důležitá jako nasazení.

6 Astmatik s β -blokátozem

Kontraindikace bývají dané přidruženou chorobou: β -blokátor u astmatu, NSA u renální insuficience a vředové choroby, metformin při riziku laktátové acidózy.

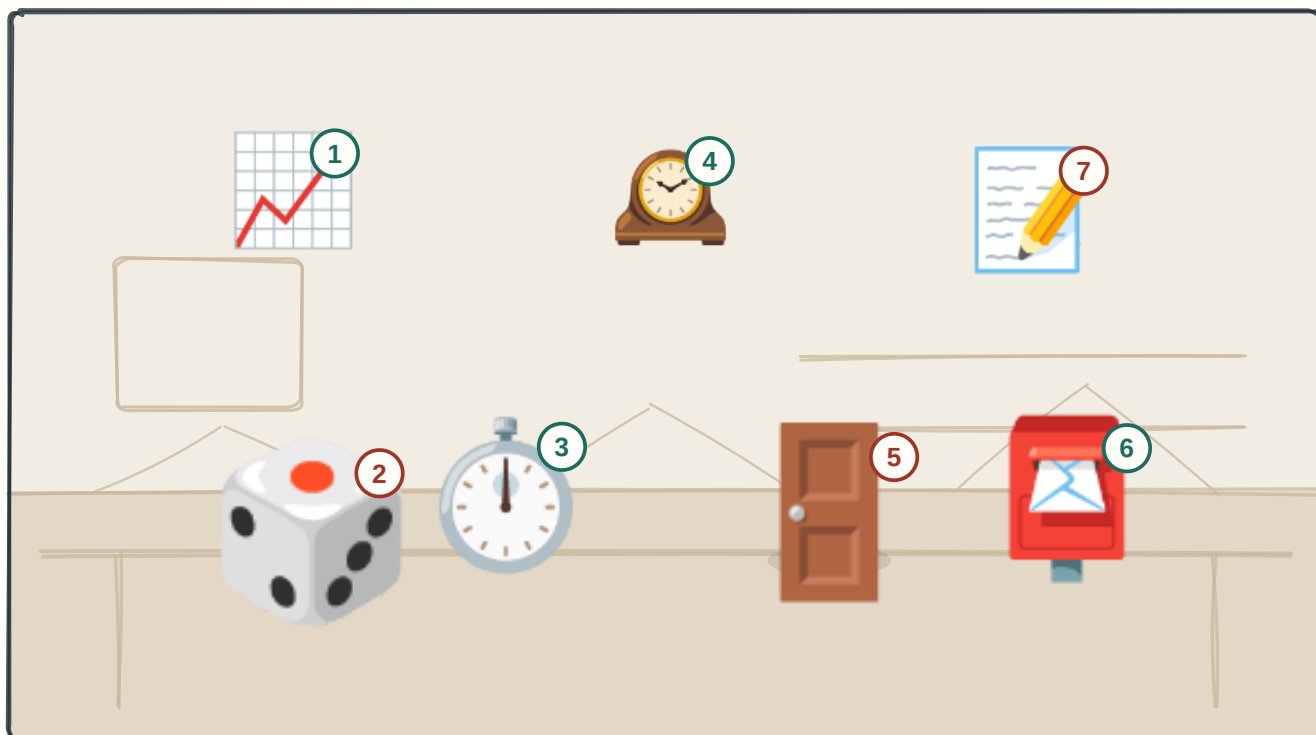
7 Otazník nad novým příznakem

Nový příznak je nežádoucí účinek léku, dokud se neprokáže opak — teprve pak se hledá nová diagnóza.

⚠ Polypragmazie není jen počet léků, ale i jejich vzájemná zbytečnost — cílem je nejmenší počet léčiv, který splní léčebný záměr.

029 Nežádoucí účinky léčiv

DVĚ ŠUPLÍKY: „ČEKANÝ“ A „BIZARNÍ“ — v prvním se dávka snižuje, ve druhém se lék už nikdy nepodává.

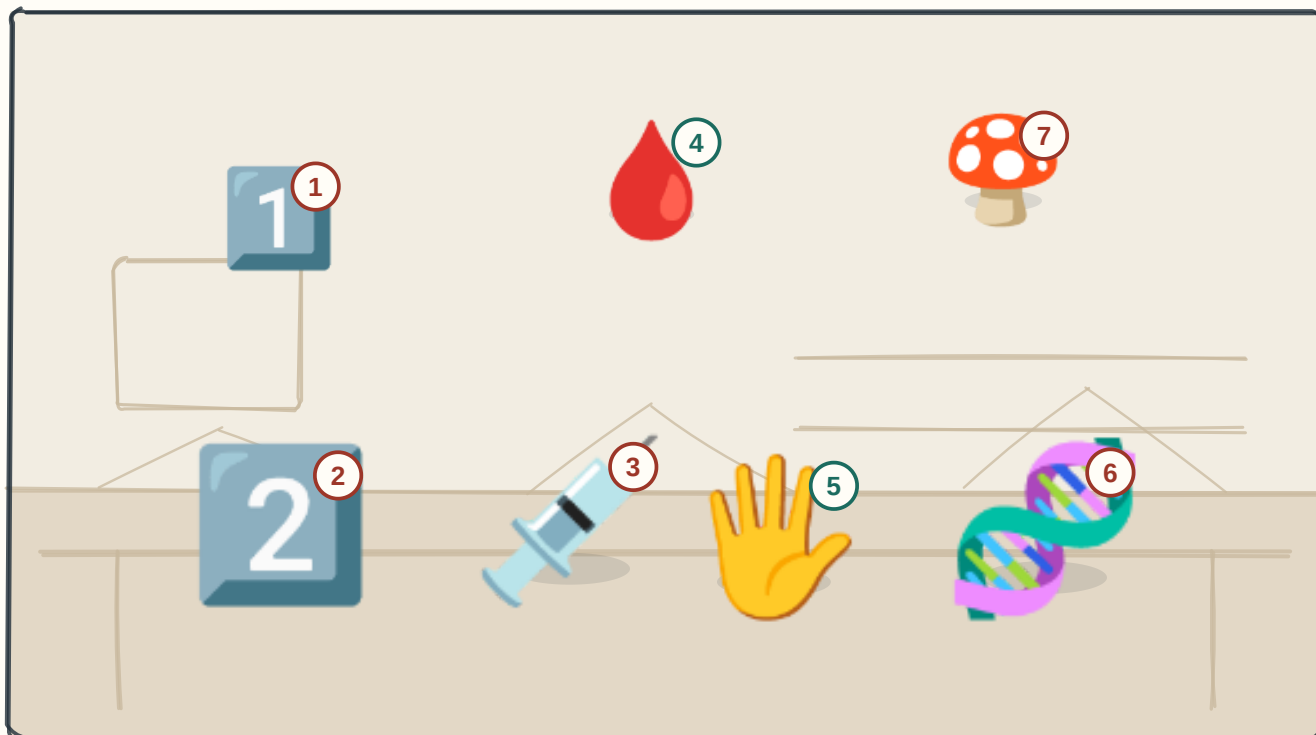


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Šuplík A**
TYP A (Augmented) — zesílený farmakologický účinek: závisí na dávce, je předvídatelný a častý. Krvácení po warfarinu, hypoglykemie po inzulínu, bradykardie po β -blokátoru. Řeší se snížením dávky.
- 2 Šuplík B s kostkou**
TYP B (Bizarre) — nesouvisí s dávkou ani s mechanismem, nedá se předvídat; vzácný, ale často závažný. Alergie, aplastická anémie po chloramfenikolu, maligní hypertermie, Stevensův–Johnsonův syndrom.
- 3 Hodiny**
TYP C — chronický, při dlouhém podávání (osteoporóza po kortikoidech).
- 4 Staré hodiny**
TYP D — pozdní: teratogenita, kancerogenita.
- 5 Bouchnuté dveře**
TYP E — po náhlém vysazení: rebound hypertenze, adrenální insuficience, rebound nespavost.
- 6 Schránka hlášení**
Podezření se hlásí SÚKL; u nově registrovaných léčiv (černý trojúhelník) i podezření běžná — právě tak se odhalí to, co ve fázi III nevyšlo najevo.
- 7 Zápis do dokumentace**
Typ B znamená lék vysadit, už nikdy nepodat a poznamenat do dokumentace.

⚠ Rozdělení A/B rozhoduje o postupu: typ A se řeší dávkou, typ B vysazením — proto je nutné je odlišit dřív, než se sáhne po úpravě dávkování.

DVĚ SETKÁNÍ — první je tiché, druhé bouřlivé. Bez prvního nikdy nepřijde druhé.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Tiché první setkání**
SENZIBILIZACE probíhá BEZ příznaků — proto reakce nikdy nepřijde při úplně prvním podání.
- 2 Bouřlivé druhé setkání**
TYP I (IgE, časný) — kopřivka, angioedém, bronchospasmus, ANAFYLAXE během minut.
- 3 Adrenalinové pero**
U anafylaxe je lékem první volby ADRENALIN INTRAMUSKULÁRNĚ do stehna; antihistaminika a kortikosteroidy jsou jen doplňkové a působí příliš pomalu.
- 4 Typ II a III**
Typ II cytotoxický, typ III imunokomplexový (sérová nemoc).
- 5 Ekzém na ruce**
Typ IV pozdní buněčný — kontaktní ekzém, makulopapulózní exantém za dny.
- 6 Idiosynkrazie**
Geneticky podmíněná neobvyklá reakce BEZ účasti imunity — hemolýza při deficitu G6PD, maligní hypertermie po sukcinylcholinu, prodloužená apnoe při atypické pseudocholinesteráze.
- 7 Ampicilin u mononukleózy**
Exantém po ampicilinu u infekční mononukleózy NENÍ alergie — a nesmí se tak zapsat.

⚠ Nausea po antibiotiku není alergie, ale nesnášenlivost — přesto se často zapisuje jako alergie a pacient pak zbytečně přijde o celou lékovou skupinu.

031 Karcinogenní a mutagenní účinky

DLOUHÝ STÍN — mutagen poškodí DNA dnes, nádor vyroste za dvacet let.



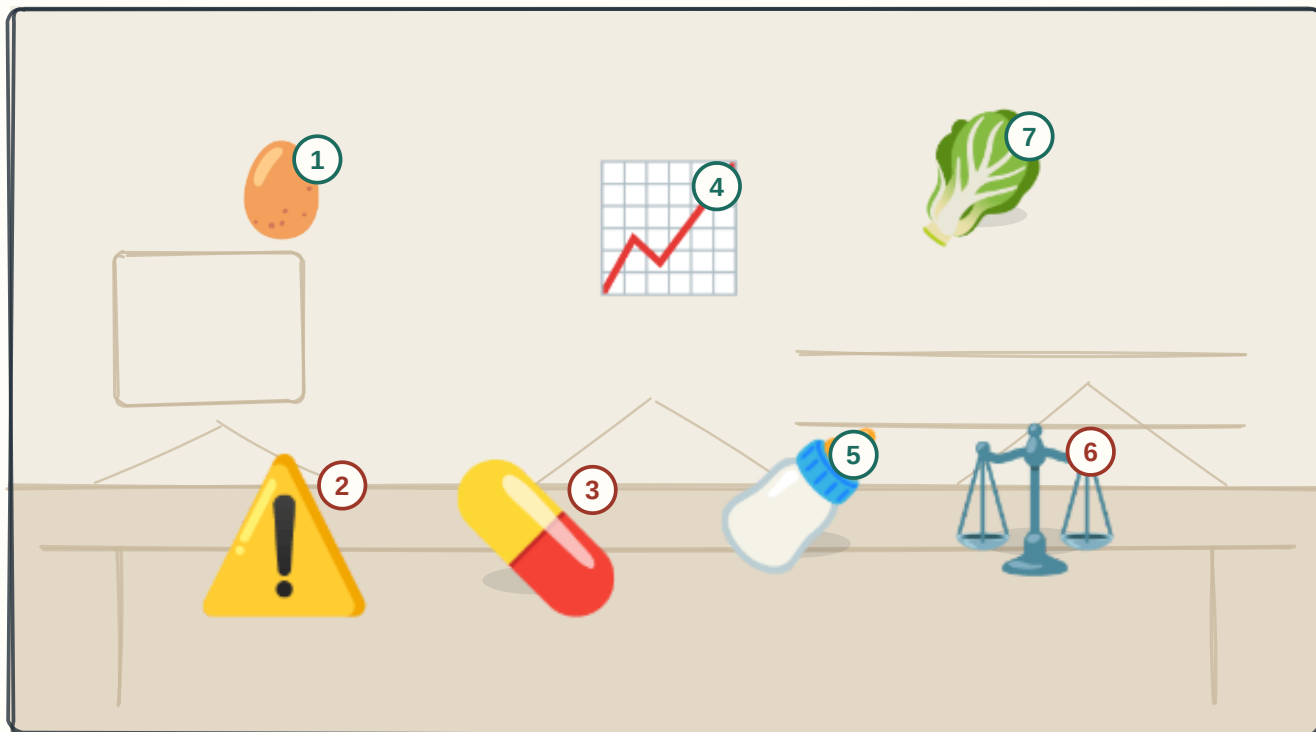
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Zlomená šroubovice**
MUTAGENITA — poškození genetické informace: genové mutace, chromozomové aberace, změny počtu chromozomů. V zárodečných buňkách se přenáší na potomstvo.
- 2 Nádor**
KARCINOGENEZE má fáze INICIACE (nevratné poškození DNA), PROMOCE (podpora množení poškozeného klonu) a PROGRESE.
- 3 Dlouhé přesýpací hodiny**
Latence je roky až desetiletí — proto se karcinogenita odhalí až po letech užívání a žádná registrační studie ji nezachytí.
- 4 Amesův test**
Testuje se předklinicky: Amesův test (mutagenita na bakteriích), testy chromozomových aberací, dlouhodobé studie na hlodavcích.
- 5 Cytostatikum**
Alkylační látky vyvolávají sekundární leukemie — lék na nádor zvyšuje riziko nádoru druhého.
- 6 Imunosuprese**
Imunosupresiva zvyšují výskyt lymfomů a kožních nádorů.
- 7 Cigareta**
Genotoxické karcinogeny nemají bezpečnou dávku; negenotoxické (hormonální, imunosupresivní) působí nepřímo — estrogeny bez gestagenu a karcinom endometria.

! To, že lék léčí nádor a zároveň zvyšuje riziko jiného, není rozpor — je to poměr rizika a prospěchu, který se váží u každého pacienta zvlášť.

032 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

KALENDÁŘ TĚHOTENSTVÍ — nejnebezpečnější je 3.–8. TÝDEN, kdy žena často ještě neví, že je těhotná.

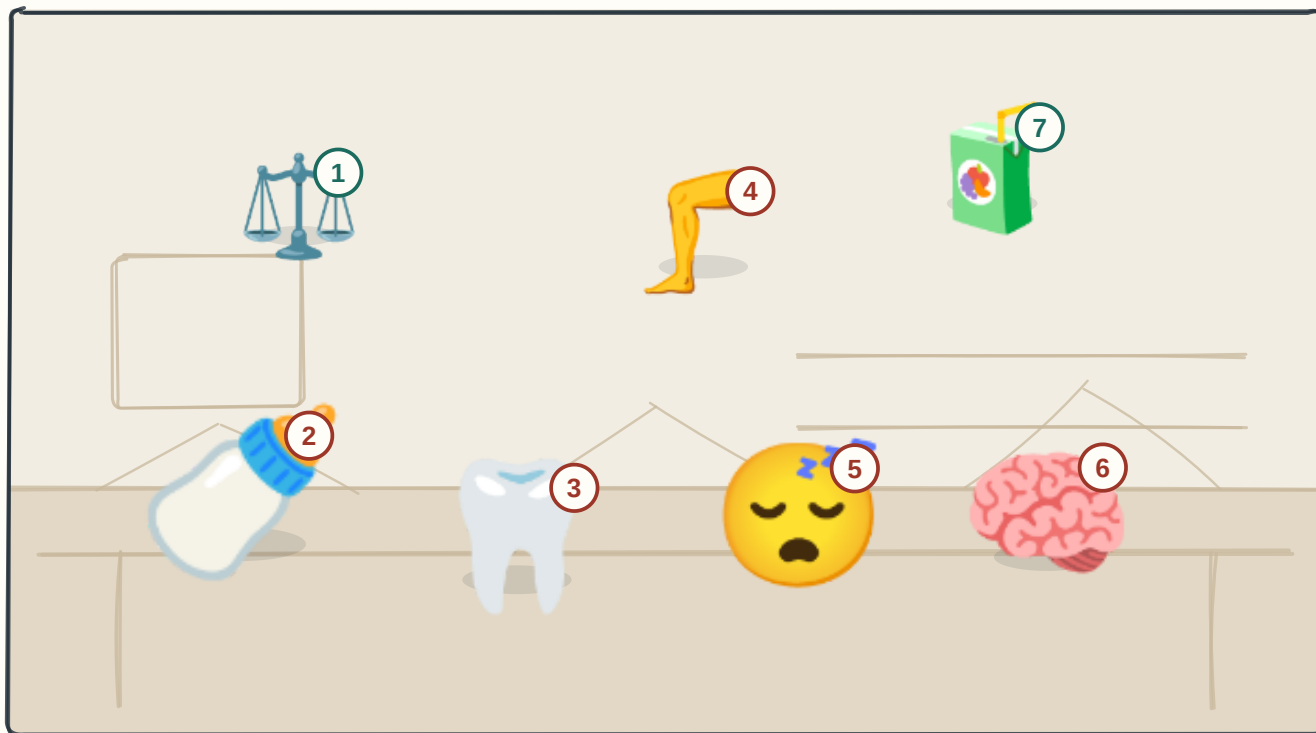


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Vajíčko**
0.–2. TÝDEN — pravidlo „všechno, nebo nic“: buď zárodek zanikne, nebo se poškození plně opraví.
- 2 Červené pole na kalendáři**
3.–8. TÝDEN — ORGANOGENEZE, období největšího rizika strukturních vad.
- 3 Seznam teratogenů**
Isotretinoin a retinoidy, thalidomid, warfarin, valproát, karbamazepin, fenytoin, metotrexát, mykofenolát, ACE inhibitory a sartany, tetracykliny, živé vakcíny, inhibitory 5- α -reduktázy.
- 4 Rostoucí plod**
Od 9. týdne vznikají FUNKČNÍ poruchy a poruchy růstu: ACE inhibitory poškozují ledviny plodu, NSA předčasně uzavírají ductus arteriosus, tetracykliny barví zuby.
- 5 Kojení**
Do mléka přechází nejspíš látka lipofilní, málo vázaná na bílkoviny a zásaditá. Podává se ihned PO kojení. Kontraindikovány jsou cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron.
- 6 Váhy rizika**
Neléčená nemoc matky (epilepsie, astma, těžká deprese, infekce) ohrožuje plod často víc než lék — neléčí se „nulovým rizikem“, ale poměrem rizika a prospěchu.
- 7 Kyselina listová**
Podává se preventivně už před početím jako prevence rozštěpů neurální trubice; u žen na antiepileptikách ve vyšší dávce.

⚠ Bezpečnost v graviditě se nedá odvodit z toho, že je lék volně prodejný — NSA jsou ve třetím trimestru kontraindikované, přestože je má doma každý.

DĚTSKÁ ORDINACE S VÁHAMI — dítě není zmenšený dospělý, dává se na KILOGRAM.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Váhy

Dávkuje se na kilogram tělesné hmotnosti, u cytostatik na plochu povrchu těla — nikdy „zlomkem dávky dospělého“ od oka.

2 Kojenec

Novorozenec má nezralou glukuronidaci (gray baby syndrom po chloramfenikolu), vyšší podíl tělesné vody, nižší vazbu na bílkoviny a nezralou glomerulární filtraci.

3 Obarvený zub

Tetracykliny do 8 let — zbarvení zubů a hypoplazie skloviny.

4 Poškozená chrupavka

Chinolony u dětí poškozují chrupavku.

5 Kodein

Kodein a tramadol — útlum dechu u ultrarychlých metabolizátorů CYP2D6; u dětí kontraindikované.

6 Reyeův syndrom

Kyselina acetylsalicylová u dítěte s horečnatým virovým onemocněním — Reyeův syndrom. Antipyretiky volby jsou paracetamol a ibuprofen.

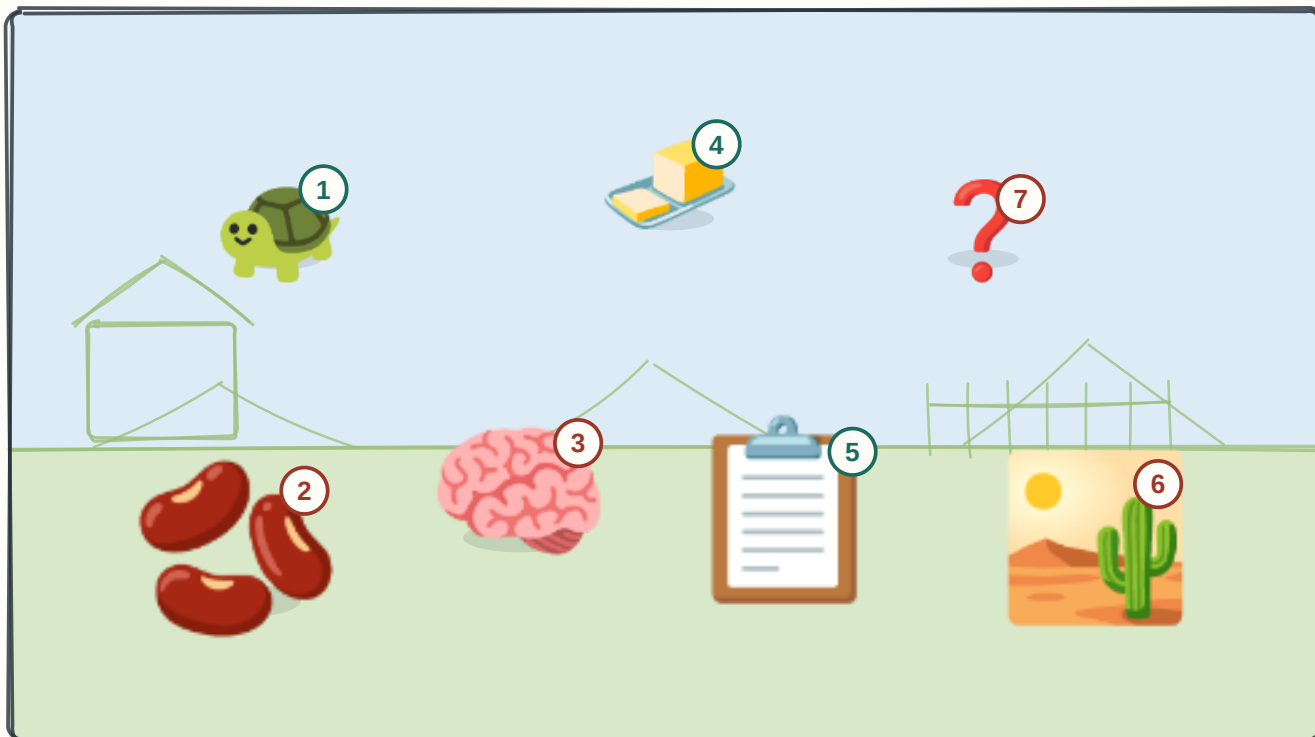
7 Sirup a čípek

Formy: perorální roztoky, sirupy, kapky, čípky; při dlouhodobé léčbě pozor na obsah cukru a etanolu.

⚠ Řada léčiv nemá u dětí registraci a podává se off-label podle odborných doporučení — klinické studie na dětech jsou vzácné.

034 Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

POMALÁ CESTA — START LOW, GO SLOW. A každý nový příznak je podezřelý z toho, že ho způsobil lék.

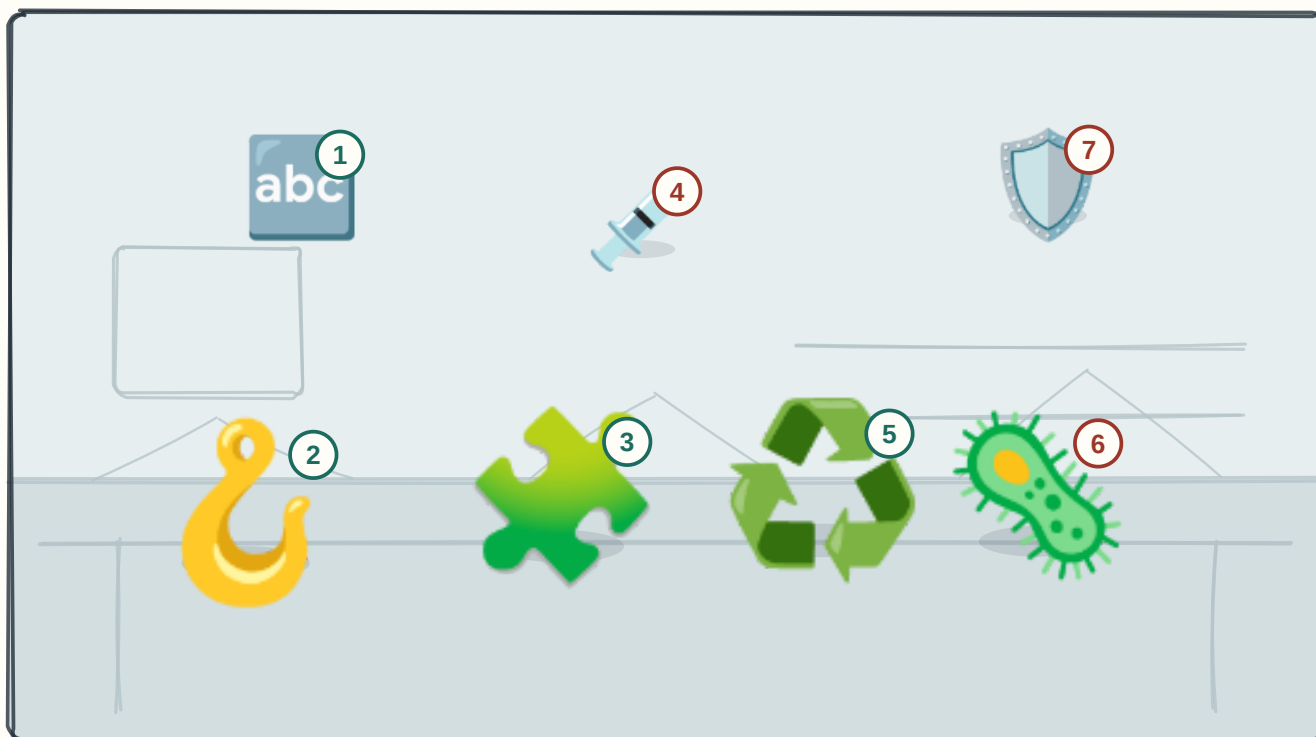


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Želva na cestě**
Start low, go slow — nižší úvodní dávka a pomalá titrace s kontrolou účinku i nežádoucích účinků.
- 2 **Ledvina**
Glomerulární filtrace klesá s věkem i při NORMÁLNÍM sérovém kreatininu, protože ubývá svalové hmoty — počítá se clearance, ne jen kreatinin.
- 3 **Citlivý mozek**
Vyšší citlivost na benzodiazepiny, opioidy, anticholinergika a antipsychotika — riziko pádů, zmatenosti a deliria.
- 4 **Tuková zásoba**
Ubývá svalů a přibývá tuku, takže lipofilní léčiva se hromadí a mají delší poločas.
- 5 **Seznam Beers**
Beersova kritéria a STOPP/START vyjmenovávají u seniorů nevhodná léčiva (dlouhodobě působící benzodiazepiny, anticholinergika, NSA) i ta, která chybějí.
- 6 **Anticholinergní zátěž**
Sčítá se z mnoha léků najednou (antihistaminika I. generace, tricyklicka, spasmolytika, některá antipsychotika) — zmatenost, retence moči, zácpa, pády.
- 7 **Otazník**
Nový příznak u seniora je nežádoucí účinek léku, dokud se neprokáže opak — jinak vzniká preskripční kaskáda.

⚠ Depreskripce je u seniora stejně důležitá jako nasazení nového léku — a často přinese větší užitek.

TABULE S KONCOVKAMI — konec názvu prozradí, co to je.



CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Koncovka -mab | MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKA. Předposlední slabika říká původ: -xi- chimérická (infliximab), -zu- humanizovaná (trastuzumab), -u- plně lidská (adalimumab). |
| 2 Koncovka -cept | FÚZNÍ BÍLKOVINA, solubilní receptor, který na sebe naváže cytokin: etanercept váže TNF- α , dále abatacept, aflibercept. |
| 3 Koncovka -nib | MALÁ MOLEKULA, inhibitor kinázy — na rozdíl od protilátek se podává PERORÁLNĚ (imatinib, tofacitinib, ibrutinib). |
| 4 Injekce, ne tableta | Protilátky jsou bílkoviny — v trávicím traktu by se strávily, proto se podávají parenterálně a vyžadují chladový řetězec. |
| 5 Podobná, ne stejná kopie | BIOSIMILAR — u bílkoviny nelze vyrobit přesnou kopii jako u generika; dokládá se srovnatelná kvalita, účinnost a bezpečnost, ne pouhá bioekvivalence. |
| 6 Latentní tuberkulóza | Před anti-TNF- α je nutné vyloučit latentní tuberkulózu a hepatitidu B — hrozí reaktivace. |
| 7 Protilátky proti léku | Imunogenicita — tvorba neutralizujících protilátek proti léku, které ho časem přestanou nechat účinkovat. Dále infuzní a hypersenzitivní reakce. |

! Inhibitory kontrolních bodů (nivolumab, pembrolizumab) působí opačně než imunosupresiva — uvolňují brzdu imunity, a proto jejich nežádoucí účinky vypadají jako autoimunitní choroby.

DVOJE DVEŘE ACETYLCHOLINU — nikotinové (bleskové, kanál) a muskarinové (pomalé, přes G-protein).



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Rychlé dveře N**

NIKOTINOVÉ receptory jsou ionotropní — samy iontovým kanálem, účinek za milisekundy. Nn v gangliích a dření nadledvin, Nm na nervosvalové ploténce.
- 2 Pomalé dveře M**

MUSKARINOVÉ receptory jsou metabotropní, přes G-protein. M1 v CNS a gangliích, M2 v srdci (zpomalí ho), M3 v hladkém svalu a žlázách (kontrakce, sekrece).
- 3 Nůžky esterázy**

Acetylcholin vzniká z cholinu a acetyl-CoA (cholinacetyltransferáza) a po uvolnění ho okamžitě štěpí ACETYLCHOLINESTERÁZA — proto je jeho účinek velmi krátký.
- 4 Tekoucí voda**

Účinky parasympatiku: slinění, slzení, pocení, mióza a akomodace na blízko.
- 5 Zpomalené srdce**

Bradykardie přes M2.
- 6 Stažené bronchy**

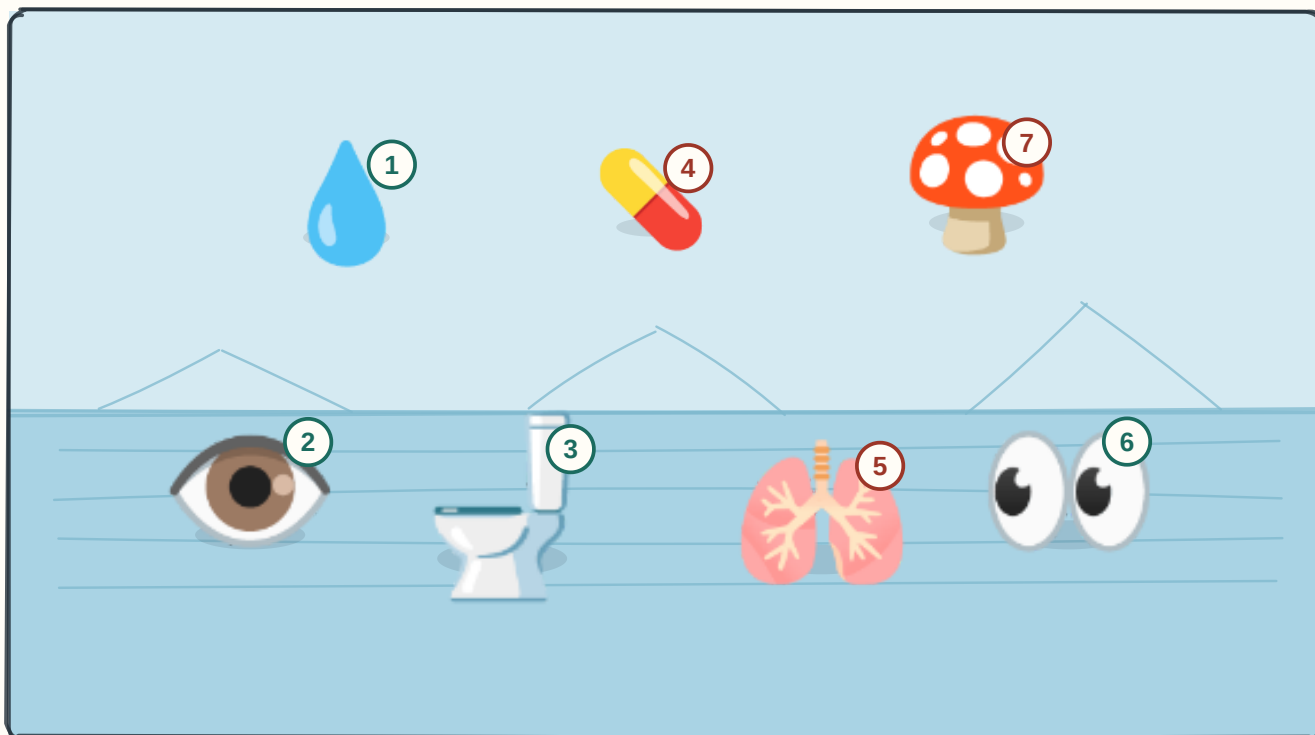
Bronchokonstrikce a zvýšená sekrece hlenu — proto jsou cholinomimetika u astmatu kontraindikovaná.
- 7 Vyprázdnění**

Zvýšená peristaltika a vyprázdnění močového měchýře.

! Sympatikus i parasympatikus mají v gangliích tentýž nikotinový receptor — proto ganglioplegika ovlivňují obojí a mají tolik nežádoucích účinků.

37 Přímá cholinomimetika

PROMOKLÁ KRAJINA — všechno teče a všechno se stahuje. SLUDGE.

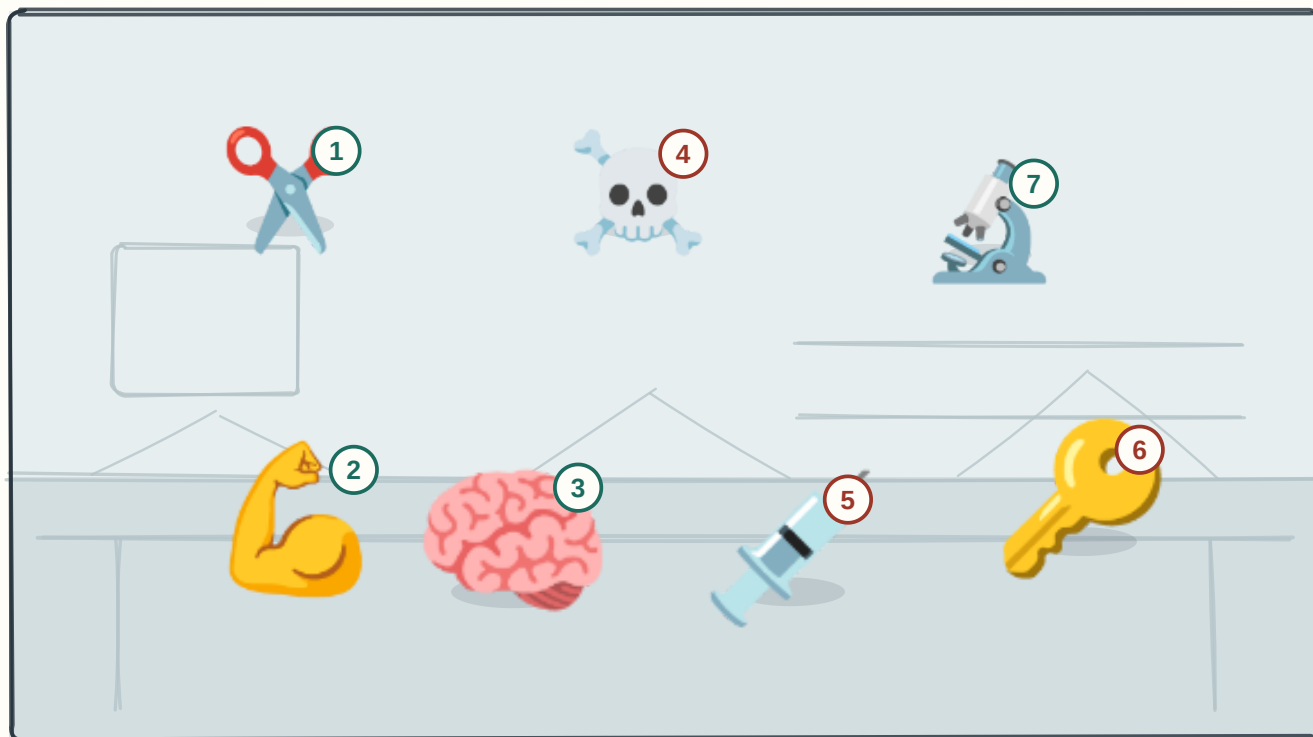


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Děšť SLUDGE**
Salivation, Lacrimation, Urination, Diarrhea, GI motility, Emesis — typický muskarinový obraz.
- 2 **Zúžená zornice**
PILOKARPIN stahuje musculus sphincter pupillae (mióza) a ciliární sval, čímž otevře komorový úhel — u glaukomu s uzavřeným úhlem a u xerostomie po ozáření.
- 3 **Plný měchýř**
BETHANECHOL — karbamátový ester odolný vůči acetylcholinesteráze; stimuluje močový měchýř a střevo u pooperační atonie.
- 4 **Lahvička atropinu**
ANTIDOTEM předávkování je ATROPIN.
- 5 **Stažené bronchy**
Kontraindikace: astma a CHOPN (bronchokonstrikce), vředová choroba, bradykardie a poruchy vedení, obstrukce močových cest a střeva.
- 6 **Karbachol**
Karbachol se používá v oftalmologii; methacholin jen k bronchoprovokačnímu testu.
- 7 **Muchomůrka**
Muskarin z muchomůrky červené a strmělek působí týž obraz — otrava se léčí atropinem.

⚠ Přímá cholinomimetika působí i bez vlastního acetylcholinu, protože sedají rovnou na receptor — na rozdíl od nepřímých, která potřebují zachovanou produkci mediátoru.

PŘESTŘÍŽENÉ NŮŽKY — acetylcholin se nerozkládá, tak se ho v synapsi hromadí čím dál víc.



CO JE VE SCÉNĚ

① **Zlomené nůžky**

Inhibice ACETYLCHOLINESTERÁZY zvyšuje koncentraci acetylcholinu v synapsi — účinek je nepřímý a závisí na vlastní produkci mediátoru.

② **Slabý sval**

NEOSTIGMIN a pyridostigmin jsou KVARTÉRNÍ aminy — do CNS nepronikají; u myasthenia gravis, k dekurarizaci po nedepolarizujících myorelaxancích a u pooperační atonie.

③ **Mozek**

DONEPEZIL, rivastigmin a galantamin jsou terciární aminy — do CNS pronikají, u Alzheimerovy choroby. Fysostigmin je antidotem anticholinergního deliria.

④ **Postřikovač**

ORGANOFOSFÁTY (insekticidy, bojové látky) vážou enzym NEVRATNĚ — cholinergní krize: mióza, bronchorea, bronchospasmus, bradykardie, křeče, obrna dýchacích svalů.

⑤ **Atropin**

Antidotum I: ATROPIN — blokuje muskarinové účinky.

⑥ **Pralidoxim**

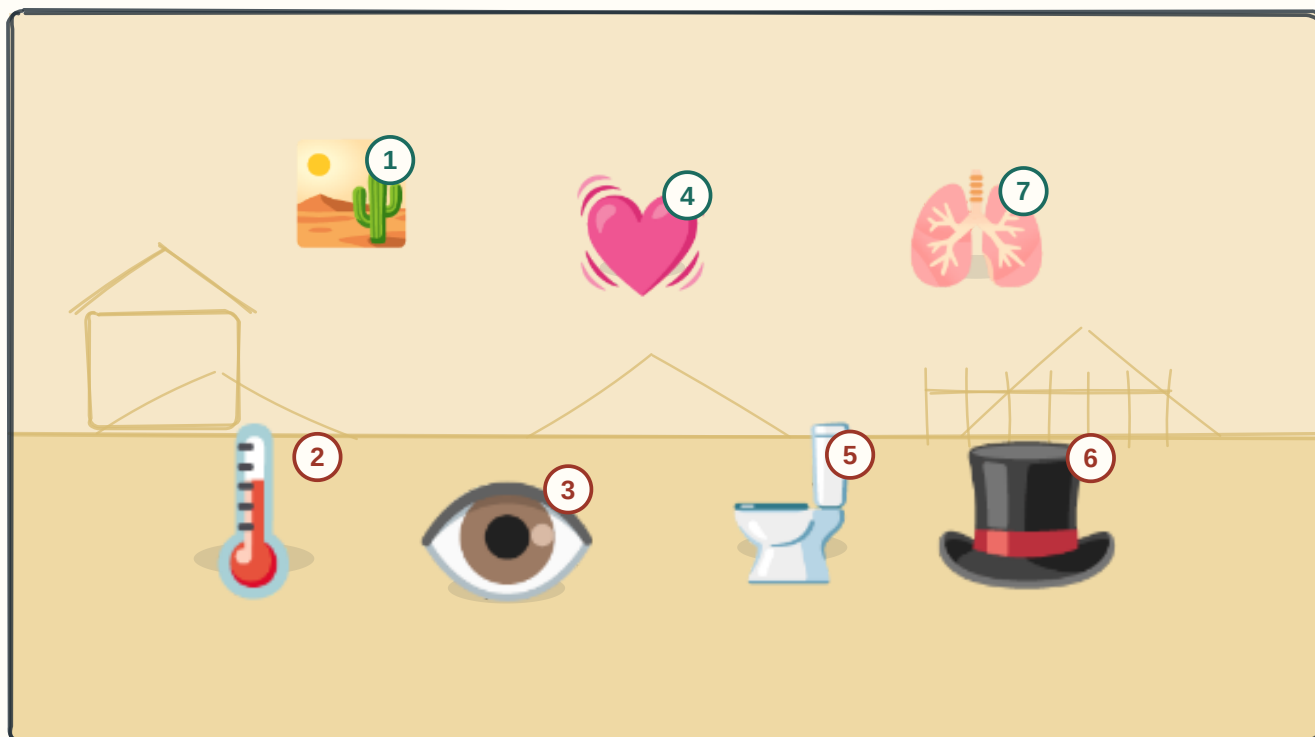
Antidotum II: PRALIDOXIM — reaktivuje enzym, dokud nedojde ke „stárnutí“ vazby.

⑦ **Edrofonium**

Edrofonium má velmi krátký účinek (dříve diagnostický test u myasthenia gravis).

⚠ Atropin sám organofosfátovou otravu nevyřeší — neúčinkuje na nikotinové receptory, a tedy ani na obrnu dýchacích svalů. Proto se přidává pralidoxim.

VYPRAHLÁ POUŠŤ — suchý jako kost, rudý jako řepa, horký jako pec, slepý jako netopýr, šílený jako kloboučník.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Vyschlá půda

Blokáda muskarinových receptorů — sucho v ústech, vyschlé sliznice, zástava pocení.

2 Rozpálený teploměr

Bez pocení stoupá teplota — hypertermie, u dětí nebezpečná. Kůže je suchá a zarudlá.

3 Obří oko

Mydriáza a paralýza akomodace (cykloplegie). Kontraindikací je GLAUKOM S UZAVŘENÝM ÚHLEM — rozšířená duhovka uzavře komorový úhel.

4 Splašené srdce

Blokáda M2 → tachykardie. Atropin se proto podává u bradykardie a v premedikaci.

5 Zamčený záchod

Retence moči (pozor u hyperplazie prostaty) a zácpa až paralytický ileus.

6 Šílený kloboučník

Centrální anticholinergní syndrom — neklid, zmatenost, delirium. Antidotem FYSOSTIGMIN (terciární amin, projde do CNS).

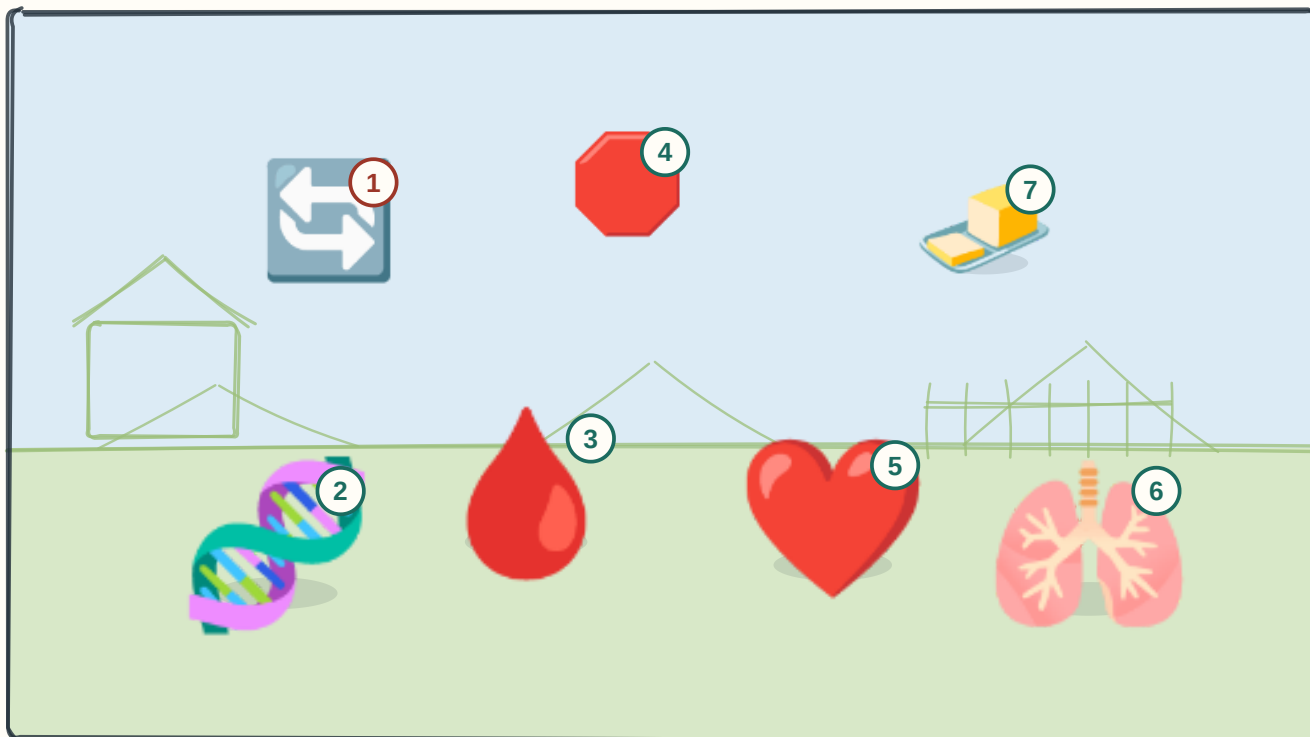
7 Rozepnuté plíce

Ipratropium a tiotropium inhalačně u CHOPN a astmatu. Dále butylskopolamin (spasmolytikum), tropikamid (oční vyšetření), biperiden, oxybutynin a solifenacin.

! Butylskopolamin je KVARTÉRNÍ amin — neprojde do CNS, takže neseseduje ani nevyvolá delirium. Atropin a skopolamin (terciární) ano.

40 Adrenergní přenos vzruchu

RECYKLAČNÍ DVŮR — noradrenalin se nerozkládá jako acetylcholin, ale z 80 % se VRACÍ ZPĚT do nervu.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Recyklační kruh**

Účinek končí především ZPĚTNÝM VYCHYTÁVÁNÍM (uptake-1) do nervového zakončení; teprve pak látku odbourává MAO a COMT. Kokain, tricyklicka a SNRI tento transportér blokuji.
- 2 Výrobní linka**

Tyrosin → DOPA (tyrosinhydroxyláza, krok určující rychlost) → dopamin → noradrenalin; v dřeni nadledvin dále na adrenalin.
- 3 Stažená céva**

$\alpha 1$ — vazokonstrikce, mydriáza, kontrakce svěrače měchýře a prostaty.
- 4 Brzda na nervu**

$\alpha 2$ — PRESYNAPTICKY tlumí další výlev noradrenalinu; proto klonidin snižuje tlak centrálně.
- 5 Zrychlené srdce**

$\beta 1$ — zvýšená frekvence, vodivost a kontraktilita; v ledvině výlev reninu.
- 6 Rozšířené bronchy**

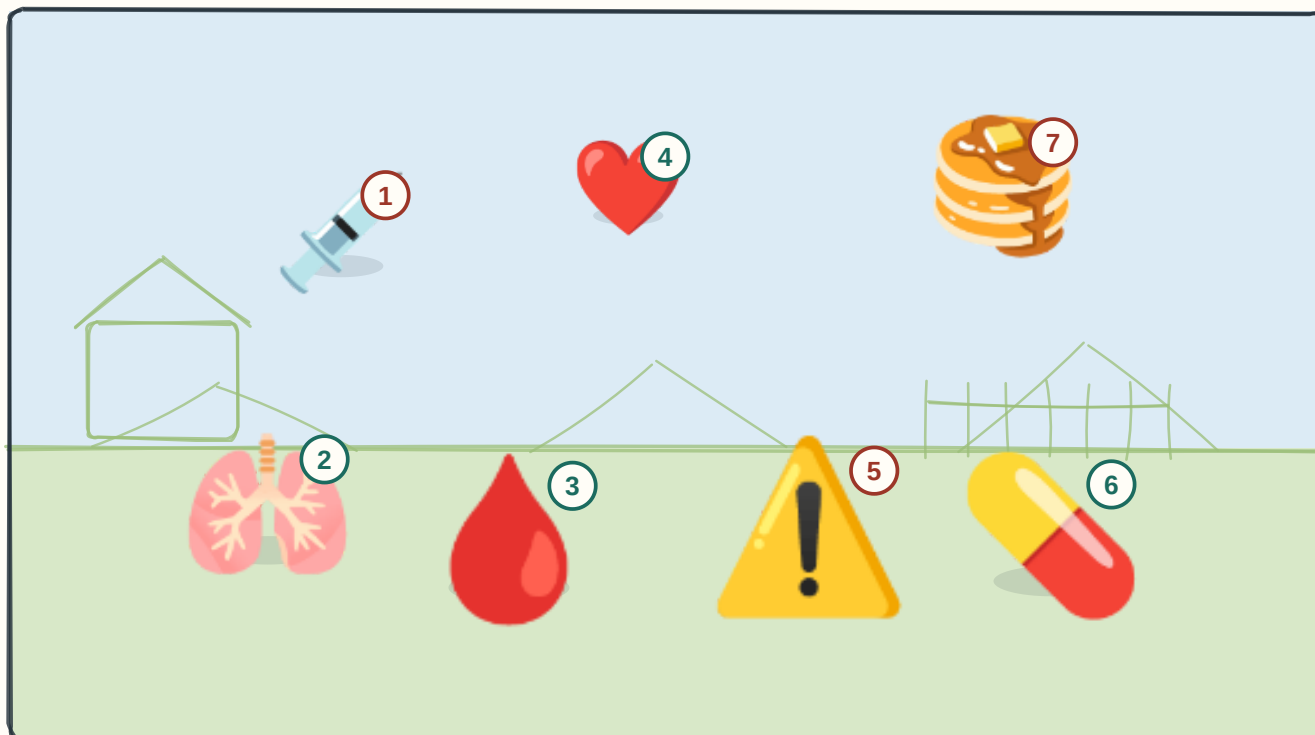
$\beta 2$ — bronchodilatace, vazodilatace ve svalech, relaxace dělohy, tremor, hypokalemie.
- 7 Tuková buňka**

$\beta 3$ — lipolýza a relaxace detruzoru (mirabegron).

! Adrenalin má afinitu ke všem receptorům, noradrenalin převážně k α a $\beta 1$ — proto noradrenalin zvyšuje tlak vazokonstrikcí, kdežto adrenalin navíc rozšiřuje bronchy.

41 Neselektivní sympatomimetika

ZÁCHRANÁŘSKÝ VŮZ — jediný lék, který u anafylaxe umí obojí najednou: otevřít bronchy a stáhnout cévy.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Pero do stehna**

U ANAFYLAXE je ADRENALIN lékem první volby — intramuskulárně do stehna (m. vastus lateralis); nástup je rychlejší a bezpečnější než subkutánně.
- 2 Otevřené bronchy**

β_2 rozšíří bronchy.
- 3 Ustupující otok**

α_1 stáhne cévy a ustoupí otok sliznice a angioedém — obojí zároveň, což žádný jiný lék neumí.
- 4 Srdeční zástava**

β_1 zvyšuje kontraktilitu a frekvenci; adrenalin se podává při srdeční zástavě a v šoku.
- 5 Arytmie**

Vysoké dávky působí arytmiie a hypertenzi.
- 6 S lokálním anestetikem**

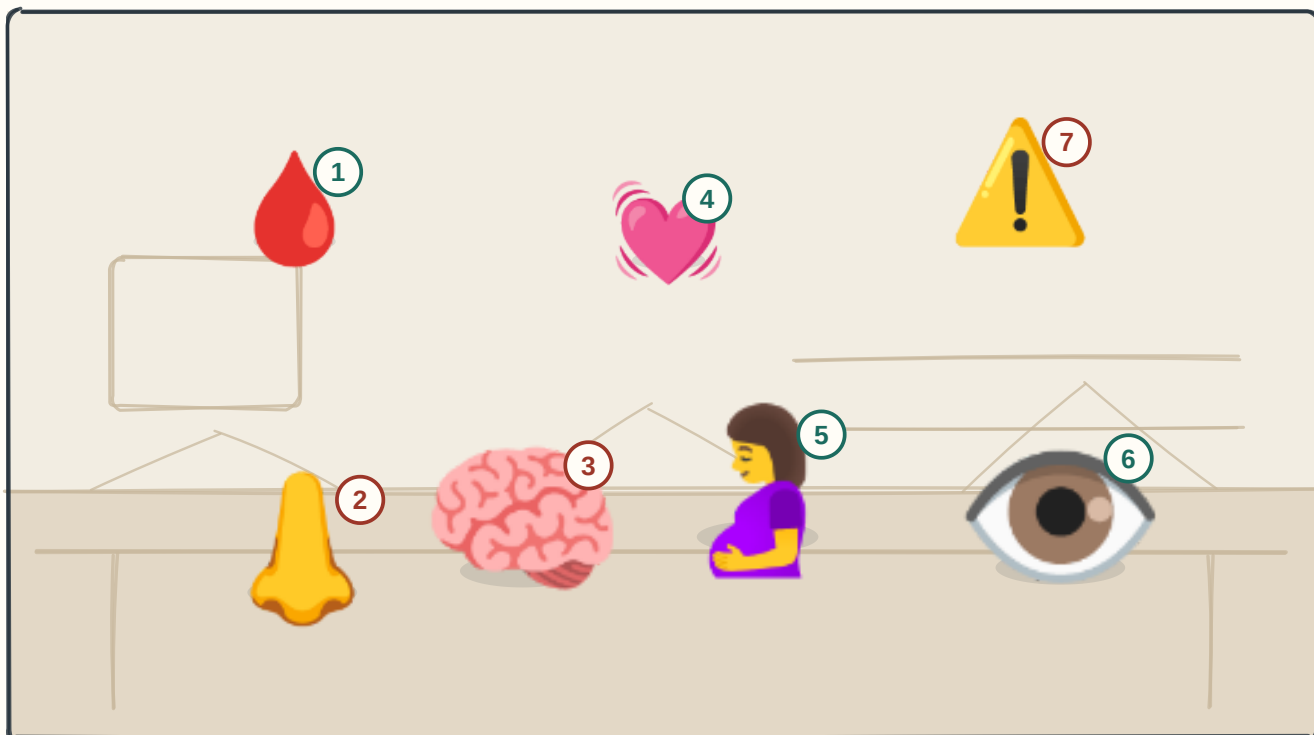
Přídavek adrenalinu způsobí vazokonstrikci — zpomalí vstřebávání, prodlouží účinek a sníží krvácení a systémovou toxicitu.
- 7 Glukagon v záloze**

U pacienta na β -blokátoru může být adrenalin méně účinný — pak se podává glukagon, který srdce stimuluje mimo β -receptor.

! Izoprenalin je neselektivní β -agonista (β_1 i β_2) — dnes okrajově u bradykardie a AV blokády; dopamin a dobutamin patří k inotropní podpoře.

42 Sympatomimetika alfa

STAŽENÉ POTRUBÍ — α_1 stahuje cévy. Ale α_2 v mozku dělá pravý opak: tlak SNIŽUJE.

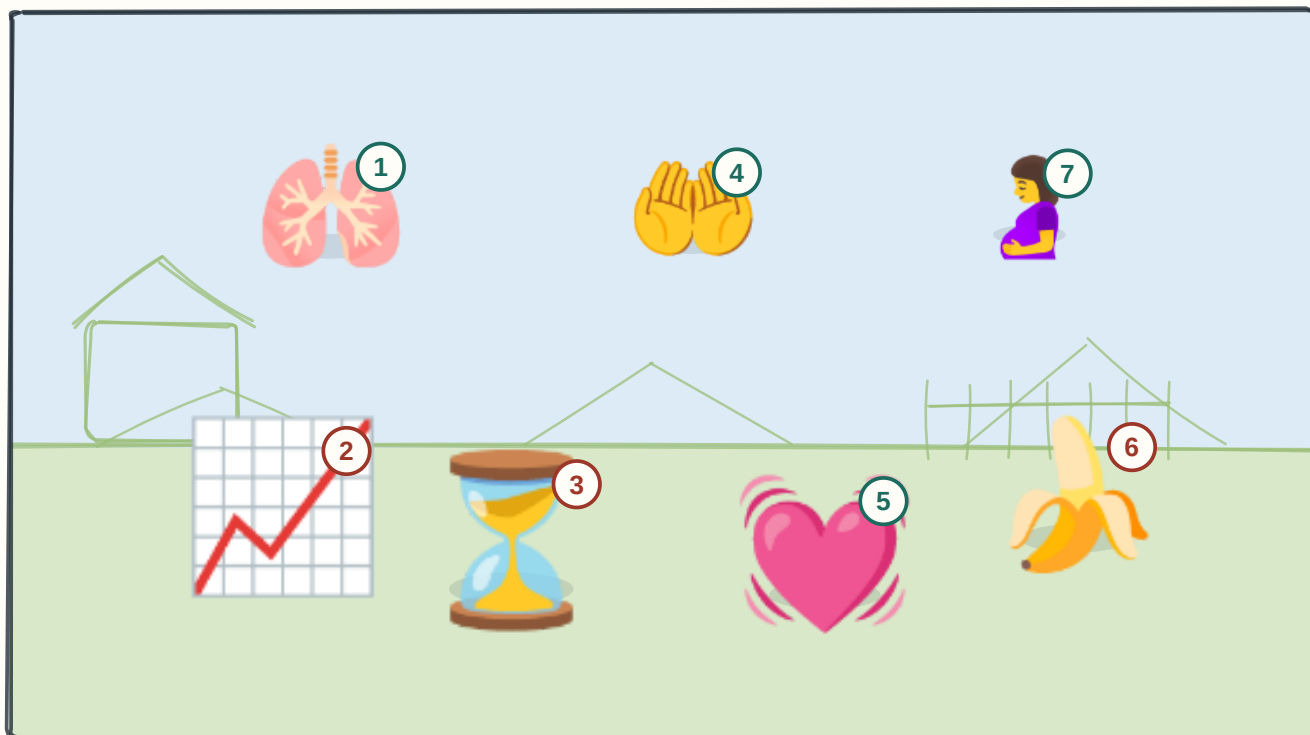


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Stažená trubka**
 α_1 -agonisté (fenylefrin, noradrenalin, midodrin) stahují cévy, zvyšují periferní odpor a krevní tlak — v šoku, při hypotenzi a k lokální vazokonstrikci.
- 2 Nosní kapky**
Xylometazolin, oxymetazolin, nafazolin — jen 5–7 DNÍ, jinak vzniká rhinitis medicamentosa s odrazovým otokem a závislostí na kapkách.
- 3 Brzda v mozku**
 α_2 -agonisté (klonidin, methyldopa, brimonidin, dexmedetomidin) působí na PRESYNAPTICKÝ receptor v CNS — tlumí výlev noradrenalinu, a proto tlak SNIŽUJÍ.
- 4 Zpomalené srdce**
Prudký vzestup tlaku vyvolá baroreflexem BRADYKARDII — proto po fenylefrinu srdce zpomalí, ačkoli jde o sympatomimetikum.
- 5 Methyldopa**
Methyldopa je lékem volby u hypertenze v graviditě.
- 6 Brimonidin**
Brimonidin se používá lokálně u glaukomu.
- 7 Náhlé vysazení**
Náhlé vysazení klonidinu vyvolá REBOUND HYPERTENZI s tachykardií a pocením — vysazuje se postupně.

⚠ Že agonista snižuje tlak, není chyba — rozhoduje, na kterém receptoru a na které straně synapse působí.

TŘESOUČÍ SE RUCE NAD INHALÁTOREM — β_2 otevře bronchy a vždycky přidá stejnou trojici: třes, tachykardii, hypokalemii.



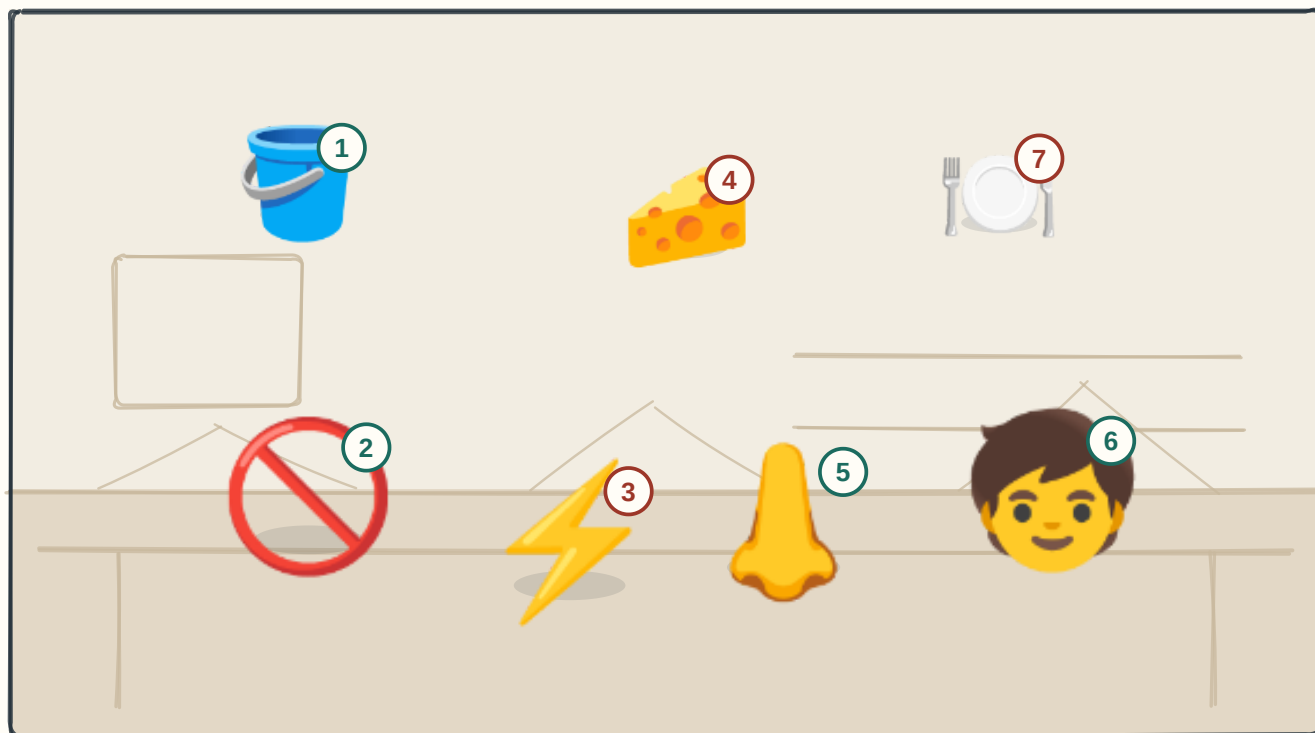
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Otevřené bronchy**
 β_2 -agonisté relaxují hladký sval bronchu. SABA (salbutamol, fenoterol, terbutalin) působí během minut — úlevová léčba.
- 2 Prázdné krabičky**
Vysoká spotřeba SABA znamená špatně kontrolované astma.
- 3 Dlouhý účinek**
LABA (formoterol, salmeterol, indakaterol) působí 12–24 hodin. NIKDY samostatně u astmatu — monoterapie zvyšuje mortalitu; vždy s inhalačním kortikoidem.
- 4 Třesoucí se ruce**
Tremor (β_2 v kosterním svalu).
- 5 Bušící srdce**
Tachykardie — částečná stimulace β_1 a reflexně.
- 6 Klesající draslík**
Hypokalemie — draslík se přesouvá do buňky; pozor při současné léčbě diuretiky a digoxinem.
- 7 Tokolýza**
 β_2 -agonisté relaxují dělohu — hexoprenalin k tokolýze při hrozícím předčasném porodu. β_1 -agonista dobutamin slouží k inotropní podpoře.

! β_2 -agonista neléčí zánět, jen uvolní sval — proto astma nikdy nestojí na něm samotném, ale na inhalačním kortikoidu.

44 Nepřímá sympatomimetika

VYPLAVENÝ SKLAD — nesedají na receptor, jen vysypou zásoby. A sklad se dá vyprázdnit.



CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|---|---|
| <p>① Převrácený kbelík</p> <p>② Zabedněný vchod</p> <p>③ Prázdný sklad</p> <p>④ Zrající sýr</p> <p>⑤ Dekongescens</p> <p>⑥ ADHD</p> <p>⑦ Tyramin z potravy</p> | <p>Efedrin, pseudoefedrin, amfetamin a metamfetamin obracejí chod transportéru a VYPLAVUJÍ noradrenalin z nervového zakončení.</p> <p>Kokain, tricyklická antidepresiva a SNRI BLOKUJÍ zpětné vychytávání — mediátor zůstává v synapsi déle.</p> <p>TACHYFYLAXE — opakované podání vyčerpá zásobu mediátoru, účinek rychle slábne a zvýšení dávky NEPOMŮŽE.</p> <p>S inhibitory MAO hrozí HYPERTENZNÍ KRIZE — „sýrový efekt“ po potravinách bohatých na tyramin (zrající sýry, uzeniny, červené víno).</p> <p>Efedrin a pseudoefedrin jako dekongescencia a při hypotenzi.</p> <p>Amfetaminové deriváty terapeuticky u ADHD a narkolepsie, jinak zneužívané.</p> <p>Tyramin je nepřímé sympatomimetikum z potravy — normálně ho MAO ve střevě zlikviduje; při léčbě IMAO se dostane do oběhu.</p> |
|---|---|

⚠ Nepřímé sympatomimetikum nezabere tam, kde jsou zásoby mediátoru vyčerpány — proto se v šoku dává přednost přímým agonistům.

45 Sympatolytika alfa

PRVNÍ VSTÁNÍ Z POSTELE — po první dávce se podlomí kolena. Proto se bere na noc.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Klesající tlak

Blokáda α_1 uvolní hladký sval cév — klesá periferní odpor a tlak. Doxazosin a terazosin se používají u hypertenze i u prostaty.

2 Postel

FENOMÉN PRVNÍ DÁVKY — prudká ortostatická hypotenze a synkopa; proto se začíná nízkou dávkou na noc.

3 Prostata

TAMSULOSIN a silodosin jsou uroselektivní (α_{1A}) — uvolní hladký sval prostaty a hrdla měchýře, tlak ovlivní málo.

4 Retrográdní ejakulace

Typický nežádoucí účinek tamsulosinu.

5 Plovoucí duhovka

IFIS — intraoperative floppy iris syndrome; před operací katarakty je nutné oftalmologa upozornit na užívání tamsulosinu.

6 Feochromocytom

Fenoxymetamin a fentolamin jsou neselektivní α -blokátory u feochromocytomu — podávají se PŘED β -blokátorem.

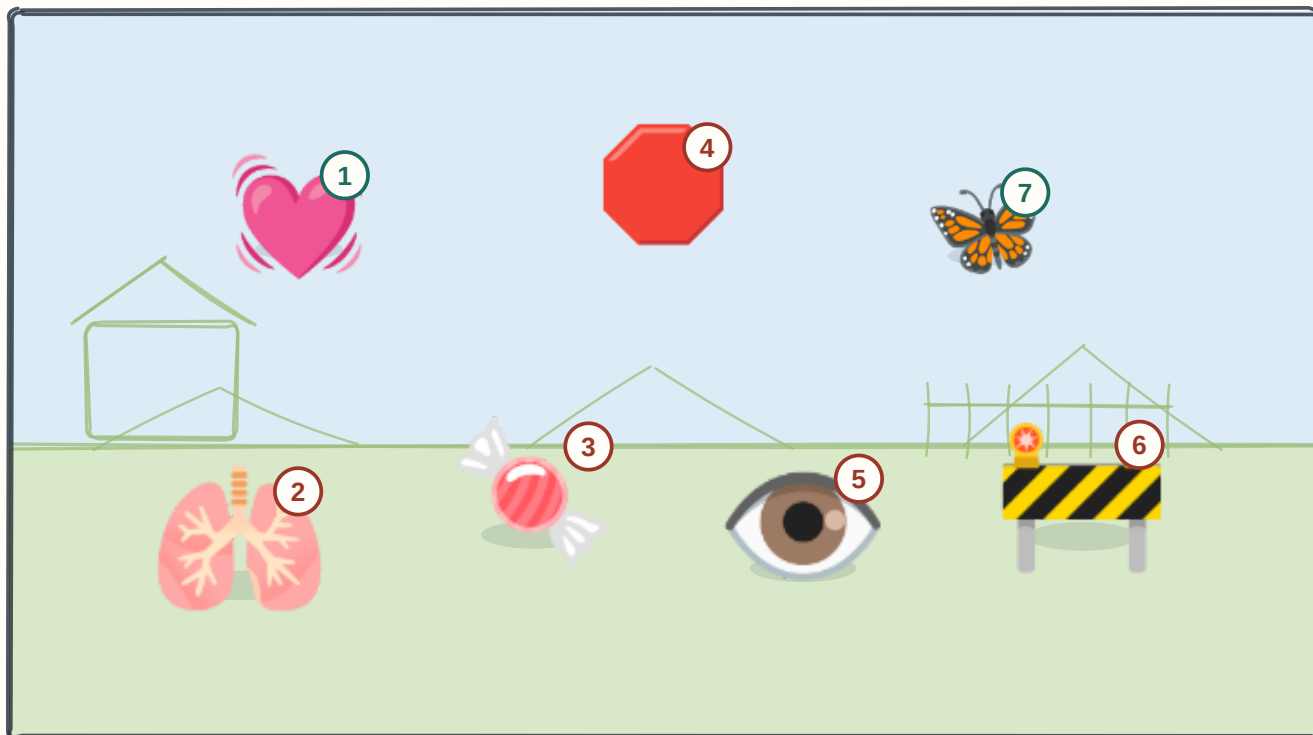
7 Zakázané pořadí

U feochromocytomu se nikdy nezačíná β -blokátorem — nebrzděná α -stimulace by vyvolala hypertenzní krizi.

! α -blokátory nejsou dnes lékem první volby u hypertenze — používají se spíše u rezistentní hypertenze nebo tam, kde je současně hyperplazie prostaty.

46 Sympatolytika beta (betablokátory)

ZPOMALENÁ VESNICE — všechno tu jde pomaleji: srdce, dech i cukr. A odjet se nesmí náhle.



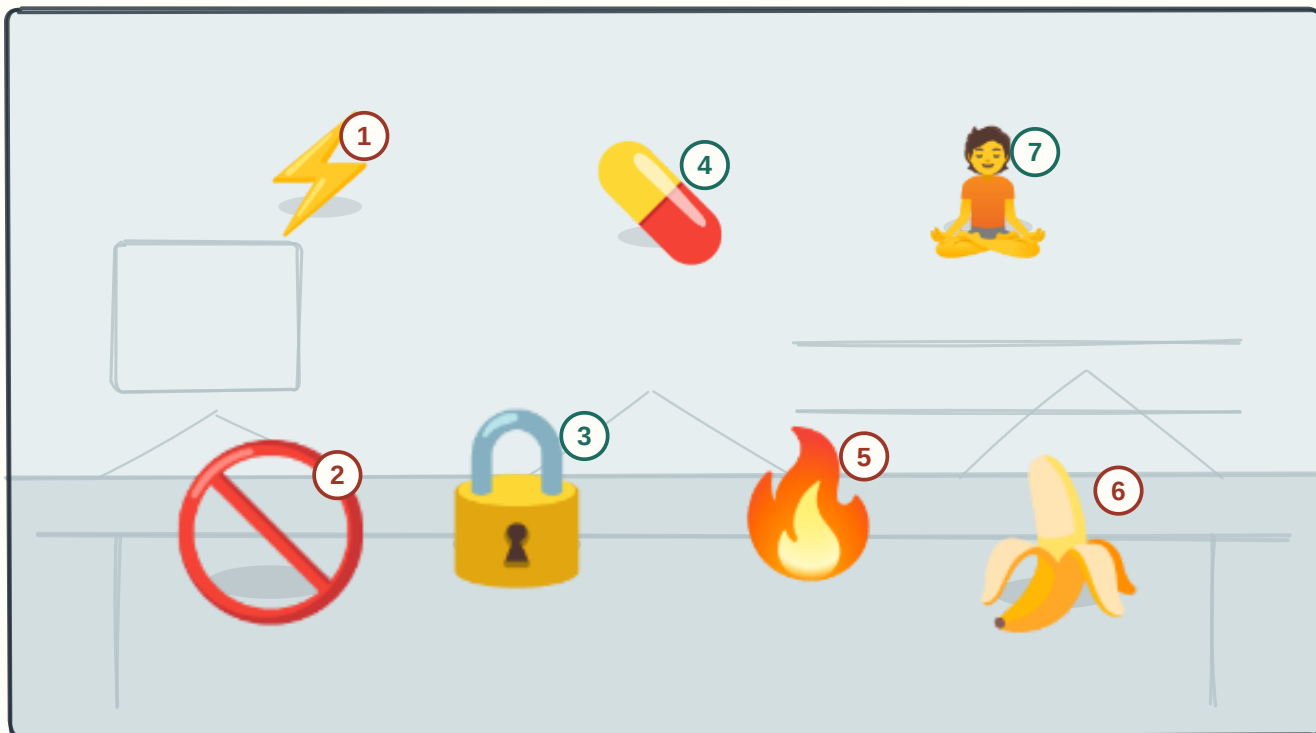
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Zpomalené srdce**
Blokáda β_1 snižuje frekvenci, kontraktilitu, vodivost a spotřebu kyslíku myokardem; snižuje i výlev reninu.
- 2 Sevržené plíce**
Neselektivní (propranolol, sotalol) blokují i β_2 → bronchospasmus. Kardioselektivní (bisoprolol, metoprolol, atenolol, nebivolol) jsou bezpečnější, ve vysoké dávce selektivita mizí.
- 3 Schovaný bonbon**
U diabetika maskují varovné příznaky hypoglykemie (tachykardii, třes) — pocení zůstává.
- 4 Zákaz náhlého odjezdu**
NEVYSAZOVAT NÁHLE — up-regulace receptorů vede k rebound tachykardii, hypertenzi a může vyprovokovat anginu nebo infarkt.
- 5 Kapka do oka**
Timolol v očních kapkách se vstřebá a může vyvolat bradykardii a bronchospasmus.
- 6 Zaseknutá závara**
Kombinace s verapamilem nebo diltiazemem hrozí těžkou bradykardií a AV bloádou.
- 7 Motýl štítné žlázy**
Indikace: hypertenze, ischemická choroba, arytmie, srdeční selhání (bisoprolol, karvedilol, metoprolol), tyreotoxikóza, tremor, migréna, glaukom.

⚠ Karvedilol a labetalol blokují i α_1 ; sotalol má navíc antiarytmický účinek III. třídy; nebivolol uvolňuje oxid dusnatý.

47 Myorelaxancia

DVĚ CESTY K OCHRUTÍ — jedna sval nejdřív ROZKMITÁ a zvrátit se nedá, druhá ho jen odpojí a zvrátit jde.



CO JE VE SCÉNĚ

① **Záškruby svalu**

SUKCINYLCHOLIN je DEPOLARIZUJÍCÍ — chová se jako acetylcholin, který se nerozkládá: nejprve receptor trvale aktivuje (fascikulace), pak nastane blokáda. Působí 5–10 minut.

② **Nelze zvrátit**

Depolarizující blok NELZE zvrátit neostigminem — ten by ho prohloubil.

③ **Obsazený zámek**

NEDEPOLARIZUJÍCÍ (rocuronium, vekuronium, atrakurium, cisatracurium) jsou kompetitivní antagonisté nikotinového receptoru — sval ochrne bez fascikulací.

④ **Sugammadex**

Nedepolarizující blok lze zvrátit neostigminem, u rocuronia specificky SUGAMMADEXEM.

⑤ **Maligní hypertermie**

Vzácná geneticky podmíněná reakce na sukcinylcholin a inhalační anestetika: prudký vzestup teploty, rigidita, acidóza. Antidotem DANTROLEN.

⑥ **Hyperkalemie**

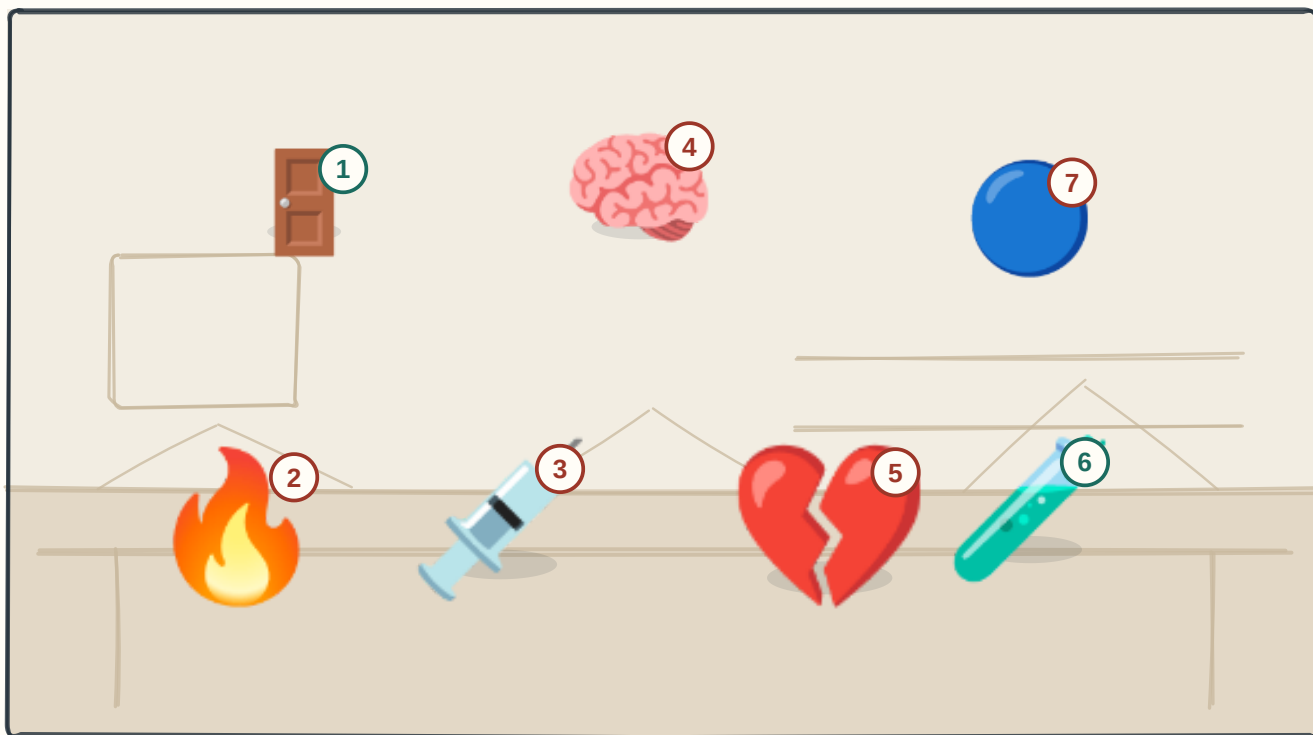
Sukcinylcholin uvolní draslík — nebezpečné u popálenin, polytraumat a neuromuskulárních chorob. Dále bolest svalů, vzestup nitroočního tlaku, prodloužená apnoe při atypické pseudocholinesteráze.

⑦ **Baklofen**

Centrální myorelaxancia: baklofen (agonista GABA-B), tizanidin, tolperison — na spasticitu, nikoli k anestezii.

⚠ Myorelaxans netlumí vědomí ani bolest — pacient musí být zároveň uspán a analgetizován, jinak je ochrnutý při vědomí.

ZANESENÝ ZÁMEK V ZÁNĚTU — kanál se zavírá zevnitř, ale v kyselém prostředí se k němu lék nedostane.

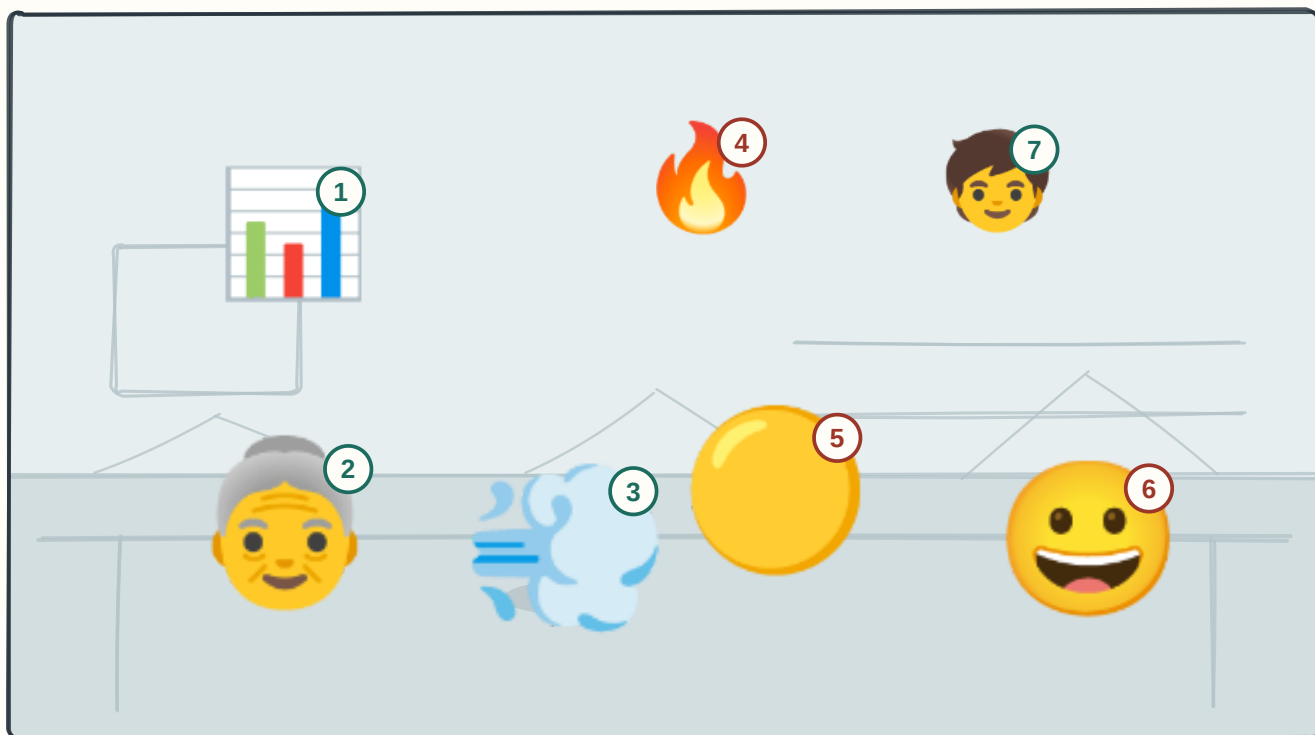


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Sodíkový kanál**
Vážou se ZE VNITŘ na napětově řízený sodíkový kanál a brání vzniku a šíření akčního potenciálu.
- 2 **Zanícená tkáň**
V kyselém prostředí zánětu převládá ionizovaná forma, která neprojde membránou k místu účinku — proto se v zaníceném terénu často nepodaří umrtvit.
- 3 **S adrenalinem**
Vazokonstrikce prodlouží účinek, sníží krvácení a systémovou toxicitu. NEPODÁVAT do akrálních částí (prsty, nos, ucho) — riziko ischemie.
- 4 **Brnění kolem úst**
Systémová toxicita začíná v CNS: kovová chuť, brnění kolem úst, hučení, závrať, křeče — a TEPRVE PAK přijde kardiotoxicita.
- 5 **Bupivakain**
Bupivakain je nejekardiotoxičtější; léčbou systémové toxicity je lipidová emulze.
- 6 **Estery a amidy**
ESTERY (prokain, benzokain, tetrakain) štěpí plazmatické esterázy, častější alergie (metabolit PABA). AMIDY (lidokain, mepivakain, artikain, bupivakain, prilokain) se metabolizují v játrech, alergie vzácná.
- 7 **Modrá krev**
Prilokain a benzokain mohou vyvolat methemoglobinemii — antidotem methylenová modř.

⚠ Nej dřív vypadne bolest a teplo, pak dotek a nakonec motorika — tenká nemyelinizovaná vlákna se blokují první. Lidokain je zároveň antiarytmikum třídy Ib.

MĚŘIDLO MAC — čím NIŽŠÍ číslo, tím SILNĚJŠÍ látka.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Měřidlo MAC

MAC — minimální alveolární koncentrace, při níž se 50 % pacientů nepohne po kožním řezu; je mírou potence. NÍZKÉ MAC = VYSOKÁ potence.

2 Klesající MAC

MAC klesá s věkem, v graviditě a při současném podání opioidů.

3 Rychlá pára

Rychlost nástupu určuje rozpustnost v krvi: čím nižší, tím rychlejší nástup i probuzení. Desfluran a sevofluran nastupují rychle, halothan pomalu.

4 Maligní hypertermie

Halogenovaná anestetika (sevofluran, desfluran, isofluran) mohou spolu se succinylcholinem vyvolat malignitní hypertermii — antidotem DANTROLEN.

5 Halothan

Halothan navíc hepatotoxicita — dnes se prakticky nepoužívá.

6 Rajský plyn

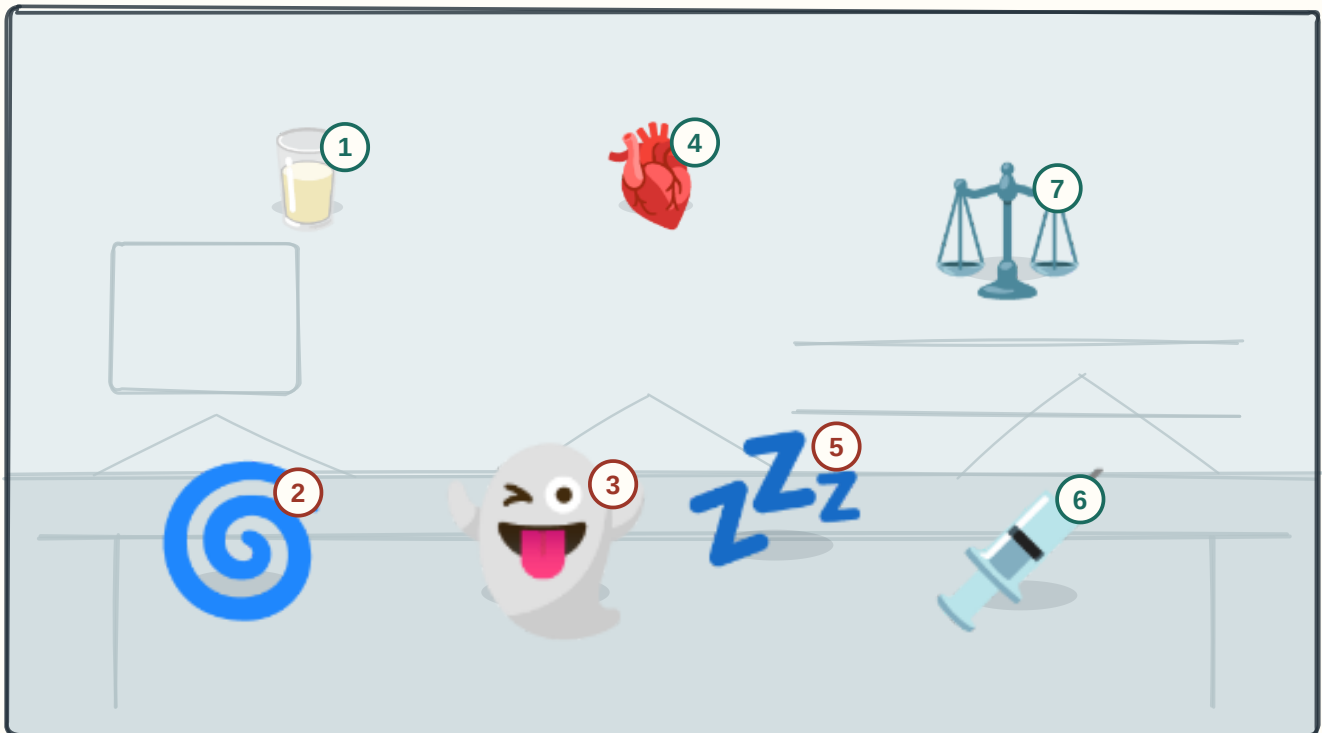
Oxid dusný (N₂O) má výbornou ANALGEZII, ale slabý anestetický účinek — jen jako doplněk. Inaktivuje vitamin B12 a difunduje do uzavřených dutin.

7 Sevofluran u dětí

Sevofluran je pro dobrou snášenlivost dýchacími cestami vhodný k úvodu do anestezie u dětí.

! Inhalační anestetika snižují krevní tlak a tlumí dýchání — proto se vedou v kombinaci s dalšími složkami anestezie, ne samostatně ve vysoké dávce.

ČTYŘI LÁHVE NA SÁLE — a jedna z nich se chová opačně než ostatní.



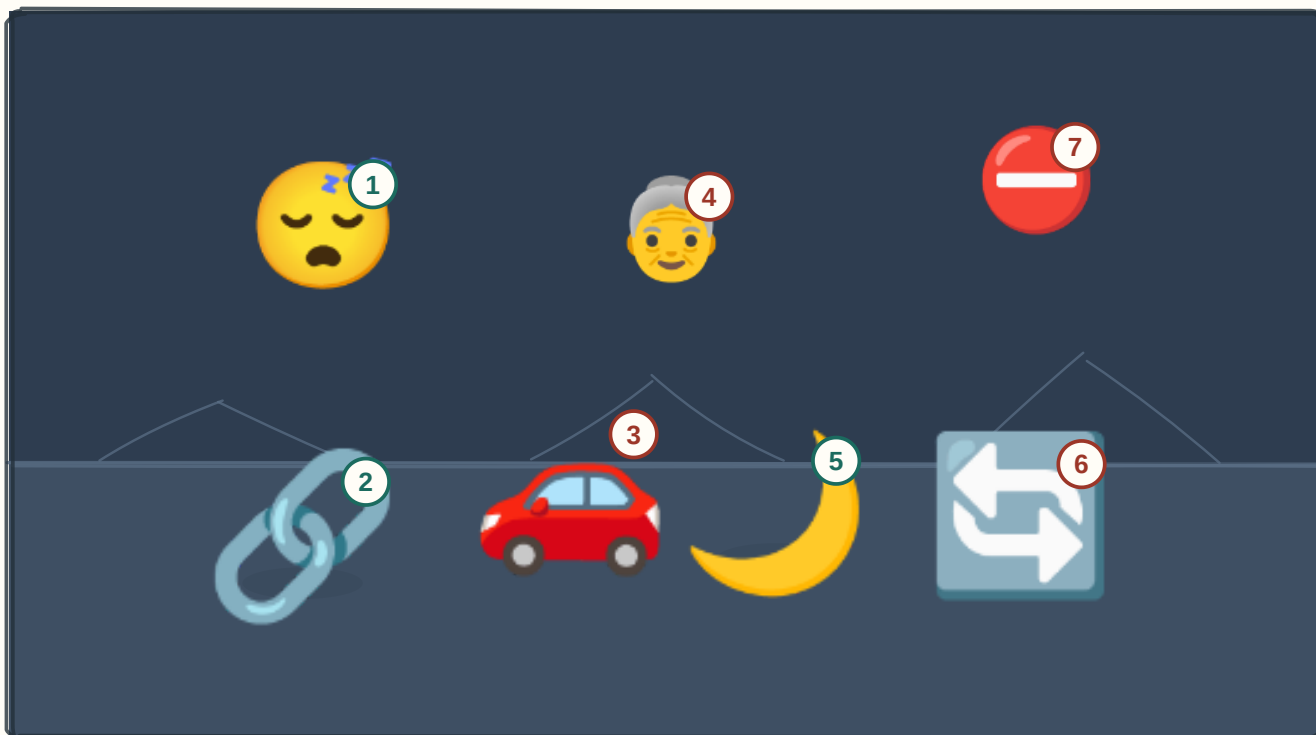
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Bílá láhev propofolu**
 PROPOFOL — nejužívanější, rychlý nástup i odeznění, antiemetický účinek. Nežádoucí: pokles krevního tlaku, útlum dechu, bolest při injekci; při dlouhé vysokodávkované infuzi propofolový infuzní syndrom.
- 2 Ketamin**
 KETAMIN je antagonist NMDA — disociativní anestezie se silnou analgezií. Na rozdíl od ostatních krevní tlak NEKLESÁ (stoupá) a dechová aktivita se zachovává — proto se hodí v šoku a v přednemocniční péči.
- 3 Halucinace při probouzení**
 Ketamin působí halucinace a neklid při probouzení — tlumí je benzodiazepin. Esketamin se používá u farmakorezistentní deprese.
- 4 Etomidát**
 ETOMIDÁT je oběhově velmi stabilní — vhodný u kardiaka; tlumí ale syntézu kortizolu, proto se nepodává v infuzi.
- 5 Thiopental**
 THIOPIENTAL — účinek končí REDISTRIBUCÍ do svalu a tuku, nikoli eliminací; pacient se probudí rychle, ale látka v těle přetrvává a při opakovaném podání se kumuluje.
- 6 Opioid**
 Anestezie se vede kombinací: hypnotikum + analgetikum (opioid) + myorelaxans.
- 7 Tři složky**
 Jedna látka nezvládne všechny tři složky současně — proto se anestezie vždy skládá.

! Ketamin je výjimkou z většiny pravidel o intravenózních anestetikách — proto se u něj vyplatí pamatovat si právě to, čím se liší.

51 Hypnotika

NOČNÍ POKOJ S JEDNÍM ZÁMKEM — Z-léčiva i benzodiazepiny sedají na TÝŽ receptor, a proto mají stejná rizika.



CO JE VE SCÉNĚ

① **Spící postava**

Z-hypnotika (zolpidem, zopiklon, zaleplon) zkracují dobu usnutí; krátký poločas, takže ráno tlumí méně než benzodiazepiny.

② **Společný zámek**

Vážou se selektivně na $\omega 1$ podjednotku GABA-A receptoru — proto působí hypnoticky, ale mnohem méně anxiolyticky, myorelaxačně a antikonvulzivně.

③ **Jízda ve spánku**

Nežádoucí: amnézie a PARASOMNIE — jízda a jedení ve spánku.

④ **Pád u postele**

U seniorů riziko pádů a zmatenosti — patří na seznam nevhodných léčiv.

⑤ **Melatonin**

Melatonin a agonisté melatoninových receptorů upravují cirkadiánní rytmus; bezpečné a nenávykové, ale slabší.

⑥ **Rebound nespavost**

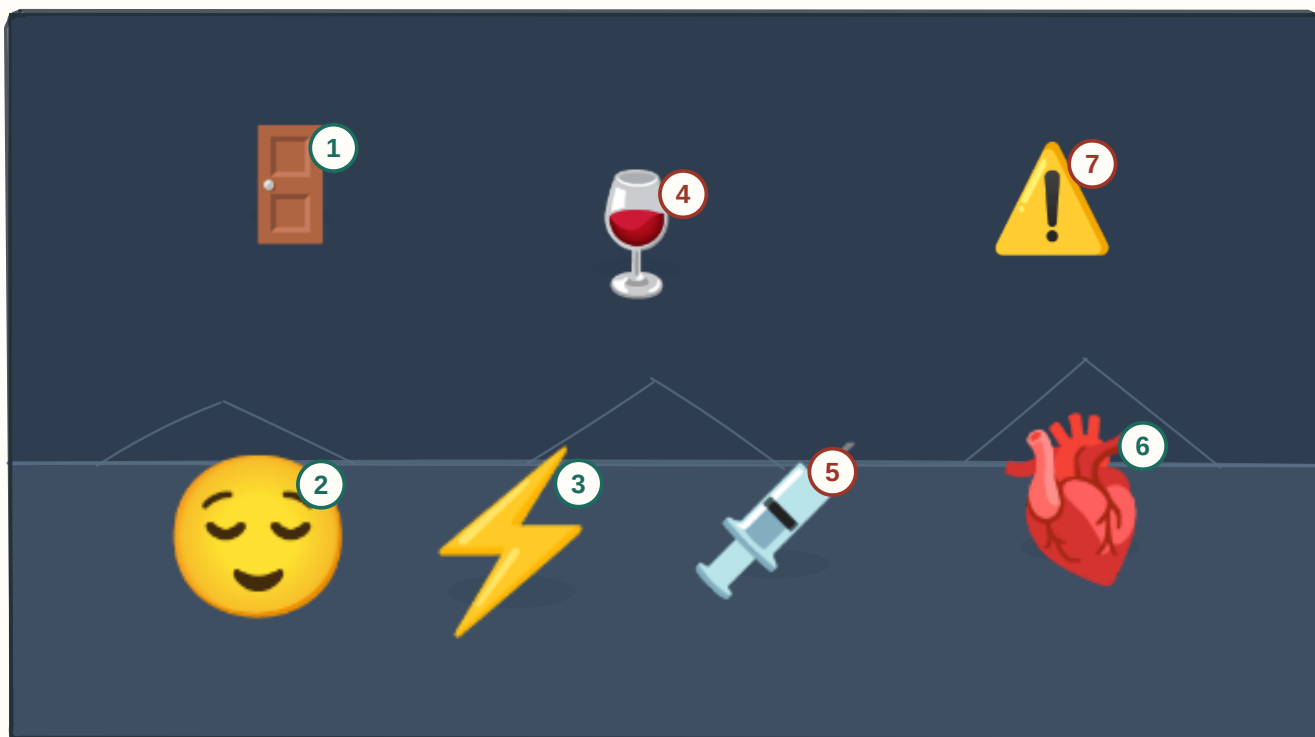
Podávat co nejkratší dobu — po vysazení hrozí rebound nespavost. Základem léčby je spánková hygiena a kognitivně-behaviorální terapie.

⑦ **Barbiturát v trezoru**

Barbituráty se dnes jako hypnotika nepoužívají — úzké terapeutické okno, útlum dechu bez stropu a silná indukce CYP450.

⚠ Flumazenil je antidotem i u Z-hypnotik, protože působí na tentýž GABA-A receptor — přestože chemicky benzodiazepiny nejsou.

DVEŘE, KTERÉ SE OTVÍRAJÍ ČASTĚJI — ale jen tam, kde už GABA je. Proto mají strop.

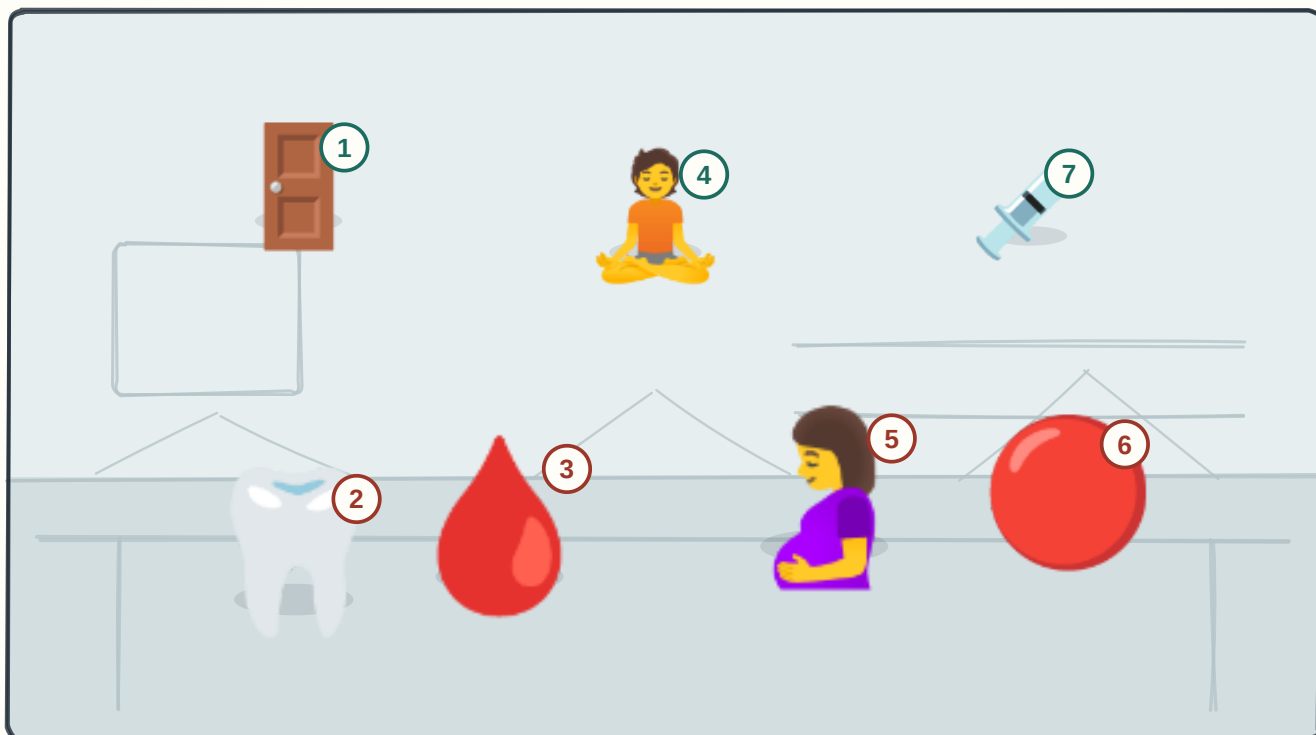


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Rychle kmitající dveře**
Benzodiazepiny zvyšují FREKVENCI otevírání chloridového kanálu GABA-A; barbituráty zvyšují DOBU otevření a ve vysoké dávce kanál otevřou i bez GABA — proto nemají strop.
- 2 Uklidněná postava**
Čtyři účinky: anxiolytický, hypnotický, antikonvulzivní a centrálně myorelaxační; dále anterográdní amnézie (využívá se při výkonech).
- 3 Status epilepticus**
Lék volby u status epilepticus — diazepam, midazolam, lorazepam.
- 4 Sklenka a opioid**
Samotný benzodiazepin dech tlumí málo, ale s ALKOHOLEM, OPIOIDY nebo Z-léčivý hrozí smrtelný útlum dechu — nejčastější příčina úmrtí.
- 5 Flumazenil**
Kompetitivní antagonist; u chronického uživatele nebo při smíšené intoxikaci s tricykly může vyvolat KŘEČE — podává se uvážlivě.
- 6 Oxazepam u jaterní léze**
Krátkce midazolam · středně alprazolam, oxazepam, lorazepam (u jaterní léze — jen konjugace) · dlouze diazepam, klonazepam.
- 7 Odvykací stav**
Odvykací stav je nebezpečný (křeče, delirium) — vysazuje se pomalu.

⚠ U seniorů se preferují krátkodobě působící a jen krátce — dlouhodobě působící benzodiazepiny znamenají pády, zmatenost a zlomeniny krčku.

PŘETÍŽENÁ ROZVODNA — buď se zavře sodíkový kanál, nebo se posílí brzda GABA.

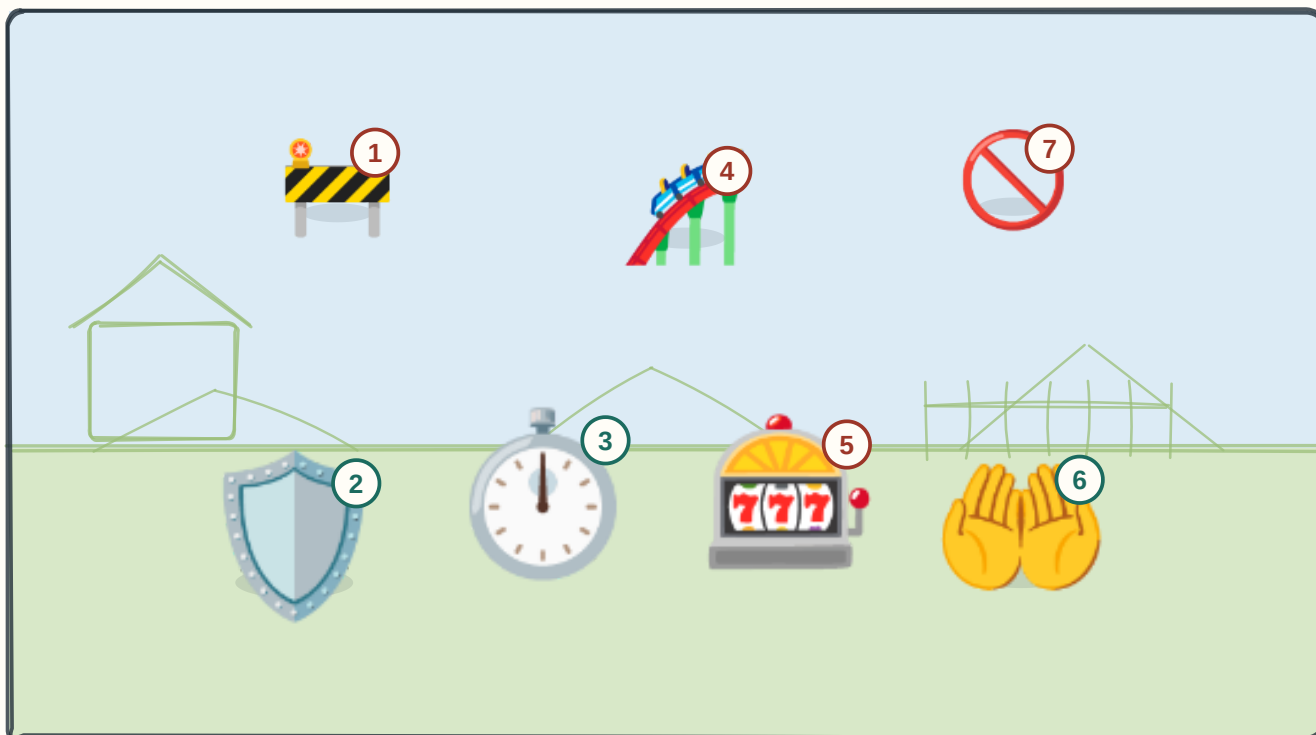


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Zavřený sodíkový kanál**
Blokáda napětově řízených sodíkových kanálů brzdí opakované výboje: fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, lakosamid.
- 2 **Zbytnělé dásně**
FENYTOIN — saturační kinetika, gingivální hyperplazie, hirsutismus.
- 3 **Karbamazepin**
Silný INDUKTOR CYP450 (sníží účinnost kontracepce a warfarinu), hyponatremie, agranulocytóza.
- 4 **Posílená brzda GABA**
Benzodiazepiny, fenobarbital, valproát, tiagabin, vigabatrin. Ethosuximid blokuje kalciové kanály typu T a je lékem volby u absencí.
- 5 **Těhotná**
VALPROÁT je nejsilnější teratogen mezi antiepileptiky (rozštěpy neurální trubice, poruchy vývoje, snížení IQ) — u žen ve fertilním věku jen výjimečně a se spolehlivou kontracepcí.
- 6 **Vyrážka**
LAMOTRIGIN se musí titrovat velmi pomalu — jinak hrozí Stevensův–Johnsonův syndrom; riziko roste při současném valproátu, který jeho hladinu zvyšuje.
- 7 **Status epilepticus**
Lékem první volby je benzodiazepin, dále fenytoin nebo valproát nitrožilně.

! Karbamazepin je induktor, valproát naopak inhibitor — proto jejich kombinace nefunguje intuitivně a hladiny se musí sledovat.

ZÁVORA PŘED MOZKEM — dopamin sám neprojde, proto se posílá LEVODOPA a k ní hlídač.

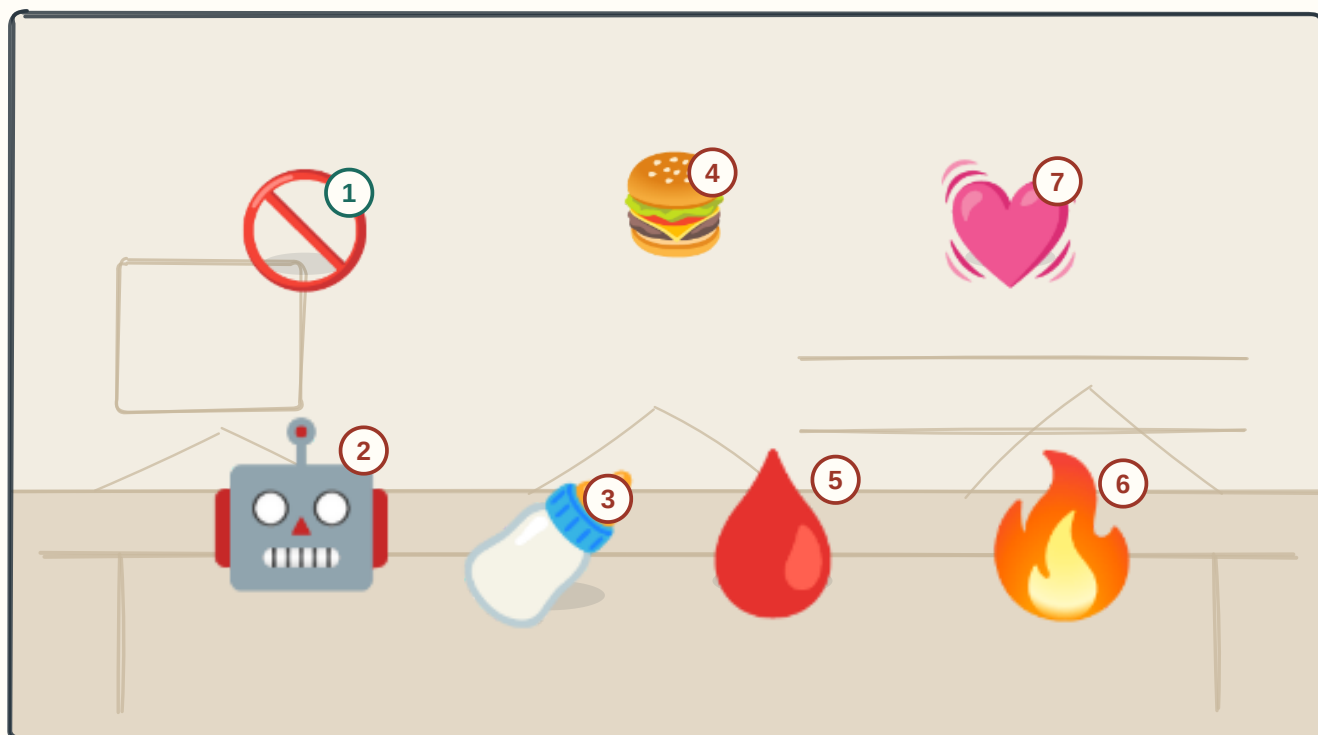


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Závora bariéry**
Dopamin NEPROCHÁZÍ hematoencefalickou bariérou; levodopa ano a v mozku se dekarboxyluje na dopamin.
- 2 Hlídač karbidopa**
Kombinuje se s inhibítozem periférní dekarboxylázy (karbidopa, benserazid) — jinak by se rozložila v těle a způsobila nauzeu, zvracení a hypotenzi.
- 3 Prodloužení účinku**
Inhibitory COMT (entakapon) a MAO-B (selegilin, rasagilin) prodlouží účinek levodopy.
- 4 Horská dráha**
Po letech léčby kolísání účinku (wearing-off, on-off fenomén) a polékové dyskineze — proto se u mladších začíná agonisty dopaminu a levodopa se oddaluje.
- 5 Automat**
Agonisté dopaminu (pramipexol, ropinirol, rotigotin) — poruchy IMPULZIVNÍHO CHOVÁNÍ (hráčství, nakupování, hypersexualita) a náhlé usnutí.
- 6 Třes**
Anticholinergika (biperiden) pomáhají hlavně na třes, ale u starších působí zmatenost. Amantadin tlumí dyskineze.
- 7 Metoklopramid**
Antipsychotika a metoklopramid blokují D2 a vyvolávají polékový parkinsonský syndrom — u parkinsonika se nepodávají.

⚠ Levodopa může u disponovaných vyvolat psychózu — léčba parkinsonismu a léčba psychózy jdou proti sobě a musí se vyvažovat.

DVĚ KŘÍDLA JEDNOHO ODDĚLENÍ — ve starém se ztuhne, v novém se ztloustne.

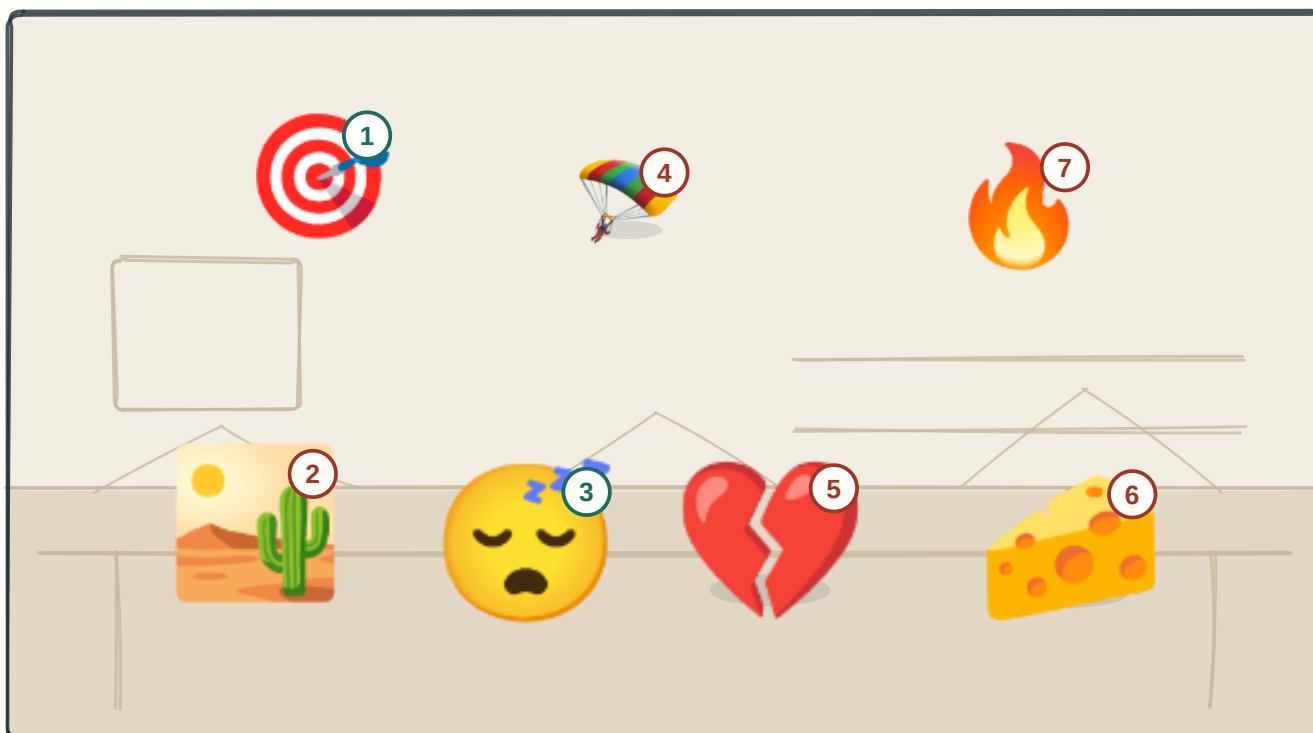


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Blokáda D2**
Účinek na pozitivní příznaky (halucinace, bludy) plyne z blokády D2 v MEZOLIMBICKÉ dráze.
- 2 **Ztuhlá postava**
Klasická (haloperidol, flufenazin, chlorpromazin) blokují D2 i v nigrostriatální dráze: akutní dystonie, parkinsonský syndrom, akatizie a po letech TARDIVNÍ DYSKINEZE, která bývá nevratná.
- 3 **Galaktorea**
Blokáda v tuberoinfundibulární dráze → hyperprolaktinémie: galaktorea, amenorea, gynekomastie.
- 4 **Metabolický syndrom**
Atypická (olanzapin, klozapin, risperidon, kvetiapin, aripiprazol) blokují navíc 5-HT_{2A} — méně hybných potíží, ale přírůstek hmotnosti, diabetes 2. typu a dyslipidemie.
- 5 **Klozapin**
KLOZAPIN působí AGRANULOCYTÓZU — nutné pravidelné kontroly krevního obrazu; je vyhrazen farmakorezistentní schizofrenii.
- 6 **Neuroleptický maligní syndrom**
Horečka, svalová rigidita, porucha vědomí, vzestup kreatinkinázy. Léčba: vysadit neuroleptikum, dantrolen, bromokriptin, podpůrná péče.
- 7 **Prodloužené QT**
Zvláště haloperidol a ziprasidon; dále sedace, ortostatická hypotenze, anticholinergní účinky.

⚠ Negativní příznaky (oploštění, apatie) reagují podstatně hůř než pozitivní — a klasická neuroleptika je mohou dokonce zhoršit.

STARÁ PUŠKA S ŠIROKÝM ROZPTYLEM — treť i to, co treťit neměla.



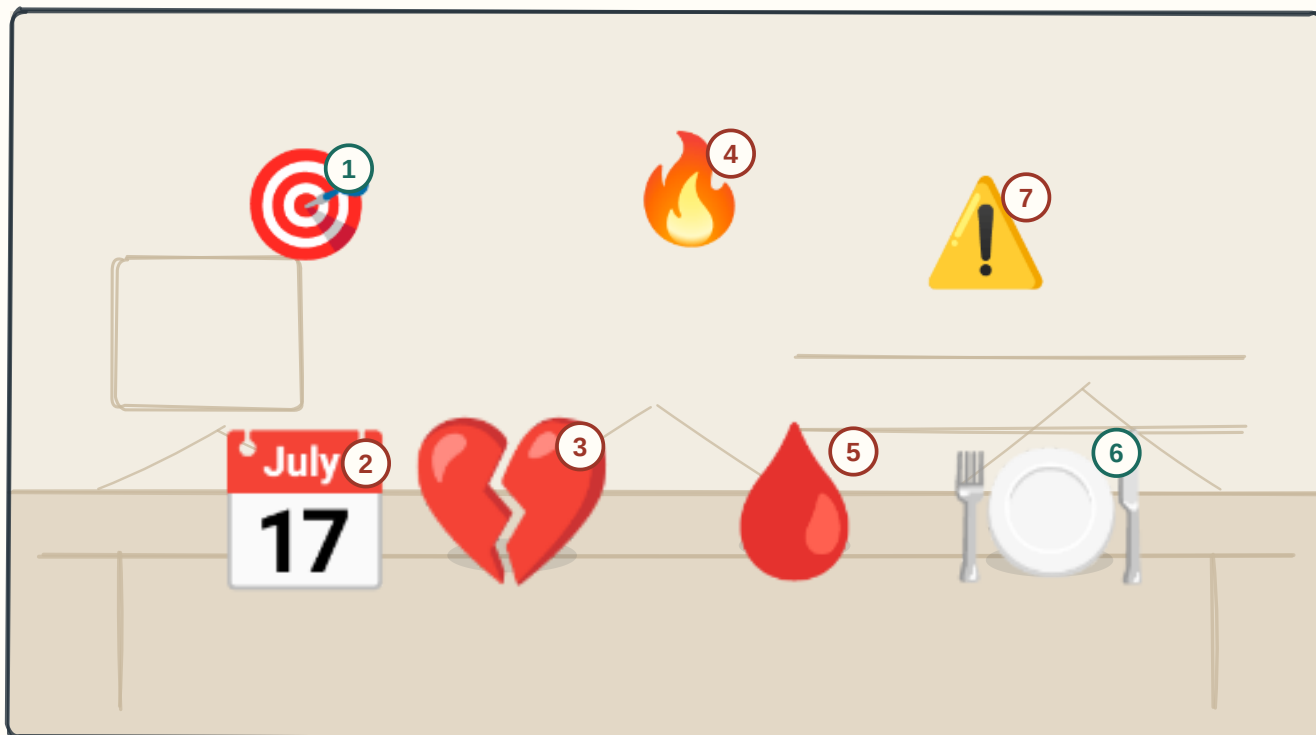
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Široký rozptyl**
Tricyklicka (amitriptylin, klomipramin, imipramin, nortriptylin) blokují zpětné vychytávání noradrenalinu i serotoninu — účinná, ale málo selektivní.
- 2 **Sucho v ústech**
Blokáda muskarinových receptorů: sucho v ústech, rozmazané vidění, zácpa, retence moči, u seniorů zmatenost.
- 3 **Sedace**
Blokáda H1: sedace a přírůstek hmotnosti.
- 4 **Pád při vstávání**
Blokáda α_1 : ortostatická hypotenze a pády.
- 5 **Předávkování**
Blokádou sodíkových kanálů arytmie, rozšíření QRS, křeče a kóma — u suicidálního pacienta se nepředepisují ve velkém balení.
- 6 **Sýrový efekt**
Ireverzibilní neselektivní IMAO (tranylcypromin) — při tyraminu v potravě HYPERTENZNÍ KRIZE. Moklobemid je reverzibilní selektivní inhibitor MAO-A, a proto bezpečnější.
- 7 **Serotoninový syndrom**
Kombinace IMAO s SSRI, tramadolem nebo triptany — horečka, rigidita, myoklonus, neklid; mezi IMAO a SSRI je nutná několikátýdenní pauza.

! Tricyklicka se dnes používají hlavně u neuropatické bolesti a v profylaxi migrény — účinnost mají, ale bezpečnostní profil je proti SSRI nevýhodný.

57 Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

ČEKÁRNA S KALENDÁŘEM — účinek přijde za 2–4 TÝDNY, nežádoucí účinky hned první den.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Úzký terč**

SSRI (sertralin, escitalopram, citalopram, fluoxetin, paroxetin, fluvoxamin) blokují serotoninový transportér — dnes první volba, protože jsou BEZPEČNĚJŠÍ, hlavně při předávkování.
- 2 Kalendář**

Nástup účinku 2–4 týdny, nežádoucí účinky hned — nejčastější důvod, proč pacient léčbu předčasně ukončí.
- 3 Sexuální dysfunkce**

Velmi častá; dále nauzea, nespavost nebo útlum, hyponatremie u seniorů a na začátku zvýšení úzkosti.
- 4 Serotoninový syndrom**

Při kombinaci s IMAO, tramadolem, triptany, linezolidem nebo třezalkou: horečka, rigidita, myoklonus, průjem, neklid až kóma.
- 5 Krvácení**

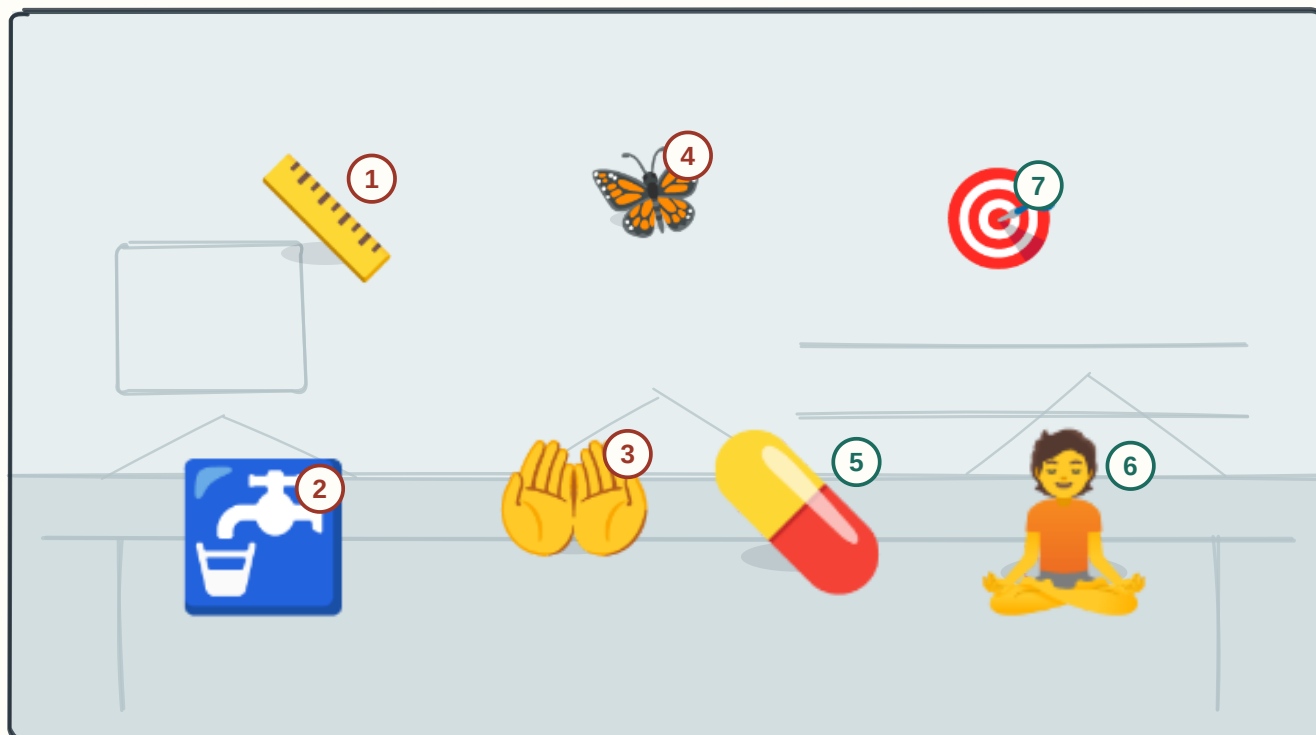
SSRI snižují vychytávání serotoninu i do destiček — spolu s NSA nebo antiagregancii roste riziko krvácení do trávicího traktu.
- 6 Mirtazapin**

SNRI: venlafaxin a duloxetin (i u diabetické neuropatie). Mirtazapin je sedativní a zvyšuje chuť k jídlu — vhodný u nespavosti a kachexie. Bupropion pomáhá při odvykání kouření, ale snižuje práh křečí.
- 7 Syndrom z vysazení**

SSRI se nevysazují náhle (kromě fluoxetinu s dlouhým poločasem) — závratě, „elektrické šoky“, úzkost, chřipkovité příznaky.

! Fluoxetin a paroxetin jsou silné inhibitory CYP2D6 — sníží účinek kodeinu a tamoxifenu, což jsou obě proléčiva.

LÉKÁRNA S PŘESNÝMI VÁHAMI — u lithia se hladiny neměří pro jistotu, ale povinně.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Přesné váhy

LITHIUM má velmi úzké terapeutické okno — hladiny se sledují pravidelně. U bipolární poruchy jako jediné prokazatelně snižuje riziko sebevraždy.

2 Vyschlá studna

Vylučuje se výhradně ledvinami a soupeří se sodíkem — při dehydrataci, zvracení, průjmů, dietě s omezením soli a při NSA, thiazidech nebo ACE inhibitory hladina prudce stoupá.

3 Třes a ataxie

Intoxikace: třes, zvracení, ataxie, zmatenost, křeče.

4 Štítná žláza

Dlouhodobě hypotyreóza (sledovat TSH), nefrogenní diabetes insipidus s polyurií a žízní, tremor, přírůstek hmotnosti. Je teratogenní (Ebsteinova anomálie).

5 Alternativy

Valproát (u mánie, teratogenní), lamotrigin (spíše na depresivní fázi), karbamazepin, atypická antipsychotika.

6 Buspiron

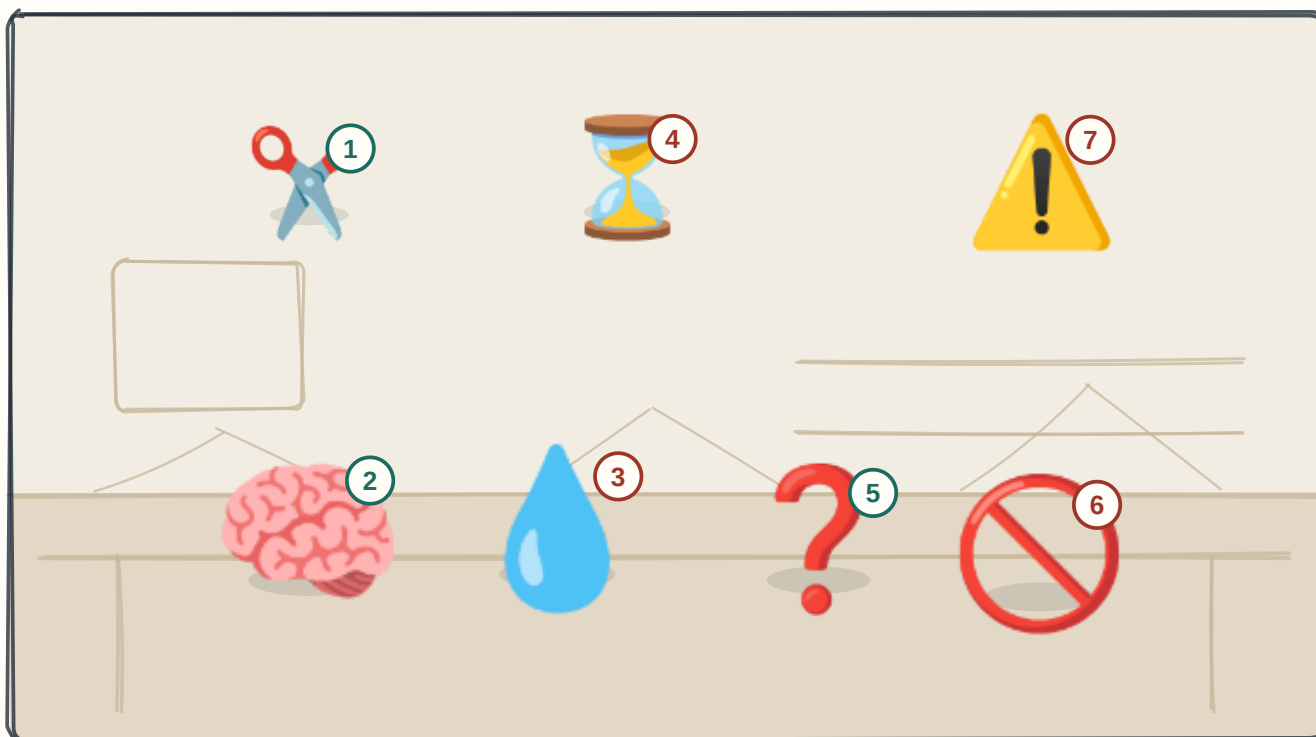
Anxiolytika: benzodiazepiny jen krátkodobě · buspiron (agonista 5-HT_{1A}, nenávykový, pomalý nástup) · hydroxyzin.

7 SSRI dlouhodobě

Pro dlouhodobou léčbu úzkostných poruch jsou lékem volby SSRI a SNRI, nikoli benzodiazepiny.

⚠ U bipolární poruchy se antidepresivum nikdy nepodává samo — může přesmyknout pacienta do mánie; podává se pod clonou stabilizátoru nálady.

DŮM S UBÝVAJÍCÍ PAMĚTÍ — léčba zpomalí příznaky, ale nemoc nezastaví.

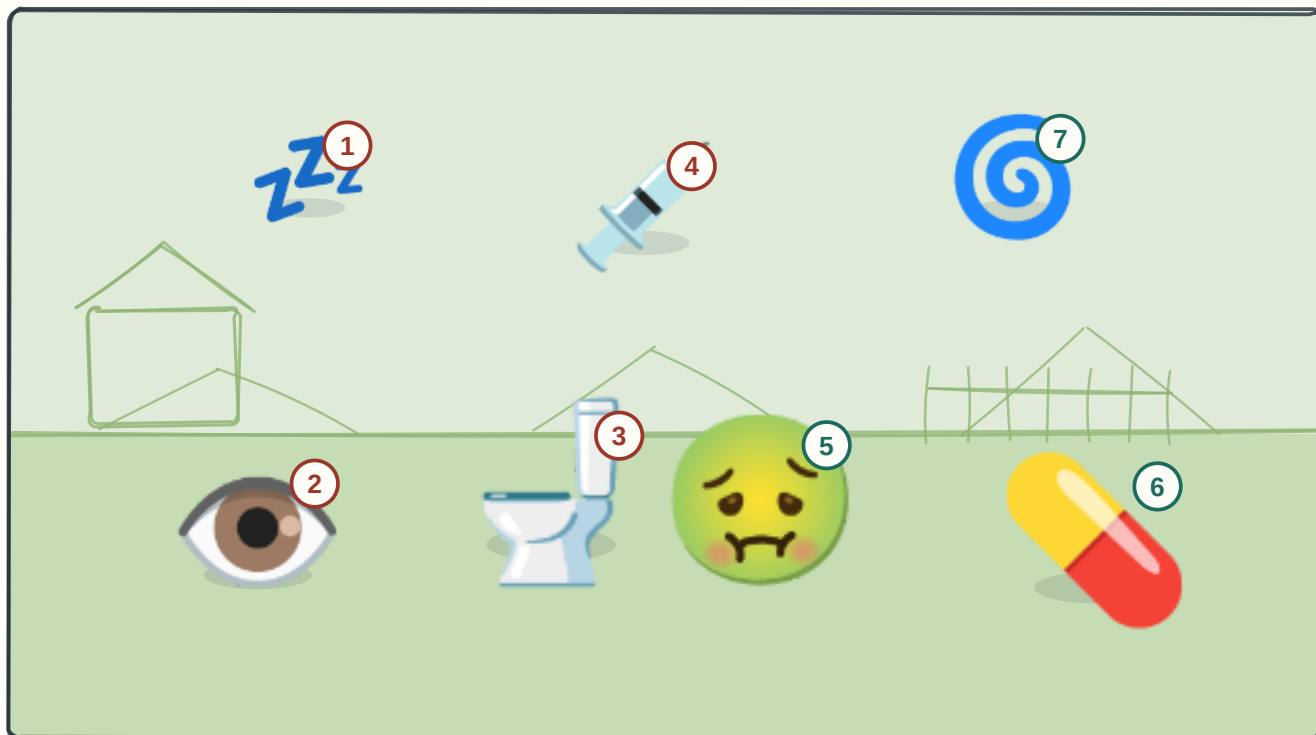


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Zlomené nůžky**
Inhibitory acetylcholinesterázy (donepezil, rivastigmin, galantamin) zvyšují acetylcholin v CNS — u lehké až středně těžké formy.
- 2 **Memantin**
Antagonista NMDA receptoru — chrání před excitotoxicitou glutamátu; u středně těžké až těžké formy. lze kombinovat.
- 3 **Cholinergní obtíže**
Nauzea, zvracení, průjem, nechutenství, bradykardie a synkopy (opatrnost u poruch vedení), noční můry, svalové křeče.
- 4 **Ubývajícím písek**
Léčba zlepšuje kognici a soběstačnost DOČASNĚ — progresi nezastaví.
- 5 **Nootropika**
Piracetam, ginkgo biloba a extrakty mají důkazy o účinnosti slabé; nenahrazují výše uvedenou léčbu.
- 6 **Anticholinergika**
Antihistaminika I. generace, tricyklická a oxybutynin kognici zhoršují — působí přesně proti nasazené léčbě.
- 7 **Antipsychotika u demence**
U poruch chování jen krátce a v nízké dávce — u demence zvyšují mortalitu a riziko cévní mozkové příhody.

! Nefarmakologická opatření (kognitivní trénink, pohyb, léčba přidružených chorob, úprava prostředí) mají u demence srovnatelný význam jako léky.

MÁKOVÉ POLE S TŘEMI ZNAMENÍMI — útlum, špendlíkové zornice a zácpa, která nikdy neustoupí.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Spící postava

μ -receptor: analgezie, euforie, sedace, útlum kašle — a ÚTLUM DECHOVÉHO CENTRA, který je hlavní příčinou smrti při předávkování.

2 Špendlíková zornice

MIÓZA je klíčovým příznakem otravy; triáda: útlum vědomí + útlum dechu + mióza. Tolerance na miózu nevzniká.

3 Zácpa

Zpomalení peristaltiky přes periferní μ -receptory; tolerance prakticky nevzniká — laxativum se podává profylakticky po celou dobu léčby.

4 Naloxon

Kompetitivní antagonist; působí KRÁTCE, proto je nutné opakované podání a sledování — jinak se útlum dechu vrátí. U závislého vyvolá odvykací stav.

5 Nauzea

Stimulace area postrema — nauzea a zvracení; dále retence moči, svědění a uvolnění histaminu, biliární spasmus.

6 Kodein

Proléčivo aktivované CYP2D6 na morfin; používá se jako antitusikum.

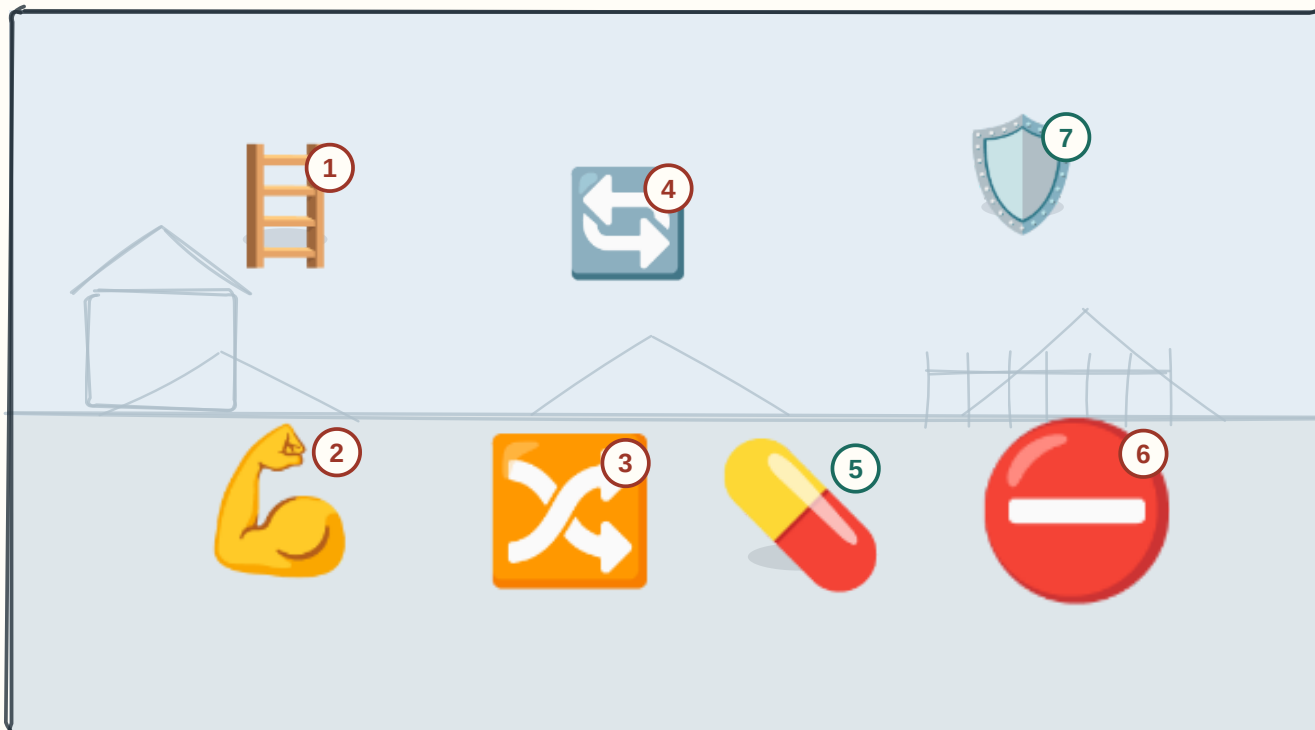
7 Papaverin

Papaverin je myotropní spasmolytikum, nikoli analgetikum. Thebain je výchozí látkou pro polosyntetické opioidy.

⚠ U bolesti při kolice se morfin kombinuje se spasmolytikem, protože sám zvyšuje tonus hladkého svalů a biliární spasmus může zhoršit.

61 Deriváty a náhražky morfinu

ŽEBŘÍK SE STROPEM — parciální agonista výš nevyleze a plného agonistu shodí dolů.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Žebřík se stropem

BUPRENORFIN je parciální agonista μ — má STROPOVÝ efekt (bezpečnější útlum dechu), ale vysokou afinitu: podaný na plného agonistu ho VYTĚSNÍ a vyvolá odvykací stav.

2 Fentanyl

Asi 100× potentnější než morfin — transdermální náplast u chronické nádorové bolesti, i.v. v anestezii. Sufentanil a remifentanil jsou ještě silnější a kratší.

3 Tramadol

Slabý opioidní agonista, který navíc blokuje zpětné vychytávání serotoninu a noradrenalinu — SNIŽUJE PRÁH KŘEČÍ a s SSRI hrozí serotoninový syndrom; je proléčivo aktivované CYP2D6.

4 Metadon

Dlouhý a proměnlivý poločas — vhodný k substituci, ale hrozí kumulace a PRODLOUŽENÍ QT.

5 Oxykodon s naloxonem

Oxykodon se často kombinuje s naloxonem proti zácpě; dále piritramid a hydromorfon.

6 Pethidin

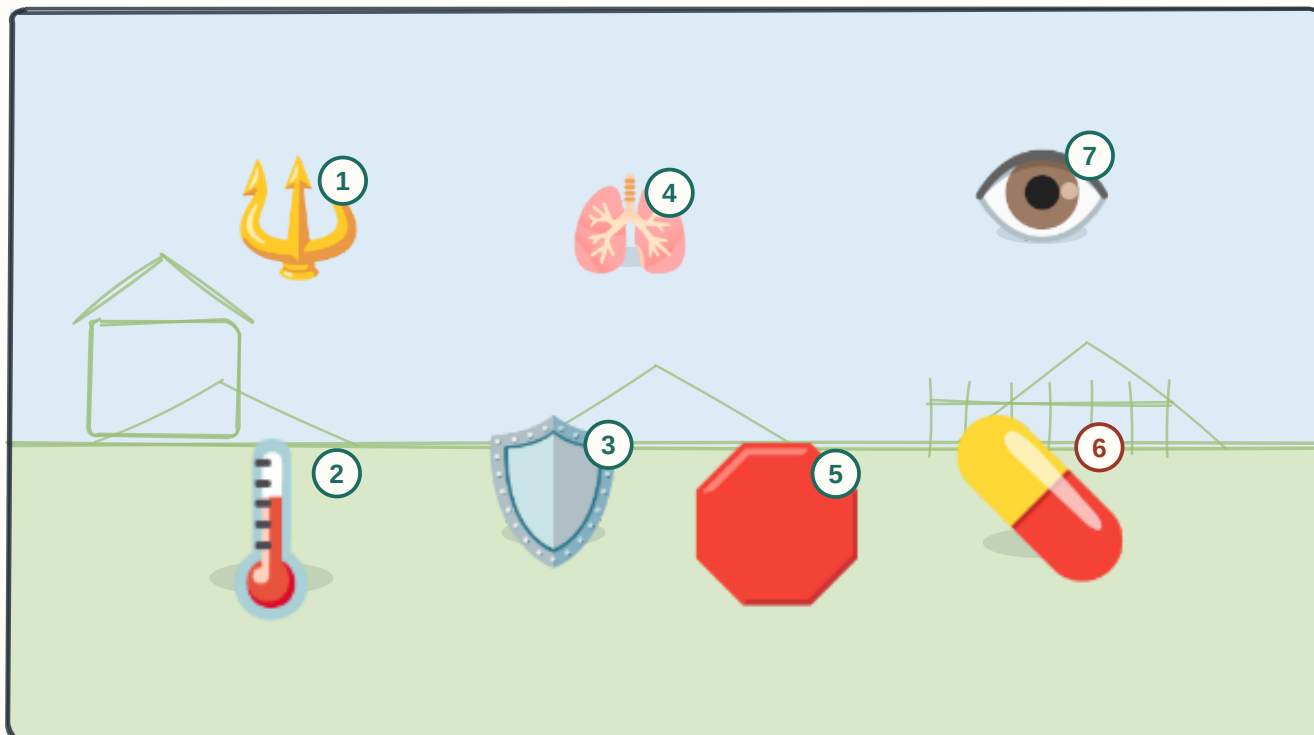
Metabolit norpethidin je neurotoxický — dnes se nedoporučuje.

7 Naltrexon

Dlouhodobě působící antagonist v udržovací léčbě závislosti (i na alkoholu); naloxon slouží akutně při předávkování.

⚠ Agonisté-antagonisté (nalbupin, pentazocin) mají také strop a u pacienta na plném agonistovi mohou vyvolat odvykací stav — stejně jako buprenorfin.

ROZCESTÍ NAD KYSELINOU ARACHIDONOVOU — dvě cesty. NSA zavře jednu, kortikoid obě.



CO JE VE SCÉNĚ

① Rozcestník

Fosfolipáza A2 uvolní z membrány KYSELINU ARACHIDONOVOU; z ní vycházejí dvě větve.

② Cesta COX

Cyklooxygenáza tvoří prostaglandiny (zánět, bolest, horečka, ochrana žaludeční sliznice, průtok ledvinami), prostacyklin PGI₂ (vazodilatace, brzdí agregaci) a tromboxan TXA₂ (vazokonstrikce, podporuje agregaci).

③ COX-1 versus COX-2

COX-1 je konstitutivní (ochranná), COX-2 indukovaná zánětem.

④ Cesta LOX

Lipoxygenáza tvoří LEUKOTRIENY — silná bronchokonstrikce, zvýšená propustnost cév a chemotaxe; odtud montelukast u astmatu.

⑤ Kortikoid nahoře

Glukokortikoidy inhibují fosfolipázu A2 (přes lipokortin) a zavřou OBĚ větve — proto jsou protizánětlivě účinnější než NSA.

⑥ Misoprostol

Analog PGE₁ chrání žaludek před NSA, ale je KONTRAINDIKOVÁN V GRAVIDITĚ.

⑦ Latanoprost

Léčebné využití eikosanoidů: latanoprost (glaukom), alprostadil, dinoproston (indukce porodu), epoprostenol (plicní hypertenze).

⚠ Aspirinem indukované astma vzniká právě tady: zablokovaná COX odkloní kyselinu arachidonovou do LOX větve a vznikne nadbytek leukotrienů.

BEZPEČNÝ DŮM S JEDNOU PROPADLINOU — paracetamol nedráždí nic, ale při předávkování zničí játra.

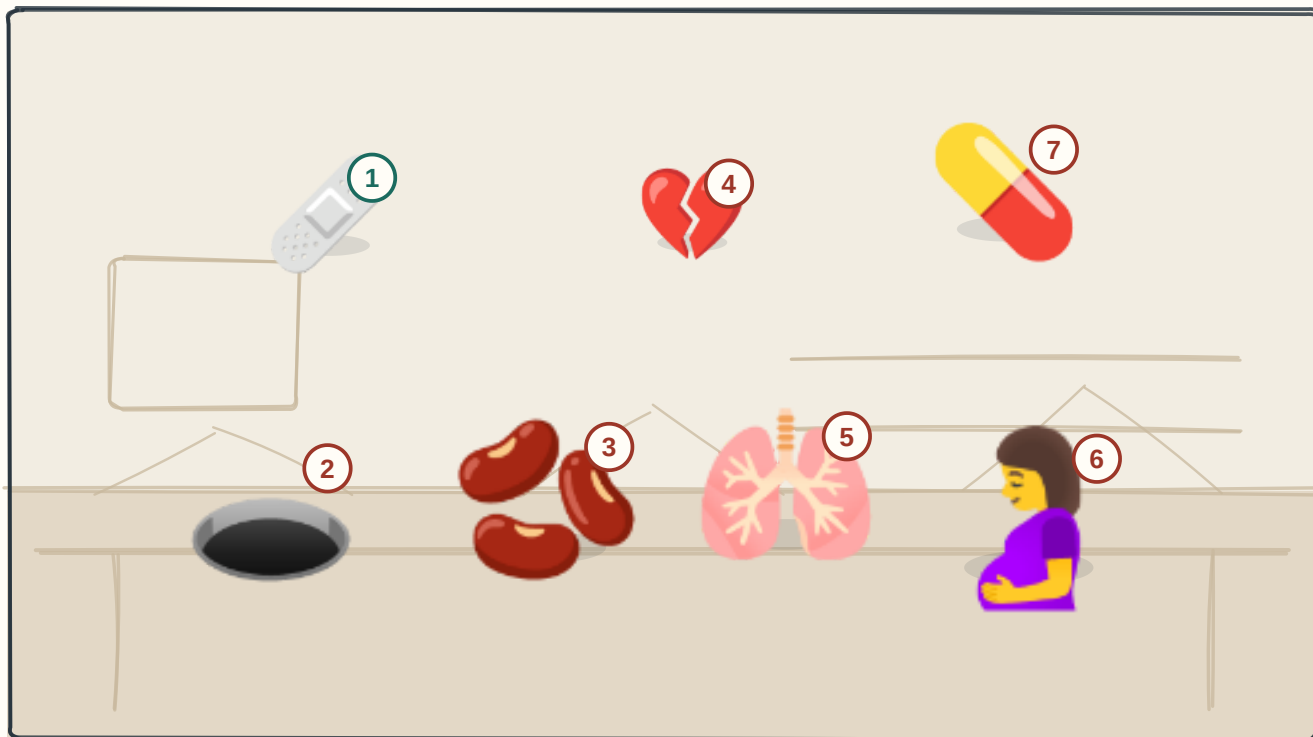


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Teploměr**
PARACETAMOL působí centrálně (COX v CNS) — analgeticky a antipyreticky; protizánětlivý účinek prakticky nemá.
- 2 **Těhotná**
Nedráždí žaludeční sliznici, neovlivňuje agregaci destiček a nezhoršuje astma — analgetikum první volby v graviditě, u dětí a u vředové choroby.
- 3 **Propadlina**
Při vyčerpání glutathionu se hromadí toxický metabolit NAPQI a vzniká centrolobulární jaterní nekróza.
- 4 **Alkoholik**
Riziko stoupá u chronického alkoholika, malnutrice a při hladovění.
- 5 **Opožděné potíže**
Potíže se objeví se zpožděním 1–2 dnů, kdy už může být poškození nevratné.
- 6 **N-acetylcystein**
ANTIDOTUM — doplní glutathion; podává se i při pouhém podezření podle nomogramu, účinný je zvláště v prvních hodinách.
- 7 **Metamizol**
Silné analgetikum se spasmolytickým účinkem (vhodné u kolik) — riziko AGRANULOCYTÓZY a hypotenze při rychlém i.v. podání.

⚠ Paracetamol je v mnoha kombinovaných přípravcích proti chřipce — pacient si tak snadno nevědomky podá dvojnásobnou denní dávku. Na to se ptej cíleně.

TŘI PROPADLINY NAJEDNOU — žaludek, ledvina a srdce. NSA škodí všem třem současně.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Ustupující zánět

Inhibice COX snižuje tvorbu prostaglandinů — analgeticky, antipyreticky a **PROTIZÁNĚTLIVĚ** (na rozdíl od paracetamolu).

2 Vřed

COX-1 tvoří prostaglandiny chránící žaludeční sliznici; jejich úbytek vede k erozím a vředům, které mohou krváct **BEZ** varovné bolesti. U rizikových se přidává inhibitor protonové pumpy.

3 Ledvina

Prostaglandiny udržují průtok ledvinou; NSA ho snižují — retence sodíku a vody, otoky, vzestup tlaku, zhoršení srdečního selhání a riziko akutního poškození ledvin.

4 Koxiby

Selektivní inhibitory COX-2 šetří žaludek, ale zvyšují riziko trombotických příhod. Naproxen má z NSA nejvyšší kardiovaskulární riziko.

5 Aspirinem indukované astma

Odklon do leukotrienové větve; dále alergie.

6 Třetí trimestr

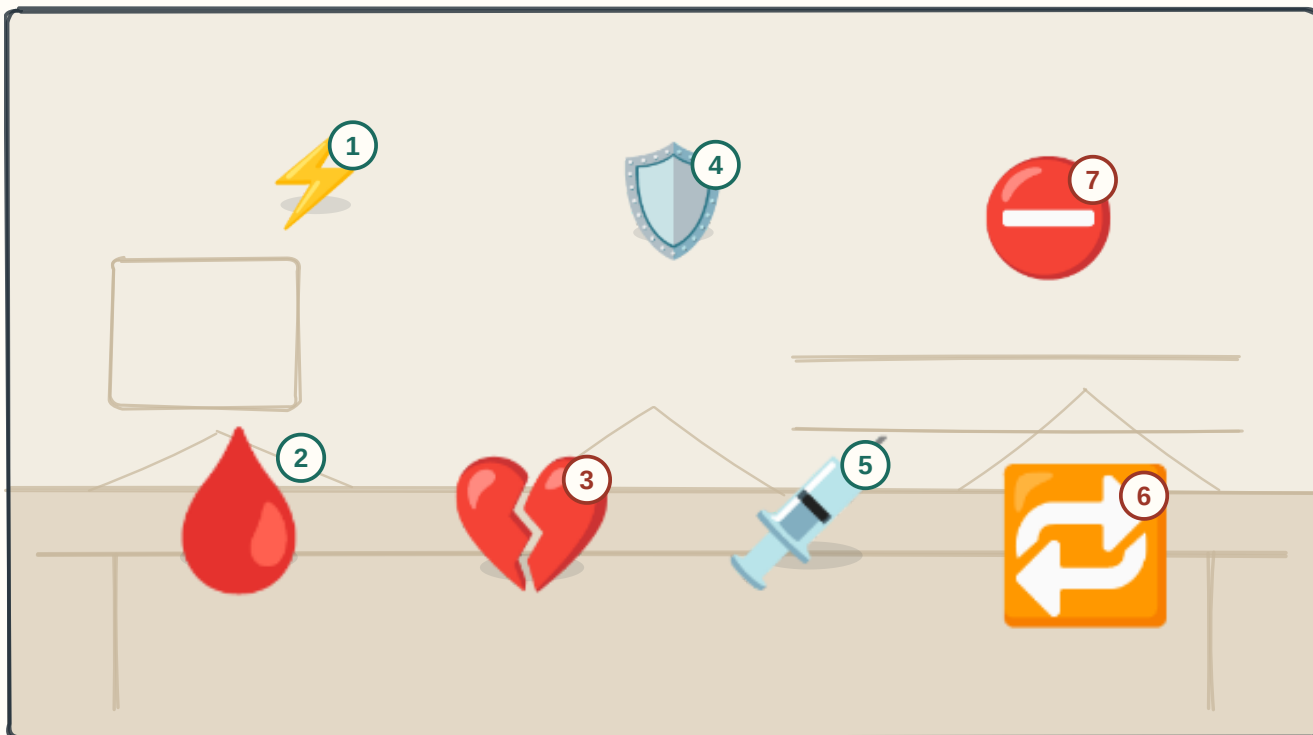
Předčasný uzávěr ductus arteriosus — ve třetím trimestru kontraindikované.

7 Ibuprofen před aspirinem

Ibuprofen ruší antiagregační účinek nízkodávkovaného aspirinu, pokud se podá před ním.

⚠ Nízká dávka kyseliny acetylsalicylové (75–100 mg) blokuje COX-1 v destičkách NEVRATNĚ na celou jejich životnost — proto působí antiagregačně, ne protizánětlivě.

DVOJE DVEŘE — jedny na probíhající záchvat, druhé na prevenci. Zaměnit je je klasická chyba.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Akutní záchvat

Lehký záchvat: NSA nebo paracetamol, co nejdříve, s prokinetikem (metoklopramid) proti zvracení a zpomalenému vyprazdňování žaludku.

2 Triptan

Sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan jsou agonisté 5-HT_{1B/1D} — stahují rozšířené intrakraniální cévy a tlumí uvolňování neuropeptidů.

3 Kontraindikace triptanů

Ischemická choroba srdeční, neléčená hypertenze, prodělaná cévní mozková příhoda, hemiplegická migréna. S SSRI hrozí serotoninový syndrom.

4 Profylaxe

Při častých nebo těžkých atakách: propranolol, metoprolol, topiramát, valproát (ne u žen ve fertilním věku), amitriptylin, kandesartan.

5 Anti-CGRP

Monoklonální protilátky proti CGRP (erenumab) a gepanty.

6 Bolest z nadužívání

Vzniká při užívání analgetik více než ~10–15 dní v měsíci — léčí se VYSAZENÍM, ne přidáním.

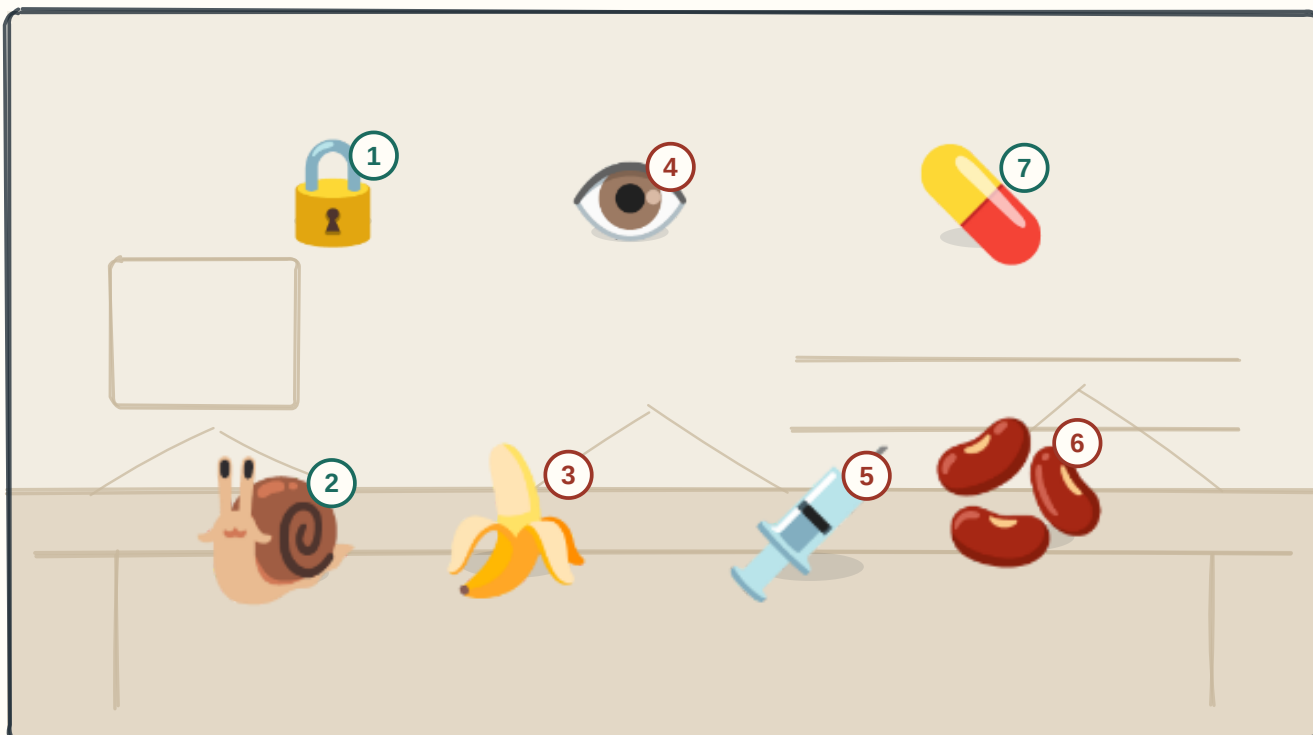
7 Ergotamin

Dnes okrajově — silná a dlouhá vazokonstrikce, riziko ergotismu; nikdy se nekombinuje s triptanem.

⚠ Triptan není analgetikum a na tenzní bolest hlavy nefunguje; naopak profylaktikum neuleví od probíhajícího záchvatu.

66 Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

ZASEKNUTÁ PUMPA — sodík zůstane v buňce, nevymění se za vápník, a vápníku přibude. A všechno stojí na DRASLÍKU.

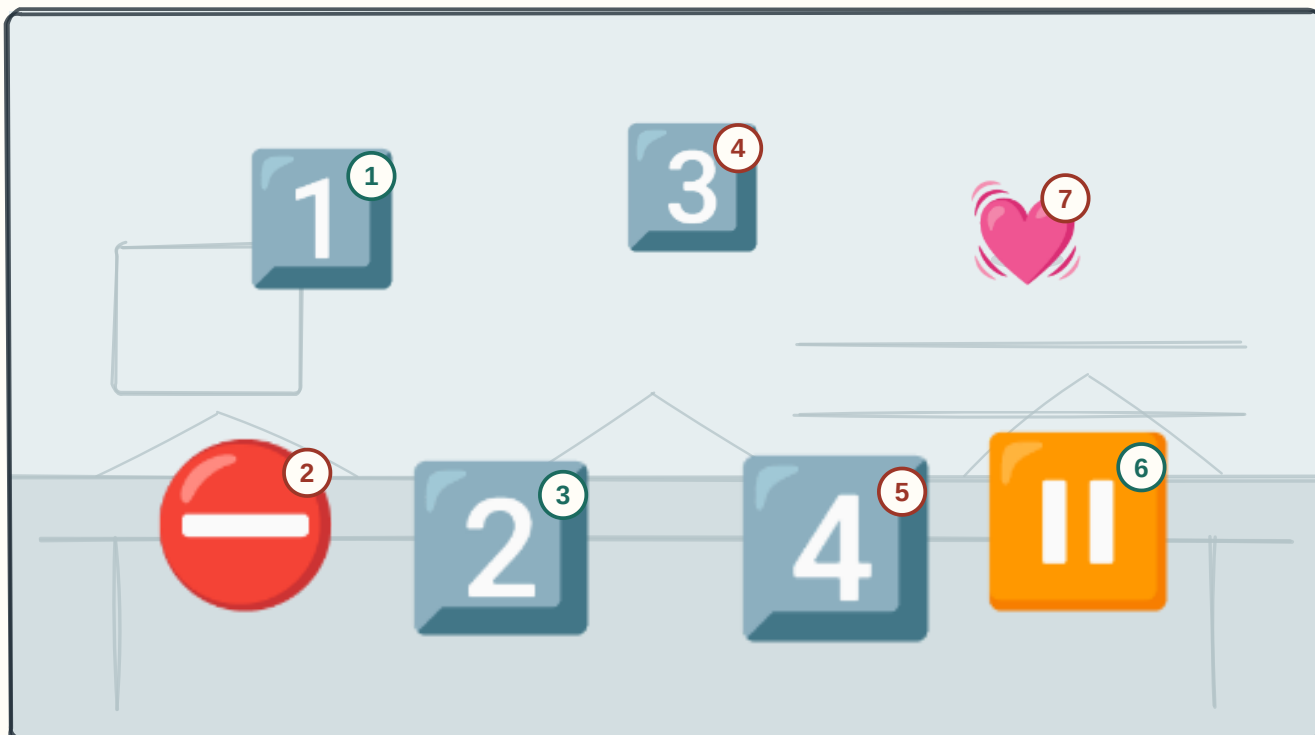


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Zaseknutá pumpa**
Inhibice Na^+/K^+ -ATPázy zvýší nitrobuněčný sodík, tím se zpomalí výměník $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ a v buňce zůstane více VÁPŇÍKU — odtud pozitivně inotropní účinek.
- 2 Zpomalený převod**
Zvyšuje tonus vagu — zpomaluje frekvenci a vedení AV uzlem; u fibrilace síní s rychlou odpovědí komor a u srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (mortalitu nesnižuje, jen příznaky).
- 3 Chybějící draslík**
Digoxin soupeří s draslíkem o totéž vazebné místo — při HYPOKALEMII se váže víc a toxicita prudce roste. Pozor při kličkových a thiazidových diureticích, zvracení a průjmu.
- 4 Žluté vidění**
Intoxikace: nauzea, zvracení, průjem, poruchy barevného vidění (žlutozelené, halo), zmatenost a arytmie (bigeminie, AV blokáda).
- 5 Fab protilátky**
Antidotem jsou protilátky (Fab fragmenty). Úzké terapeutické okno — měří se hladiny.
- 6 Ledvina**
Vylučuje se ledvinami — u renální insuficience a u seniorů se dávka snižuje. Amiodaron, verapamil a chinidin hladinu zvyšují.
- 7 Ostatní inotropika**
Dobutamin (β_1 -agonista) a inhibitory fosfodiesterázy III (milrinon) jen krátkodobě u akutního selhání; levosimendan zvyšuje citlivost myofilament na vápník.

⚠ Hyperkalcemie a hypomagnezemie toxicitu digoxinu také zvyšují — proto se u pacienta na digoxinu sledují ionty jako celek, ne jen draslík.

ČTYŘI PŘEPÍNAČE V ROZVODNĚ — sodík, beta, draslík, vápník. A skoro každý umí sám vyvolat arytmií.

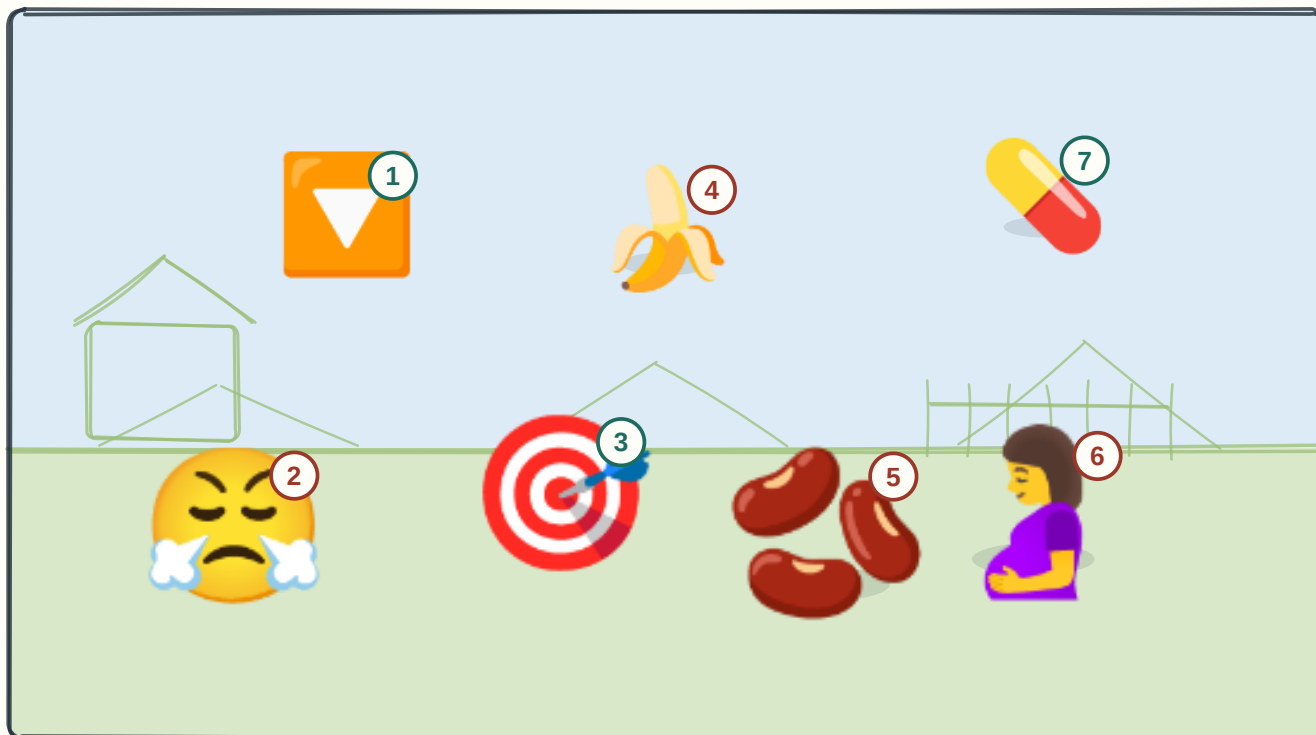


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Přepínač I — sodík**
Ia (chinidin, prokainamid) prodlužují repolarizaci; Ib (lidokain, mexiletin) ji zkracují (komorové arytmie u ischemie); Ic (propafenon, flekainid) nejsilněji zpomalují vedení.
- 2 **Zákaz po infarktu**
Třída Ic je kontraindikovaná po infarktu a při strukturálním poškození srdce — zvyšuje mortalitu.
- 3 **Přepínač II — beta**
 β -blokátory zpomalují sinusový uzel a vedení AV uzlem; SNIŽUJÍ MORTALITU, což většina ostatních antiarytmik neumí.
- 4 **Přepínač III — draslík**
Blokáda draslíkových kanálů prodlužuje repolarizaci a QT. AMIODARON je nejúčinnější, ale má rozsáhlou orgánovou toxicitu: plicní fibróza, hepatotoxicita, tyreopatie (obsahuje jod), depozita v rohovce, fotosenzitivita a šedomodré zbarvení kůže; poločas týdny až měsíce.
- 5 **Přepínač IV — vápník**
Verapamil a diltiazem zpomalují AV uzel u supraventrikulárních arytmií. NEKOMBINOVAT s β -blokátorem a nepodávat u srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí.
- 6 **Adenosin**
Mimo klasifikaci: adenosin (přechodná AV blokáda ukončí supraventrikulární tachykardii), digoxin, magnezium u torsade de pointes, ivabradin.
- 7 **Torsade de pointes**
Léčiva prodlužující QT (III. třída, ale i makrolidy, chinolony, antipsychotika, ondansetron) se v riziku SČÍTÁJÍ.

⚠ Proarytmogenní účinek je vlastní celé skupině — antiarytmikum se proto nasazuje jen tehdy, když prospěch jasně převáží nad tímto rizikem.

JEDEN ENZYM, DVĚ PRÁCE — tvoří angiotensin II a rozkládá bradykinin. Odtud kašel.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Klesající tlak

Blokádou ACE klesá angiotensin II — cévy se rozšíří, klesne aldosteron. Chrání ledviny u diabetické nefropatie a snižují mortalitu u srdečního selhání a po infarktu.

2 Suchý kašel

ACE rozkládá i BRADYKININ; při blokádě se hromadí — suchý dráždivý kašel (až 15 %) a vzácně angioedém.

3 Sartan

Sartany (losartan, valsartan, telmisartan) blokují receptor AT1 přímo, bradykinin neovlivňují, a proto kašel nevyvolávají.

4 Hyperkalemie

Nekombinovat s kalium šetřícími diuretiky a doplňky draslíku.

5 Stenóza renální tepny

Oboustranná stenóza renálních tepen je kontraindikací — filtrace závisí na angiotensinu II a její blokáda způsobí selhání ledvin.

6 Gravidita

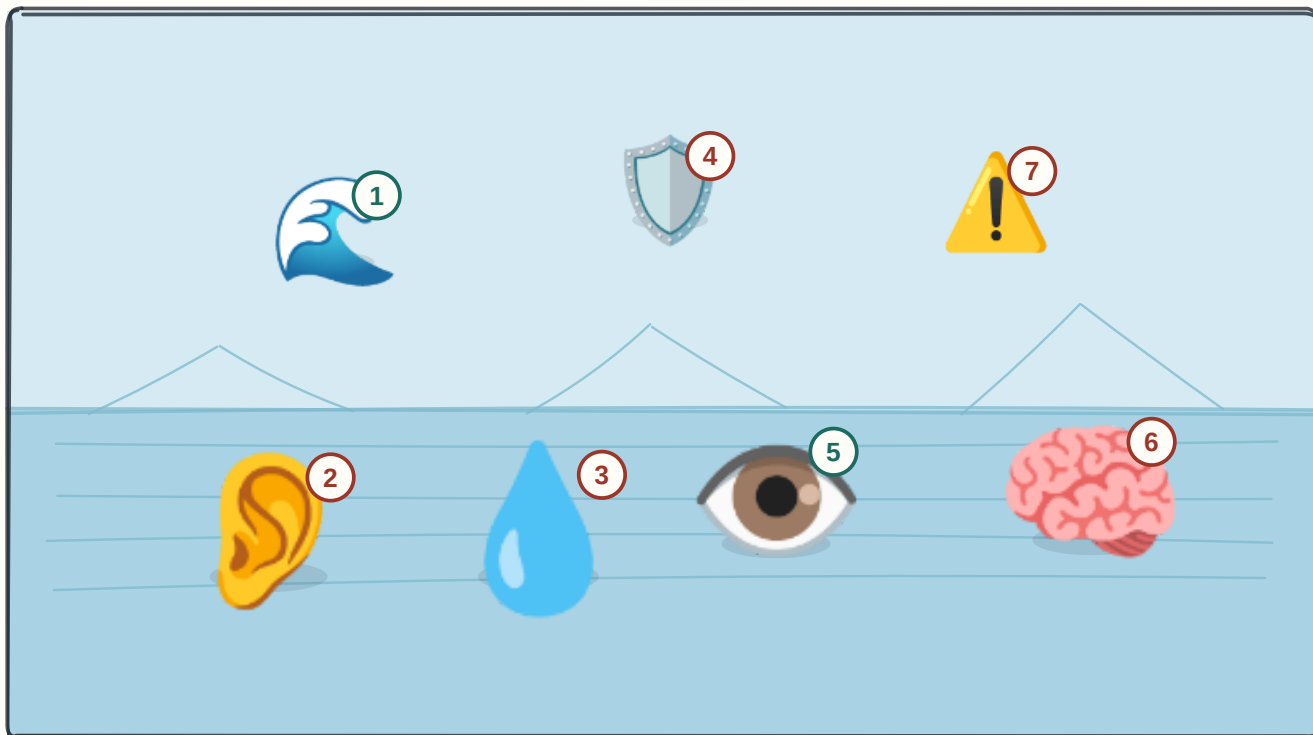
ACE inhibitory i sartany jsou v graviditě ABSOLUTNĚ kontraindikované — poškozují ledviny plodu, oligohydramnion, hypoplazie lebky.

7 ARNI

Sakubitril/valsartan je u srdečního selhání účinnější než samotný ACE inhibitor. ACE inhibitor a sartan se spolu nepodávají.

! „Trojkombinace“ ACE inhibitor + diuretikum + NSA je klasická příčina akutního poškození ledvin — na to se u pacienta s otoky ptej cíleně.

ŘEKA S ČTYŘMI STAVIDLY — kde v nefronu stavidlo stojí, to určuje sílu i nežádoucí účinek.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Stavidlo v kličce

FUROSEMID blokuje kotransportér Na-K-2Cl ve vzestupném raménku Henleovy kličky — nejsilnější účinek, funguje i při renální insuficienci.

2 Ototoxicita

Kličková: hypokalemie, hyponatremie, hypomagnezemie, hypovolemie, metabolická alkalóza, hyperurikemie a OTOTOXICITA (zvláště s aminoglykosidy).

3 Thiazidové stavidlo

Hydrochlorothiazid, indapamid — blokují Na-Cl kotransportér v distálním tubulu. ZVYŠUJÍ vápník v krvi (na rozdíl od kličkových), zvyšují kyselinu močovou (mohou vyprovokovat dnu), glykemii a lipidy; hypokalemie a hyponatremie.

4 Spironolakton

Antagonisté aldosteronu (spironolakton, eplerenon) snižují mortalitu u srdečního selhání; hlavním rizikem je HYPERKALEMIE, spironolakton navíc gynekomastie.

5 Acetazolamid

Inhibitor karboanhydrázy — glaukom, výšková nemoc, metabolická alkalóza.

6 Manitol

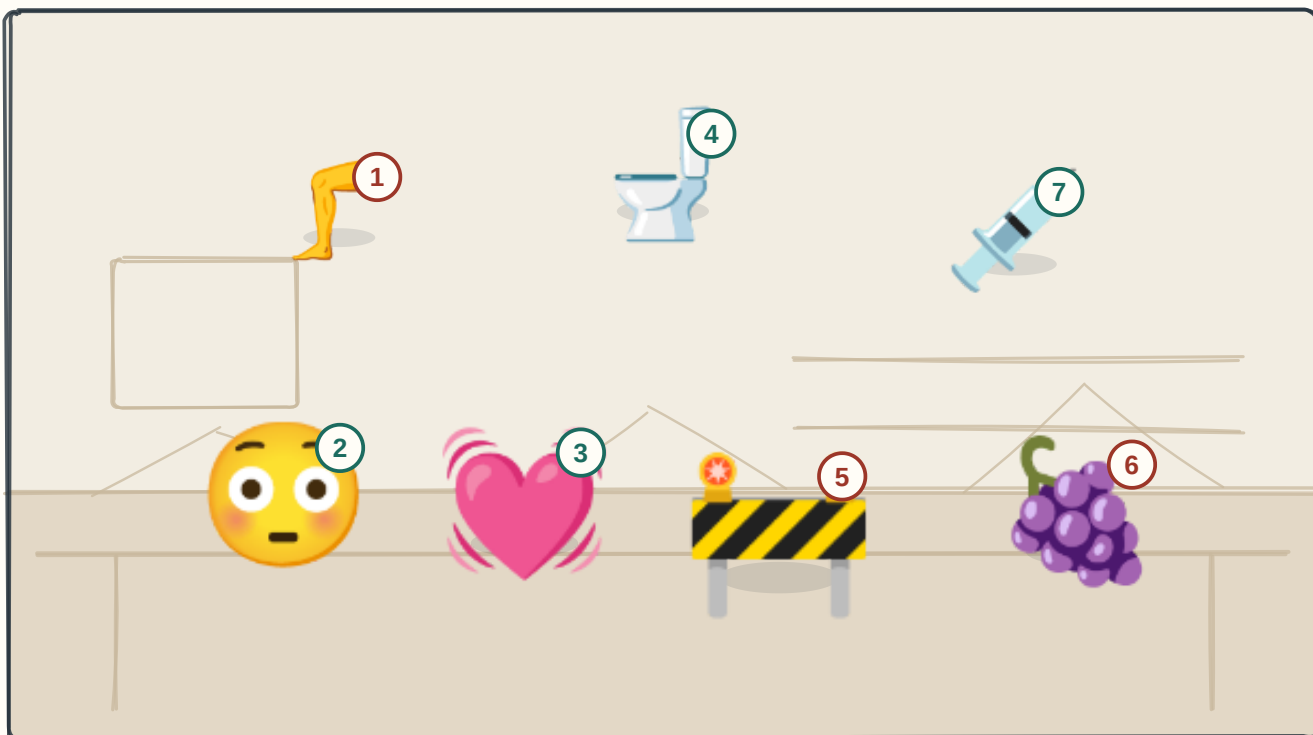
Osmotické diuretikum u nitrolební hypertenze a edému mozku — kontraindikováno u srdečního selhání a anurie.

7 Sekvenční blokáda

Kličkové s thiazidem působí velmi silně — riziko těžkých iontových poruch.

⚠ Hypokalemie po diuretiku zvyšuje toxicitu digoxinu a riziko arytmií — u pacienta na obojím se draslík kontroluje pravidelně.

DVĚ ULICE JEDNOHO MĚSTA — jedna vede k CÉVĚ, druhá k SRDCI.



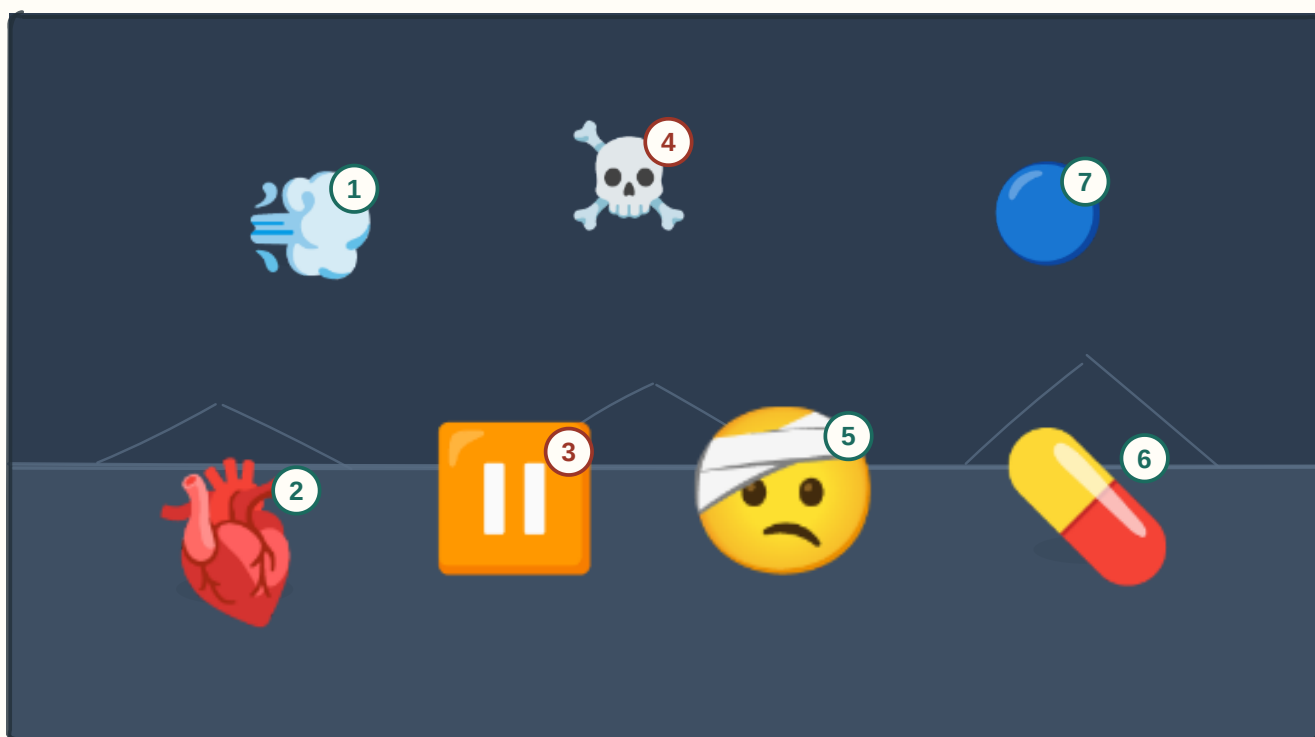
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Oteklé kotníky**
DIHYDROPYRIDINY (amlodipin, nifedipin, lerkandipin, nimodipin) působí na hladký sval CÉV — vazodilatace, pokles tlaku. Otoky kotníků nereagují na diuretikum.
- 2 **Návaly a bolest hlavy**
Dále reflexní tachykardie a gingivální hyperplazie. Nimodipin u vazospasmu po subarachnoidálním krvácení.
- 3 **Zpomalené srdce**
VERAPAMIL (fenylalkylamin) a DILTIAZEM (benzothiazepin — ne benzodiazepin) tlumí i srdce: zpomalují sinusový uzel a vedení AV uzlem, snižují kontraktilitu.
- 4 **Zácpa**
Verapamil typicky působí zácpu.
- 5 **Zakázaná kombinace**
Verapamil ani diltiazem se NEKOMBINUJÍ s β -blokátořem — hrozí těžká bradykardie a AV blokáda; nepodávají se ani u srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí.
- 6 **Grapefruit**
Metabolizují se CYP3A4 — grapefruitová šťáva a azolová antimykotika jejich hladinu prudce zvyšují.
- 7 **Předávkování**
Léčí se kalcie a vysokodávkovaným inzulínem s glukózou.

⚠ Krátkodobě působící nifedipin se u hypertenze nepoužívá — prudký pokles tlaku vyvolá reflexní tachykardii a může vyprovokovat ischemii.

71 Nitrity a nitráty

PLYNOVÁ TRUBKA S NOČNÍ PAUZOU — kdo ji nezavře na noc, ráno už mu nefunguje.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Unikající plyn**

Nitráty jsou zdrojem OXIDU DUSNATÉHO, který zvýší cyklický GMP a relaxuje hladký sval cévy.
- 2 Odlehčené srdce**

Převažuje dilatace ŽIL — klesá žilní návrat a předtížení, a tím spotřeba kyslíku myokardem; ve vyšších dávkách i dilatace tepen a koronární vazodilatace.
- 3 Noční pauza**

Při trvalé hladině vzniká během dne TOLERANCE — proto se ponechává interval 8–12 hodin bez nitrátu (náplast se na noc sundává).
- 4 Sildenafil**

Kombinace s inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil) je ABSOLUTNĚ kontraindikovaná — obě látky zvyšují cGMP a spolu způsobí život ohrožující hypotenzi.
- 5 Bolest hlavy**

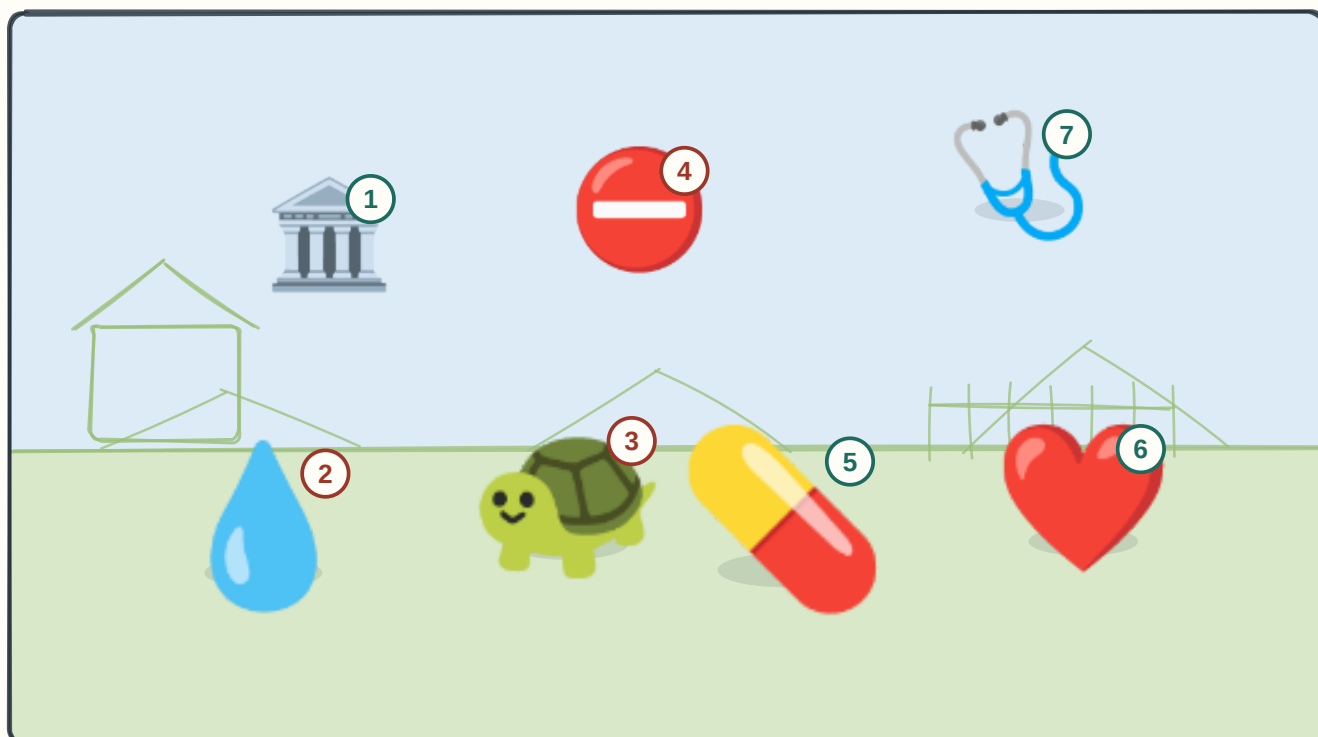
Nežádoucí: pulzující bolest hlavy, návaly, ortostatická hypotenze, reflexní tachykardie.
- 6 Zástupci**

Nitroglycerin sublingválně u akutní ataky, isosorbid-dinitrát a -mononitrát dlouhodobě, nitroprusid sodný v infuzi u hypertenzní krize.
- 7 Dusitany a kyanidy**

Dusitany oxidují hemoglobin na methemoglobin — proto se dusitan sodný používá jako antidotum otravy kyanidy.

! Kontraindikací nitrátů je hypertrofická obstrukční kardiomyopatie a těžká aortální stenóza — snížení předtížení tam vede k prudkému poklesu srdečního výdeje.

ČTYŘI PILÍŘE JEDNÉ STAVBY — a diuretikum, které jen uklidí vodu, ale stavbu nedrží.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Čtyři pilíře

U selhání se sníženou ejekční frakcí snižují mortalitu: ACE inhibitor (nebo ARNI), β -blokátor, antagonisty mineralokortikoidních receptorů a GLIFLOZINY.

2 Diuretikum

Klíčková diuretika odstraní městnání a dušnost — zlepší PŘÍZNAKY, ale PROGNOZU nezmění. Dávka se titruje podle hmotnosti a otoků.

3 Pomalá titrace

β -blokátor se zahajuje až u stabilizovaného pacienta a velmi nízkou dávkou — na začátku může selhání přechodně zhoršit, přestože dlouhodobě prodlužuje život.

4 Zakázané léky

NSA (retence sodíku a vody, zhoršení funkce ledvin), verapamil a diltiazem (negativně inotropní), glitazony, většina antiarytmik I. třídy.

5 Digoxin

Zlepší příznaky a kontrolu frekvence u fibrilace síní; mortalitu nesnižuje.

6 Ivabradin

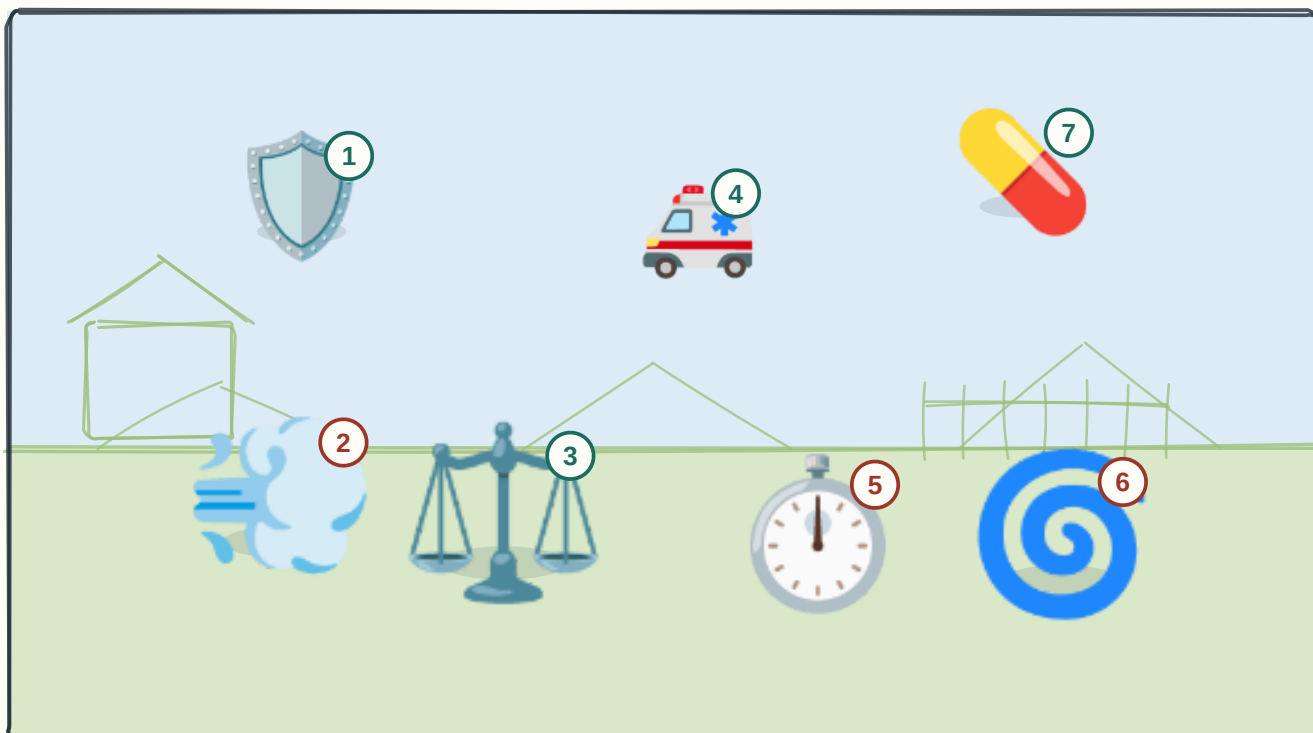
Při vysoké frekvenci na sinusovém rytmu.

7 Zachovaná ejekční frakce

Tam je průkaz účinku slabší — zůstávají glifloziny, léčba městnání diuretikem a důsledná léčba přidružených chorob.

⚠ Cílem není „posílit srdce“, ale odlehčit mu — proto pilíře léčby snižují zátěž a neurohumorální aktivaci, místo aby zvyšovaly kontraktilitu.

DVĚ VĚTVE JEDNÉ LÉČBY — jedna prodlužuje ŽIVOT, druhá jen ulevuje.

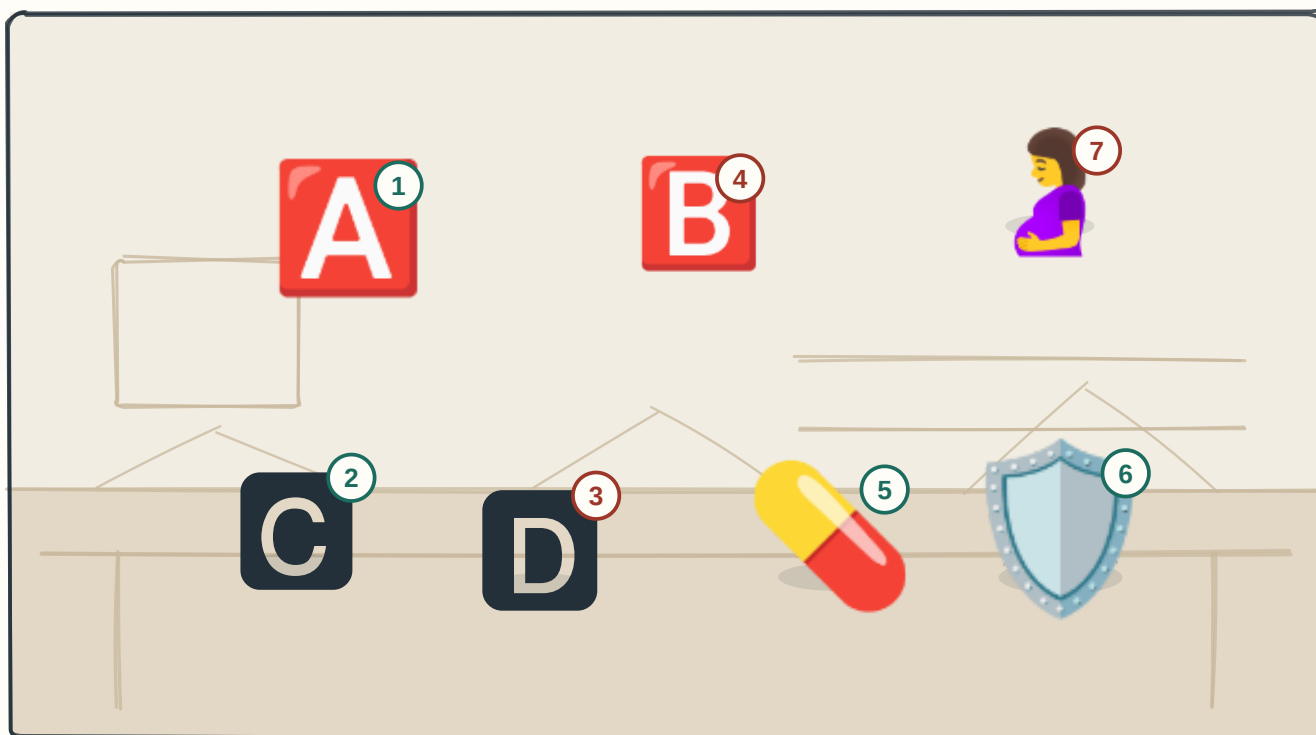


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Větev prognostická**
Prognózu zlepšují: kyselina acetylsalicylová (nebo klopido­grel), STATIN ve vysoké dávce bez ohledu na výchozí cholesterol, ACE inhibitor a β -blokátor (zvláště po infarktu).
- 2 Větev symptomatická**
Nitráty, β -blokátory a blokátory kalciových kanálů snižují spotřebu kyslíku; ivabradin zpomaluje sinusový uzel; trimetazidin mění metabolismus myokardu. Nitrát NEPROD­LUŽUJE ŽIVOT.
- 3 Rovnováha kyslíku**
Vše směřuje k jedinému: snížit spotřebu kyslíku myokardem (frekvence, kontraktilita, napětí stěny) a zlepšit jeho nabídku.
- 4 Akutní koronární syndrom**
Kyslík (jen při hypoxii), nitrát, morfin, kyselina acetylsalicylová + druhý antiagregans (tikagrelor, prasugrel, klopido­grel), antikoagulace, statin, β -blokátor.
- 5 Čas do revaskularizace**
Rozhoduje co nejrychlejší revaskularizace — farmakoterapie ji nenahradí.
- 6 Prinzmetalova angina**
Vazospastická — lékem volby jsou blokátory kalciových kanálů a nitráty; β -blokátory ji mohou ZHORŠIT.
- 7 Statin**
Statin a antiagregans rozhodují o prognóze — to je nejčastější doplňující otázka.

! Úleva od bolesti není totéž co zlepšení prognózy — proto se nitrát nikdy nepodává místo statinu a antiagregans, ale vedle nich.

ČTYŘI PÍSMENA NA DVEŘÍCH — A, C, D, B. A dnes se začíná rovnou dvojkombinací.

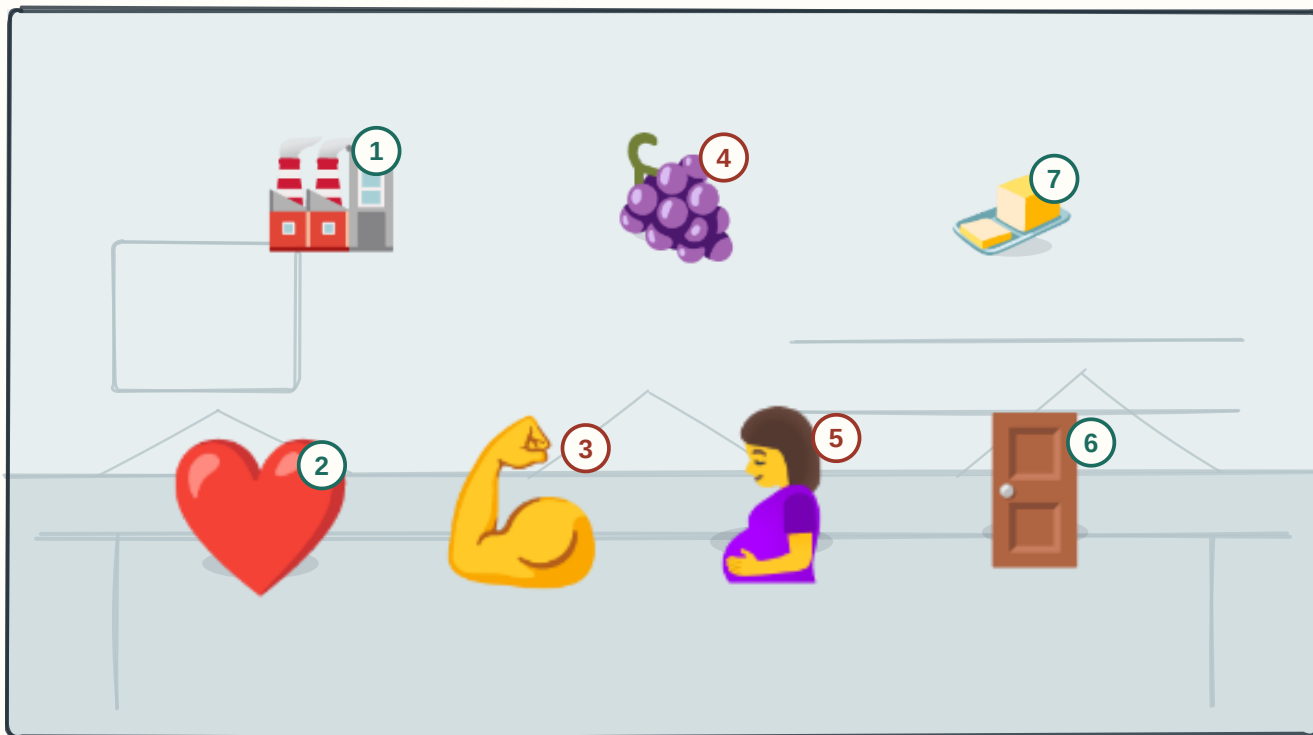


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Dveře A
ACE inhibitory a sartany — první volba u mladších, u diabetu, nefropatie, srdečního selhání a po infarktu. V graviditě kontraindikovány.
- 2 Dveře C
Blokátory kalciových kanálů (amlodipin) — vhodné u starších a u izolované systolické hypertenze; nežádoucí otoky kotníků.
- 3 Dveře D
Thiazidy a indapamid — účinné a levné; pozor na hypokalemii, hyperurikemii a zhoršení glykemie.
- 4 Dveře B
 β -blokátory dnes NEJSOU první volbou u nekomplikované hypertenze — nasazují se, existuje-li další důvod (ischemická choroba, srdeční selhání, arytmie, tyreotoxikóza).
- 5 Jedna tableta
Zahazuje se fixní dvojkombinací (A+C nebo A+D) — účinnější a lépe se dodržuje. ACE inhibitor a sartan se spolu nekombinují.
- 6 Spironolakton
U rezistentní hypertenze se přidává spironolakton.
- 7 Gravidita
Lékem volby jsou methyldopa, labetalol a nifedipin; ACE inhibitory, sartany a atenolol jsou kontraindikované.

⚠ Cílem není samotné číslo na tonometru, ale snížení kardiovaskulárního rizika — proto se volí lék podle přidružených chorob, ne jen podle síly účinku.

TOVÁRNA NA CHOLESTEROL SE ZAVŘENOU LINKOU — játra si pak nasadí víc vrátnic a vytáhnou LDL z krve.

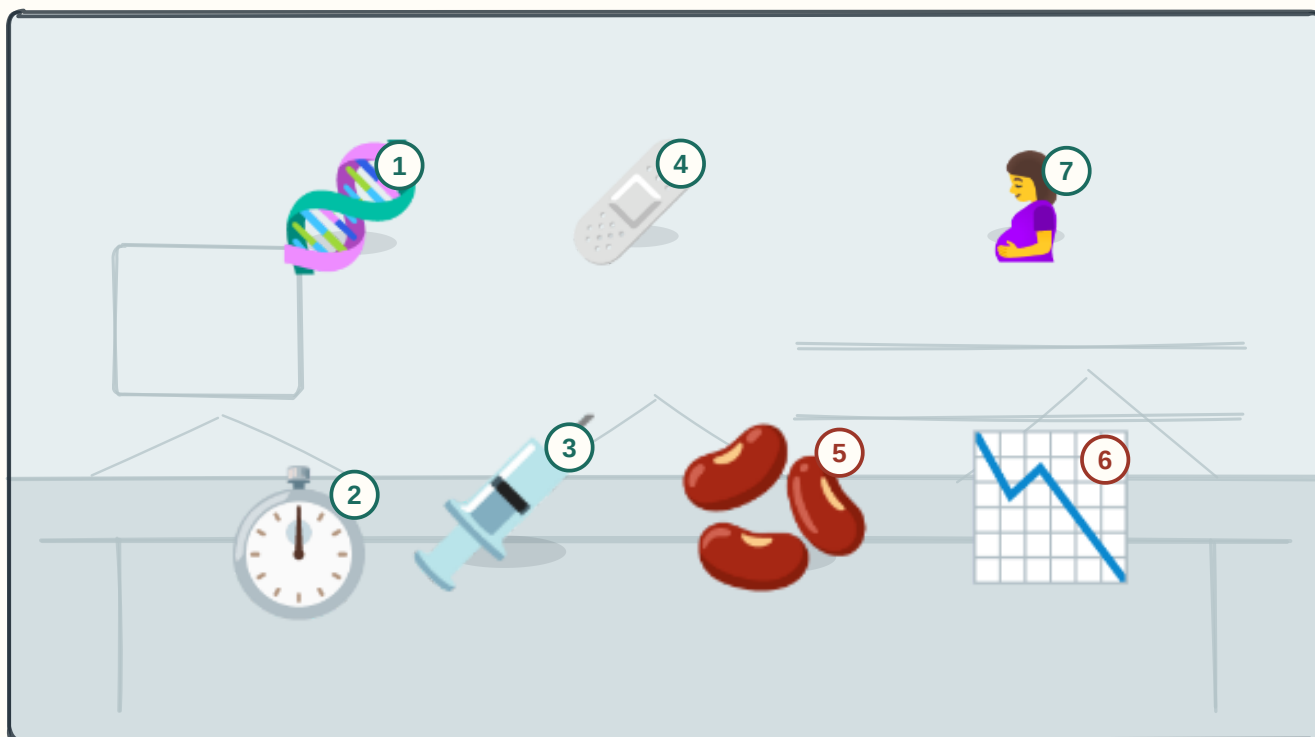


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Zastavená linka**
STATINY blokují HMG-CoA-reduktázu, krok určující rychlost syntézy cholesterolu; buňka reaguje zvýšením počtu LDL receptorů, které vychytávají LDL z krve.
- 2 **Snížená mortalita**
Statiny snižují mortalitu a mají i protizánětlivý, plakstabilizující účinek.
- 3 **Bolavý sval**
MYOPATIE — bolest svalů se vzestupem kreatinkinázy, vzácně RABDOMYOLÝZA s akutním selháním ledvin. Dále vzestup jaterních testů a mírně zvýšené riziko diabetu.
- 4 **Grapefruit a makrolid**
Riziko myopatie prudce stoupá s inhibitory CYP3A4 (klarithromycin, itraconazol, verapamil, grapefruit) a s fibráty (zvláště gemfibrozilem). Rosuvastatin a pravastatin jsou přes CYP3A4 metabolizovány méně.
- 5 **Gravidita**
Statiny jsou v graviditě a při kojení kontraindikované — cholesterol je nezbytný pro vývoj plodu.
- 6 **Ezetimib**
Blokují vstřebávání cholesterolu ve střevě; inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) injekčně a velmi účinně.
- 7 **Fibráty a pryskyřice**
Fibráty hlavně na triglyceridy; kolestyramin váže žlučové kyseliny a zhoršuje vstřebávání jiných léčiv a vitaminů rozpustných v tucích.

⚠ Bolest svalů při statinu bývá i nocebo — proto se ověří kreatinkináza a zkusí jiný statin nebo nižší dávka, než se skupina opustí úplně.

DVĚ KOHOUTKY NAD ANTITROMBINEM — jeden se dá rychle zavřít, druhý ne úplně.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Antitrombin III

Heparin sám nesráží — mnohonásobně zesiluje účinek antitrombinu III, který inaktivuje trombin (IIa) a faktor Xa.

2 aPTT

NEFRAKCIIONOVANÝ heparin: nitrožilně, krátký poločas, sleduje se aPTT. Výhodou je rychlá ovladatelnost a použitelnost při renálním selhání.

3 Protamin

ANTIDOTEM nefrakcionovaného heparinu je PROTAMIN-SULFÁT; u nízkomolekulárního zvrátí účinek jen částečně.

4 Podkožní injekce

LMWH (enoxaparin, nadroparin, dalteparin) působí hlavně na faktor Xa; subkutánně, předvídatelný účinek, bez rutinní monitorace (jen anti-Xa u gravidity, obezity a renální insuficience).

5 Ledvina

LMWH se vylučují ledvinami — u renální insuficience se dávka snižuje.

6 HIT

Heparinem indukovaná TROMBOCYTOPENIE (typ II, 5.–10. den) vede paradoxně k TROMBÓZE, nikoli ke krvácení. Heparin se okamžitě vysadí a nahradí argatrobanem nebo fondaparinuxem.

7 Gravidita

Hepariny neprocházejí placentou — proto jsou antikoagulanciem volby v graviditě.

! Dlouhodobé podávání heparinu způsobuje osteoporózu a vzestup jaterních testů; u nízkomolekulárního je toto riziko nižší než u nefrakcionovaného.

ZELINÁŘSTVÍ S PAVUČINOU — čím víc zeleniny v košíku, tím hůř warfarin funguje.

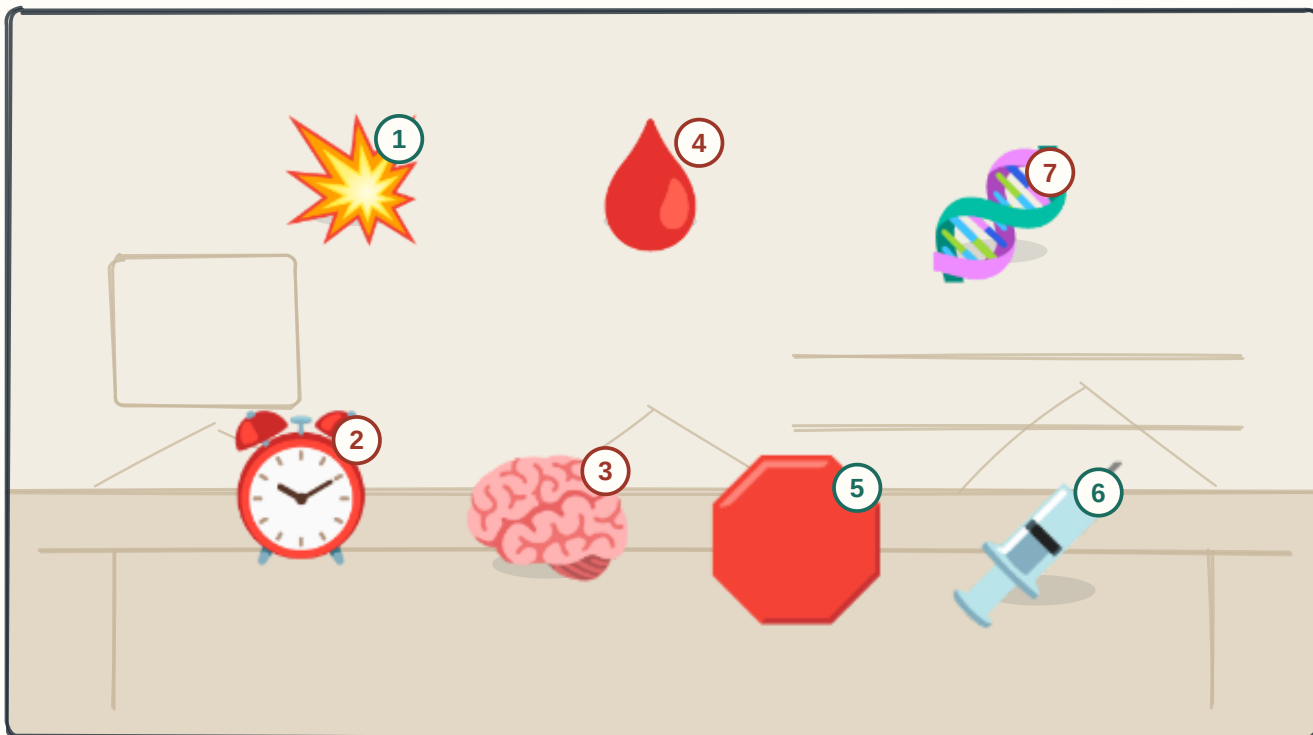


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Bedna zelí**
 Warfarin je antagonist vitaminu K — listová zelenina a brokolice jeho účinek **SNÍŽUJÍ**. Účinek se sleduje pomocí INR (u fibrilace síní cíl 2–3).
- 2 Pavučina**
 Blokuje vitamin K-epoxidreduktázu, a tím γ -karboxylaci faktorů II, VII, IX a X.
- 3 Přesýpací hodiny**
 Nástup 3–5 dní. Nejkratší poločas mají **PROTEINY C a S** — proto na začátku převládá prokoagulační stav (kožní nekróza) a překrývá se heparinem.
- 4 Antibiotika**
 Likvidují střevní bakterie tvořící vitamin K → INR stoupá. Totéž amiodaron, metronidazol, azoly, NSA a alkohol.
- 5 Těhotná**
 Warfarin je v graviditě teratogenní — tam patří nízkomolekulární heparin.
- 6 Vitamin K**
 Antidotum warfarinu: vitamin K, při závažném krvácení koncentrát protrombinového komplexu.
- 7 DOAC**
 Dabigatran (přímý inhibitor trombinu, antidotum idarucizumab) a xabany — rivaroxaban, apixaban, edoxaban (inhibitory X_a , antidotum andexanet alfa). Fixní dávka, bez monitorace, méně interakcí, nižší riziko nitrolebního krvácení.

⚠ U mechanické chlopenní náhrady a u antifosfolipidového syndromu zůstává warfarin jedinou možností — DOAC tam selhávají.

HODINY, KTERÉ ROZHODUJÍ — trombolytikum umí rozpustit trombus, ale jen dokud běží čas.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Rozpouštějící se sraženina

Alteplasa, tenekteplasa a streptokináza mění plazminogen na plazmin, který štěpí fibrin. Indikace: infarkt (není-li dostupná katetrizace), ischemická cévní mozková příhoda, masivní plicní embolie.

2 Hodiny

U ischemické cévní mozkové příhody je okno zhruba 4,5 hodiny od začátku příznaků; účinek prudce klesá s časem.

3 CT před podáním

Vždy je nutné nejprve vyloučit krvácení zobrazením.

4 Krvácení

Kontraindikace: prodělané nitrolební krvácení, nádor či malformace mozku, cévní mozková příhoda v posledních měsících, nedávná velká operace nebo trauma, aktivní krvácení, těžká nekontrolovaná hypertenze, disekce aorty.

5 Kyselina tranexamová

Hemostatika působí opačně: inhibitor fibrinolýzy u traumatu, poporodního krvácení a menoragie.

6 Desmopresin

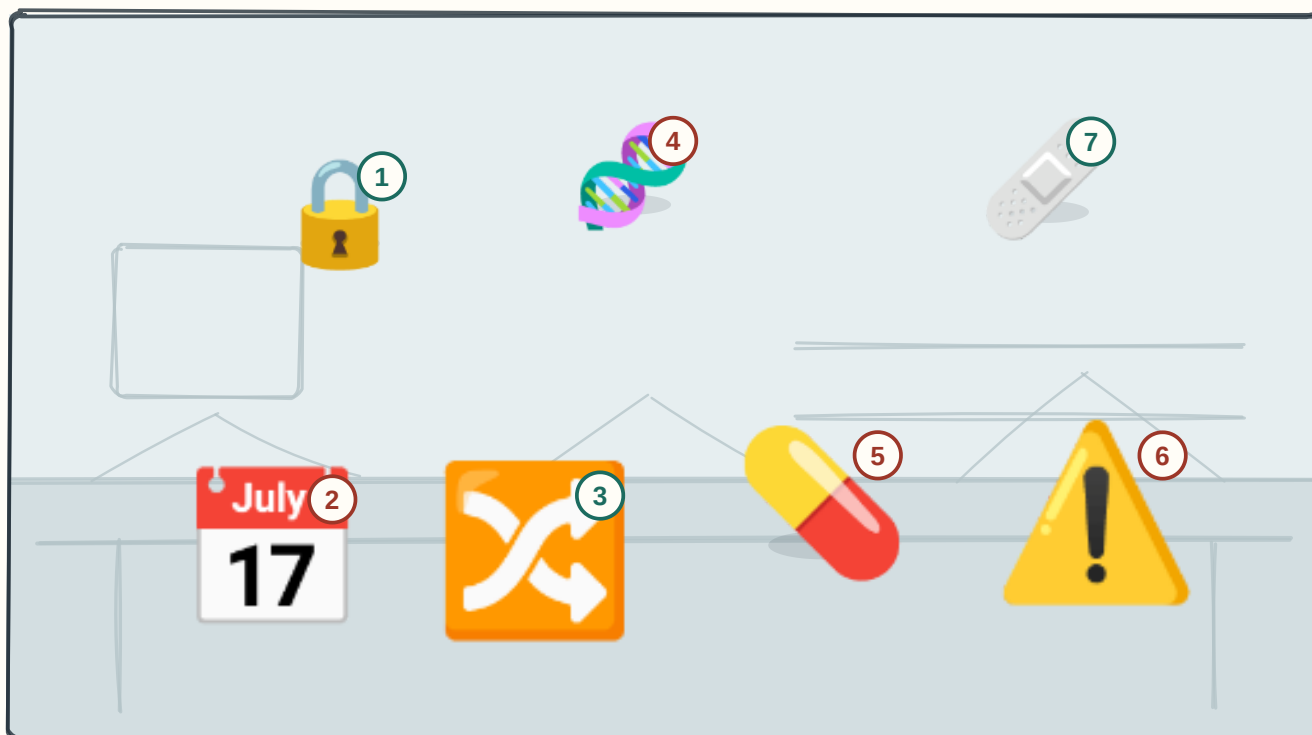
U hemofilie A a von Willebrandovy choroby uvolní faktor VIII a vWF ze zásob; dále vitamin K, koncentrát protrombinového komplexu, čerstvá mražená plazma, lokálně fibrinové lepidlo.

7 Substituce faktorů

Hemofilie A je VROZENÝ (X-vázaný) defekt faktoru VIII — nikoli získaný. U hemofilie B faktor IX; emicizumab profylakticky.

⚠ Trombolytikum a antikoagulans nejsou totéž: první rozpouští už vzniklou sraženinu, druhé jen brání jejímu růstu a vzniku nové.

DESTIČKA BEZ JÁDRA — co jí aspirin zablokuje, si už nikdy nevyrobí zpátky.

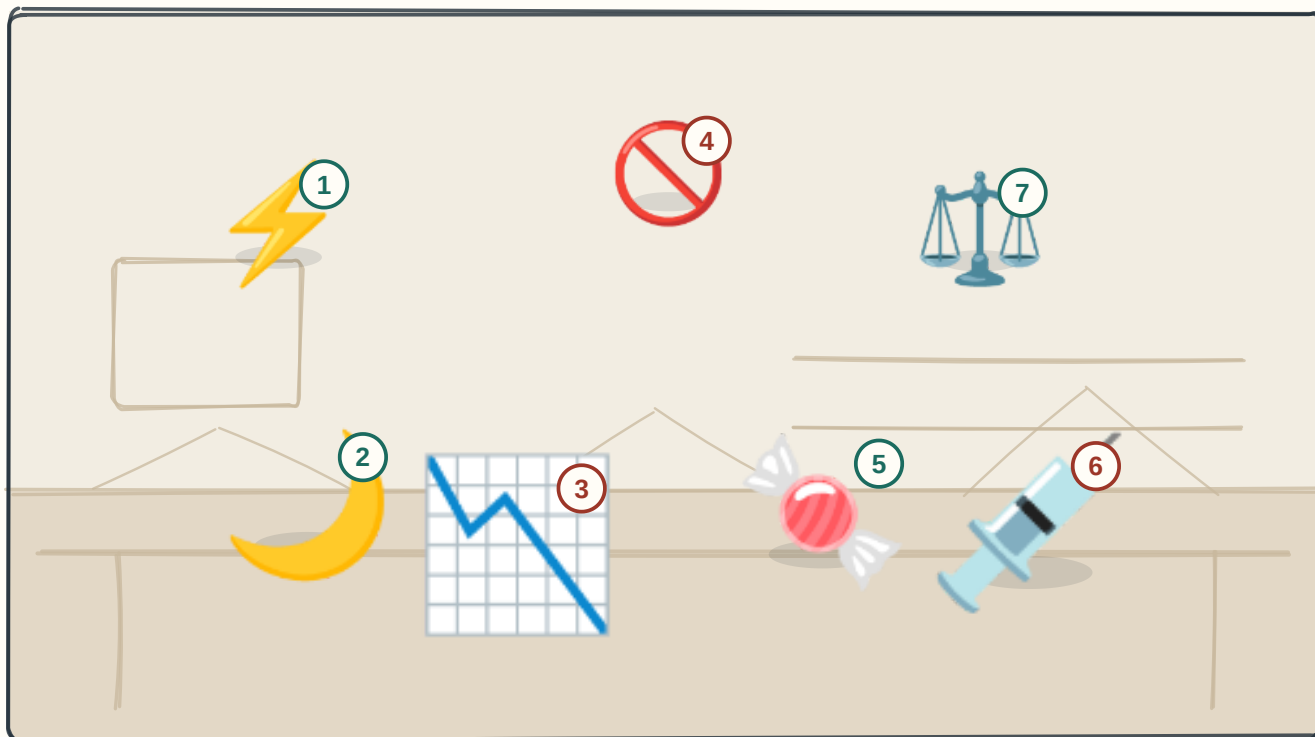


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Nevratný zámek**
Nízká dávka kyseliny acetylsalicylové (75–100 mg) IREVERZIBILNĚ acetyluje COX-1 v destičce a zablokuje tvorbu tromboxanu A₂.
- 2 **Kalendář 7–10 dní**
Destička nemá jádro a nový enzym nevytvoří — účinek trvá po celou její životnost (7–10 dní). Z toho se vychází při rozhodování o vysazení před operací.
- 3 **Receptor P2Y12**
Klopidogrel, prasugrel a tikagrelor blokují destičkový ADP receptor P2Y12.
- 4 **Klopidogrel je proléčivo**
Aktivuje ho CYP2C19 — u pomalých metabolizátorů účinkuje málo; tikagrelor a prasugrel působí spolehlivěji a rychleji.
- 5 **Omeprazol**
Inhibuje CYP2C19 a snižuje účinnost klopidogrelu — volí se pantoprazol.
- 6 **Ibuprofen před aspirinem**
Zabrání jeho vazbě na COX-1 a ruší antiagregační účinek.
- 7 **Duální antiagregace**
ASA + inhibitor P2Y12 po akutním koronárním syndromu a po implantaci stentu po stanovenou dobu; inhibitory glykoproteinu IIb/IIIa nitrožilně při katetrizaci.

! Antiagregans působí na destičku (arteriální trombóza), antikoagulans na plazmatické faktory (žilní trombóza a embolie) — záměna indikací je typická chyba.

DVĚ HLADINY JEDNOHO DNE — bazál drží klid mezi jídly, bolus kryje talíř. A pod nimi číhá hypoglykemie.



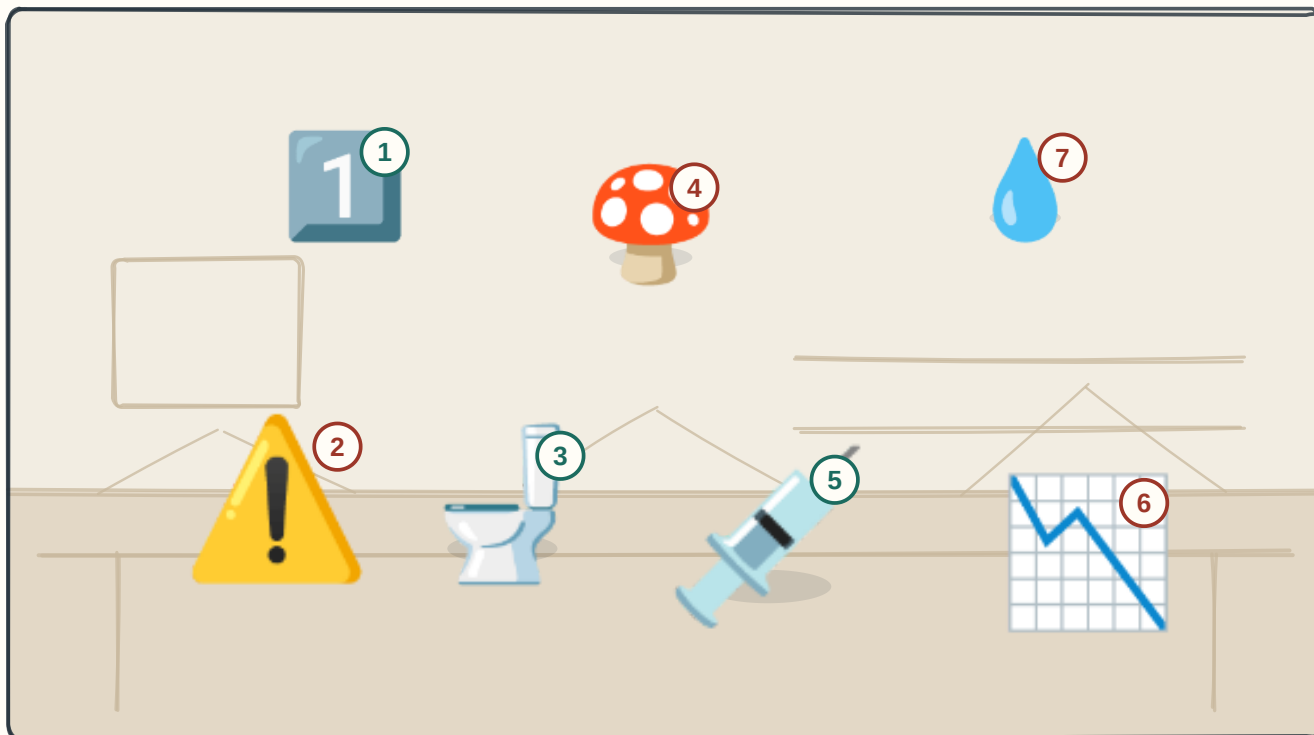
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Bolus k jídlu**
 Ultrakrátká analoga (lispro, aspart, glulisin) nastupují za minuty a podávají se těsně před jídlem; krátký humánní inzulin 30 minut předem.
- 2 Bazál na noc**
 Dlouhodobě působící analoga (glargin, detemir, degludek) mají plochý profil bez vrcholu — nižší riziko noční hypoglykemie než NPH inzulin.
- 3 Hypoglykemie**
 Nejnebezpečnější komplikace: pocení, třes, palpitace, hlad (adrenergní) a poté zmatenost, porucha chování, křeče, kóma (neuroglykopenické).
- 4 β-blokátor**
 Maskuje adrenergní varovné příznaky — kromě pocení.
- 5 Cukr ústy**
 Při vědomí cukr ústy; při bezvědomí glukóza nitrožilně.
- 6 Glukagon**
 I.m. nebo intranazálně; NEPŮSOBÍ při vyčerpaných jaterních zásobách glykogenu (například u alkoholika). Používá se i jako antidotum při předávkování β-blokátory.
- 7 Přírůstek hmotnosti**
 Inzulin vede k přírůstku hmotnosti, lipodystrofii v místě vpichu (střídat místa) a hypokalemii — toho se využívá v léčbě hyperkalemie.

⚠ Režim bazál-bolus napodobuje fyziologickou sekreci — proto se dávka bazálu upravuje podle glykemie nalačno a bolusu podle jídla, ne obojí najednou.

81 Perorální antidiabetika

TRŽIŠTĚ S CUKREM — každý stánek snižuje glykémii jinak, a jen dva z nich umí shodit pacienta do hypoglykemie.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Metformin v čele

PRVNÍ VOLBA u diabetu 2. typu — snižuje jaterní glukoneogenezi a zvyšuje citlivost k inzulinu. Nezpůsobuje hypoglykémii ani přírůstek hmotnosti.

2 Laktátová acidóza

Metformin je kontraindikován při renální insuficienci, hypoxii, těžkém jaterním onemocnění a alkoholismu; před jodovou kontrastní látkou a před operací se VYSAZUJE. Dále průjem, nauzea a deficit vitamínu B12.

3 Cukr v moči

GLIFLOZINY (dapagliflozin, empagliflozin) blokují SGLT2 — cukr odchází močí. Snižují hmotnost, tlak a mortalitu u srdečního selhání, chrání ledviny.

4 Genitální mykóza

Typický nežádoucí účinek gliflozinů; vzácně euglykemická ketoacidóza.

5 GLP-1 agonisté

Liraglutid, semaglutid, dulaglutid — zpomalují vyprazdňování žaludku, zvyšují sytost, snižují hmotnost a kardiovaskulární riziko; nauzea, riziko pankreatitidy. Gliptiny (sitagliptin) jsou hmotnostně neutrální.

6 Sulfonylurea

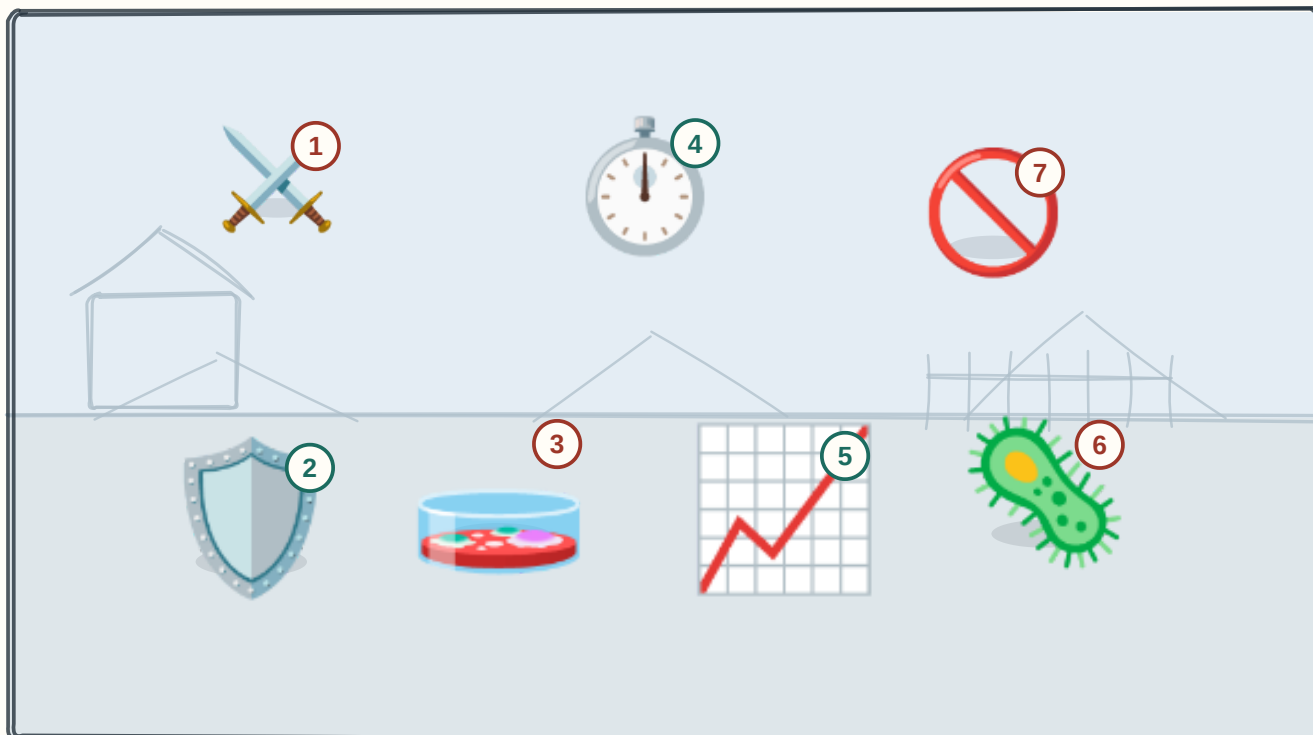
Gliklazid a glimepirid zavírají draslíkový kanál β -buňky a vyplavují inzulin — způsobují HYPOGLYKÉMII a přírůstek hmotnosti. Totéž glinidy.

7 Pioglitazon

Zvyšuje citlivost, ale působí retenci tekutin a je kontraindikován u srdečního selhání.

⚠ Hypoglykémii z perorálních antidiabetik způsobují prakticky jen deriváty sulfonylurey a glinidy — metformin, glifloziny, gliptiny ani GLP-1 agonisté samy o sobě ne.

OBLÉHÁNÍ HRADU — buď nepřítele zabiješ, nebo mu jen zabrániš množit se a zbytek dodělá posádka.



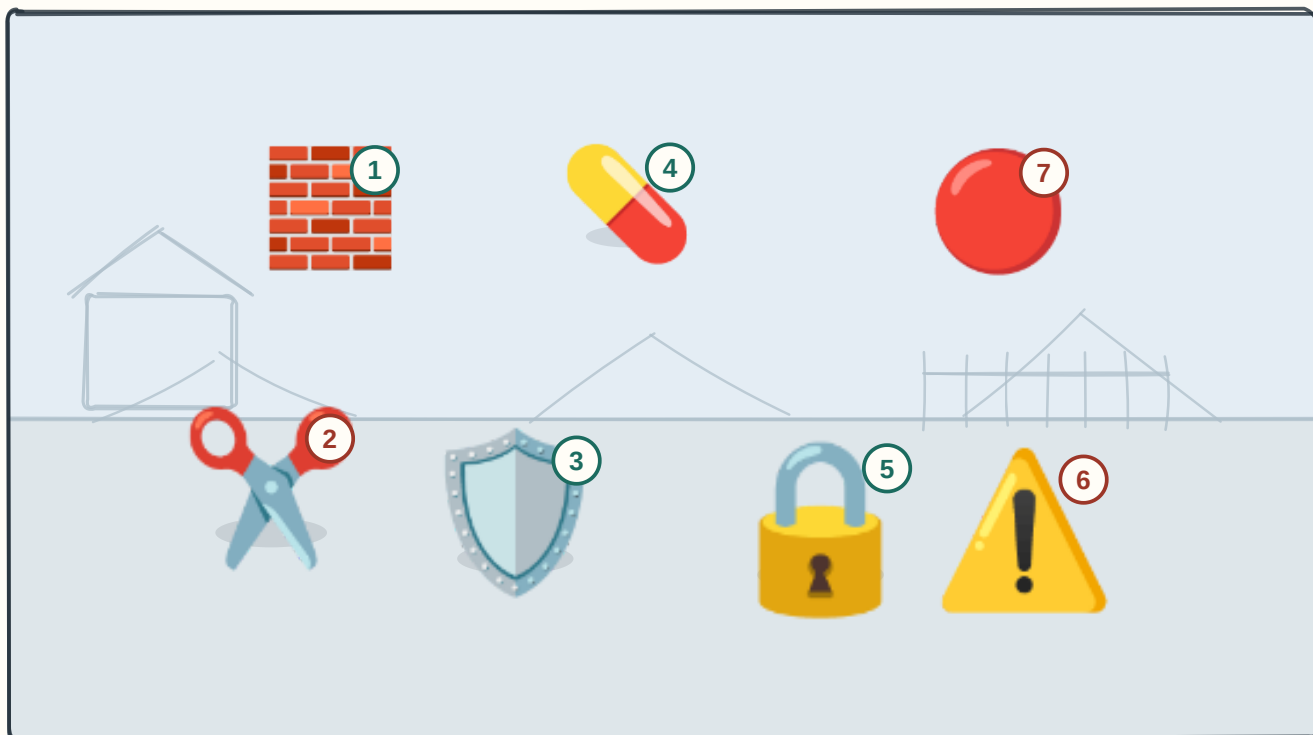
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Meč — baktericidní**
 Betalaktamy, glykopeptidy, aminoglykosidy, chinolony, metronidazol. U imunokompromitovaného, u ENDOKARDITIDY a MENINGITIDY je baktericidní léčba nutná.
- 2 Štít — bakteriostatické**
 Makrolidy, tetracykliny, linkosamidy, sulfonamidy, chloramfenikol — brzdí množení, zbytek musí dodělat imunita.
- 3 Odběr před léčbou**
 Empirická léčba se zahajuje podle nejpravděpodobnějšího původce a lokální epidemiologie, ale ODBĚR NA KULTIVACI se dělá PŘED prvním podáním. Po výsledku se deeskaluje na co nejužší spektrum.
- 4 Časově závislé**
 Betalaktamy zabíjejí časově závisle — rozhoduje doba nad minimální inhibiční koncentrací; podávají se častěji nebo v prodloužené infuzi.
- 5 Koncentračně závislé**
 Aminoglykosidy a chinolony — podávají se jednou denně ve vysoké dávce.
- 6 Rezistence**
 Vzniká mutací nebo přenosem plazmidu. Zásady: nepodávat na virózu, dodržet dávku a délku, nezaměňovat kolonizaci za infekci, používat co nejužší spektrum.
- 7 Nevhodná kombinace**
 Baktericidní se zpravidla nekombinuje s bakteriostatickým — to by účinek oslabilo.

⚠ Profylaxe má být krátká a cílená: chirurgická jedna dávka před výkonem. Delší podávání nechrání víc, jen selektuje rezistentní kmeny.

83 Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

ROZBOŘENÁ HRADBA — betalaktam brání stavbě stěny, bakterie se brání nůžkami a my jí nasadíme obětního beránka.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Nedostavěná zeď

Peniciliny blokují transpeptidázy (penicilin vázající proteiny) a znemožní stavbu peptidoglykanu — buňka praskne osmotickým tlakem. Baktericidní, jen na rostoucí bakterie.

2 Nůžky betalaktamázy

Hlavní mechanismus rezistence — enzym rozštěpí betalaktamový kruh.

3 Klavulanát

Kyselina klavulanová, sulbaktam a tazobaktam samy antibakteriální účinek prakticky nemají — obětují se enzymu a chrání antibiotikum (amoxicilin/klavulanát, piperacilin/tazobaktam).

4 Penicilin G a V

Přirozené — streptokoky, spirochéty (lék volby u syfilis), anaeroby dutiny ústní.

5 Oxacilin

Protistafylokokové, odolné penicilináze. Aminopeniciliny (amoxicilin, ampicilin) mají širší spektrum; piperacilin pokrývá Pseudomonas.

6 Alergie

Peniciliny jsou nejčastějším lékovým alergenem; anafylaxe v anamnéze je kontraindikací celé skupiny. Zkřížená alergie s cefalosporiny existuje, ale je nižší, než se dřív uvádělo.

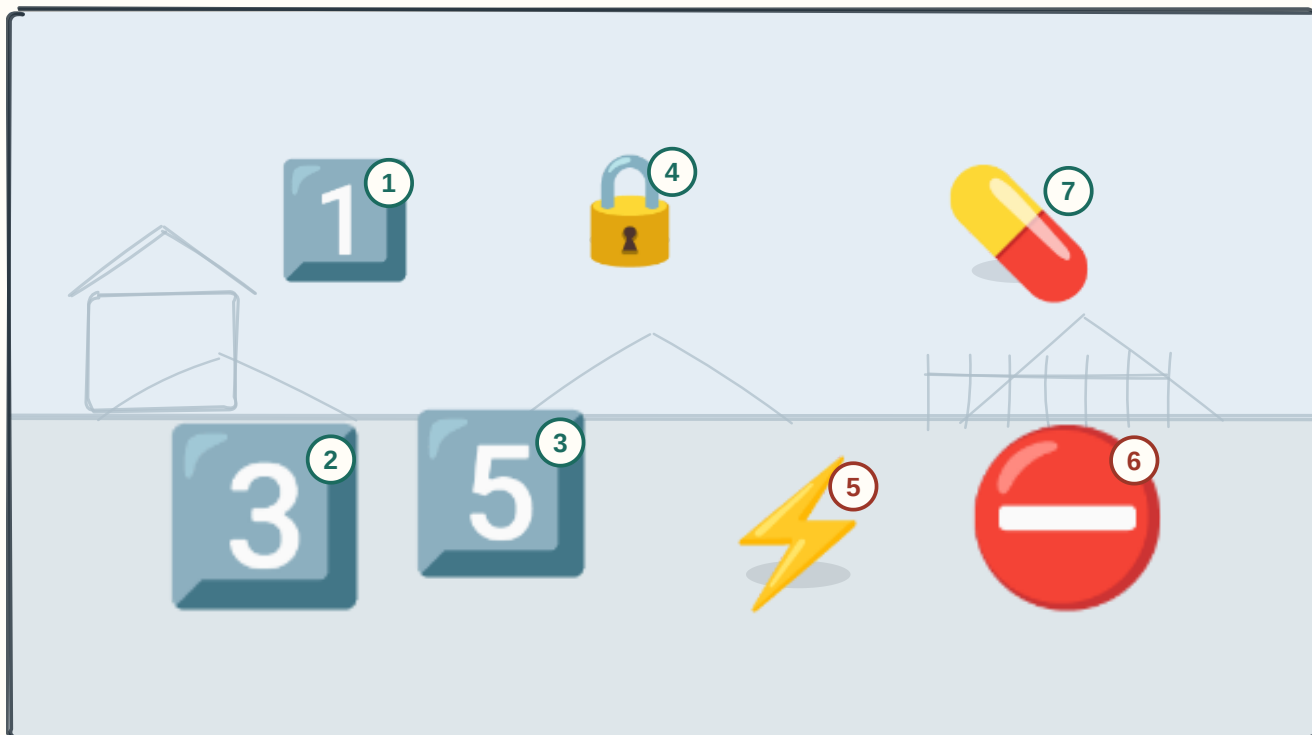
7 Exantém u mononukleózy

Ampicilin u infekční mononukleózy vyvolá exantém, který NENÍ alergií.

⚠ Peniciliny mají velmi široké terapeutické okno a jsou bezpečné i v graviditě — hlavním nežádoucím účinkem je průjem a alergie, nikoli orgánová toxicita.

84 Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

PĚT PATER JEDNÉ VĚŽE — čím výš, tím víc gram-negativních. A enterokok se nedostane do žádného.



CO JE VE SCÉNĚ

1 První patro

Cefazolin, cefalexin — dobře na gram-pozitivní; cefazolin je standardem chirurgické profylaxe.

2 Třetí patro

Ceftriaxon, cefotaxim, ceftazidim — silné na gram-negativní, pronikají do CNS; ceftriaxon je lékem volby u bakteriální meningitidy a kapavky. Ceftazidim pokrývá Pseudomonas.

3 Vyšší patra

IV. generace cefepim, V. generace ceftarolin (účinný i na MRSA).

4 Trezor karbapenemů

Meropenem, imipenem, ertapenem — nejširší spektrum včetně ESBL producentů a anaerobů; REZERVNÍ antibiotika pro těžké a rezistentní infekce.

5 Imipenem a křeče

Imipenem snižuje práh křečí; ertapenem nepokrývá Pseudomonas.

6 Mezera ve spektru

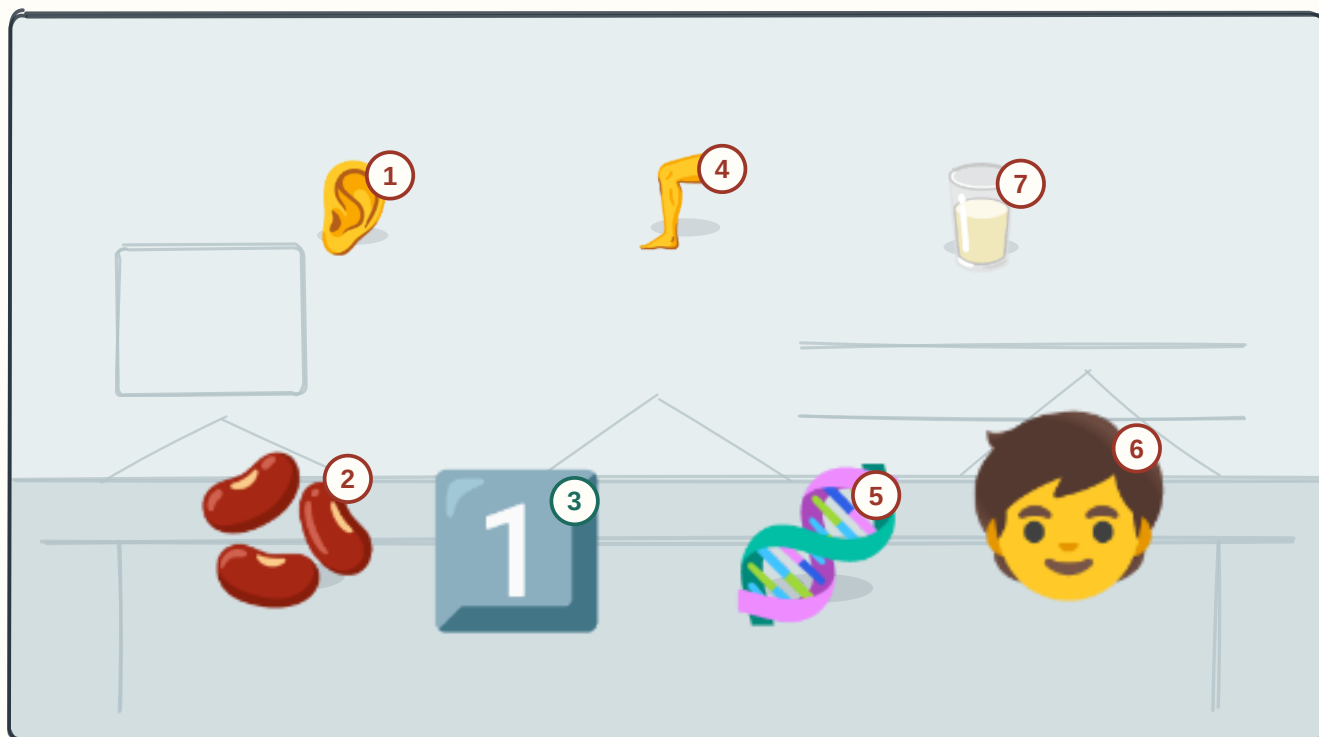
Běžné cefalosporiny NEPŮSOBÍ na enterokoky, MRSA, listerie a atypické patogeny — klasická zkušební otázka.

7 Aztreonam

Monobaktam působí pouze na gram-negativní aeroby; nemá zkříženou alergii s peniciliny, proto je volbou u těžké alergie na betalaktamy.

⚠ Cefalosporiny širokého spektra silně narušují střevní mikroflóru — patří k nejrizikovějším antibiotikům z hlediska klostridiové kolitidy.

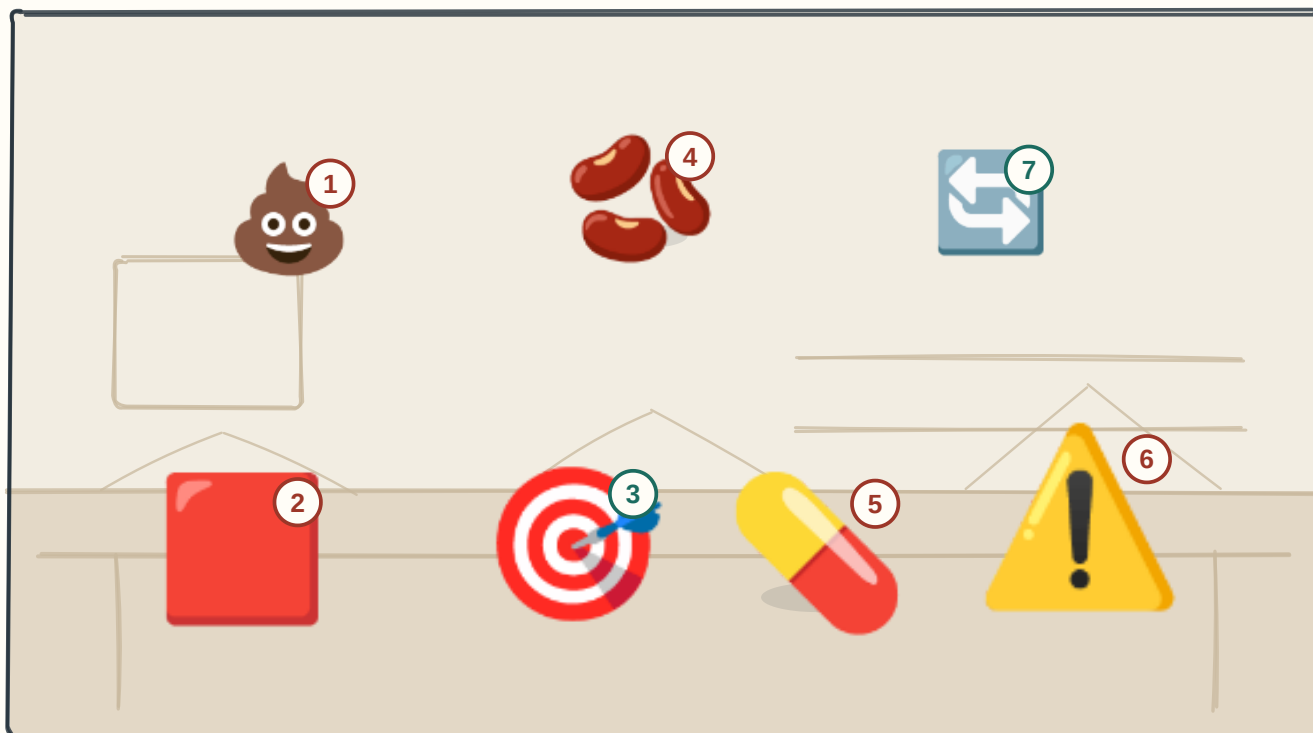
DVĚ SKUPINY, DVĚ TRVALÉ ŠKODY — nevratná hluchota a přetržená šlacha.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Ucho**
AMINOGLYKOSIDY (gentamicin, amikacin, tobramycin, streptomycin) blokují 30S podjednotku. OTOTOXICITA (kochleární i vestibulární) bývá NEVRATNÁ.
- 2 **Ledvina**
Nefrotoxicita je zpravidla reverzibilní; riziko stoupá s furosemidem a vankomycinem. Nutná monitorace hladin.
- 3 **Jednou denně**
Podávají se jednou denně ve vysoké dávce — zabíjejí koncentračně závisle a mají postantibiotický efekt; tento režim je zároveň méně toxický. Nevstřebávají se ze střeva.
- 4 **Přetržená šlacha**
FLUOROCHINOLONY (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin) působí tendinitidu a rupturu Achillovy šlachy — riziko roste s kortikoidy a věkem.
- 5 **Topoizomeráza**
Chinolony inhibují bakteriální TOPOIZOMERÁZU II (DNA-gyrázu) a IV — nikoli DNA-polymerázu.
- 6 **Chrupavka**
U dětí poškozují chrupavku, proto se jim nepodávají.
- 7 **Chelatace**
S vápníkem, hořčíkem a železem se snižuje vstřebání — nezapíjet mlékem, s odstupem od antacid. Dále prodloužení QT, fotosenzitivita, neuropatie, riziko disekce aorty; ciprofloxacin je inhibitor CYP1A2 (zvýší theofylin).

! Kvůli závažným nežádoucím účinkům se dnes chinolony nemají používat u nekomplikovaných infekcí, kde existuje jiná volba.

ODDĚLENÍ SE DVĚMA ZNAMENÍMI — rudý muž u infuze a klostridium na záchodě.


CO JE VE SCÉNĚ

1 **Klostridium**

KLINDAMYCIN (linkosamid, blokuje 50S) proniká dobře do kostí a působí na anaeroby a stafylokoky, ale z antibiotik NEJČASTĚJI vyvolává pseudomembranózní kolitidu (*Clostridioides difficile*).

2 **Rudý muž**

VANKOMYCIN podaný rychlou infuzí uvolní histamin — zarudnutí obličeje a trupu, svědění, hypotenze. NENÍ to alergie; řeší se zpomalením infuze a antihistaminikem.

3 **Jen gram-pozitivní**

Glykopeptidy (vankomycin, teikoplanin) blokují stavbu stěny (vazba na D-alanyl-D-alanin) a působí POUZE na gram-pozitivní bakterie. Rezerva na MRSA.

4 **Nefrotoxicita**

Vankomycin je nefrotoxický a ototoxický — nutná monitorace hladin.

5 **Perorální vankomycin**

Nevstřebává se a používá se právě na klostridiovou kolitidu — nitrožilně se do střevního lumen nedostane.

6 **Kolistin**

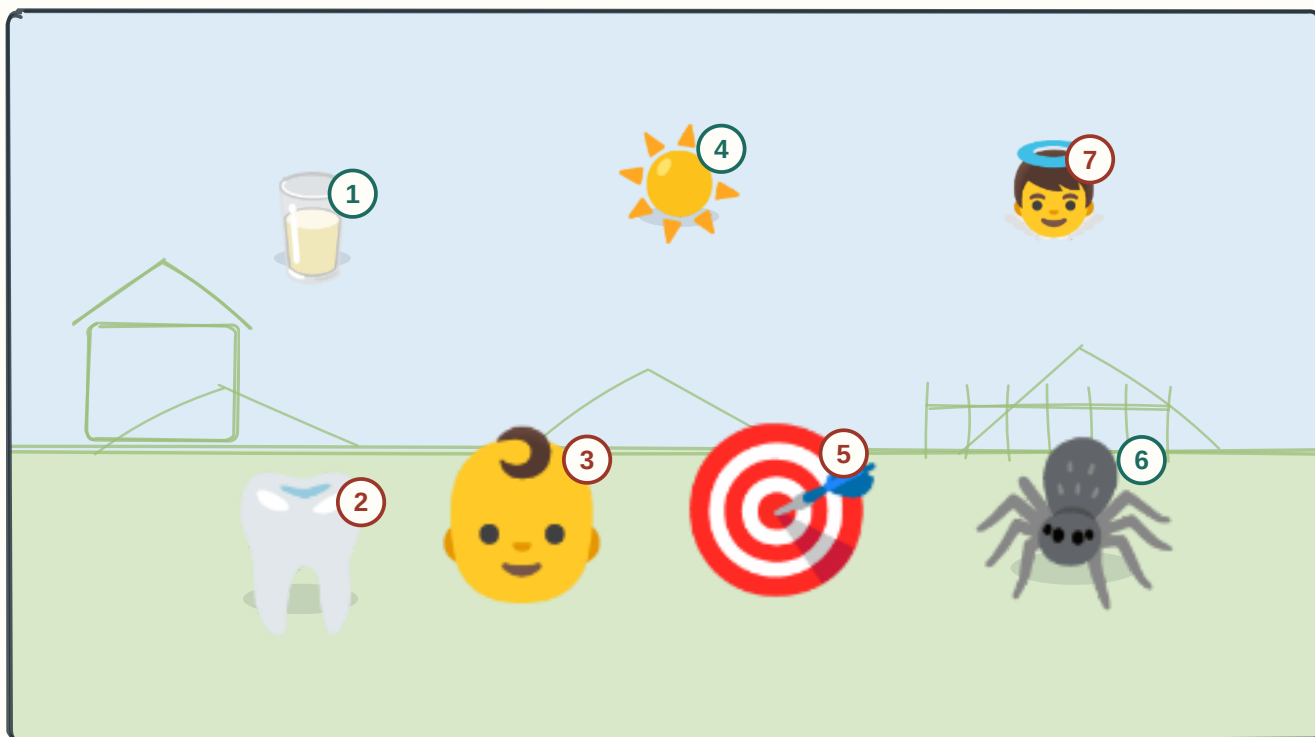
Polymyxin E narušuje membránu gram-negativních bakterií jako detergent; výrazně nefrotoxický a neurotoxický — poslední možnost u multirezistentních kmenů.

7 **Fidaxomicin**

Klostridiová kolitida se léčí perorálním vankomycinem nebo fidaxomicinem, případně metronidazolem; při recidivách transplantací fekální mikrobioty.

⚠ Antibiotikum, které nejčastěji způsobí klostridiovou kolitidu, není totéž jako to, kterým se léčí — klindamycin ji vyvolá, vankomycin perorálně ji léčí.

MLÉKÁRNA, KDE SE BARVÍ ZUBY — všechno, co tam je, na sebe váže vápník.

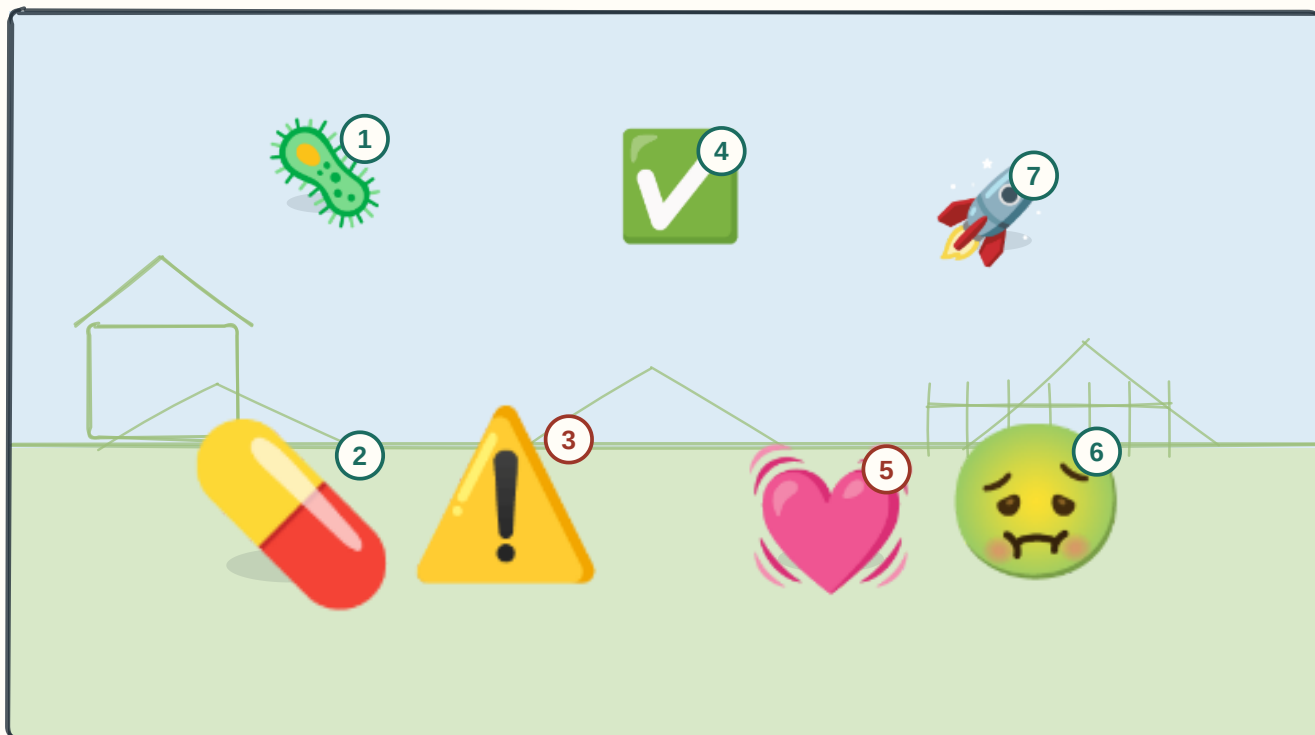


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Konev mléka**
Chelatace s Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} a Fe — nezapíjet mlékem, neužívat s antacidy, železem a vápníkem.
- 2 **Obarvený zub**
Ukládá se do mineralizující tkáně; šedohnědé zbarvení je UVNITŘ skloviny a dentinu — bělením ani leštěním se neodstraní.
- 3 **Dítě u plotu**
Kontraindikace do 8 let věku, v graviditě a při kojení — hypoplazie skloviny a zbarvení zubů.
- 4 **Pálící slunce**
Fotosenzitivita — pacienta je nutné varovat před sluněním. Dále ezofagitida (zapíjet velkým množstvím vody a nelehat si).
- 5 **Terč s číslem 30**
Blokáda 30S podjednotky ribozomu = PROTEOSYNTÉZA, nikoli buněčná stěna. Bakteriostatické.
- 6 **Klíště a pavouk**
Široké spektrum včetně atypických: chlamydie, mykoplazmata, borrelie, rickettsie. Doxycyklin je dnes hlavní zástupce.
- 7 **Šedé miminko**
Amfenikoly — chloramfenikol blokuje 50S. Aplastická anemie (typ B, nezávislá na dávce) a gray baby syndrom u novorozence s nezralou glukuronidací; zůstal v očních kapkách.

! Ve zdroji katedry je u tetracyklinů uvedena inhibice buněčné stěny — to je chyba. Stěnu blokuji betalaktamy a glykopeptidy.

ATYPICKÁ VESNICE BEZ HRADEB — na patogeny bez buněčné stěny betalaktamy nefungují, makrolidy ano.

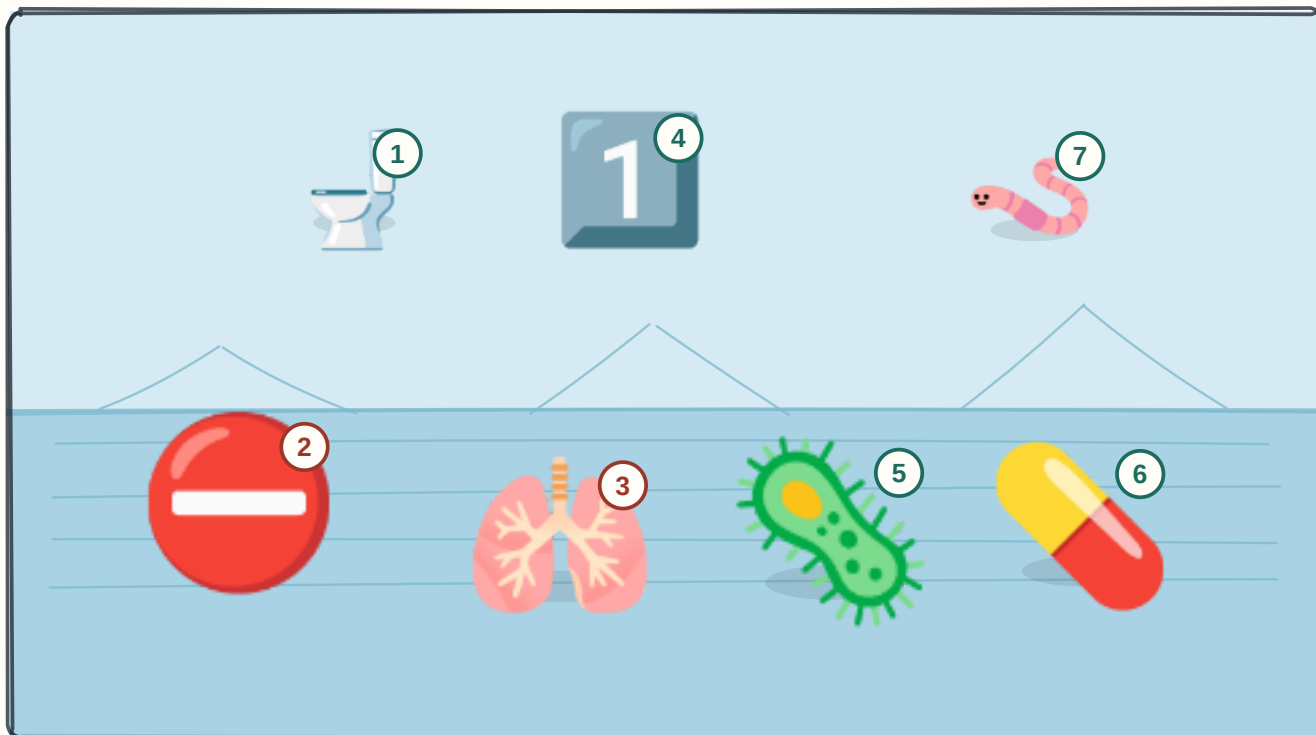


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Patogen bez stěny**
Blokují 50S podjednotku ribozomu, bakteriostaticky. Pokrývají mykoplazmata, chlamydie, legionelu a původce černého kašle — na ty betalaktamy nefungují.
- 2 **Náhrada penicilinu**
Jsou alternativou u pacientů s alergií na penicilin, bez zkřížené reakce.
- 3 **Klarithromycin**
Erythromycin a klarithromycin jsou SILNÉ INHIBITORY CYP3A4 — zvyšují hladiny statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení), cyklosporinu, karbamazepinu a blokátorů kalciových kanálů.
- 4 **Azithromycin**
CYP3A4 prakticky neinhibuje — volba u polymorbidního pacienta. Má velmi dlouhý tkáňový poločas, třídní kúra působí ještě řadu dní.
- 5 **Prodloužené QT**
Sčítá se s chinolony, antipsychotiky a ondansetronem.
- 6 **Žaludek**
Gastrointestinální nesnášenlivost — erythromycin dráždí žaludek přes MOTILINOVÝ receptor.
- 7 **Prokinetikum**
Této vlastnosti se využívá, když se erythromycin podává jako prokinetikum u gastroparézy.

⚠ Makrolidy jsou bakteriostatické — u endokarditidy a u neutropenického pacienta nestačí; tam je nutná baktericidní léčba.

LÉK, KTERÝ NIKAM NEDOJDE — působí jen tam, kde se nahromadí: v moči nebo ve střevě.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Měchýř**

NITROFURANTOIN se aktivuje bakteriálními nitroreduktázami na radikály poškozující DNA; účinné hladiny má POUZE V MOČI — proto na nekomplikovanou cystitidu.
- 2 Zákaz u pyelonefritidy**

Netvoří tkáňové hladiny; kontraindikován při renální insuficienci (nedostane se do moči) a v posledním trimestru gravidity.
- 3 Plicní fibróza**

Dlouhodobě hrozí plicní fibróza a polyneuropatie.
- 4 Jedna dávka**

FOSFOMYCIN blokuje ranou fázi syntézy peptidoglykanu — jednorázová dávka 3 g u nekomplikované cystitidy. Dále kotrimoxazol a u komplikovaných infekcí chinolony.
- 5 Rifaximin**

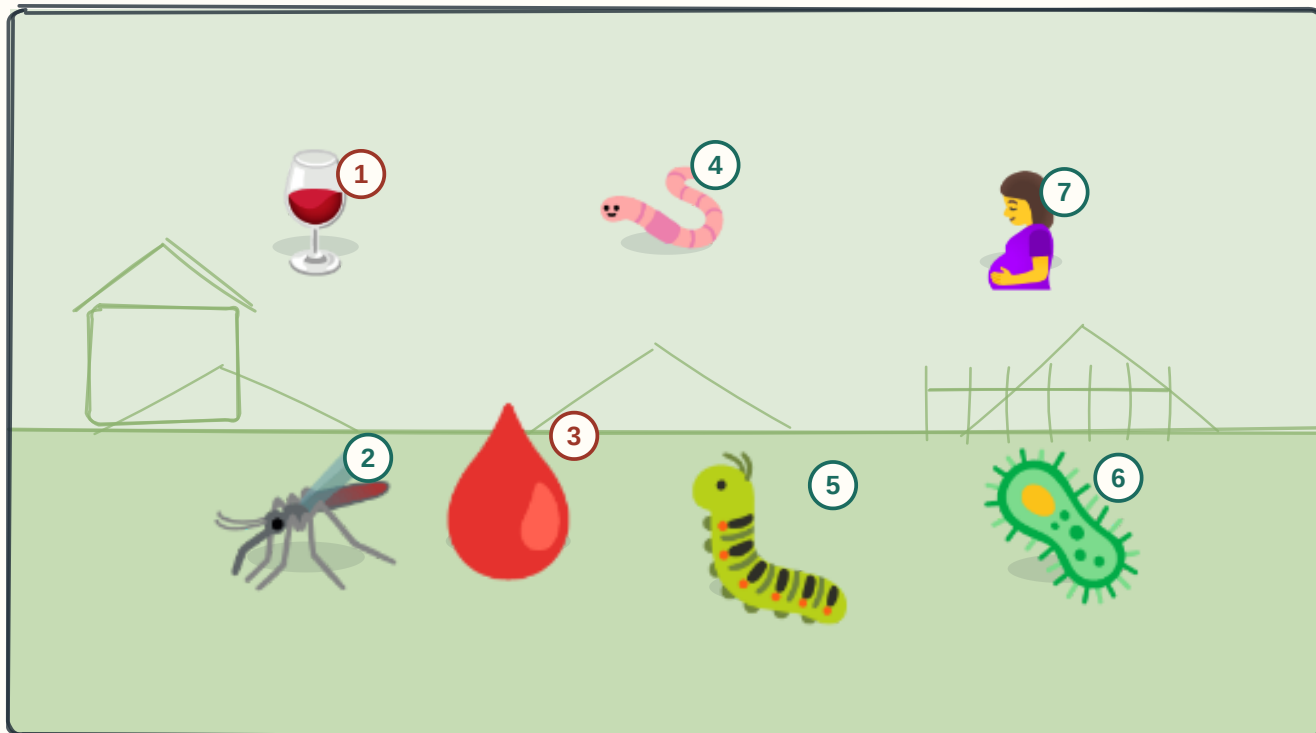
Nevstřebatelný derivát rifamycinu — cestovatelský průjem a prevence JATERNÍ ENCEFALOPATIE (snižuje střevní produkci amoniaku). Nifuroxazid je střevní nitrofuran.
- 6 Perorální vankomycin**

Nevstřebává se a je léčbou klostridiové kolitidy, stejně jako fidaxomicin.
- 7 Metronidazol**

Pokrývá anaeroby a améby.

⚠ Lék, který se nevstřebá, nemá systémové nežádoucí účinky — ale ani systémový účinek. Proto nestačí, jakmile infekce překročí sliznici.

DŽUNGLE PLNÁ CIZOPASNÍKŮ — každý lék míří na strukturu, kterou savčí buňka nemá.



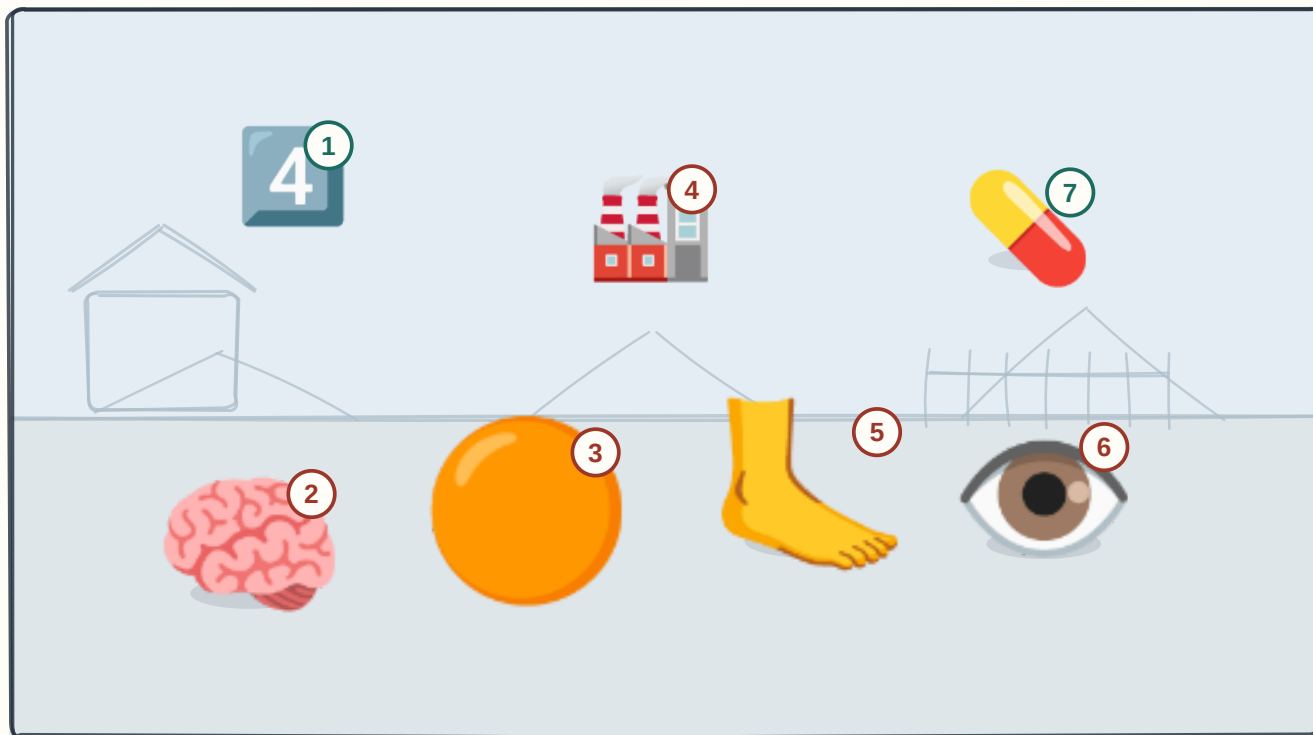
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Sklenka s metronidazolem**
 METRONIDAZOL se aktivuje v anaerobním prostředí na radikály štěpící DNA — trichomonáda, lamblie, améby a anaerobní bakterie. DISULFIRAMOVÝ efekt s alkoholem a kovová pachut'.
- 2 Komár**
 Antimalarika: artemisininové kombinace (ACT) jsou lékem volby u falciparové malárie; chlorochin, atovakvon/proguanil a doxycyklin v profylaxi.
- 3 Primachin**
 Ničí jaterní hypnozoity, ale je KONTRAINDIKOVÁN PŘI DEFICITU G6PD — hemolýza.
- 4 Červ**
 ALBENDAZOL a mebendazol vážou β -tubulin červa a blokují příjem glukózy — široké spektrum hlístic.
- 5 Motolice**
 PRAZIQUANTEL zvyšuje propustnost membrány parazita pro vápník — motolice a tasemnice.
- 6 Ivermektin**
 Otevírá glutamátem řízené chloridové kanály; užívá se i u svrabu.
- 7 Toxoplazmóza**
 Pyrimethamin se sulfadiazinem a kyselinou listovou. Ektoparazitika: permethrin a ivermektin na svrab a veš.

⚠ Selektivní toxicita je tu klíčová: co poškodí parazita, nesmí poškodit hostitele — proto se cílí na struktury, které se od savčích liší.

91 Antituberkulotika a antileprotika

ČTYŘSPŘEŽÍ HRZE — mykobakterie se dělí pomalu, proto nikdy jeden lék a nikdy krátce.

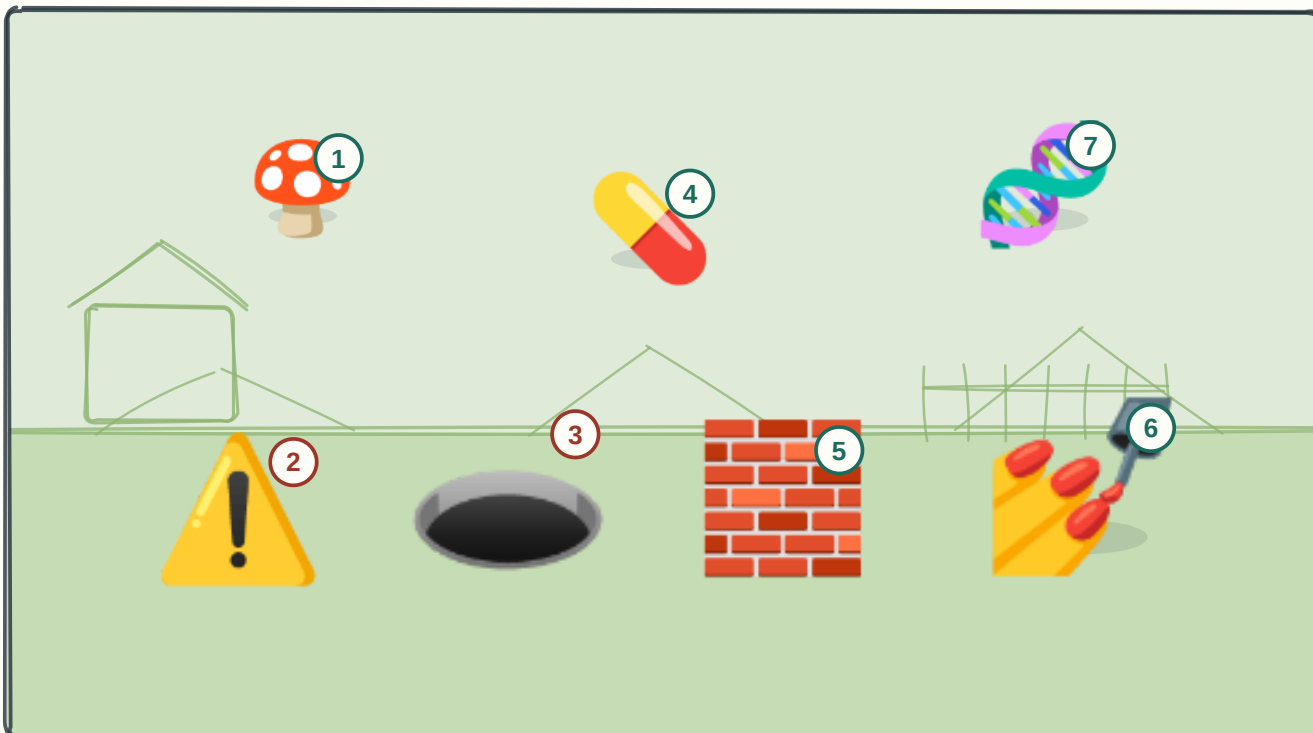


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Čtyři koně**
2 měsíce HRZE + 4 měsíce HR, pod přímým dohledem (DOT) — monoterapie by okamžitě vybrala rezistentní kmen.
- 2 Isoniazid a neuropatie**
H — blokuje syntézu kyseliny mykolové. Působí PERIFERNÍ NEUROPATII, jejíž prevencí je PYRIDOXIN (vitamin B6), a hepatotoxicitu.
- 3 Oranžová moč**
R — RIFAMPICIN inhibuje bakteriální RNA-polymerázu, barví moč, slzy a pot oranžově (barví kontaktní čočky).
- 4 Induktor**
Rifampicin je SILNÝ INDUKTOR CYP450 — sníží účinek kontraceptiv, warfarinu, antiretrovirotik.
- 5 Pyrazinamid**
Z — působí v kyselém prostředí makrofágu, zvyšuje kyselinu močovou a je hepatotoxický.
- 6 Etambutol**
E — blokuje arabinosyltransferázu a způsobuje RETROBULBÁRNÍ NEURITIDU: porucha barvocitu a ostrosti; nutné oční kontroly.
- 7 Rezerva a lepra**
Streptomycin, fluorochinolony, bedachilin, linezolid. Lepra: dapson + rifampicin + klofazimin, léčba trvá roky.

⚠ Tři ze čtyř základních antituberkulotik jsou hepatotoxická (H, R, Z) — proto se jaterní testy kontrolují po celou dobu léčby.

HOUBOVÝ LES SE DVĚMA SLABINAMI — ERGOSTEROL v membráně a GLUKAN ve stěně. Člověk nemá ani jedno.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Ergosterol

AZOLY (flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol; lokálně klotrimazol) inhibují 14- α -demetylázu, tedy syntézu ergosterolu. Fungistatické.

2 Interakce

Azoly inhibují CYP3A4 — zvyšují hladiny statinů, warfarinu, cyklosporinu a takrolimu.

3 Proděravělá membrána

AMFOTERICIN B se váže přímo na ergosterol a děruje membránu; fungicidní, pro těžké systémové mykózy. Silně NEFROTOXICKÝ, horečka a třesavka při infuzi; lipozomální forma je snášena lépe.

4 Nystatin

Polyen jen k lokálnímu a perorálnímu (nevstřebatelnému) použití — kandidóza dutiny ústní a střeva.

5 Glukanová stěna

ECHINOKANDINY (kaspofungin, anidulafungin, mikafungin) blokují syntézu β -glukanu — lidská buňka stěnu nemá, proto jsou velmi dobře snášeny; lék volby u invazivní kandidózy.

6 Terbinafin

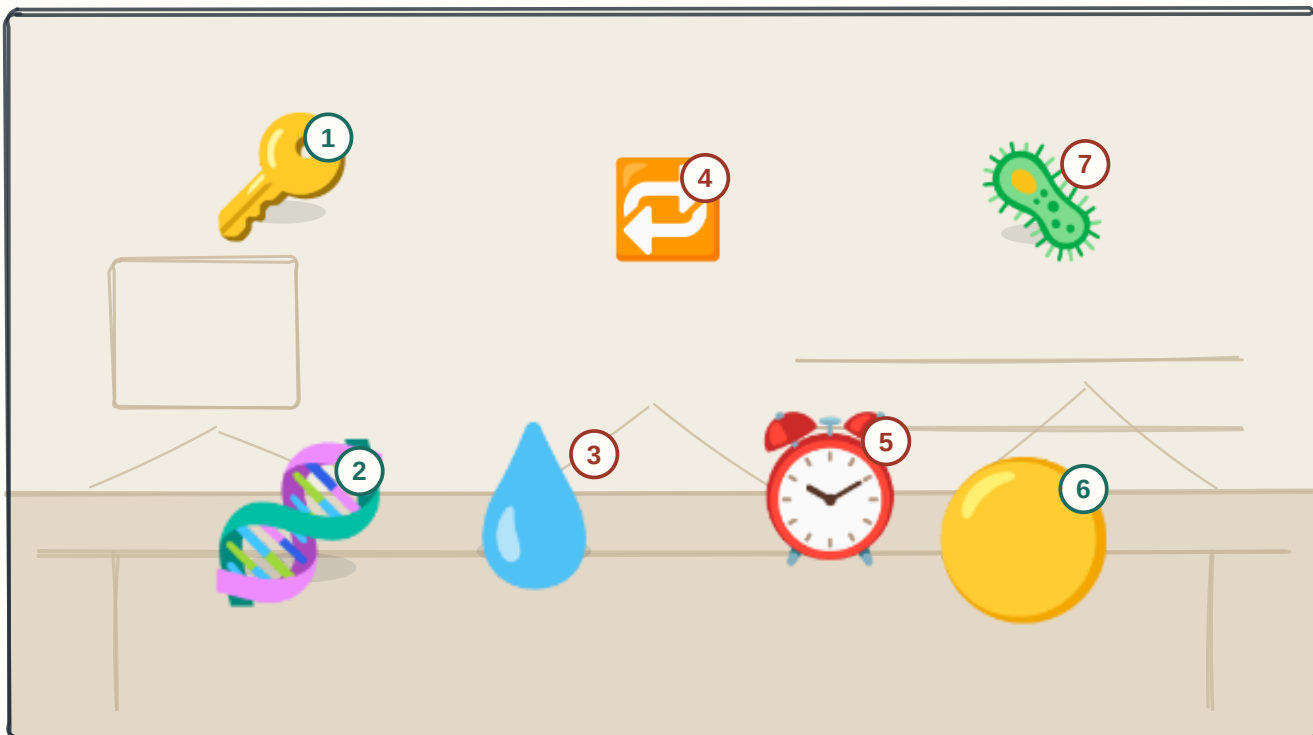
Inhibuje skvalenepoxidázu — onychomykózy a dermatofytózy.

7 Flucytosin

Vestavuje se do RNA, kombinuje se s amfotericinem u kryptokokové meningitidy.

⚠ Systémová antimykotika vyžadují dlouhou léčbu (onychomykóza měsíce) — proto se u nich hlídají jaterní testy a interakce, ne jen účinnost.

KLÍČ, KTERÝ OTEVÍRÁ JEN V INFIKOVANÉM DOMĚ — aciklovir aktivuje VIROVÁ thymidinkináza.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Virový klíč

ACIKLOVIR je proléčivo fosforylované VIROVOU thymidinkinázou — aktivuje se pouze v infikované buňce, což vysvětluje jeho vysokou bezpečnost. Valaciklovir má lepší dostupnost.

2 Terminátor řetězce

Aktivní trifosfát blokuje virovou DNA-polymerázu a působí jako terminátor řetězce.

3 Krystalurie

Nefrotoxicita a krystalurie při nedostatečné hydrataci — při i.v. podání je nutný dostatečný přívod tekutin.

4 Recidiva

Antivirotika jsou převážně VIROSTATICKÁ — potlačí replikaci, ale latentní virus nevymýtí; proto herpetické infekce recidivují.

5 48 hodin

OSELTAMIVIR a zanamivir blokují NEURAMINIDÁZU a brání uvolnění nových virionů — účinné jen DO 48 HODIN od začátku příznaků.

6 Hepatitida C

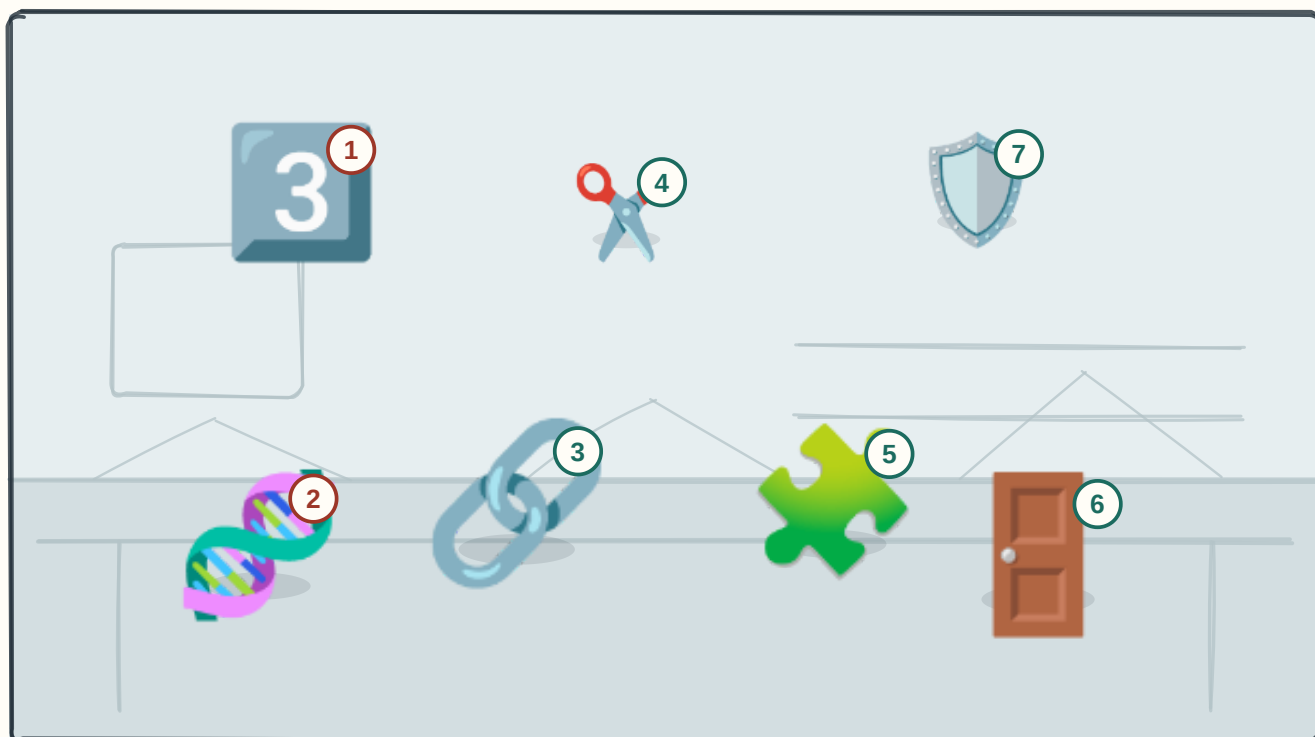
Přímo působící antivirotika (sofosbuvir, ledipasvir, glekaprevir) vyléčí naprostou většinu nemocných; hepatitida B: tenofovir, entekavir, peginterferon.

7 Cytomegalovirus

Ganciklovir a valganciklovir (myelosuprese), rezervně foskarnet a cidofovir (nefrotoxicke).

⚠ Rezistence na aciklovir vzniká nejčastěji ztrátou virové thymidinkinázy — pak se podává foskarnet, který aktivaci nepotřebuje.

TŘI ZÁMKY NA JEDNĚCH DVEŘÍCH — jeden zámek virus obejde během týdnu, tři ne.

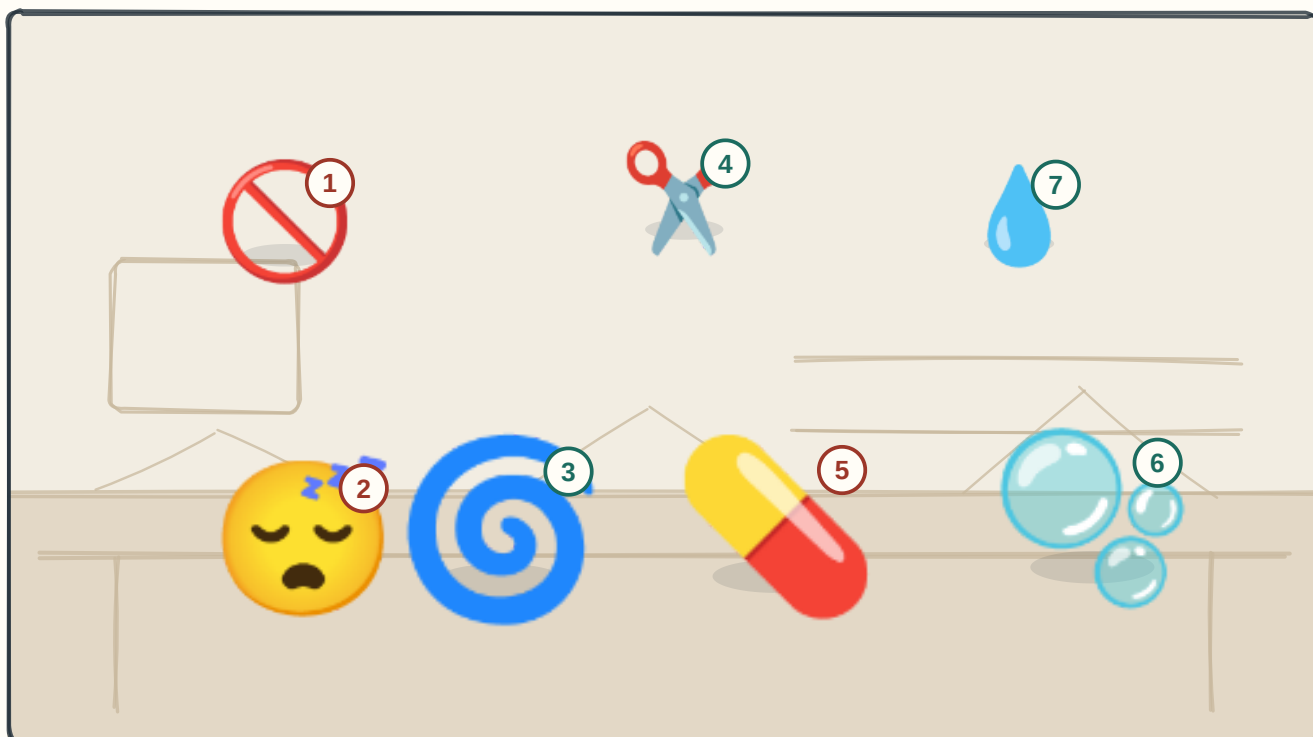


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Tři zámky**
cART: nejméně tři léčiva ze dvou skupin. Monoterapie během týdnů vybere rezistentní kmen.
- 2 **NRTI**
Tenofovir, emtricitabin, abakavir, lamivudin terminují řetězec. ABAKAVIR až po vyšetření HLA-B*5701 (hypersenzitivita); starší NRTI působí mitochondriální toxicitu a laktátovou acidózu.
- 3 **NNRTI**
Efavirenz, rilpivirin, doravirin se vážou alostericky; interagují přes CYP450, efavirenz působí neuropsychicky.
- 4 **Inhibitory proteázy**
Darunavir, atazanavir blokují štěpení polyproteinu; boostují se ritonavirem nebo kobicistatem (inhibitory CYP3A4). Dyslipidemie a lipodystrofie.
- 5 **Inhibitory integrázy**
Dolutegravir, bictegravir, raltegravir — dnes základ první linie: rychlý pokles nálože, málo interakcí.
- 6 **Inhibitory vstupu**
Maravirok (CCR5), enfuvirtid.
- 7 **PrEP**
Preexpoziční profylaxe: tenofovir s emtricitabinem.

⚠ Léčba potlačí virovou nálož pod mez detekce, ale infekci nevyléčí — provirus přetrvává v paměťových buňkách, proto se nikdy nevysazuje.

ZAHLČENÉ DÝCHACÍ CESTY — kdo uvolní hlen a zároveň zakáže kašlat, ten uškodí.

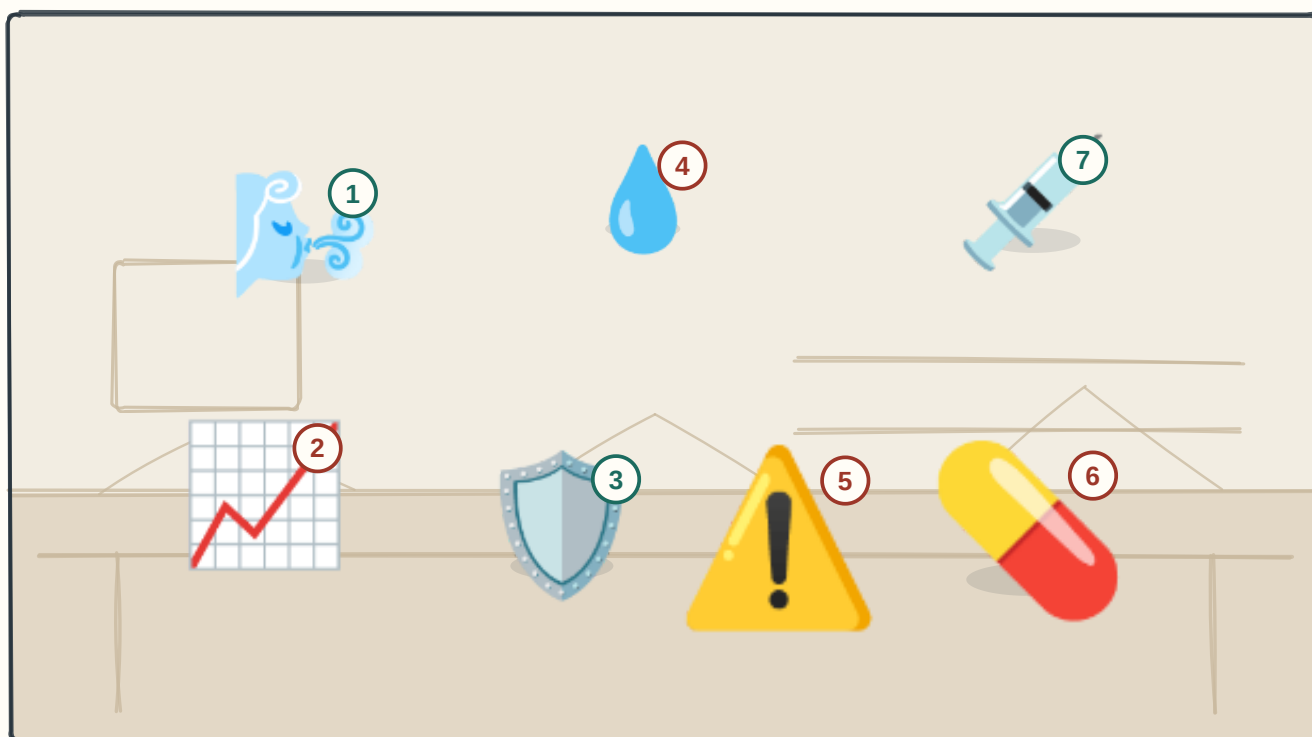


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Zakázaná kombinace**
Kašel je OBRANNÝ reflex — tlumí se jen suchý dráždivý. Antitusikum se NIKDY nekombinuje s mukolytikem, hlen by se hromadil.
- 2 Kodein**
Centrální opioidní antitusikum; proléčivo metabolizované CYP2D6 na morfin. Zácpa, útlum dechu, návykovost; u dětí kontraindikován.
- 3 Dextromethorfan**
Není analgetický ani v běžné dávce návykový, ve vysokých dávkách disociativní. Butamirát je neopiodní centrální antitusikum.
- 4 Acetylcystein**
Štěpí DISULFIDOVÉ můstky mukoproteinů, a tím hlen zředuje.
- 5 Antidotum paracetamolu**
N-acetylcystein doplňuje glutathion — druhá, zcela odlišná indikace téže látky.
- 6 Ambroxol**
Ambroxol a bromhexin zvyšují tvorbu řidšího hlenu a sekreci surfaktantu; dornáza alfa štěpí DNA v hnisavém sputu u cystické fibrózy.
- 7 Hydratace**
Expektorancia (guaifenesin, silice, břečťan) zvyšují objem sekretu; základem zůstává dostatečná hydratace.

! U dětí do dvou let se antitusika ani expektorancia zpravidla nepodávají — poměr rizika a prospěchu je nepříznivý.

DVA REGÁLY V LÉKÁRNĚ — úlevový a kontrolující. Astma stojí na tom druhém.

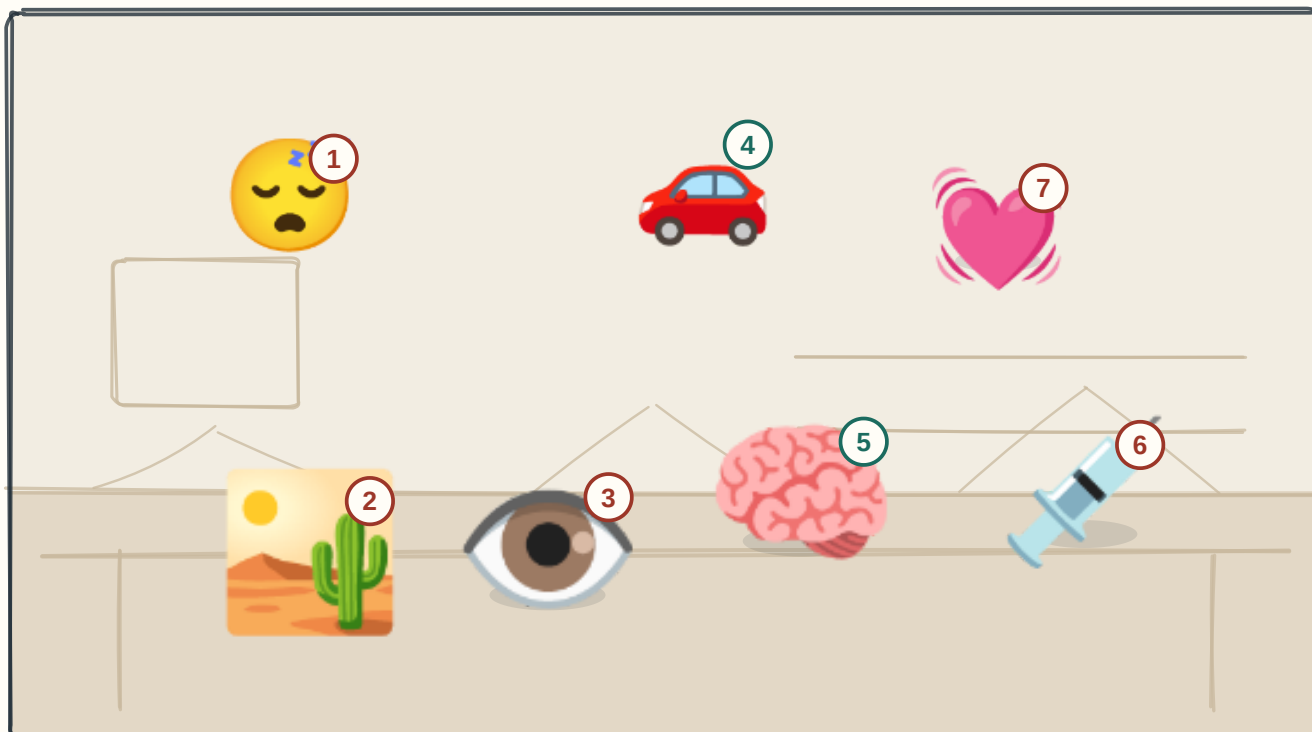


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **SABA**
Salbutamol, fenoterol relaxují hladký sval bronchu během minut — úlevová léčba. Tremor, tachykardie, hypokalemie.
- 2 **Prázdné krabičky**
Vysoká spotřeba SABA je známkou špatně kontrolovaného astmatu.
- 3 **Inhalační kortikoid**
Budesonid, flutikason, beklometason potlačují ZÁNĚT a jsou ZÁKLADEM léčby — astma je chronický zánět, ne jen bronchospasmus.
- 4 **Výplach úst**
Lokální nežádoucí účinky: orofaryngeální kandidóza a dysfonie — brání jim výplach úst po inhalaci a nástavec.
- 5 **LABA samotné**
Formoterol a salmeterol se u astmatu NIKDY nepodávají samostatně — monoterapie zvyšuje mortalitu. Standard je fixní kombinace kortikoid + formoterol.
- 6 **Montelukast**
Antileukotrien — pozor na neuropsychické reakce. Dále LAMA (tiotropium) a theofylin (úzké terapeutické okno).
- 7 **Biologika**
Omalizumab (anti-IgE), mepolizumab (anti-IL-5) u těžkého astmatu.

⚠ Neselektivní β -blokátory — i v očních kapkách (timolol) — mohou u astmatika vyvolat těžký bronchospasmus.

DVĚ GENERACE U JEDNÝCH DVEŘÍ DO MOZKU — stará projde a uspí, nová zůstane venku.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Spící postava

I. GENERACE (bisulepin, prometazin, difenhydramin, hydroxyzin) prochází hematoencefalickou bariérou — SEDACE; nesmí se řídit ani pít alkohol.

2 Sucho v ústech

Anticholinergní účinky: sucho v ústech, retence moči, rozmazané vidění, zácpa, u starších zmatenost.

3 Glaukom

Kontraindikací I. generace je glaukom s uzavřeným úhlem a hyperplazie prostaty.

4 Kinetóza

Sedativní a antiemetický efekt I. generace se využívá cíleně u kinetózy, nočního svědění a v premedikaci.

5 Zavřená brána

II. GENERACE (cetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin, bilastin) do CNS prakticky nepronikají — nesesedují a nemají anticholinergní efekt; volba pro denní léčbu.

6 Adrenalin

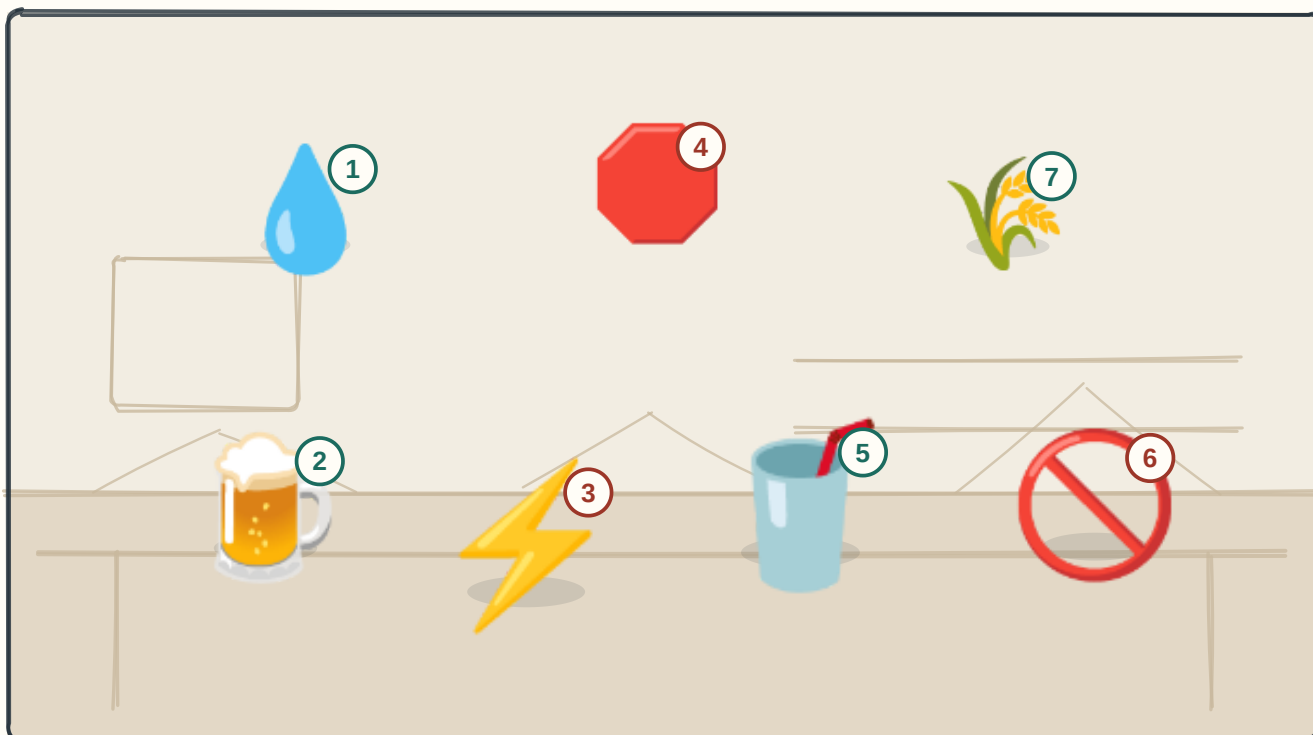
Antihistaminika tlumí svědění, kopřivku, rýmu a kýchání, ale na ANAFYLAXI nestačí — lékem první volby je ADRENALIN i.m.

7 Stažené preparáty

Terfenadin a astemizol byly staženy pro prodloužení QT. H2-antihistaminika (famotidin) tlumí žaludeční kyselinu.

! H1-antihistaminika jsou vlastně inverzní agonisté — netlumí jen navázaný histamin, ale i bazální aktivitu receptoru.

DVĚ CESTY STŘEVEM — rozjet ho, nebo zastavit. A obě mají svůj zákaz.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Makrogol
- 2 Laktulóza
- 3 Bisakodyl
- 4 Loperamid
- 5 Rehydratace
- 6 Zákaz u obstrukce
- 7 Psyllium

OSMOTICKÁ: makrogol váže vodu bez dráždění — dnes lék volby.

Nevstřebatelný disacharid, který střevní bakterie štěpí na kyseliny; táhne vodu a SNIŽUJE VSTŘEBÁVÁNÍ AMONIAKU — proto u jaterní encefalopatie.

KONTAKTNÍ (bisakodyl, senna, pikosíran) dráždí myenterický plexus; při chronickém zneužívání hypokalemie a atonie tračníku.

Agonista periferních μ -receptorů, do CNS neproniká. NESMÍ se podat u DYSENTERIE a horečnatého průjmu — riziko toxického megakolon.

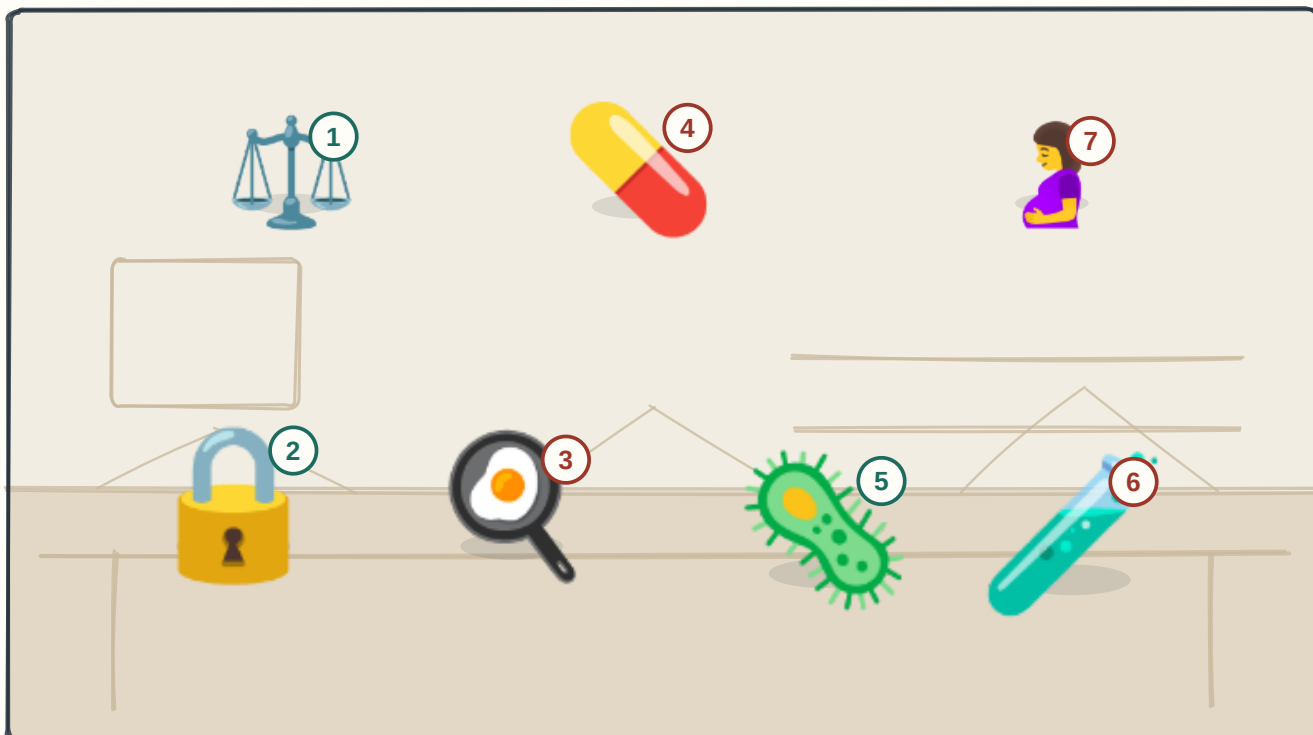
U průjmu je zásadní perorální rehydratační roztok, nikoli zástava peristaltiky. Dále adsorbencia a probiotika.

Laxativa se nepodávají při podezření na střevní obstrukci nebo náhlou příhodu břišní.

Objemová laxativa vyžadují dostatečný příjem tekutin; parafinový olej zhoršuje vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích; methylnaltrexon a naloxegol na zácpu při opioidech.

! Základem léčby zácpy zůstává vláknina, tekutiny a pohyb — laxativum se nasazuje až po vyloučení organické příčiny.

VÁHY NAD ŽALUDKEM — na jedné straně kyselina, pepsin, *H. pylori* a NSA, na druhé hlen a prostaglandiny.

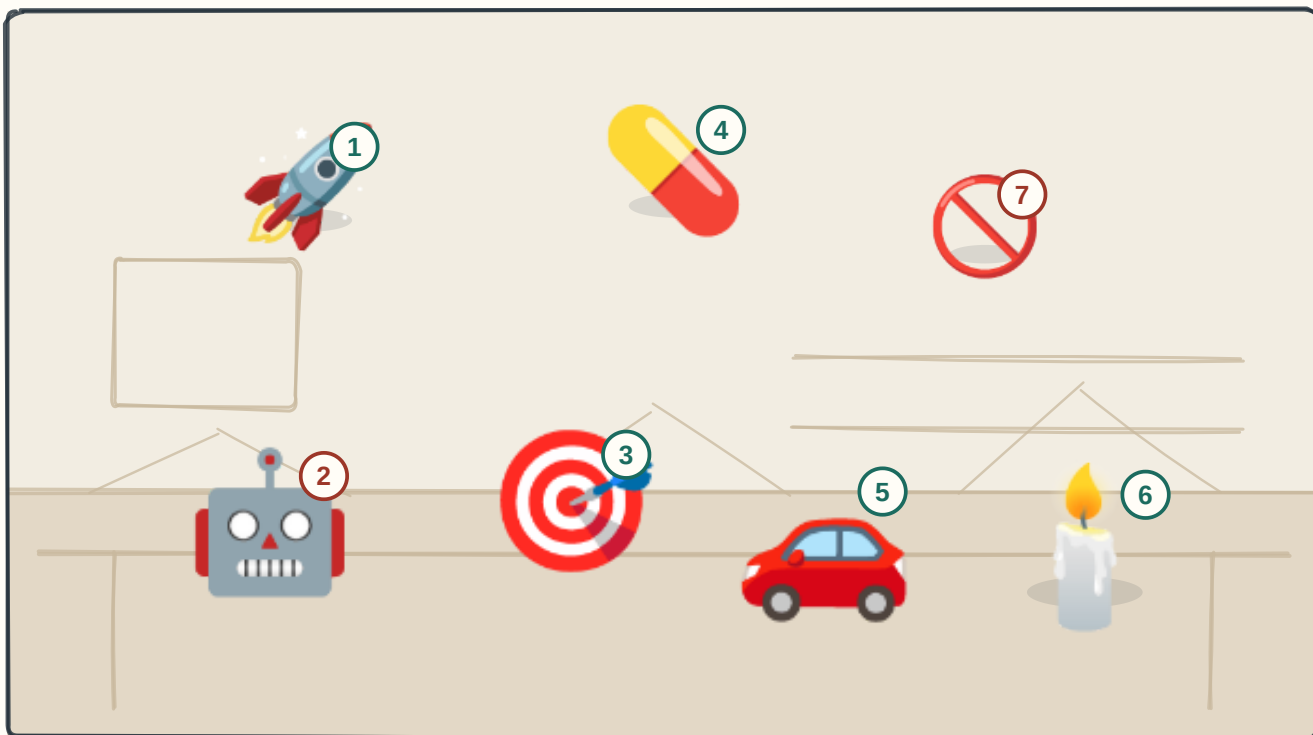


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 **Váhy**
Vřed vzniká nepoměrem mezi agresivními faktory a ochranou sliznice. Léčba tlumí kyselinu, eradikuje bakterii a odstraní vyvolávající lék.
- 2 **Protonová pumpa**
IPP (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol) ireverzibilně blokují $H^+/K^+-ATPázu$ — poslední společný krok sekrece, proto nejúčinnější.
- 3 **Nalačno**
Aktivují se jen na sekretující pumpě — podávají se 30 minut PŘED jídlem, jinak nezaberou.
- 4 **Klopidogrel**
Omeprazol inhibuje CYP2C19 a snižuje účinek klopidogrelu — volí se pantoprazol. Dlouhodobě hypomagnezémie, deficit B12, klostridiová kolitida, zlomeniny.
- 5 **Eradikace**
IPP + amoxicilin + klarithromycin (nebo metronidazol), běžně jako čtyřkombinace s bismutem, 10–14 dní.
- 6 **Antacida**
Neutralizují rychle, ale krátce a VÁŽOU jiná léčiva — podávat s odstupem.
- 7 **Misoprostol**
Analog prostaglandinu chrání před NSA, ale je kontraindikován v graviditě. Sukralfát tvoří film na spodině vředu.

⚠ Vřed po NSA může krváčet bez varovné bolesti, protože NSA bolest tlumí — proto se u rizikových podává IPP profylakticky.

TŘI RŮZNÉ PŘÍČINY ZVRACENÍ — a ke každé jiný lék. Univerzální antiemetikum neexistuje.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Prokinetikum

Metoklopramid (antagonista D2), itoprid, domperidon (do CNS proniká málo, ale prodlužuje QT) urychlují vyprazdňování žaludku a zvyšují tonus dolního jícnového svěrače.

2 Dystonie

METOKLOPRAMID prochází do CNS — akutní dystonie a po delším podávání tardivní dyskineze; odtud omezení dávky i délky a zákaz u parkinsonika.

3 Ondansetron

Setróny blokují 5-HT₃ v area postrema a ve střevě — základ u zvracení po cytostatikách, ozáření a po operaci. Zácpa, bolest hlavy, prodloužení QT.

4 Aprepitant

Antagonista NK1 proti pozdní fázi po chemoterapii; kortikosteroidy (dexametazon) v kombinaci.

5 Kinetóza

Antihistaminika I. generace (prometazin) a anticholinergika (skopolamin).

6 Paliativní péče

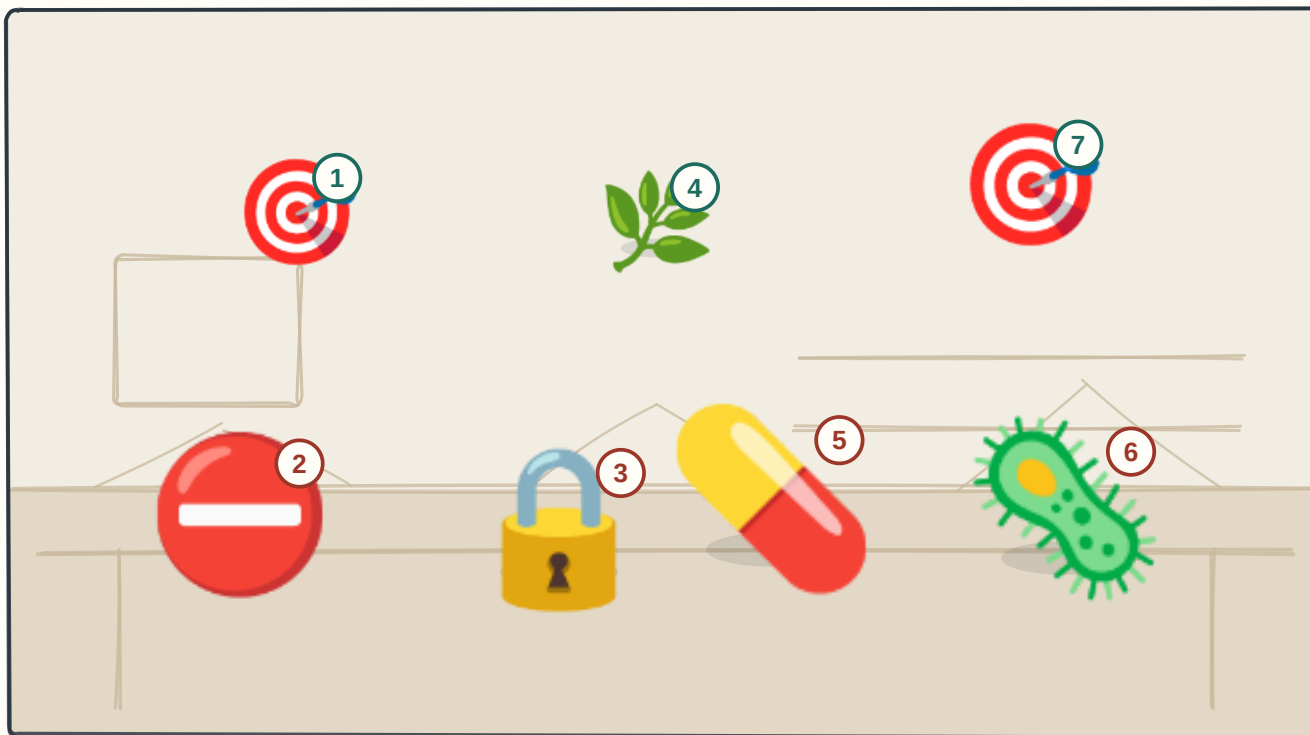
Neuroleptika (haloperidol, levomepromazin); kanabinoidy rezervně.

7 Emetika

Ipekakuanha a apomorfin se dnes při otravách prakticky nepoužívají — vyvolávat zvracení se nedoporučuje pro riziko aspirace.

! Erythromycin působí přes motilinový receptor a používá se jako prokinetikum u gastroparézy — antibiotikum v nemikrobiální indikaci.

DVĚ FÁZE JEDNÉ LÉČBY — navodit remisi a udržet ji. Kortikoid patří jen do první.

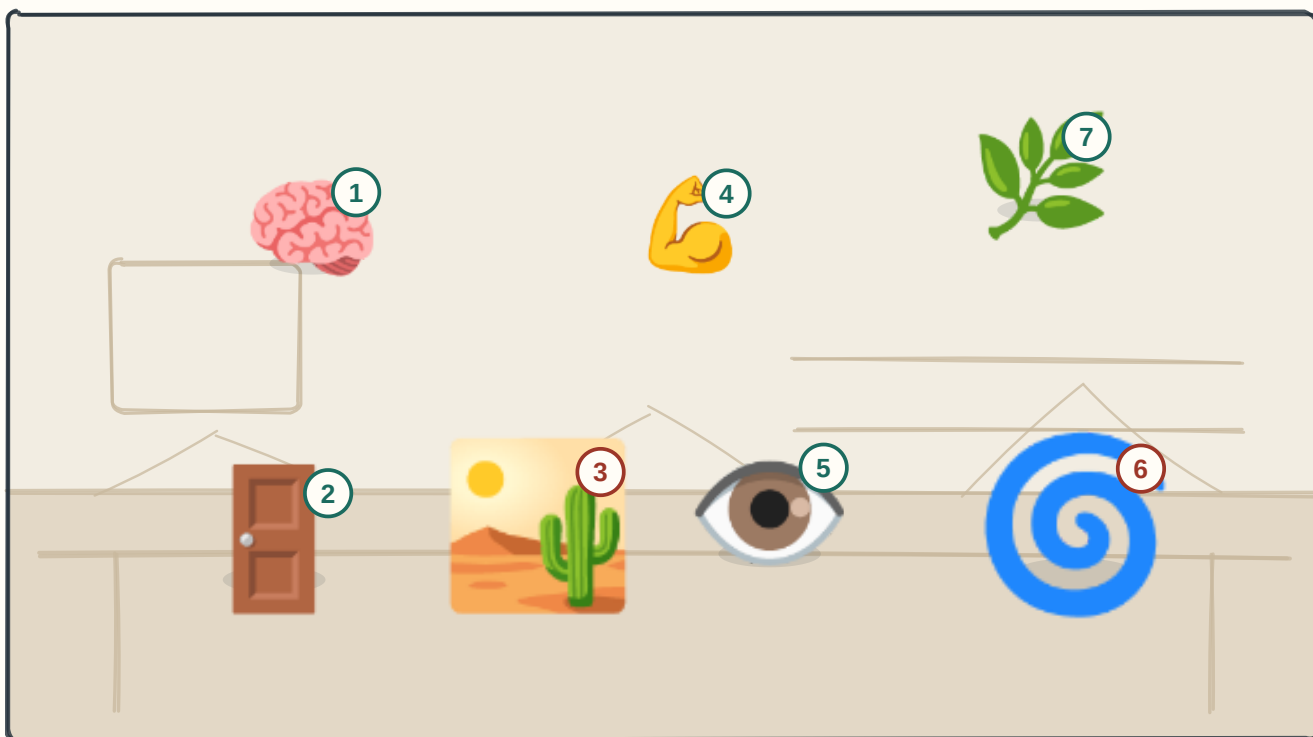


CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Navození remise**
Kortikosteroidy (prednison; u ileocékální lokalizace BUDESONID s vysokým first-pass efektem, a tedy nižší systémovou toxicitou) rychle potlačí aktivitu.
- 2 Zákaz dlouhodobě**
Kortikoidy se k UDRŽENÍ remise nikdy nepoužívají — pro nežádoucí účinky.
- 3 Azathioprin**
Azathioprin a 6-merkaptopurin udržují remisi; před nasazením se vyšetřuje aktivita TPMT kvůli riziku myelosuprese. Dále metotrexát.
- 4 Mesalazin**
5-ASA se uvolňuje v tlustém střevě a působí lokálně protizánětlivě — základ u ULCERÓZNÍ KOLITIDY, u Crohnovy nemoci malý účinek.
- 5 Sulfasalazin**
Způsobuje nauzeu, vyrážku a reverzibilní oligospermii.
- 6 Latentní tuberkulóza**
Před anti-TNF- α (infliximab, adalimumab) je nutné vyloučit latentní tuberkulózu a hepatitidu B — hrozí reaktivace.
- 7 Vedolizumab**
Anti-integrin, střevně selektivní; dále ustekinumab (anti-IL-12/23) a inhibitory JAK.

! Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida se léčí odlišně — mesalazin je účinný hlavně u kolitidy, u Crohnovy nemoci se dřív sahá po imunosupresi a biologikách.

DVĚ CESTY K UVOLNĚNÍ KŘEČE — přerušit povel, nebo působit rovnou na sval.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Přerušit povel

NEUROTROPNÍ — butylskopolamin blokuje muskarinové receptory hladkého svalu.

2 Kvartérní amin

Butylskopolamin je kvartérní amin — NEPROCHÁZÍ hematoencefalickou bariérou, takže neseduje.

3 Anticholinergní obtíže

Sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, retence moči, zácpa. Kontraindikace: glaukom s uzavřeným úhlem, hyperplazie prostaty, tachyarytmie, paralytický ileus.

4 Přímě na sval

MYOTROPNÍ — drotaverin a papaverin inhibují fosfodiesterázu, zvyšují cAMP a přímo relaxují sval; nemají anticholinergní nežádoucí účinky.

5 Volba u glaukomu

Proto jsou myotropní vhodnější u pacienta s glaukomem nebo prostatismem.

6 Metamizol

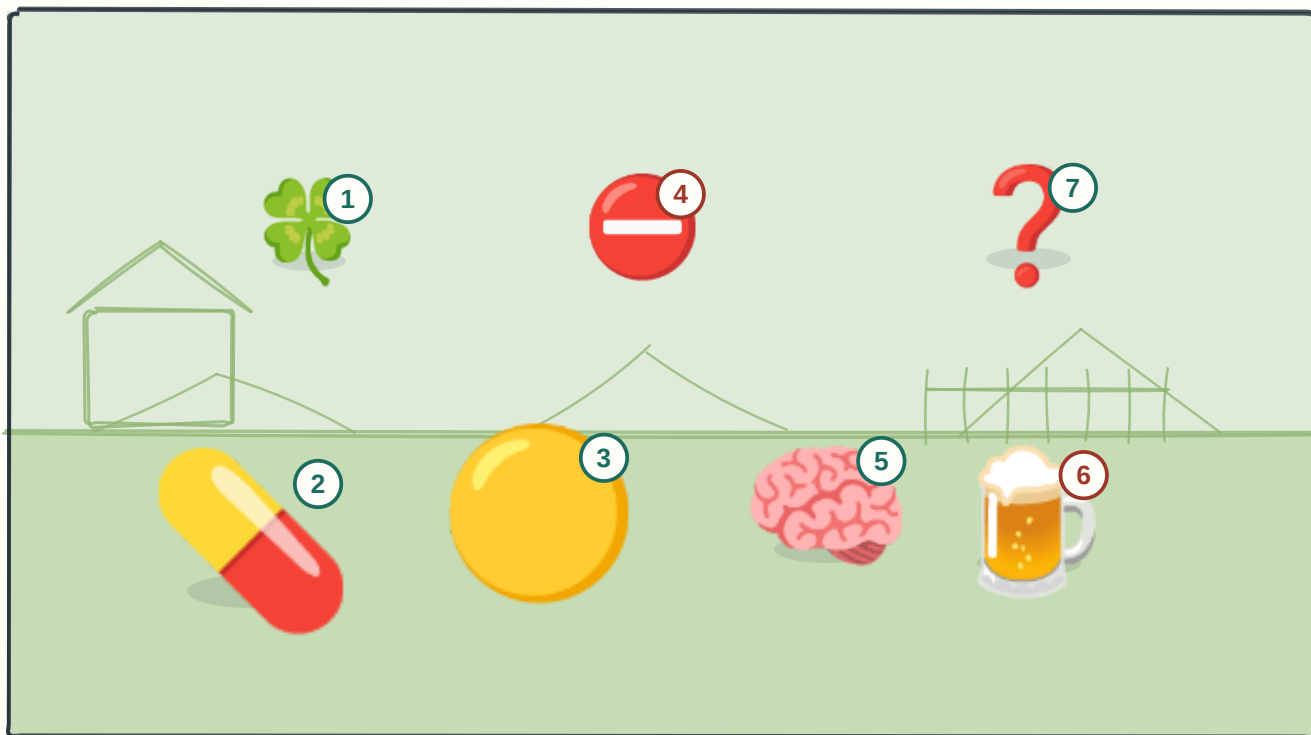
Má vlastní spasmolytickou složku — hodí se u ledvinné a žlučnickové koliky; riziko agranulocytózy a hypotenze při rychlém i.v. podání.

7 Dráždivý tračník

Mebeverin, pinaveriumbromid (blokátor kalciových kanálů střeva) a pepermintový olej.

⚠ Spasmolytikum tlumí viscerální bolest tím, že odstraní její příčinu — proto u koliky často funguje lépe než čisté analgetikum.

JÁTRA, KTERÁ NEJVÍC POMŮŽE VYSAZENÍ — u většiny „hepatoprotektiv“ je důkaz slabý.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Ostropestřec

SILYMARIN působí antioxidačně a stabilizuje membránu hepatocytu; jedinou doloženou indikací je otrava muchomůrkou zelenou, kde silibinin i.v. brání vstupu amanitinu do buňky.

2 N-acetylcystein

Doplňuje glutathion — antidotum otravy paracetamolem.

3 UDCA

Kyselina ursodeoxycholová je hydrofilní žlučová kyselina nahrazující toxické — lék volby u primární biliární cholangitidy; rozpouští drobné cholesterolové konkrementy.

4 Obstrukce

Cholagoga (choleretika zvyšují tvorbu žluči, cholekinetika vyprazdňování žlučníku) jsou KONTRAINDIKOVÁNA při obstrukci žlučových cest.

5 Encefalopatie

Ornithin-aspartát a laktulóza snižují amoniak; rifaximin snižuje jeho střevní produkci.

6 Alkohol

Nejúčinnějším hepatoprotektivem je vysazení alkoholu a hepatotoxického léku, léčba viru a redukce hmotnosti u steatózy.

7 Esenciální fosfolipidy

Používají se u steatózy, důkazy o účinnosti jsou slabé.

! Silymarin se běžně užívá jako doplněk stravy — a právě proto se na něj v anamnéze nezapomíná ptát; jeho doložená role je jen u otravy amanitinem.